

前 言

妇科学是专门研究妇女疾病的一门学科。为了继承发扬祖国医学遗产，我们搜集了古今有关中医妇科的资料，根据中医理论体系，突出中医特色，结合临床心得，编写了这本《实用中医妇科学》，以帮助初学者作为入门的阶梯，并供中医及西医学习中医临床参考。

本书分总论、各论两个部分。总论分为七章，简要讲述了妇科研究的范围、妇科的发展概况、妇女的生理特点、病因病机、诊断概要、治法概要及预防保健等；各论分为五章，近80个病种，每病分列概说、病因病机、辨证施治等项。编写形式采用以证为主，病证结合的方法。为便于中西医病名相互印证，有助于读者学习参考，书中采用了一些现代医学的病名。

由于我们的学识经验有限，书中存在的缺点错误，望广大读者予以批评指正。

编 者

于山东中医学院

一九八四年四月

目 录

总 论

第一章	妇科学研究的范围和意义	(1)
第二章	妇科学的发展概况	(3)
第三章	妇女的生理特点	(14)
第一节	胞宫	(14)
第二节	月经	(17)
第三节	五不女	(23)
第四节	妊娠与分娩	(25)
第四章	病因病机	(27)
第一节	病因	(27)
第二节	病机	(29)
附:	肾的研究概况	(33)
第五章	诊法概要	(37)
第一节	问诊	(37)
第二节	望诊	(41)
第三节	闻诊	(43)
第四节	切诊	(44)
第六章	治法概要	(48)
第一节	补肾填精	(48)
第二节	疏肝养肝	(49)

第三节 健脾和胃	(50)
第四节 调和气血	(50)
第七章 预防保健	(52)
第一节 经期卫生	(52)
第二节 孕期保健	(53)
附：现代医学对胎教的研究	(55)
第三节 临产调护	(56)
第四节 产后调养	(59)

各 论

第一章 月经病	(61)
第一节 月经不调	(62)
月经先期	(63)
月经后期	(68)
月经先后无定期	(76)
月经过多	(81)
月经过少	(84)
第二节 痛经	(87)
第三节 经闭	(92)
第四节 崩漏	(102)
第五节 经行吐衄	(113)
第六节 经行发热	(115)
第七节 经行泄泻	(122)
第八节 经前便血	(126)
第九节 经前期紧张证	(129)
第十节 经断前后诸证	(134)

第二章	带下病	(141)
第一节	白带	(142)
第二节	白崩	(146)
第三节	黄带	(148)
第四节	赤带	(151)
第五节	赤白带	(155)
第六节	青带	(160)
第七节	黑带	(162)
第八节	五色带	(165)
第九节	白浊	(167)
第十节	白淫	(169)
第三章	妊娠病	(172)
第一节	妊娠呕吐	(173)
第二节	妊娠肿胀	(177)
	附：羊水过多症	(181)
第三节	妊娠小便淋痛	(183)
第四节	妊娠小便不通	(188)
第五节	妊娠心烦	(191)
第六节	妊娠失音	(194)
第七节	妊娠咳嗽	(195)
第八节	妊娠痢证	(198)
	先兆子痫	(199)
	子痫	(201)
第九节	妊娠腹痛	(203)
第十节	胎气上逆	(207)
第十一节	流产	(203)

先兆流产	(210)
难免流产	(214)
习惯性流产	(215)
稽留流产	(220)
不完全流产	(221)
完全流产	(223)
感染性流产	(224)
第十二节 难产	(225)
附：转胎方	(228)
第四章 产后病	(230)
第一节 胞衣不下	(232)
第二节 恶露不止	(226)
第三节 恶露不下	(240)
第四节 产后小便不通	(242)
第五节 产后小便频数与失禁	(245)
第六节 产后血晕	(248)
第七节 产后发热	(248)
第八节 产后发痉	(257)
第九节 产后大便难	(259)
第十节 产后汗出	(260)
第十一节 产后腹痛	(262)
第十二节 产后身痛	(265)
第十三节 乳汁不行	(268)
第十四节 乳汁自出	(271)
附：通乳	(274)
第五章 妇科杂病	(275)

第一节	症瘕	(275)
第二节	子宫肌瘤	(281)
第三节	子宫外孕	(281)
第四节	子宫脱垂	(292)
第五节	不孕症	(297)
附:	男性不孕症	(304)
第六节	脏躁	(315)
第七节	炙癯	(318)
第八节	阴冷	(320)
第九节	阴吹	(322)
第十节	外阴瘙痒	(324)
第十一节	外阴炎	(328)
第十二节	外阴白斑	(330)
第十三节	阴道炎	(332)
	老年性阴道炎	(382)
	滴虫、霉菌性阴道炎	(333)
第十四节	阴疮	(336)
第十五节	盆腔炎	(342)
	急性盆腔炎	(343)
	慢性盆腔炎	(344)
	结核性盆腔炎	(347)
第十六节	子宫颈糜烂	(341)
第十七节	子宫颈癌	(351)
第十八节	绒毛膜上皮癌	(358)
第十九节	乳癌	(361)
附录	方剂索引	(368)

总 论

第一章 妇科学研究的范围和 意义

妇科学是研究防治妇女疾病的学科。它的范围，根据历代文献的分类，大都包括调经、崩漏、带下、种子、胎前、小产、临产、产三、杂病等项目。总之，不外经、带、胎、产、杂病五个方面。

由于妇女在生理上有经、孕、产、育等特点，因此，也就产生经、带、胎、产等一些特殊病变。如《千金要方》说：“夫妇人之别有方者，以其血气不调，胎妊、生产、崩伤之异故也。所以妇人病比男子十倍难疗……若四时节气为病，虚实冷热为患者，与丈夫同也；惟怀胎妊扶病者，避其毒药耳。”这说明妇科疾病有其独特之处。

妇科疾病是相当复杂的，所以寇宗奭有“宁治十男子，莫治一妇人”之说。但是妇女担负着孕育乳哺延续后代的责任，唯有强壮的母亲，才有健康的子女，所以做好妇科疾病防治工作，对后代的优生和民族的健康，都有密切的关系。

妇科学虽然是一个专门学科，但与其他学科，特别是内科有着不可分割的联系。因此，除妇女的一般内科疾患，可

以和男子同样处理外，若值经、孕、产、育之际，则应考虑其生理特点，酌定其治疗方法。所以对妇科学的学习和研究，具有重要的意义。

第二章 妇科学的发展概况

妇科学是祖国医学的重要组成部分之一，有着悠久的历史，在不断发展的过程中，积累了极其丰富的理论和经验，数千年来在我国妇女保健事业中起了很大作用，对我国人口的昌盛、民族的繁衍，具有密切的关系。但妇科学的起源，究竟在何时，由于目前尚缺乏可靠的历史资料以资考证，只能根据现有文字记载的发展概况，列述如下。

夏商周时代（公元前2205～前256年） 在这个时代里，我国对妇科的难产、种子、胎教等已经有了记载，如《史记》和《左传》就记述了三个难产病例：夏修己背折生禹，殷简狄胸折生契，郑庄公寤生惊姜氏等。殷墟出土的甲骨文的卜辞中，有“贞子母其毓不其（死）”等字，这是占卜孕妇和胎儿吉凶的记载，可能是因难产或临产有病而举行的。同时甲骨文还载有“疾育”（产妇病）的病证，可见那时已对妇人生育方面的疾病，加以重视了。

在胎教方面，《烈女传》中载：“太任（周文王之母）有娠，目不视恶色，耳不听淫声，口不出敖言。”可见当时已认识到母亲的精神情绪对胎儿的影响。

周朝初年（公元前11世纪），在民间已经注意到妇科常用药物的采集了。如《诗经》所谓“采采芣苢，薄言采之，”

芣苢就是车前；“中谷有蓷，嘒其干矣”，蓷就是益母草；“东门之墠，茹藘在阪”，茹藘就是茜草。说明当时的一般群众，已经掌握了一些有关妇科方面的知识。又如《山海经·中山经》所说“鵽食之宜子孙。”和“黄棘服之不字”。《山海经·南山经》所说“鹿蜀佩之宜子孙”，《山海经·西山经》所说“萐莆食之使人无子。”和“圆叶而白附，赤华而黑理，其实如枳，食之宜子孙”等。虽然这些药物现在已无从查考，但可见当时已有调经、种子、避孕的药物了。

约于战国初年（公元前475年）成书的我国第一部医书《黄帝内经》中，记载了不孕、不月、子瘕、血枯、白淫、瘕聚、肠覃、石瘕等妇科疾患的病名和成因，以及妊娠的诊断方法、妊娠期的用药治则，还记录了祖国第一张妇科方剂四乌贼骨一茹藘丸，特别详细地阐述了女子发育和衰老的过程。可知早在战国以前，祖国医学对于妇科已有相当的认识了。

战国时期（公元前475年～前221年）已出了一位兼长妇科的名医扁鹊。据《史记·扁鹊仓公列传》记载：“扁鹊名闻天下，过邯郸，闻贵妇人，即为带下医。”“带下”是妇科疾患的统称，这可以说是妇人病专科的滥觞。

以上事实说明，随着历史的发展，医学也在不断的发展，早在二千年以前，祖国医学对妇科就有比较专业性的研究，这在医学史上是一个重大贡献。

两汉时代（公元前206～公元220年）到了汉代，妇科学有了进一步的发展，据《汉书·艺文志》、《隋书·经籍

志》记载，那时已有数种妇产科的专门著作，如《妇婴儿方》十六卷、《范氏疗妇人方》十一卷、《养胎经》一卷、《疗妇人产后》三卷、《徐文伯疗妇人瘕》等。另外，《伤寒论·原序》说：撰用《胎产药录》，“胎”是怀孕，“产”是腹前，可见是一部妇科专书。《隋志》还载有张仲景著《疗妇人方》二卷，陈自明称：“民间有妇人伤寒方，称为仲景所撰，王叔和为之序。”这些可说是我国最早的妇科专著，可惜均已散佚，实在是医学上的一个重大损失。

在现存祖国医籍中，最早专篇论述妇科的，要算东汉·张仲景的《金匱要略》。这部书中有三篇是专论妇科病的，如《妇人妊娠病脉证并治》，主要论述了妊娠出血、妊娠腹痛、妊娠水肿等证；《妇人产后病脉证并治》，提出了痉、郁冒、大便难三证，并对产后腹痛、呕逆、下利等证，订立了治法；《妇人杂病脉证并治》，论述了热入血室、脏躁、经闭、腹痛、漏下、转胞、阴冷、阴疮、阴吹等证。这些宝贵的经验，至今仍有指导妇科临床的实用价值。

张仲景同时的伟大的医学家华佗（公元145～208年）对妇科也有很大的贡献。《后汉书·华佗传》载有治疗一双胞胎难产的病例说：“有李将军者，妻病，呼佗视脉。佗曰：伤身而胎不去。将军言，间实伤身，胎已去矣。佗曰：按脉，胎未去也。将军以为不然。妻稍差，百余日复动，更呼佗。佗曰：脉理如前，是两胎，先生者去血多，故后儿不得出也，胎既已死，血脉不复归，必燥著母脊。乃为下针，并令进汤。妇因欲产不通。佗曰：死胎枯燥，势不自生。使人探

之，果得死胎，人形可识，但其胎已黑。佗之绝技，皆类此也。”这些文字的记载，可知古人在此时期能凭脉证，对一生一死的双胎进行正确的诊断，且用针药合治的方法以下死胎而不效，故又采用手术帮助分娩的成果。这也表明当时医学的发展是比较全面的。然遗憾的是，华佗遗著已遭散失，殊为惋惜。

两晋南北朝时代（公元265～581年） 西晋著名脉学家王叔和（公元180～266年），著《脉经》十卷（成书于243年）。他在《内经》的基础上，对妇女的生理和病理现象，有了更进一步的认识，他观察到有些妇女的月经，并非每月一行，而没有什么病态反映，所以在他的《脉经》中指出，经水三月一来者叫居经，一年一潮者叫避年，此乃禀赋不齐，不属病态，并且详细记载了“新产离经脉”和“五崩”的症状。如“怀妊离经，其脉浮，设腹痛引腰脊，为今欲生也，但离经者不病也。又法妇人欲生，其脉离经，夜半觉日中生也。”在论及五崩时，他说：“白崩者形如涕，赤崩者形如绛津，黄崩者形如烂瓜，青崩者形如蓝色，黑崩者形如衄血也。”这些记载都是王氏从临床实践中得出的经验总结。

南齐褚澄（？～483年）著有《褚氏遗书》一卷（约成书于公元481年），内设“求嗣”一门，论述精血化生之理，提倡节欲和晚婚。如《精血》篇云：“精未通而御女以通其精，则五体有不满之处，异日有难状之疾。”《本气》篇云：“合男子多则沥枯虚人，产乳众则血枯杀人。”这是褚

氏对节欲和节制生育的认识，是合乎科学道理的，这对保护妇女身体健康具有重要意义。书中还记载了一些种子的方药，非但对不孕症创立了许多治疗方法，同时还提出不孕的原因也有属于男子方面的，打破了以往把不孕症专责女方的片面观点。

北齐·徐子才（公元505~573年）著有《逐月养胎法》一卷，对于胎儿逐月的发育叙述甚详。如“妊娠一月始胎，二月始膏，三月始胞，四月形体成，五月能动，六月筋骨立，七月毛发生，八月脏腑具，九月谷气入胃，十月诸神备，日满即产矣。”古人在当时的历史条件下，能如此细致地观察胎儿逐月发育的情况，是难能可贵的。同时对孕妇卫生的记载，也较为完备。如“饮食精熟，羹宜鱼雁，其羹牛羊”，是说明怀孕期间宜摄取丰富的营养。又如“身欲微劳，出游于野”，说明孕妇宜做轻微的劳动，并宜常到野外散步；“卧必晏起，深其居处，厚其衣服”，是主张要有充足的睡眠和适当的保暖；“沐浴浣衣，朝吸天光”，要讲究清洁卫生和吸收早晨的新鲜空气；“缓带自持”，是说衣服穿着不宜过紧；“男子勿劳”，就是限制性交等等，这些论述，都是非常合乎科学道理的。

总的说来，这一时期的妇科医学，比两汉时期有了进一步的发展。

隋唐时代（公元581~907年）这两个朝代，由于政治上比较稳定，经济文化也比较繁荣，因此在医学方面也有进一步的成就。隋代杰出的医学家巢元方在公元610年编纂的

《诸病源候论》共十五卷，其中载有妇人杂病八卷。前四卷论妇科病，包括妇女内外科诸病，有月水不利、月水不断、月水来腹痛、月水不通、崩中漏下、带下及阴肿、阴痛、阴疮、阴挺下脱等。特别在带下三十六疾候中，能够认识到十二症的带下，不同于一般带下的鉴别诊断；对阴挺下脱病因的叙述，指出：“胞络伤损；子宫虚冷，气下冲则会阴挺出，谓之下脱；亦有因产用力偃气而阴下脱者。”这种论点，也是颇为中肯的。后四卷则为妊娠病、将产、难产、产二后病等，均有较详细的论述，如《产难候》中说：“产难者，或因胎漏出血，脏燥或子宫宿挟瘀病，或触禁忌，或时觉腹痛，产时未到，即使惊动，移露早下，致子道干涩，产妇力疲，皆令难产也。”亦是符合临床实际之谈。此外，对妊娠恶阻、子痫及产后恶露不尽、虚肿、风痉和半产都作了详细的叙述，丰富了妇科学的内容。尤其对怀孕的妇女，强调提倡胎教，看来古人也是特别重视优生学的。

唐孙思邈（公元581～682年）对妇科很重视，他晚年将自己的经验和唐以前的方剂进行了总结，著成《千金要方》，把妇科一门列在卷首，这个编纂方式，也是祖国医籍中的一个伟大创举。他广泛地讨论了赤白带下，崩中漏下，求子种子、养胎禁食、临床注意、产后护理等问题，其中有不少精辟独到的见解，如对临产问题，他认为生育是自然的生理现象，别人的紧张情绪，会使产妇心理恐慌而造成难产，所以他说：“凡欲产时，特忌多人瞻视，惟得二、三人在旁，待产讫，乃可告语诸人也。若人众看视，无不难产。”对产后

护理，主张节欲，他说：“凡产后满百日，方可合会，不尔，至死虚羸，百病滋长，慎之。”这些论点是正确的。全书共收载药方540余首，灸法30条，填补了巢元方《诸病源候论》有论无方的缺憾。

王焘的《外台秘要》（撰于公元752年）收集了唐代诸家和《千金要方》遗留未载的很多方剂，如张文仲的《集验》、《小品》，崔氏、许仁则、深师等人的著述，多已亡佚，却赖之保存了一部分。其中妇人方分上、下2卷，凡85门，480余方，并论列了子痫、横产和胎衣不下等等，而且还汇集附录了《小品》、《千金要方》的坠胎方和断产方，这是祖国医学妇科学上的一个非常先进的发明。

祖国现存的第一部妇产科专著《产宝》，是唐大中初年（公元847年）昝殷所著。但此书早已散佚，清季张金城在日本得此，重印刊行，就是现在的《经效产宝》。全书分3卷，41门，260余方，每门都前列短篇，后列方药，体例与《千金要方》相似，讨论各症，相当中肯，足为后世法则。

巢氏的《诸病源候论》、孙思邈的《千金要方》、王焘的《外台秘要》，是隋唐时期的三部代表著作，对祖国医学具有很大的贡献。

两宋时代（公元961～1279年） 两宋的医学是继隋唐医学而发展的，尤其是在医学上分科更为细致，当时太医局分为九科，妇产科是其中之一，并设产科教授，是为产科独立设科之始。因此宋代妇产科学有了进一步的成就。在著作方面，有不少价值很高的妇产科专著，如李师圣的《产论》、

郭稽中的《产育宝庆集》、朱瑞章的《卫生家宝产科备要》、苗衍的《坤元是保》、齐仲甫的《女科百问》等，都是分合当时妇科学知识编辑而成。南宋·杨子建所著《十产论》，对产科贡献最大，可说是中国第一部助产学的著作。它记载了子产、伤产、催产、冻产、热产、偏产、横产、碍产、坐产、盘肠等。详细说明了使胎位转正的各种手法，指导产妇正身仰卧，促使胎儿以顺道而下。

陈自明（公元1190～1270年）综合了以前历代妇科学说，并结合自己家传的经验方，著成了一部完善的妇科专著——《妇人大全良方》（公元1237年）。对妇科学的发展具有很大的促进作用。全书24卷，共分10门，前3门属于妇科范围，包括调经、众疾、求嗣等。后6门属于产科范围，包括胎教、候胎、妊娠疾病、坐月、难产、产后等。最后1门是妇人疮疡门，论治妇人茧唇、耳胗、臃疮及肺痈、乳漏、乳癌等外科疾病。其门下共设260篇全论，论后附方，详细说明，条理井然。总之本书内容非常丰富，可以说是对宋代以前的一切妇产科理论和经验，进行了系统全面的总结。

此外，在宋代一般综合性的医学书籍中，如《圣惠方》、《圣济总录》、《本事方》、《三因方》以及《济生方》等，也都有专篇论及妇产科疾病。可见妇产科到了宋代已进入高度发展的阶段。

金元时代（公元1115～1368）金元时代医学分设13科，其中在产科兼营妇人杂病。金、元时代有四大医学家，即刘河间（字守真1110～1200年）、张从正（字子和，公元

1156~1228年)、李杲(字明之,号东垣,公元1180~1251年)、朱震亨(字彦修、号丹溪,公元1281~1358年)。他们继承了唐宋医学的余绪,又由于所在地区的气候不同,接触的对象不同,对妇科都各有自己的见解。如李子和说:“凡看妇人病,入门先问经;凡治妇人病,不可轻用破气行血之药,恐有妊在疑似之间也;凡看产后病,须问恶露多少有无,此妇科要诀也。”这些诊疗经验是非常宝贵的,至今仍为医者所遵循。李东垣治疗产科疾病,以补血为首要。他认为妇人分娩及流产漏下,昏冒不省,瞑目无所知觉,盖因荣血暴亡,有形血去,则心神无所养,血亡则危,得血则安。这些见解,对妇科的诊断和治疗用药等方面,可说是进一步的认识。朱丹溪对妊娠病的治疗,认为胎前应清热养血,而提出黄芩、白术为安胎圣药。对产后病的治疗,主张补虚为主。他说:“产后无得令虚,当以大补气血为先,虽有杂病,以末治之。”这些见解在临床上确有一定的参考价值。在《丹溪心法》中,载有妊娠切脉法和验死胎法,是当代妇科学上的新记录。

明清时代(公元1368~1911年) 明清两代在妇、产科临证上积累了很多的经验,名著颇多,现存约有一百多种。其中对妇产科论述最详的书籍首推王肯堂(公元1552~1613年)的《女科证治准绳》(公元1607年),他以陈自明的《妇人大全良方》为基础,并将张元素、朱丹溪、薛立斋的学说,充实其间,可称集明以前妇科学之大成。此书流传甚广,对后世影响很大。他对小产(半产)也非常重视,他

说：“小产不可轻视，将养十倍于正产可也。”一般小产都是因体弱，产后虚乏，或跌仆损伤所引起，其体力自较正产的正常生理现象为差，故其立论是非常合理的。

明·张景岳（公元1563～1640年），著有《景岳全书》（公元1636年），该书的《妇人规》分上、下2篇，对妇人病特别提出了由于房事关系而造成的带下、崩漏等疾病。另外，对产妇临盆催生问题，亦提出了正确的意见。他说：

“凡妊娠胎元充足，弥月而产，熟落有期，非可催摧也。所谓催者，亦不过动其气血而利导之耳……若期未至而妄用行气导血等剂以催生，亦犹摘方苞之萼，掘宋人之苗耳。”这种见解，是非常正确的。

明·万全（密斋）著《广嗣纪要》（刊于公元1549年），是一部专论女科生育问题的书。他主张男子三十而娶，女子二十而后嫁。在寡欲篇中提出“求子之道，男子贵清心寡欲以养其精；女子贵平心定意以养其血。”在择配篇中，他认为古人对女子因先天生理缺陷所造成的不孕症，有五不孕之说，即所谓“螺、纹、鼓、角、脉”。他还编有《妇人秘科》一书，亦是有临床参考价值的书。

后来武之望的《济阴纲目》（公元1626年），是根据《女科准绳》改编的。本书对妇科亦有很大的贡献。此外，薛立斋的《女科撮要》，对妇科也有所发挥。

清代医事制度有九科之分。将妇人杂病科和产科合并为妇人科，通称女科。有关妇科的著作很多。而当时最有名气的妇科著作当推《傅青主女科》，亦称“傅青主八十症”，

全书分上下2卷，分带下、血崩、鬼胎、调经、种子、妊娠、小产、难产、正产、产后十大类，他还著有《产后篇》一书，这又把祖国医学的妇科学向前推进了一步。他还继承了李东垣的学说，对胎产病立方，能够时刻照顾到病人的气血和脾胃，即使在病邪充盛的情况下，也主张攻补兼施，不能单用峻药攻伐，这种立方精神，为清以后的一般女科医家所采用。其他如肖慎斋的《女科经纶》、沈尧封的《女科辑要》、吴谦的《医宗金鉴·女科心法要诀》、陈修园的《女科要旨》，以及叶天士的《女科》等，论述均简明扼要，各有所长，在妇科方面，都有一定的成就。

胎产方面的著作，清代有阎纯玺的《胎产心法》、汪朴斋的《产科心法》、单养贤的《胎产全书》、张曜孙的《产孕集》等。最值得提出的是亟斋居士所著的《达生篇》。本书流传很广，影响极大。篇中对助产、保护胎儿和产母、预防小产、临产须知、产后保健，以及难产急救等均有叙述说明。并告慰产妇安心静卧，对临产提出六字真言，即“睡、忍痛、慢临盆”。说明分娩是个生理现象，不必惊慌和操之过急，应让其自然娩出。并且主张让产妇主动参加分娩工作，用力要适当。这与现代医学无痛分娩法的精神，是一致的。

综上所述，明清时期的妇科学亦有一定的发展。

第三章 妇女的生理特点

就人体脏腑经络气血的活动规律而言，男女基本相同。但由于妇女在解剖上有胞宫，在生理上有月经、胎孕、孕育、哺乳等特点，因此，在脏腑经络气血活动的某些方面，与男子又有所不同。

人体以脏腑经络为本，以气血为用。妇女的月经、胎孕、孕育等，都是脏腑经络气血的化生功能作用于胞宫的具体表现。脏腑是气血生化之源，经络是运行气血的通路。气血是月经、胎孕、孕育、哺乳等的物质基础，胞宫是行经和孕育胎儿的器官。因此，研究妇女的生理，必须以脏腑、经络、气血、胞宫为核心，尤其是肾、肝、脾和冲、任、督、带四脉在妇女生理、病理变化上更有其重要的意义。近年来的中西医结合研究表明，肾在中医妇科领域的地位更为突出。

第一节 胞 宫

胞宫为“奇恒之府”，亦称“女子胞”、“子脏”、“胞脏”。位于带脉之下，小腹正中，其作用是行经和孕育胎儿。张景岳说：“女子之胞，子宫是也，亦以出纳精气，

而成胎孕者为奇。”这就是现代医学“子宫”名称的依据。就胞宫的涵义来说，它不仅指现代医学的子宫，而且还包括子宫的附件，如输卵管、卵巢等。

一、¹胞宫与脏腑的关系：胞宫与脏腑的功能有着密切的关系，尤其与肾的关系更为密切。

胞宫与肾的关系：《素问·奇病论》说：“胞脉者系于肾。”肾为先天之本，元气之根，主藏精，凡人的形成、发育、生长、生殖以及消耗的补充等，都是靠精的“化生”来实现的。而精又为化血之源，是月经、胎孕的物质基础。女子二七，青春期后，肾气旺盛则天癸至，生理上开始有经胎孕育的正常活动。及至七七，肾气衰，天癸竭，就经闭而不能孕育了。

胞宫与肝的关系：肝藏血，主疏泄，司血海，对胞宫的生理功能有其重要的调节作用。故肝气与肝血的盛衰，可直接影响胞宫的功能。

胞宫与脾的关系：脾为后天之本，主运化，是气血生化之源。脾主统血，为胞宫的行经、孕育提供物质保障。所以，脾之功能如何，能直接影响胞宫的血液供应。脾与胃相表里，胃为水谷之海，主受纳腐熟水谷，胃中谷气盛，则冲脉之血盛，可使胞宫之功能充沛。

胞宫与心的关系：《素问·评热病论》说：“月事不来者，胞脉闭也。胞脉者属心而络于胞中……”心主血脉，为人体生命活动的中心，所以心的功能正常与否，也可直接影响胞宫的功能。

胞宫与肺的关系：肺主一身之气，通调水道，输布精微，故全身的气血、津液皆赖肺气运行，胞宫需要的一切物质，也要由肺来转输和调节。

二、胞宫与冲任督带四脉的关系 胞宫除与脏腑十二经脉相联系外，与冲、任、督、带四脉，特别与冲、任二脉的关系尤为密切。

冲脉：起于女子胞，分前后两支。后支沿脊柱内部上行至肾；前支由阴部两侧气冲穴开始，至胸部而散。其上者，出于颜额。冲脉是十二经气血汇聚之所，藏血最多，故有“冲为血海”之称。冲脉与足阳明胃经会于气冲，受后天水谷精微之供养，又与肾脉相并，受先天肾气之资助；即先天之元气与后天水谷之精气皆汇于冲脉，对女子月经和生育起着主要的作用。

任脉：起于胞中，出会阴，向前经阴器上行，出毛际，沿腹胸颈正中线至咽喉，达承浆，由此分为左右两支入内上行至眼部。在循行过程中和诸阴经相联系。为阴经经脉的总纲。凡经、血、津、液皆属任脉总司，故亦称“阴脉之海”。胞宫的孕育功能与任脉有直接关系，故“任主胞胎”。

督脉：起于会阴，向后循脊柱正中线上行，至腰部与肾联系，上行经后颈部至头，内连于脑，再由巅向前，经额下行入鼻柱达龈交穴。与任脉前后循环往复，维持阴阳脉气的相对平衡。

带脉：带脉起于季胁（章门穴），环身一周，如带束腰，故称带脉。其与冲任督三脉交合，下系胞宫。张子和

说：“带脉……环身一周，无上下之原，络胞而过，如束之身，”带脉的功能是约束诸经，使经脉气血循行保持常度。

第二节 月 经

月经是女子周期性子宫出血的生理现象，通常一个月来潮一次。古人因其每月到期即来，故而得名。医家又因其按月而至的特点，亦称为“月信”、“月事”、“经水”等。

一、月经的生理现象 当女子脏腑经脉的生理功能逐渐发育成熟时，月经开始来潮，称为“初潮”。初潮年龄一般在12~18岁之间，多数在14岁左右，以后逐步形成周期性，1个月左右（25~35天）来潮1次，中间除妊娠、哺乳外，一直到49岁左右月经闭止，称为“经绝”或“绝经”。

经血的持续时间称为“经期”，经期一般为2~7天，多数是3~5天（占80%）。经期第一天血量较少，第二、三天血量最多。

月经，除有一定的周期性外，每次来潮也有一定的限量。整个经期出血量的多少，医家常以本人叙述为依据，但以科学计算方法得出的结果，平均月经量为50毫升。近年有人用放射性 ^{59}Fe 或 ^{14}C 同位素标记红细胞测定正常人月经量，其数值分别为10~55毫升和35~58毫升。如每月出血量多于80毫升，即为病理状态。

从月经来潮的第一天至下次月经来潮的第一天，称为“月经周期”。月经周期一般定为28天，但周期的长短，不

仅每个人不尽相同，就是本人也不尽一致。据文献统计，月经周期在20~35天之间者占70%以上。另外，月经周期的长短又与种族、气候有关，如热带妇女周期较短，而北极爱斯基摩人则只在夏季行经。这符合祖国医学“天热地暖，则经水沸腾；天寒地冻，则经水凝滞”的理论。

正常妇女月经的颜色，一般为暗红色，开始时较浅，逐渐加深，最后又呈淡红色，不稀不稠，没有特殊气味。祖国医学在很久以前即明确指出，经血有一个与其他血液不同的特点，即不凝结，无血块（或偶然存有一些小凝块）。现代医学认为经血不凝主要是由于纤维蛋白的溶解（纤溶）。子宫内膜含有很多活化质，当间质出血时，混入经血的纤溶酶原被激活为纤溶酶，纤维蛋白在纤溶酶的作用下裂解为流动的分解产物。同时内膜组织含有其他活化酶，还能破坏许多凝血因子（如凝血因子Ⅱ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ、Ⅷ），也妨碍了血液凝固。而且宫颈粘液也含有纤维蛋白溶解酶，因而经血不凝是由于凝血和血栓溶解两个系统同时起的作用。

一般经期无特殊症状，有些妇女在经期微感乏力，下肢及背部沉重有下坠感，待月经排出后遂即消失。对工作、学习无大影响者，均不以病态论。

二、月经的异常现象 妇女除正常的月经外，尚有几种异常现象，就是“并月”、“居经”、“避年”、“崩经”、“暗经”等。

有个别健康女子，2月来1次月经的称为“并月”，3月来1次的称为“居经”或“季经”，1年来1次的叫做

“避年”。妊娠后仍按月行经的称为“激经”，终生不行经而能受孕的叫做“暗经”。前人认为，这些没有任何不适症状的异常现象，不是病态。但证诸临床，实不尽然。如张山雷在《沈氏女科辑要笺正》中说：“居经、避年，固有因于禀赋者，然总缘体弱血少之故。若其先本不衍期，而忽致间月乃行，亦是不足之病。惟间隔之期，殊无一定，有偶间一、二月者，亦有常隔三、五月者。居经、避年等称，亦是随意定名，无甚义理。”根据张氏的看法，禀赋不齐者固有之，然而总的原因是体弱血少，导致“并月”或“居经”，它又可进一步转化为“避年”。如有自觉症状表现，应以“月经后期”辨证论治。

“激经”亦称“盛胎”（胎盛），或“垢胎”（胎垢），系指怀孕后月经仍按月来潮的现象。一般认为对孕妇、胎儿无明显损害，待胎儿壮大即可自止，故不属病征。对于“激经”产生的原因，前人认为是血盛所致。如《济阴纲目》说：“大抵妊娠经来不多，而饮食精神如故，六脉和缓，滑大无病者，血盛有余也。儿大能饮自不来矣。”亦有人认为是“胎垢”，必将垢血排出体外而胎安。但张山雷在《沈氏女科辑要笺正》中说：“若妊娠月月行经，又不碍胎，惟旺盛者偶或有之，然虽如期而来，亦必不如平时之多，方为有余而溢之征，如其按月能行，且亦如未孕之状，则终恐固摄无权，半产可虑。胎盛一说，已非确论，又曰垢胎，更是无知妄作。若胎前血忽大下，则堕者其常，不堕者其偶。”这就强调指出，激经必然比未孕时月经量少，若血量多，则易

流产。张氏的见解几乎完全和现代医学的观点相同。也就是说，激经可以碍胎至期而产，但也可以转化为流产。

把“激经”的产生原因解释为“血盛”、“垢血”，尤未见确切。因为这种妇女在孕前都是气血调和的健康人，并无血盛溢血之象，而孕后血聚于下以养胎，应是相对的血虚，血盛有余则无法解释。至于垢血而下的道理更属难通。实则“激经”产生的原因乃属肾气不足。因肾为生胎之元，肾气不足，固摄无权，以致孕后流血；若肾气虚衰，引起不规则出血或大量流血，则可导致流产。

“激经”与“胎漏”不同。前者是孕后按月行经，后者是孕后不规则阴道流血，前者或对胎儿无碍，或可导致流产，属肾气不足；后者是由于气虚、血热、胎元不固、房事所伤等引起的病理变化。是流产的先兆。

妇女终生不行经或每月届期只有腰酸感觉而能受孕者称为“暗经”。至于“暗经”的形成，可从两个方面予以探讨。

(一)属于返祖现象：生物进化论证明，人类起源于动物。人类同哺乳动物中的灵长类，特别是类人猿（猩猩、黑猩猩、大猩猩）很相似，雌性都有月经，怀孕期为8~9个月等等。人类的胚胎有尾巴，人类的胎儿有一个时期全身被有长毛，有时出生后有的婴儿仍有尾巴、胎毛（毛孩），在成年妇女中复乳也并非少见。这些都属于返祖现象。

哺乳类许多动物性周期结束，其子宫内膜自行退化，并不发生子宫出血。只有灵长类由于其子宫内膜血管系统高度

分化，在性周期終了，子宮膜脫落时才出現月經。但是有极少数性成熟的婦女，卵巢及子宮內膜虽然有周期性的变化，但到性周期結束阶段子宮內膜并不脫落，而自行退化，所以尽管有性周期也不出現月經。然而，因为有排卵所以能受孕。这种人即使周期性给予性激素（人工周期療法），也可能不出现子宮出血。与哺乳动物一样，是由于子宮內膜血管系统缺乏分化所致。所以说这类暗經是一种返祖现象。

（二）时代环境所造成：有不少暗經是时代环境所致，而且多于前者。故在古代，在旧社会，暗經比现在多见。那时早婚及困苦的生活是婚前无月經的主要原因。婚后如第一次排卵而受孕，则因受孕而月經不来潮；产后哺乳期无限延长，母体健康得不到保证，卵巢功能得不到恢复，可导致月經不能来潮。一旦卵巢功能恢复，又因不节制生育而接连受孕。这种未见月經而怀孕者，古人称为暗孕。若婚前无月經，婚后连续暗孕而终生不行經者，则为暗經。

“暗經”与“暗孕”既有区别，又有联系。凡月經未来潮而受孕，但产后又按期行經者，以及产后哺育期未见月經（哺乳期閉經）又受孕者，皆属“暗孕”。因为二者皆有过月經，故不称“暗經”。

三、月經产生的机理 月經的来潮，是脏腑經脉气血作用于胞宮的正常生理现象。因此，研究月經产生的机理，要从脏腑經脉气血与月經的关系来探讨。《素問·上古天真論》說：“女子七岁，腎气盛，齿更发长，二七而天癸至，任脉通，太冲脉盛，月事以时下。”这就是历代医家从多年

的临床观察中概要地总结出了月经产生的机理。从词义上可以看出“肾气”、“天癸”、“月经”并非一物，三者是互相促进的。这就说明肾气盛，天癸至，冲、任二脉的通盛，是产生月经的主要条件。

“女子七岁肾气盛”，是说女子7岁“肾气”开始活动，逐渐旺盛，前人认为“肾气”是肾间动气，也就是促进人体生长发育的一种机能活动，它存在于两肾之间，原始于肾（先天），资生于胃（后天），也就是说肾气是先天存在的一种物质，而经过后天水谷精气所养，逐渐发挥其功能作用。“二七而天癸至”，是说女子14岁产生天癸，天即天真之气，癸即壬癸之水，是促使月经形成、来潮的重要物质。天癸似乎相当于现代医学的性激素，它直接参与男女精血的产生和生理功能。从上述可以看出天癸与肾气有密切关系，月经又与天癸有密切关系。此外，月经来潮尚须有冲、任二脉之通畅与旺盛。冲脉为十二经气血汇聚之所，是全身气血运行的要冲，称之为“血海”。其脉起于胞中，与任脉会于咽喉，络于口唇。女子发育成熟后，脏腑气血俱盛，血海盈满，下行则为月经。任脉称阴脉之海，主胞宫的功能活动，凡精、血、津、液等阴液，都属任脉总司，为人体妊娠养胎之本。任脉之气通，冲脉之血盛，下达胞宫，故月经得以来潮。其脉亦起于胞中，与肝、脾、肾三脉会于曲骨、中极、关元。因其主一身之阴，又与胞宫相联系，故任脉之气通，可促成孕育。冲、任二脉，初步设想，根据冲为血海，任主胞宫的理论，冲任二脉可能与卵巢、子宫的神经血管有关。

督脉与任脉同出会阴，一行身后而主阳，一行身前而主阴，二脉至口唇而会于龈交穴，循环往复，维持阴阳脉气的平衡，从而保持了月经的正常来潮并发挥着促使受孕的作用。带脉环腰一周，约束全身经脉。故冲、任、督三脉都要受带脉的约束，才能维持其各自的正常功能。

月经的成分是血，而血的生长，统摄运行，有赖于气的生化与调节，同时气又要依靠血的营养。因此，在产生月经的机理上，不但气血是根本的物质基础，而且他们之间的关系又是相互为用的。气血来源于脏腑，脏腑之中，心主血，肝藏血，脾统血，肾藏精，可见脏腑对月经的产生都有其重要的作用，尤以肝、肾、脾、胃更为重要。所以祖国医学认为，月经的来潮是脏腑经脉气血作用于胞宫的生理现象。

第三节 五不女

明·万全撰《广嗣纪要·择配篇》中，有“五不女”之说。“五不女”即“螺”、“纹”、“鼓”、“角”、“脉”五种。他认为，这五种女子由于先天性生理缺陷而不能生育，故名“五不女”。

“螺”指阴户中有螺纹妨碍性交者。正常阴道壁上有许多皱褶，以适应阴道的伸展，以手摸之似螺纹状，尤以阴道前壁更明显。正常之处女膜厚约2毫米，一般是在第一次性交时破裂。也有的处女膜厚且坚韧，造成性交困难，故受孕机会减少。从前人对阴户中有螺纹妨碍性交的描述来看，螺

与现代医学中的处女膜坚韧相似。

“纹”即纹阴，指阴门细小，现代医学称阴道狭窄（细小）。正常人阴道可容二指，前壁长7～9厘米，后壁长10～12厘米。如果在发育过程中，会合后的副中肾管的最下端仅部分贯通，则形成阴道狭窄。发育不良的阴道粘膜皱褶很少而光滑（即无螺紋），故它与螺（螺紋——皱褶多）不同。狭窄的阴道一是妨碍性交，二是常合并其他内生殖器发育不良，故不易受孕。

“鼓”，即鼓花，阴户如蒙鼓皮，无窍可通。现代医学称处女膜闭锁，或称无孔处女膜。手术切开，仍有受孕可能。

“角”，即角花，状如阴中有角。即阴蒂肥大。现代医学中所说的女性假两性人，也称女性半阴阳人，即属此类。多数是由于先天性肾上腺皮质增生所致。常有家族史。

“脉”，是终身不行经，也不能受孕者。“脉”包括了现代医学中的先天性无子宫，始基子宫或子宫内膜缺乏。因无子宫或无子宫内膜，故不能行经受孕。

先天性无子宫有时合并先天性无阴道，即医籍中所说的“石女”，亦称“实女”。

从上述可知，“五不女”中“螺”、“纹”、“鼓”、“角”四症是指女子外生殖器官的生理缺陷；而“脉”症是指女子内生殖器官的生理缺陷。

第四节 妊娠与分娩

《素问·上古天真论》说：“女子……二七而天癸至，任脉通，太冲脉盛，月事以时下，故有子。”说明女子发育成熟后，月经按期来潮，就有了孕育的能力。受孕的部位在胞宫，而受孕的机理在于肾气盛，天癸至，任通冲盛。《灵枢·决气》篇说：“两神相搏，合而成形。”说明月事以时下的女子和精气溢泄的男子两性相交，两精结合，就能构成妊娠。

初次怀孕的妇女叫“初孕妇”，怀孕两次以上的妇女，称“经孕妇”。受孕以后，月经停止来潮，脏腑经络的气血，下注冲任，以养胎元。此时，全身的血相对不足，气相对有余，形成了阴聚于下，阳盛于上的特点。

在妊娠初期，由于血聚于下，冲脉之气较盛，如胃气素虚者，易挟肝胃之气上逆，多有择食喜酸，恶心作呕，晨起头晕等现象，俗称妊娠反应。妊娠期间，白带增多，乳房增大作胀，甚至乳头痛不敢着衣，乳头及乳晕呈黑褐色，并可挤出黄色的初乳。妊娠8个月后，小腹膨隆，可摸到包块。4个多月后，可以感觉到胎动。妊娠期间的小便频数也属正常现象。

从怀孕到分娩的时间，称为妊娠期。妊娠期一般为280天左右，按28天为1个妊娠月，正好是10个妊娠月。杨子建《十产论》说：“妇人怀胎十月，阴阳气足，忽腰腹作阵疼

痛，相次胎气顿陷，至于脐腹痛极，乃至腰间重痛，谷道挺进，继之浆破血出，儿子遂出，名曰正产。”此处所说的正产，即足月正常产。临产之时腰腹阵阵作痛，小腹下坠，间隔时间越来越短，持续时间越来越长，继之肛门坠胀，产户窘迫，胎儿逐渐娩出，胎衣（胎盘）也随之而下。

由于分娩时的出血，耗伤了阴液，阴血骤虚，阳气易浮，因此，在产后1~2日内常有轻微的发热（不能超过38℃）、恶寒、自汗等，这是产后暂时性阴虚阳旺的症状。一般在短时间内即可自行消失。产后数日之内，因胞宫正在恢复过程中，下腹部常有轻微的阵发性疼痛，以哺乳时更为明显（因婴儿吸吮乳头，可以刺激子宫收缩），而且按之有块（子宫），此包块逐日变小，一般在产后第10~14天消失（此时子宫已缩小降入骨盆）。产后从阴道排出的液体称为恶露。恶露中含有血液，坏死的蜕膜组织及粘液。一般产后头3天为血性恶露，量也较多，以后颜色逐渐变淡成为浆液性恶露；7~10天后恶露呈白色或黄白色称为白恶露。恶露多数在2周左右消失，最多不超过3周。否则为病。

由于产后哺乳，脾胃所化生之精微，除供应母体本身的营养需要外，另一部分则随冲脉与阳明之气上行（乳房属足阳明胃经），化生为乳汁，所以哺乳期间，常有月经停闭，称为哺乳期闭经。

产后6~8周的时间，称为产褥期，产褥期合理调养，产妇的身体就会恢复孕前常态。

第四章 病因病机

清·徐灵胎说：“妇人之疾，与男子无异，惟经带胎产之病不同，且多症瘕之疾。其所以多症瘕之故，亦以经带胎产之血，易于凝滞，故较之男子为多。”但若妇女气血调匀，脏腑安和，冲任通盛，则经、带、胎、产正常，反之，即成为病。因此，研究妇女病的病因病机，也要从外因内因和脏腑气血及冲任督带诸脉的变化来探讨。

导致妇科疾病的因素为外感六淫，内伤七情，以及饮食劳倦等皆可致病。

妇科病的病理特点，概括为气血失调，脏腑功能失常和冲任督带损伤。三者是互相影响，互为因果的。

本章仅就上述病因病机分别予以重点阐述。

第一节 病 因

一、外感六淫 风、寒、暑、湿、燥、火六淫之邪，皆可引起妇科疾病。其中寒、热、湿三邪最易致病。

寒邪：人体阳气不足，卫气不固，就易受寒邪侵袭而为病。较常见的如恶寒、发热、头痛、身痛、骨节疼痛或腹痛泄泻等症。如寒邪过盛，阳气受损，则阳虚气弱，脏腑功能

衰退，影响气血运行。寒属阴邪。《素问·调经论》说：

“阴盛则内寒。”血为寒凝，流行不畅，经脉受阻，则可出现月经后期、痛经、闭经等症，甚者可形成症瘕积聚。如《灵枢·水胀》说：“石瘕生于胞中，寒气客于子门，子门闭塞，气不得通，恶血当泻不泻，衃血留止，日以益大，状如怀子，月事不以时下。”

热邪：“热为火之渐，火为热之极”，火与热，只是程度的差异。《素问·五运行大论》说：“其在天为热，在地为火……其性为暑。”所以温热、暑热均属火的病邪，病证都表现为热性。热为阳邪，易伤气耗阴。热邪扰动血海，迫血妄行，可出现月经先期、月经过多、崩漏、产后发热等症。

湿邪：湿为阴邪，性质重浊而粘腻，最易阻滞气的活动，障碍脾的运化。临床表现：外感湿邪，常见体重腰酸、四肢困倦、关节肌肉疼痛，常限于一处不移，重者头重如裹，颈项酸痛；湿浊内阻，常见胸闷不舒、胃纳不佳、小便不利、大便溏泻、带下绵绵、下肢浮肿等症。

二、内伤七情 喜、怒、忧、思、悲、恐、惊等七种精神情志变化的表现，是对外界事物的反映。如这些精神活动过度强烈和持久，就会影响脏腑气血的功能，引起脏腑失调，气血不和而致病。《素问·阴阳别论》说：“二阳之病发心脾，有不得隐曲，女子不月。”说明女子可由于情志不遂，隐曲不得伸，忧愁思虑，而造成经闭。《素问·举痛论》说：“百病生于气也，怒则气上，悲则气消，恐则气下

……思则气结。”这都说明内伤七情是重要的致病原因。郁怒则伤肝，肝气郁结，冲任气滞，血行不畅，可导致闭经，痛经，月经先后不定期，月经量少，不孕等；肝郁化火，迫血妄行，又可引起月经先期、月经量多、崩漏等症。

三、饮食劳倦 饮食不节，过食辛辣刺激等食物，因而脾胃积热，热扰冲任，迫血妄行，每可引起月经过多，月经先期和崩漏；如过食生冷，又可导致经闭，痛经。

劳倦，是泛指一些虚损证的致病因素。在经期、孕期、产褥期，宜注意身体调护。如过度的体力劳动和剧烈的运动，会耗伤气血，变生诸疾。若过度安逸，则脏腑功能减弱，气血运行不畅，也不利于身体的康复。

早婚、多产、房室不节，则耗伤肾气，精血两亏，均可发生经、带、胎、产诸病。

第二节 病 机

一、气血失调 《灵枢·五音五味》说：“妇人之生，有余于气，不足于血，以其数脱血也。”说明由于妇女在经、孕、产、哺乳期易耗血，使机体常处于血分不足，气分偏盛的病理状态。然气血失调时，气虚、血热、血瘀等，在妇科病机中也占有相当重要的地位。

气与血相互依存，相互资生，血为气之母，气为血之帅，伤于血必及于气，伤于气亦必及于血。血病则气不能独化，气病则血不能畅行。故临床常见气血同病，气血两虚，

气滞血淤等。在气血同病时，有的以气病为主，有的以血病为主。血病为主的，如外感热邪与血相搏，热迫血妄行，血不循常道，可引起月经先期、月经过多、崩漏、经行吐衄、流产等；寒与血相搏，血见寒则凝滞，血流不畅，可引起痛经、经闭、经行后期、产后腹痛，甚至症瘕积聚等；湿邪重着，易于下注，若湿热结合则为湿热，可引起赤白带下，阴痒、阴肿及不孕等；若湿与寒并则为寒湿，可致痛经、经闭、带下等。气病为主的，因伤于气者必及于血，气逆则血上，可引起经行吐衄；气陷则血下，气虚则血脱，可引起月经先期、月经量多、崩漏、坠胎等；气滞则血淤，可引起痛经、经闭、症瘕等；气乱则血乱，可引起月经不调，先后无定期等。可见，妇女虽以血为本，但赖气生，又赖气行，气与血又有如此密不可分的关系，故气血失调是产生妇科疾病的重要机理之一。

二、脏腑功能失调 妇女以血为本，而血的化生，皆依赖于脏腑的调和。脏腑功能正常，气顺血和，冲盛任通，体健经调就不会生病。若正气不足，则七情六淫等病因，均可引起脏腑功能失调，导致经、带、胎、产诸病。如肝气不疏则肝郁，可致月经不调、痛经；若偏气滞，多为经行腹胀或月经先后不定期；若偏血滞，可致痛经、经闭；如饮食劳倦或忧思伤脾，生化之源不足，血海不能按时满盈，可引起月经后期、月经过少、经闭；或脾气虚衰不能统血，血随气陷，可致月经过多或崩漏；如肾气不足，冲任不固，可致胎动不安、堕胎、不孕、经行先后不定期等；肾阴亏损，则精亏血

少，可致月经后期、月经过少、经闭、不孕等；肾阴不足，气化失常，冲任失于温煦，胞脉虚寒，可致带下、子肿、不孕；如因忧愁思虑伤心，使心阴暗耗，营血不足，可致月经过少、经闭、脏躁；心火偏亢，引动肾火，扰动血海，迫血妄行，可致月经过多、崩漏；如阴虚火旺，灼肺伤津，经行之时冲气上逆迫肺，损伤肺络，可致经行吐衄。

由此可知，心、肝、脾、肺、肾功能失调，均可导致妇科疾病疾患。但在脏腑功能失调中，以肾、肝、脾三脏与妇科病最为密切。因而应根据妇女不同年龄的生理特点分别重视肾、肝、脾三脏的作用。《素问·病机气宜保命集》说：

“妇人童幼天癸未行之间，皆属少阴；天癸既行，皆从厥阴论之；天癸既绝，乃属太阴经也。”说明少女时期着重在肾，中年时期着重在肝，断经之后着重在脾。因为女子在年少青春之时，肾气初盛，生殖器官发育尚未完全成熟，若感受病邪，容易伤及肾气，影响冲任二脉的通盛，而引起月经疾患。肾气之盛衰，决定着人体的生长发育，故青年女子应着重益肾。中年妇女由于经、孕、产、哺乳的生理特点，易伤于血，肝为藏血之脏，血伤则肝失所养，气遂横逆，故易发生月经不调、痛经、闭经、带下等病。同时由于肝血虚，则肝气有余，所以情绪易于激动，使肝气郁滞，发生气结、气逆、气乱等症。故中年妇女应着重养肝。老年妇女断经前后，因肾气已衰，气血皆虚，常可导致断经前后诸症。而肾气之衰，气血之虚，全赖后天水谷滋养，脾为后天之本，气血生化之源，故此时应着重健脾。

三、冲任督带损伤 《素问·骨空论》说：“任脉为病……女子带下瘕聚。冲脉为病，逆气里急。督脉为病……女子不孕。”《难经》云：“带之为病，腹满，腰溶溶如坐水中。”说明任、冲、督、带四脉与妇科疾病的关系。冲、任二脉均起于胞中，与督脉同出于会阴，带脉环腰一周，络胞而过，约束诸脉，在生理上与胞宫的关系尤为密切。故四脉发生病理变化时必然导致妇科疾病。四脉之中冲任二脉尤为重要，因冲为血海，任主胞胎，冲任受损，则血海不能按时满盈，胞胎则无所系，因而发生经、带、胎、产诸病。

导致冲、任、督、带四脉损伤的原因虽多，但总不离虚实两个方面。如受寒饮冷则血液凝滞，热邪内扰则迫血妄行，情志抑郁则气滞血淤，湿痰下注则经脉壅塞，恼怒动火则血行逆乱，劳倦气伤则血失统摄。凡此种种，都能造成气血不和，运行失常，影响冲任督带的正常生理作用，而为月经不调、痛经、崩漏、带下或流产等疾患。余如先天肾气不足，或后天脾胃亏损，也能影响冲任督带，产生经、带、胎、产等病。因此冲、任、督、带四脉的损伤，就成为导致妇科疾病的重要内在原因之一。

综上所述，可知气血失调、脏腑功能失常及冲任督带的损伤，皆可引起妇科疾病。三者虽各有不同的发病机理，但它们是相互联系和相互影响的。气血失调可导致脏腑功能失常及冲任督带的损伤；脏腑功能失常也必然导致气血失调及损伤冲任督带；而冲任督带又与肝脾肾有不可分割的关系，故四脉的损伤也会影响脏腑功能及气血失调。总之，病变不

论起于那个脏腑经络，病机反应总是整体的。因此，在探讨病机的时候，既要了解邪在哪经，病在何脏，更要探求其相互影响，才能从千变万化之中，找出病机转变的关键所在。

附，肾的研究概况

一、肾在妇科的重要地位 肾在祖国医学理论体系中是非常重要的脏，在妇科则占头等重要的地位。古医籍指出，与妇科关系最密切的是肝脾肾三脏，青年时期着重在肾，中年时期着重在肝，老年时期着重在脾。在三脏中肝脏占头等重要地位。而现今学者认为，肾在各个时期的重要地位均超过他脏。过去，医者特别重视肝郁不舒，认为肝郁不舒是妇科的主要致病因素。这与社会因素是有关系的。因为在旧社会妇女处在社会的最底层，深受封建礼教思想的统治和束缚，因而肝郁这一因素自然显得格外突出。如今社会不同了，新中国的妇女已获得了彻底解放，她们在各行各业中具有与男子同等的地位和权力，因而，肝郁因素随着时代的变化已大为减少。肾在妇女生理、病理各方面的重要性应占首位。虽妇科病种类繁多，变化各异，然而详其病因，则知经、带、胎、产及杂病等无不与肾有密切关系，如月经先期、月经后期、月经先后不定期、月经过少、经闭、居经、避年、崩漏、痛经、激经、带下病、流产、子肿、产后发热、不孕症、断经前后诸症、子宫脱垂等等，均可因肾虚而致。根据异病同治的道理，熟练地掌握补肾法，可以治疗多

种妇科疾病。足见肾在妇科中的地位之重要。

二、肾的实验研究 以往对肾的研究，一般仅限于临床观察的方式，1960年上海第一医学院脏象专题组开始对肾进行了专题研究，近年来全国许多单位从多方面进行研究，取得了更大成就。一致认为，祖国医学中的肾，包括了现代医学的神经系统、内分泌系统、生殖系统、泌尿系统及免疫系统。

§二

研究者探索了异病同治的物质基础，在按辨证施治原则治疗的多种疾病中，发现在现代医学中全然不同的六种疾病（神经衰弱、支气管哮喘、无排卵型功能性子宫出血、妊娠中毒症、冠状动脉粥样硬化症、红斑性狼疮），当发展到某一阶段时，都可以用补肾调整阴阳的方法而提高疗效。说明了这几种病有共同的基本病机——肾虚，也说明了“久病及肾”的道理是正确的。

一般认为肾中水火的关系，可以用阴阳的关系来概括。因五脏六腑之阳都由肾阳来温养，说明肾也是各脏腑的调节中心。联系现代医学中神经系统对机体的调节作用来研究肾虚的奥秘，发现只要符合肾阳虚的见证，其24小时尿17羟皮质类固醇含量普遍低于正常值。这就为诊断肾虚提供了精确的客观指标，为中医诊断走向客观化、标准化、规范化迈出了可喜的一步。在实验治疗中也发现，随着阴阳症状的转化，尿17羟皮质类固醇的含量也随之转化。研究者以阴阳互根这一现实为基础，采取阴阳并补法与育阴涵阳法为主的治法，当阳虚偏重型与阴虚偏重型有阴阳转化症状出现时，尿

17羟皮质类固醇值也有相应的转化，及至按阴阳互根观点用药后，尿17羟皮质类固醇值又恢复正常。这就充分证明了肾虚与尿17羟皮质类固醇值的固定关系。

用红细胞糖酵解与氧化强度为标准的实验发现，肾阴虚组较正常人组显著增高，肾阳虚组较正常人组显著降低。而经用补肾调整阴阳的药物治疗1个半月后，两组都趋于正常值。因为红细胞糖酵解减弱，反应机体生热效应减弱，可以说明阳虚生寒的道理。红细胞糖酵解增强，反应机体生热效应加强，可以说明阴虚生热的道理。

采用促肾上腺皮质激素（ACTH）静脉点滴试验发现，肾阳虚的病人半数有延迟反应，提示肾阳虚的病人有垂体——肾上腺皮质系统兴奋性低下，并且用于两个已知垂体——肾上腺皮质系统兴奋性低下的病种中，虽然肾阳虚的症状并不明显，但用补肾阳的方法治疗获得了满意的效果。这说明肾阳虚的病人垂体——肾上腺皮质系统兴奋性是低下的。

有人用肾虚患者甲皱微循环的改变进行研究，发现肾阳虚患者的甲皱微循环管袢数目开放较少，管袢内血流速度减慢。以此可以说明肾阳虚的客观证据。而这种异常改变又可以通过补肾益气的治疗而消失。

近几年来，许多人从临床各科的角度出发，对肾虚的各种表现进行了系统研究。

神经系统：在高血压、慢性痢疾患者中，肾阳虚型的大脑皮质兴奋性降低，脑电图 α 波频率较快，波幅较低，对声

和光刺激反应潜伏期较长,持续时间短,运动从属时值表明皮层运动分析器有抑制过程。服用补阳药物后有明显好转。

内分泌系统:在肾阳虚患者尸检中发现,垂体、肾上腺皮质、卵巢、甲状腺、睾丸皆呈退行性变。

免疫方面:现已证明肾阳虚者细胞免疫或体液免疫都是低下的。T细胞平均值显著低于正常人,用补阳药可使低值回升正常,同时细胞免疫得以改善。

生殖系统:我们在临床实践中也发现,经闭、不孕有肾阳虚表现的患者,阴道细胞涂片,显示卵巢功能低下,青年患者有的生殖器官发育不良。

另外,在心血管系统、血液系统、消化系统、泌尿系统以及物质代谢方面,都有些新的研究,因与妇科关系不大,故不赘述。

第五章 诊法概要

妇科疾病诊断，也和内科一样，需要通过问、望、闻、切四诊。但由于妇女在生理、病理方面都有其特点，故在诊断上也有其特异之处。因此，本章仅就有关经、带、胎、产等方面的诊断方法，作扼要的叙述。

第一节 问 诊

问诊是诊断疾病的重要方法之一，是作出正确诊断的必不可少的第一步。要确诊一个疾病，首先必须了解它的全部情况，辨证才有充分的根据，何况很多症候都是患者的自觉症状，必须通过问诊，才易于洞察病情。兹将问诊的方法、内容和步骤分述于下：

一、问诊的方法及注意事项 在问诊时，医生必须有充分的耐心、同情心及责任感，态度要和蔼。要使病人毫无保留地、毫无顾虑地据实叙说。这样，得到的病史才真实可靠，有参考价值。有时病人对医生十分信赖，把从未告人的秘密（如性机能异常）告诉了医生，医生应予以保守秘密，这是医生的职责。

有的病人在陈述病史时杂乱无章，轻重颠倒，医生要抓

住重点，深入追询。对病人所提出的病名，应进一步将主要病情的特点询问清楚，记录时可冠以引号。最后将病人的陈述按轻重先后加以整理，提纲挈领，按时间顺序编写系统、简要而科学的病史记录。

二、问年龄 年龄是初诊时首先要询问的，由于不同年龄的妇女其生理状态亦有所不同，因而在发病上亦有差异。有些疾病多发于青年，如痛经、月经先后无定期；有些病则多发于中年，如肝郁、崩漏，带下等；有些病又多见于老年，如经断前后诸证及肿瘤等；所以询问患者年龄在诊断上具有重要意义。

三、问月经 首先问初潮年龄和初潮后的月经情况，包括月经周期、经期天数、血量多少、经色、经质、有无血块，行经时有无痛处等；现在经期是否准确，每次持续几天，有无先期或后期，经量的多少，质的稠粘或清稀，有无特殊臭味，以及行经时有无腰、腹、胸、胁、乳房疼痛，以及最后1次月经的日期等。

如初潮年龄过迟，周期不定，量少，色淡，常为肾气未充，冲任不盛；或脾胃亏损，气血生化不足所致。

月经先期，量多，色深红或紫，时夹血块，面红，喜凉畏热，大多属热；月经后期，量少，色黯红或淡，喜热畏凉，或小腹冷痛得热减轻，大都属寒。月经量多或日久不止，色红或紫，腰腹胀痛，头昏口干，多属血热；如血似黑豆汁，喜热畏凉，四肢清冷，小腹冷痛，喜得热按，多为虚寒。如行经时小腹冷痛拒按，大都属实；隐痛而喜按，大都

属虚。经将行而腹先痛属气滞；经行后而腹作痛属血虚。行经期胀甚于痛为气滞，痛甚于胀为血瘀。

停经数月，面色苍白或青黄，头目眩晕，饮食减少，心悸气短，或腰腹胀痛，甚则形体消瘦，皮肤干燥，多为血虚经闭。

如停经2个月左右，嗜酸作呕，头昏头痛，倦怠嗜睡，不欲饮食，多为妊娠早期。停经4个月以上，腹部渐大，自觉有物微动，乳头色黑，乳房发胀，为妊娠中期。

如受孕后而按月行经为“盛胎”，不时下血为“胎漏”。

四、问带下 带下是妇女常有的现象。若平时津津常润，白带不多，仅在月经中期、经前或孕期，带下略多，无臭味，无不适，则属生理现象，不是病态。如带下过多，或色、质、味异常，则为病态，且可变生他疾。因此，在问诊方面除询问月经情况外，还要问有无带下以及带下的颜色、多少、清浊、有无臭气、阴痒等。必要时应结合化验检查，才能做出明确诊断。

如带下量多色白，精神不振，胃纳不佳，多属脾虚湿注；如带下质稀如水，腰痛如折，小腹冷感，小便清长，则为肾虚；如赤白杂下，淋漓不断，微有臭气，多属肝经湿热。如带下量多、质稀、色黄绿，呈泡沫状，多为滴虫感染；若带下如豆腐渣状，伴有外阴、阴道作痒或疼痛，多为霉菌感染；若五色带下，秽臭异常，多为肿瘤或杂菌感染。凡带下色白而清稀，其气腥臭，多为虚证、寒证；色黄或赤，稠粘臭秽，多为实证、热证。

五、问妊娠 诊断妇科疾病，除了问月经、带下之外，还要询问患者是否已婚。如已婚，应进一步询问有无生育史，生过几胎，有无小产、人工流产，以往分娩情况是否正常，现在有无胎动下血、头晕目眩、肢体浮肿等。如孕育之后，经常腰部酸胀，以及受孕而屡次堕胎、小产者，早期多见于肾虚（子宫发育不良或内分泌不足），中期多见于气虚（子宫颈功能不全等）。如婚久不孕，可能为生殖器官发育不良或有其他缺陷，又多为肾气亏损或肝郁气滞所致。如怀孕而胎动下血，应防流产。有孕而按月行经为“激经”。妊娠期有头晕目眩、肢体浮肿者，应预防子痫证的发生。

六、问产后 应问分娩情况是否正常，产时流血多少，恶露多少，颜色红淡，有无臭气，以及小腹有无胀痛，大便是否通畅等，如产时艰难，或流血过多，多属气血两虚之证。如恶露过多，颜色鲜红而有臭气，多属血热；如量少有块，小腹痛而拒按，多属瘀滞（如子宫复旧不良、胎盘残留、感染等）。如大便于涩难下，又常是津液不足之象。

七、问前后二阴 在了解经、带、胎、产之后，还应询问前阴和后阴有无特殊感觉。如妊娠常感前后阴坠胀，腰部酸胀，此为肾虚，多主小产。妊娠早期，子宫增大而将膀胱向上推移，及妊娠晚期胎儿压迫膀胱，皆可引起尿频现象，产后可自愈。如小便滞涩，胀急而痛，倚息不得卧，为小便不通，多属气虚或胎儿下压膀胱。如怀孕而小便频数，淋漓涩痛，为妊娠淋证，多属虚热。产后自觉阴道坠胀，或有物坠出阴道外，为子宫脱垂，多属气虚。外阴及阴道瘙痒疼痛，为

阴痒，属湿热下注。

八、问旧病 除了解现在病情外，要进一步询问过去曾患何种疾病，以便分析病者气血的盛衰，体质的强弱，结合现在病帮助诊断。

九、问生活、职业、嗜好及家庭情况 了解生活、职业、嗜好及家庭情况，对分析病情亦有参考价值。如久居湿地，或在水湿地区作业，常为寒湿所侵，易患带下及痛经。如在经期、产后冒雨涉水，或过食生冷，血为寒滞，易患痛经、经闭。喜食辛辣香燥之物，容易引起血热，而致月经不调、经行吐衄、便血等病。如家庭不和，易致肝郁气滞，发生月经不调、痛经、经闭、不孕或流产。如性生活频繁，或在经期、产后交合，易致肾气亏损，产生经乱、崩漏、带下等病。这些都是在临证时必须询问清楚的。

通过以上月经、带下、妊娠、产后以及二阴、旧病、生活、职业等问诊所收集的资料中，可以了解患者气血的盛衰、身体的强弱，这对分析病情的寒、热、虚、实有很大帮助。

第二节 望 诊

“有诸内必形诸外”，说明人体内部的病变多在外部有所表现。望诊就是通过对病人有目的的观察，从而获得与疾病有关的辨证资料的方法。

妇科望诊，除观察病人的神色、形态、唇色、舌质、舌

苔外，还应注意观察经血、带下和恶露的 量、色、质的变化。

一、望神色 神色是人体生命的总体现，是先天和后天精气的反映。脏腑气血功能正常，人则有神（“气血者，人之神也”）。反之，精衰则体弱，体弱则神疲。通过病人神色的变化，可测知疾病的轻重预后。“有神”者病情轻，预后良好。“无神”者病情重，预后差。故《灵枢·天年》说：“失神者死，得神者生。”

二、望面色 《四诊决微》说：“夫气由脏发，色随气华。”故面部气色与脏腑气血的盛衰有密切关系。如面色青而紫暗，多属瘀血停滞，常见于痛经、闭经、症瘕等；面色黑而晦黯，为肾气虚衰，多见于闭经、不孕、带下等；面色苍白，多属血虚，常见于月经后期、月经过少、经闭等；面色㿠白（面色虚浮而光白）而体胖，多属气虚挟痰，可见于月经先期、月经量多、带下、不孕等；若面色白而两颧发红，多为阴虚火旺，可见于阴虚血热之经闭等。

三、望唇色 唇色红紫为血热，鲜红为阴虚火旺，常见于月经先期、月经过多和崩漏等；唇色淡白或淡红，为脾虚血亏，可见于崩漏、经闭等；唇色青而淡者，为阳虚有寒，青而深者，为寒凝血瘀，多见于月经后期、痛经、经闭、带下、不孕、症瘕等。

四、望舌色 包括舌质与舌苔 舌质色红为血热，多见于月经先期、月经过多和崩漏等；舌质淡红为血虚，多见于月经后期、月经过少、经闭和久崩久漏之征。舌质淡白不荣，

舌体胖嫩者，多为气血两虚，可见于崩漏日久或经闭不行；舌质色紫黯或有瘀点，为血瘀之征，可见于痛经、经闭、症瘕、死胎不下等。

舌苔黄主热，薄黄为微热，黄厚为热盛，黄厚而腻为湿热；苔薄白而燥为伤津，薄白而润为寒滞，苔白而腻为痰湿；苔黑而润为阳虚有寒，苔黑而燥为火炽津枯；黑苔常为血瘀之征。

五、望月经 如经色紫红，多属血热；经色淡红，多为气虚；经色紫黯，多属瘀滞；经质粘稠，多为血热；经质稀薄，多属虚寒；血块多者，多为血瘀；经量过多，多属血热或气虚；经量过少，多为血虚或肾虚；经量时多时少，多属气郁。

六、望带下 带下色白，多属脾湿；带下色黄，多属湿热；带下色赤，多属血热或热毒；带下清稀，多属脾虚肾虚；带质粘稠，多属湿热蕴结。

七、望恶露 如恶露量多、色淡红、质稀、无臭味者，多属气虚；恶露色红或紫、粘稠而有臭味者，多属血热；恶露色紫黑且有块者，多属血瘀。

此外，乳头及乳晕色黑者，为有孕。

第三节 闻 诊

闻诊是医生运用听觉和嗅觉来辨别病人的异常声音和异常气味的一种诊断方法。包括闻声音和嗅气味两个方面。

经、带、恶露之气味在问诊中虽已提及，此乃患者主诉，而医生在检查时所嗅到的气味，就更为可靠，应予以注意。

一、闻声音 从病人的声音变化可以辨别外感内伤和寒热虚实的病情。如懒言而语音低微者，多为虚证或寒证；语音洪亮，或神昏谵语者，多为实证热证；声低而细为气虚；时时叹息为气郁；妊娠后期声音低哑，甚至不能出声，为妊娠失音；分娩时不断呵欠，为脱血夺气（如子宫破裂后，即出现呵欠）。

二、闻气味 行经之时，其气臭秽者为热，其气腥臭者为寒；崩漏或杂带下并有奇臭（恶臭）者，多见于败脓或肿瘤；带下气臭秽者为湿热，气腥者为虚寒；妊娠恶阻时，若口有烂苹果味为酸中毒；妊娠后胎不动，腹不长，口有臭味，可为胎死腹中。产后恶露发臭，体温升高而腹痛者为产后感染。

第四节 切 诊

切诊包括脉诊和触诊两部分。脉诊是诊察病人的脉搏变化；触诊是对病人的胸腹、手足、肌肤及其他部位的触摸按压。切诊是获得辨证资料的重要依据。

一、脉诊 几千年来，祖国医学经过不断的 研究 和 发展，从临床实践中积累了极其丰富的脉诊理论和经验，兹概述如下：

妇人之脉，一般较弱于男子，略沉而细，其状柔软，尺

脉较盛，右大于左，此为正常脉象。

（一）月经脉：月经将至或正值经期，无口苦、身热、腹胀等现象，而左手脉洪大于右手，或两寸浮数，两关脉弦，为经期正常脉象。如脉见洪大滑数有力者，为冲任伏热，多见于月经过多、月经先期。如六脉沉迟，为阳虚内寒，生化失常，血海不足，多见于月经后期或量少。如脉细而数，为血热伤津，阴亏血少之征，可见于血枯经闭。如尺脉微涩，多为血虚经闭。尺脉滑，多为血实经闭。崩中下血脉宜虚大弦数，反见浮洪而急，漏下不止，脉宜小虚缓弱，反见大紧数实，均为反常现象，表示病情严重。

（二）带下脉：带下量多，色黄，脉弦数者，多见于湿热下注。若带下量多，色白，脉见缓滑者，多为脾虚湿盛，带下质稀，清冷，腰痛如折，脉沉迟微弱，尺脉尤甚者，属肾阳虚衰。

（三）妊娠脉：滑、数、动为常见之妊娠脉象，身体素弱的妇女，月经停闭，尺脉按之不绝者，亦为有孕。然以滑数脉最为常见。

也有身虽有病（指经闭、呕吐）而无病脉（有经闭、呕吐等，但脉仍正常），以及身虽无病而有病脉（指脉虽滑动而无心悸，脉虽滑数而无发热）。以上两者，应考虑为妊娠。

如怀孕之后，六脉沉细短涩，或两尺脉弱，而又继续不匀，多为气血虚弱，应防堕胎小产。

（四）临产脉：足月妊娠，尺脉转急如切绳、转珠或脉象浮散乱，为临产脉象。若孕妇两手中指本节至顶节两

侧，有脉搏应手乱动，同时阵阵腹痛下坠者，即是临产之兆。

（五）产后脉：产后气血多虚，脉见虚缓和平，为正常现象。产后出血不止，且多日不减，反见脉滑而数，为阴虚未复，虚阳上泛，或外感实邪之征。

二、触诊 触诊，是现代医学常用的诊断方法，用于妇科检查，更有助于作出较正确的诊断。

（一）腹诊：腹诊是辅助脉诊之不足而进行的腹部按压及妇科内诊检查的方法，对妇科诊断尤为重要。通过腹部触诊，可以了解腹胀、腹痛、包块的部位、性质，进一步辨别虚、实、寒、热在气或在血，有利于治疗。如腹痛喜按者，多属虚证；腹痛拒按者，多属实证；寒证者，多喜暖；热证者，多恶热。并结合疼痛部位、发生原因，参考全身症状作出诊断。又如对包块检查时，腹诊触知有形有质，拒按触痛，固定不移者，为血结、卵巢肿痛或子宫肌瘤，是谓之症；若有形积结，触之不硬，推之可移，按之可散或时聚时散者，为气聚，是谓之瘕；症与瘕是血结与气聚，不能等同相观。若停经3个月，在下腹正中触到包块，多为妊娠。若停经6个月，则可查清胎位，触到大、圆、硬有浮动感的为胎头，大、圆、不硬无浮动感的为胎臀，宽大平坦的为胎背，小、多数能动的为肢体。同时通过触诊，还可发现有无腹水。

（二）体表诊：若头面四肢肿胀，按之凹陷不起者，为水肿；若身面浮肿，随按随起者，为气肿。

（三）内诊：是对已婚妇女，为弥补腹部触诊之不足，可采取的特殊检查方法。

1.双合诊：以一只戴有乳胶手套的中、食二指进入阴道，另一手置于腹部进行联合检查，以了解下述情况：阴道松紧度及深度，阴道壁是否光滑，有无结节、肿物（部位、大小）。后穹窿是否饱满。宫颈的大小、位置、硬度 表面情况，活动性及有无抬举痛，子宫的位置、大小、形状、硬度、表面情况，活动性及有无压痛。附件区（输卵管及卵巢）有无压痛及肿物。如有肿物，注意其部位、大小、形状、硬度（囊性或实质性）、表面情况及活动性，有无压痛，肿物与周围组织的关系。

2.三合诊：为帮助双合诊，进一步了解子宫后方及宫旁组织等情况选用的诊查方法，即食指进入阴道，中指伸入肛门直肠，另一手置于下腹部互相配合检查。

3.窥器检查：为直观检查方法，以了解阴道颜色和有无炎症、溃疡、糜烂、肿物；宫颈大小、形状，有无溃疡、糜烂、息肉、癌肿及其部位、范围大小，宫口形状，有无分泌物等。

须指出，检查时，态度要严肃认真。检查前让病员排空小便，以免膀胱充盈妨碍检查，造成误诊；月经期如无特殊情况，一般不作阴道检查。阴道出血患者，必须检查时，应注意无菌消毒，以防感染。未婚妇女，应作肛诊（间接腹部联合检查）；遇有检查不满意，必须进行阴道检查或窥器检查时，须事先征得家长及本人同意。

第六章 治法概要

妇科疾病的治疗方法，也和其他各科疾病一样，必须根据“治病必求于本”的原则，运用四诊八纲，查明病因病机，分清寒、热、虚、实，进行辨证论治。再结合气候、环境、饮食、起居、性情等情况，然后确定治疗方法。但由于妇女的生理特点与男子不同，在辨证论治中，遣方用药，又与男子有别。因此，在临证治疗中，应根据妇女在不同阶段的生理、病理特点，运用补肾填精、疏肝养肝、健脾和胃、补气养血等法则，调整全身机能，恢复机体健康。

第一节 补肾填精

肾为先天之本，元气之根，藏真阴而寓元阳，为水火之脏，是人体生长、发育、生殖的根源。它在天癸的产生和冲任二脉的通盛方面，起着极其重要的作用。妇女肾气盛，天癸至，任脉通，太冲脉盛，才能有行经和孕育的正常功能。若肾阳不足、或肾阳亏虚、或阴阳两虚。皆可使天癸不足，冲任失调，导致经带胎产诸病。

肾主藏精，而多虚证，只宜固秘，不宜泄露，所以肾多虚证。因此，补肾气也是治疗妇科疾病中的一种重要法则。尤

其在青春期肾气未充之际，更为必要。至于具体方法，肾阳不足者，宜温肾助阳；肾阴亏损者，宜滋肾养阴；阴阳两虚者，则阴阳双补。总之，只能补其不足，不能伐其有余。

此外，因肝为肾之子，赖肾水以滋养。肝肾同司下焦，肝藏血，肾藏精，肝肾同源，精血相生。肝肾又为冲任之本，肝肾有病可以影响冲、任，冲任受损亦可涉及肝肾。一般常见的经闭、不孕、崩漏、带下、滑胎等，大都由肝肾虚弱，冲任受损所引起。故治法应以滋补肝肾为主，并根据具体情况，辨证施治，分别处理。养肝肾即是益冲任之源，源充则流自畅，疾病自可全愈。

第二节 疏肝养肝

肝主藏血，又司全身筋骨关节之屈伸，体阴而用阳，其性刚强，喜调达而恶抑郁，凡精神情志之调节功能，最与肝气有密切关系。若肝气和平，情志舒畅，则气血通调，血海宁静，周身之血亦随之而安。如因忧郁愤怒，损伤肝气，可致肝气郁结不得疏泄，郁而化火，火动则阳失潜藏，引起肝阳上亢，阳亢则内风自生，风火相煽，上升颠顶，或横窜经络，以致血不归脏，随气火而并走于上，形成肝阳妄动之实证；继之伤及肾阴，肾阴亏乏，精不化血，肝失濡养，则成肝阴不足、虚阳上扰的虚证。故在妇科疾病中，多见胸肋胀满，乳房胀痛，少腹疼痛，眩晕，头痛，或耳鸣耳聋，震颤等症者，就是这一机理（中年妇女为多）。因此，在治则上，以

疏肝理气，柔肝养阴为主。其具体方法，郁结者疏之、泄之，上逆者抑之、平之，阳亢者柔之、缓之，阴亏者滋之、养之。总宜使肝气冲和，阴阳平调为要。

第三节 健脾和胃

脾与胃互为表里。胃主受纳，腐熟水谷，脾主运化，输布水谷精微，为气血生化之源，五脏六腑，四肢百骸，皆赖以濡养。脾又具有统血、主肌肉四肢等重要生理功能。故合称脾胃。为“后天之本”。而冲脉又隶属于阳明。若妇女谷气盛则血海满而经候如期，胎孕正常。如脾胃失调，生化之源不足，就可发生月经、胎孕诸病。在这种情况下，健脾和胃，资其化源，则病自愈。至于调理的方法，仍须根据不同病情，采用虚者补之，实者泻之，寒者温之，热者清之的原则辨证施治。即使病邪未伤脾胃，用药亦须注意，不宜过用滋腻克伐之品，以免损伤脾胃正气，影响消化功能。尤其妇女在绝经以后，肾气渐虚，全赖后天水谷以滋养，此时健脾和胃就更为重要。

第四节 调和气血

气和血，是人体生命活动的动力和源泉，它既是脏腑功能的反映，又是脏腑活动的产物，人体病理变化无不涉及气血。然妇女以血为主，故对妇科疾病的治疗着重在血。但气

为血帅，血随气行，无论何种因素，只要影响气和血，就会使气血失调而引起疾病，所以治疗应以调和气血为要务。如气血协调，任通冲盛，则经、带、胎、产诸病自可痊愈。至于调理的方法，首先要根据临床症状辨清在气在血，然后确定治法。如病在气分，则以治气为主，治血为辅。如气逆的降气顺气，气郁的开郁行气，气乱的调气理气，气寒的温阳扶气，气热的泄热清气，气虚气陷的升阳益气，并佐以活血、补血之药。病在血分的以治血为主，佐以治气。如血寒宜温，血热宜清，血虚宜补，血滞宜通，并佐以理气、行气或补气之品。这是调理气血的一般原则。如因失血过多而引起虚脱者，此时“有形之血不能速生，无形之气所当急固”，则应补气固脱为急务；兼四肢厥逆脉微者，佐以助阳。气复阳回，方始脱险，如舍气顾血，则缓不济急。

此外，在采用温补、清补、滋补、行气、逐瘀等法时，应随时注意气血的调匀，用药不宜过于滋腻或耗散，以免滞气滞血或伤气伤血。

第七章 预防保健

《素问·四气调神大论》谓：“圣人不治已病治未病，不治已乱治未乱，此之谓也。夫病已成而后药之，乱已成而后治之，譬犹渴而穿井，斗而铸锥，不亦晚乎！”这与现今以“预防为主”的思想是一致的。因此，要做好保健工作，必须防患于未然。由于妇女有经、孕、产、乳等特点，所以四期（经期、孕期、产褥期、哺乳期）的卫生调护就更为重要。对于妇女卫生知识的宣传，应当引起高度的重视，做到无病先防，有病早治，以减少妇科疾病的发生，保障妇女的身体健康。

第一节 经期卫生

《妇人大全良方》云：“若遇经行，最宜谨慎，苟能调摄得宜，则经应以时矣。”说明自宋代始，祖国医学即强调经期卫生的重要性。因为行经期间，正气偏虚，血室正开，邪气易侵，而罹疾患。“虚邪贼风，避之有时”，故经期卫生不容忽视。

一、心情舒畅 经行之时，肝血偏虚，肝气偏盛，情感容易激动，应自我控制，勿过于悲伤恼怒。若肝气不舒，气

血逆乱，即可引起月经失调。

二、劳逸适度 经期可以从事日常的工作、学习和劳动。超负荷的体力劳动或运动，易耗气动血，可引起经期延长和月经过多。现代医学认为，从事一般的体力劳动，不但无害反而有利，因为适当的体力劳动可以促进盆腔的血液循环，使血液流畅，从而减轻腰酸背痛及下腹部坠胀感。而过重的体力劳动和剧烈的体育运动则使盆腔过度充血，引起月经过多，经期延长及腹痛腰酸等。此外，还应保证充足的睡眠，使精神饱满，情绪稳定。

三、调节饮食 经期不宜过食辛辣温燥的食物和饮料，以免血中蕴热，热迫血行。亦不宜过食生冷寒凉之品，以免血为寒凝，血行不畅。

四、注意寒温 经期宜保温暖，避风寒。如冒雨涉水或冷水洗浴，可导致寒凝血滞，月经不调。

五、保持清洁 保持外阴清洁，非常重要。月经带及内衣要勤加换洗，纸垫或布垫要洁净、柔软，易于吸水。经期可以淋浴，但不宜盆浴、池浴和坐浴，以免邪毒入侵。

六、避免房事 正值经期，合之非宜。强行交合，毒邪侵袭胞宫，可引起出血量多、经期延长、腰酸背痛，甚至感染发烧，导致盆腔炎症。

第二节 孕期保健

孕期保健，古人已包含了“胎教”的内容。两千多年前

刘向（公元前79～前8年）在《列女传》中说：“古者妇人妊子，寝不侧，坐不边，立不跂，不食邪味，割不正不食，席不正不坐，目不视邪色，耳不听淫声。夜则令瞽诵诗道正事，如此则生子形容端正，才过人矣。”这是说，妊娠之后行为要规矩，作风要正派，不看黄色书籍，不听靡靡之声，晚上安静的诵念诗歌，这样，胎儿出生后，则体健貌美，才智过人。作者在书中并举例以教后人：“太任（周文王之母）……及其有身，目不视恶色，耳不听淫声，口不出傲言，能以胎教子，而生文王。”这些都属于最早的胎教内容。

北齐名医徐之才提出“逐月养胎法”，使孕期卫生保健增加了更多的内容。如“饮食精熟”、“羹宜鱼雁”、“其羹牛羊”，说明了孕期要给予丰富的营养食物；“身欲微劳，无得静处，出游于野”，是说孕期应从事一般日常劳动，并常外出散步；“劳身摇肢，无使定止，动作屈伸，以运血气。”说明适当的运动有利于气血的运行；“厚其衣服”、“缓带自持”，即衣服要保暖，而且宽大可体；“卧必晏起”，要有充足的睡眠；“朝吸天光”，要呼吸些新鲜空气；“沐浴洗衣”，常沐浴和洗换衣服，讲究清洁卫生；“男子勿劳”，应限制性交。今天看来，这些论述都是非常符合科学道理的。

隋·巢元方的《诸病源候论》认为，妊娠三个月“形象始化，未有定仪”，“见物而变”。若想使孩儿“美好端正”、“多智有力”、“贤良圣德”，就要多看“白璧美玉”，“端心正座，清虚和一，坐无邪席，立无偏倚，行无

邪径，目无邪视，耳无邪听，口无邪言，心无邪念。无妄喜怒，无得思虑。”说明孕期要创造优美舒适的环境，行为端正，勿胡思乱想，保持心情舒畅，精神愉快。

宋·陈自明在《妇人良方》中有专篇论述保健，内容详尽，清代医家对保健尤为重视。兹结合现代内容归纳如下。

一、勿乱服药 《便产须知》说：“勿乱服药”，“勿妄针灸”。强调孕期服药要慎重，无病者不宜服药“养胎”，因有病则病当之，无病则体当之。需服药时，选药配方，应予审慎。

二、饮食调养 宜食清淡富有营养而又容易消化的食物，慎用干硬和刺激性较强的食物，忌大饥大饱，戒吸烟饮酒，以保持脾胃调和，大便通畅。

三、起居有常 环境要舒适，生活有规律，外避风寒，内调七情，心情舒畅，精神愉快。

四、劳逸适度 不宜提拿重物及攀高涉险，以免伤胎。睡眠要充足，但又不宜过于贪睡，以免气滞难产。

五、杜绝房事 房劳损肾，耗伤胎元，易致堕胎和小产。正如《大科经纶》说：“妇人觉有妊，男即不宜与接，若无忌，主半产。”现代医学认为，妊娠头8个月，性交易致流产，后8个月性交易致早产，且易引起产后感染。

六、衣着合体 衣服要宽大、轻松、柔软、合体，且勿紧胸束腰，以免影响气血运行，有碍胎儿成长。勿用较紧的乳罩，以免影响乳房发育，或造成乳头内陷。

七、清洁卫生 保持皮肤及外阴清洁，应经常洗澡，但

以淋浴为宜。

八、乳头护理 妊娠7个月后，应经常用温开水擦洗乳头，以保持清洁，并可预防哺乳时乳头皲裂。如乳头内陷，则应经常用手将其牵引（或用吸引法吸出），以利于产后吮乳。

九、定期检查 妊娠6个月以前每月检查1次；从第7个月起每2周检查1次，最后1个月应每周检查1次，发现异常及时纠正。

附：现代医学对胎教的研究

孕期保健包括胎教的某些内容，但就其涵义来讲不尽相同。胎教的理论认为，母亲的品德行为能够影响胎儿，故母亲对于女的教育应从胎儿时期开始。而孕期保健则不应包含这个内容。

胎教的作用，已经逐渐被国内外学者所肯定。人的智慧是由大脑所决定的，而胎儿脑的发育则受到孕妇各种条件的影响。当受精卵生长1个月时，神经管开始形成，这根神经管对直接或间接的刺激能够产生反应。妊娠第2个月出现大脑的雏形，此时脑细胞发育迅速，对于从母体传来的影响比较敏感，良好的刺激（如愉快的心情及丰富的营养条件等）有利于脑细胞的分裂繁殖。而恶性刺激对胎儿脑的发育会产生不良影响。妊娠4、5个月时，大脑的形象已基本形成。

7个月时，脑的发育基本定型。7个月后，脑的体积逐渐增大，沟回进一步加深加宽。故孕期让孕妇心情舒畅，多想些

美好的情境，多听些悦耳的声音，读些有益于身心健康的诗词歌赋，陶冶情操，以良好的心理状态去“教育胎儿”能促使胎儿脑细胞的健康发育。

国外医学家几十年的实验研究证明，光线、声音以及母亲的情绪和动作都能对胎儿产生影响。例如科学家们对孕妇进行子宫内窥镜镜检查发现，胎儿眼睛能够随着送入的光线活动。触动胎儿的足底，足趾即活动，同时膝、髋关节屈曲，触动胎儿的手心，手指会紧握。用多普勒测定仪监测时发现，不同的音响使胎儿的心跳次数有改变。这一现象说明，声音可以传入胎儿的耳朵，通过神经反射引起心跳加快。刚出生的婴儿在哭闹不安时，把他（她）的耳朵贴在母亲胸前的心脏部位，婴儿就会安静下来。科学家们认为这是由于婴儿听到了在胎里听惯了的声音。根据这个现象，有人把母亲的心音录下来，放给婴幼儿听，以使其入睡。比利时医生给100个孕妇进行试验，在她们头部通上12个电极连在1个电子设备上，观察到在孕妇开始做梦的同时，8个月的胎儿与母亲有共同的特点：身体也一动不动，眼珠迅速转动。

以上实验说明，母亲的思想情操，喜怒哀乐，生活条件，环境变化等，都可对胎儿产生影响。有人认为，如果在胎里给胎儿多听些悦耳、动听、舒畅、轻柔的声音，孩子的性格都可能温顺、恬静。相反，如果胎儿常听到狂言乱语或无休止的噪音，就会刺激胎儿的神经，产生不良后果。宋朝陈自明所说的“胎教产图之书，不可谓之遇而不加信。”是有科学道理的。今后，随着科学的发展，胎教的研究必然会取

得新的成果。

第三节 临产调护

妊娠足月而产是正常的生理现象。《便产须知》说：“盖产自有时，如果熟香飘，瓜熟蒂落是也。”妇人临产之时，不必恐怖和惊疑。应谨守《达生篇》睡、忍痛、慢临盆的六字要诀。此六字诀对于精神比较紧张的妇女尤为适用，以免过早用力耗气，造成滞产。《妇人良方》说：“妊娠至临月，当安神定虑，时时步履，不可多睡饱食。”说明临近产期不可过度安逸，以免气滞而致难产。《妇人良方》还指出：“欲产时，不可多人喧哄惶惶。”是说产房应保持安静，切忌喧哗，或切切私议，使产妇精神不安，引起难产。唐·孙思邈强调说：“凡欲产时，特忌多人瞻视，惟得三、二人在旁，待产讫乃可告语诸人也，若人众看之，无不难产。”

在中西医结合的今天，应推广新法接生，严格消毒，预防感染。

此外，前人强调临产时服用催生之剂，以助顺产。张景岳却谓：“凡妊娠胎元充足，弥月而产，熟落有期，非可催推也。所谓催者，亦不过助其气血利导之耳。……若期未至而妄用行气导血等剂以为催生，亦犹摘方苞之萼，捩宋人之苗耳。”诚哉斯言，苟勿妄施。

第四节 产后调养

由于分娩之时耗气伤血，故产后气血俱虚（古人称“产后百节空虚”），正气不足，邪气易侵，稍有不慎，则易致病。而且产后患病多重危难疗。正是“犯时微若秋毫，成病重如山岳。”（《妇人良方》）然而，若“产妇将息如法，脏腑调和，庶无诸疾苦。”（《妇人良方》）足见产后调养尤为重要。

一、谨避风寒 《金匱要略》曰：“新产血虚多汗出，喜中风。”故新产之后，居室宜避风寒（但应保持空气流通），衣着被褥以保暖为宜。夏季亦不可过于食凉及当风坐卧，以免寒邪侵袭而感冒。然而炎热之夏也不可紧闭门户，以防中暑。

二、切勿过劳 产后身体虚弱，不宜过早或过度劳动，否则，气虚下陷，易致子宫脱垂。

三、饮食调养 产后脾胃虚弱，饮食应清淡而富于营养，勿食生冷及肥腻食物，尤忌辛辣，以免损伤脾胃，影响乳汁，或滞血、动血等。

四、心情舒畅 精神要愉快，心情要舒畅，切忌暴怒或忧思，以免气逆血滞，引起胸胁腹痛。

五、清洁卫生 新产之后，血室未复，易感外邪（引起产褥感染），故外阴清洁十分重要，宜常用温水洗涤，衣着亦宜勤加洗换。同时注意乳房的清洁，哺乳之前应用温水洗

净孔大，若乳头皲裂应涂以油膏。

六、节制房事 《千金方》说：“凡产后满百日，方可交合，不尔，至死虚羸，百病滋长，慎之。”现代医学主张产褥期（产后6～8周）之内，应绝对避免性交。

各 论

第一章 月经病

月经病是妇科最常见的疾病，它几乎占妇科门诊量的一半。月经病不仅影响妇女的身体健康，而且影响生育，应积极进行防治。

月经病的临床表现是多种多样的，但归纳起来不外经期、周期、经量、经色、经质的改变，以及经期和行经前后所出现的症状等。临床常见的有月经不调、痛经、崩漏、经闭、经行吐衄、经行发热、经行泄泻、经行便血、经前紧张症、经绝前后诸症等，都是本章所要叙述的范围。至于在经期中或行经前，出现轻微的小腹胀满，腰酸体倦，胃纳欠佳，乳房稍感发胀，以及性情急躁等，经行过后，都会自然消失，不须治疗。在月经初潮时，往往周期不太规律，或停闭3~5个月，如无其他特殊症状出现，短期内也能恢复正常。

月经病的致病因素是多方面的，外感以寒、热、湿为主；内伤以忧、思、怒、多产及房室不节居多。这些诱因是在机体正气不足，气血失调，冲任受损的情况下，才能导致

月经疾病。

治疗月经病应根据辨证论治的原则，重在调经以治本。如果因为身体有其他病而导致的月经病，当先治他病，病去则月经自调；反之，因月经而引起他病者，当先调经，经调则他病自愈。至于调经常用的方法有调气、扶脾、补肾等。理气在于通调气机，以开郁行气为主，但不宜过用香燥之品，以免耗伤气血；扶脾为益血之源，以健脾升阳为主，不宜过用甘润或辛温，反致损伤脾阳或脾阴；补肾在于益先天之真气，以填精补血，但又必须结合养火之品，使水充火足，精血俱旺，则月经自调。

为了预防本病的发生，平素应注意参加劳动锻炼，增强体质；经期应注意卫生，避免房事、过劳、着凉、过食辛辣及精神刺激；切实做好计划生育，避免多妊、多产，注意产后卫生保健。

第一节 月经不调

《妇科玉尺》说：“经贵乎如期，若来时或前或后，或多或少，或月二、三至，或数月一至，皆为不调。”本书所述内容，包括月经先期、月经后期、月经先后不定期、月经过多、月经过少等。对月经不调，应作妇科检查，排除生殖器官器质性病变及妊娠并发病，以确定诊断。

月经先期

月经周期提前7天以上，甚至1月两潮者，称为“月经先期”，也叫“经期赶前”、“经行先期”、“经早”等。如周期仅提前3、5天，并无其他不适感觉，属于正常范围。如偶尔提前1次者，亦不作病论。

【病因病机】 引起本病的主要原因是血热气虚所致。血热则迫血妄行，气虚则冲任不固。

(一)血热：多由平素内热蕴结，或感受热邪，或过食辛辣，过服暖宫药物，或阴虚阳盛，使机体阳气偏亢，火热太盛，或情志不舒，使肝气内郁，肝郁化火等影响冲任失调，迫血妄行，以致经血先期而来。

(二)气虚：素体虚弱，或劳倦过度，饮食失调，或忧思伤脾，使脾气虚衰，冲任不固，血失统摄，导致月经先期而下。

【辨证施治】 凡经量多、色紫而质稠者为实热；经量少、色红、质稠者为阴虚挟热；量或多或少、色或红或紫，兼有胸闷肋痛，小腹作胀为肝郁化火，经量多、色淡清稀的为气虚。

本病的治疗以清热、补虚为主要大法。但清热不宜用大苦大寒之物，以防寒凝滞血；补虚须佐理气之品，以免骤补滞气。另外，在一般经血排出不利时，亦或兼挟瘀块，如无特殊不适，则不同于血瘀滞气，宜活血不宜破血。

（一）实热先期：

1. 临床表现：月经超前，量多，色深红或紫，稠粘有臭味；心烦口渴，大便干，小便黄。舌红，苔薄黄，脉滑数有力。

2. 主证分析：内热炽盛，血得热则妄行，故月经超前而量多，血为热灼，故经色红或紫，质稠粘有臭味；邪热扰心则心烦不安；内热伤津则口渴便干溲黄。舌红，苔薄黄，脉滑数有力，均为内有实热之征。

3. 治疗法则：凉血清热。

4. 处方用药：清经汤（《傅青主女科》）加减。

生地黄、益母草各15克，当归、白芍、青蒿、黄芩、丹皮、茯苓各9克，黄柏3克。水煎2次分服。

按：本方是清经汤去熟地、赤芍、地骨皮，加青蒿、当归、益母草。

方中生地凉血，当归、白芍养血敛阴，青蒿、丹皮、黄芩、黄柏清热泻火凉血，茯苓宁心，益母草活血化瘀。诸药相合，具有凉血活血之作用。本方运用活血药的目的，是避免使用凉血药时易引起血行不畅之弊，尤其在月经期不宜使用凉血药的情况下，投用本方可无此顾虑。

如口渴舌干便燥甚者，可加麦冬、玄参各9克，以增滋阴生津之效。

（二）虚热先期：

1. 临床表现：月经先期，量少，色红，两颧潮红，午后发热，五心烦热，盗汗，咽干不欲饮。舌红，无苔，脉细数。

无力。

2.主证分析：阴虚生内热，热灼津血，故月经先期而量少，色红；阴虚不能恋阳，阳浮于外，故两颧潮红；热伏阴分，故午后发热，五心烦热；阴虚火动，逼津外泄，故盗汗出，咽干而不欲饮。舌红，无苔，脉细数无力，均为阴虚内热之象。

3.治疗法则：滋阴清热。

4.处方用药：两地汤（《傅青主女科》）加味。

生地黄30克，麦冬、玄参、地骨皮、益母草各12克，银柴胡、青蒿、白薇、白芍、阿胶（烔化）各9克。水煎2次分服。

按：本方是两地汤加银柴胡、青蒿、白薇、益母草。

方中重用生地合麦冬、玄参凉血滋阴以生水；地骨皮、银柴胡、白薇凉血以清虚热；白芍敛阴以收浮阳；阿胶养血；益母草化瘀以防凉滞。全方虽属清热之剂，但多为滋水之药，可使阴生阳敛，泄热而不伤津。

（三）郁热先期：

1.临床表现：月经提前，经量时多时少，色红或紫，或有瘀块；经前乳房、两胁和小腹胀痛，烦躁易怒。舌红，苔薄黄，脉弦数。

2.主证分析：肝郁化热，热迫血行，故经行先期，血色紫红；肝郁气机不畅，冲任失调，则经量时多时少，或排泄不爽，挟有瘀块；气滞于肝经，故见乳房、胸胁、小腹胀痛，肝郁热盛则烦躁易怒。舌红，苔黄，脉弦数，均为肝郁

化热之征。

3. 治疗法则：疏肝解郁清热。

4. 处方用药：丹栀逍遥散（《医统》）加味。

丹皮、焦栀子、柴胡、当归、白术、茯苓、茜草炭各9克，炒白芍12克，薄荷1.5克，煨姜1片，生甘草3克。水煎2次分服。

按：本方是丹栀逍遥散加茜草。

方中柴胡疏肝理气解郁，当归、白芍养血和营以柔肝；“见肝之病，知肝传脾，必先实脾”，故用茯苓、白术、煨姜、甘草健脾和中，丹皮、栀子清热泻火，栀子、茜草炒炭应用，可起止血作用；佐薄荷一味，协同柴胡条达肝气。对于肝郁化火，血虚脾弱引起的月经超前，颇为适合。

若头晕、耳鸣者，白芍加倍用量；胸痞暖气者去白术，加青皮6克；经量少而有血块者，加益母草、泽兰各12克；潮热者加青蒿9克，鳖甲12克。

（四）气虚先期：

1. 临床表现：经期超前，量多，质薄，色淡；面色皖白，精神倦怠，身体怕冷，言语无力，头目眩晕，心悸气短，腰腿酸软。舌质淡红，或虚白胖大，苔薄润，脉虚弱无力。

2. 主证分析：身体素虚，或久病气虚，气虚则统摄无权，冲任因而不固，引起月经超前，色淡质稀；气虚则血亦虚，心血不足，不华于面，故面色虚浮而白；气血不足，不荣于脑，故头晕目眩；心血不足，脾气虚弱，故精神倦怠，

语言无力，心悸气短，腰腿酸软；气虚导致阳虚，则身体怕冷。舌质淡或胖大，苔薄润，脉软弱无力，俱是气虚不支之象。

3. 治疗法则：补气养血。

4. 处方用药：补气固经丸（《沈氏尊生书》）合当归补血汤（《内外辨惑论》）。

党参15克，炙黄芪18~24克，炒白术、茯苓各9克，当归、炙甘草各6克，砂仁3克。水煎2次分服。

方中党参、白术、茯苓、炙甘草健脾益气；合黄芪辅参术大补脾肺之气，以资生化之源；配当归补血和营，生血之力相得益彰；佐砂仁开胃理气，以防呆滞。合用则阳生阴长，经血自调。本方对于经期超前，或崩漏不止，因于气虚不能摄血者，都很有效。

（五）脾虚先期：

1. 临床表现：经期超前，量多色淡；面色苍黄，皮肤浮肿，头晕神疲。心悸怔忡，体倦乏力，口淡无味，纳减。舌苔白腻，脉象虚细或细涩。

2. 主证分析：思虑过度，劳伤心脾，心藏血，脾统血，脾虚失统，血液妄行，故经期超前而量多；血虚失荣，故面色苍黄，头晕神疲；心血亏损，故心悸怔忡；脾主四肢，虚则健运迟滞，故体倦乏力，胃减无味。舌苔白腻，脉虚细，均乃心脾两虚之征。

3. 治疗法则：健脾养心，益气补血。

4. 处方用药：归脾汤（《济生方》）。

党参、炙黄芪15克，炒白术、茯苓、当归、桂圆肉各

9克，炒枣仁12克，远志6克，木香8克，炙甘草4.5克，生姜2片，大枣3枚（劈）。水煎2次分服。

方中参、术、苓、草健脾益气，辅黄芪以增强益气之效；枣仁、桂圆肉、远志补心益脾，安神定志；当归滋补阴血，木香行气醒脾，二物既理血中之滞，又助参芪补气，气壮脾强，则能摄血统血，使以姜枣和胃进食。综合本方的作用，是属气血双补，心脾同治，故为经期超前以及崩漏下血常用之剂。

月经后期

凡月经周期延后7天以上者，称为“月经后期”，亦称“经期错后”或“经迟”。若偶尔1次月经延后，下次仍如期来潮者，不作后期论。

【病因病机】 本病的发生，主要是营血不足，或气血运行受阻，因而月经后期。临床上常见的病因有血寒、血虚、阴虚、血瘀、气滞与痰阻。

（一）血寒：经行之际过食生冷，或冒雨涉水，感受寒凉，寒邪乘虚客于胞宫。血为寒凝，经脉不通，是为寒实后期。如禀赋素弱，阳气素虚，寒自内生，寒则血凝，而影响脏腑气化功能，使血的生成减缓，以致冲任血虚，血海不能按时满盈，月事不能应期来潮，是为虚寒后期。

（二）血虚：体质素虚，或大病久病之后，或产乳过多，伤耗津血，或大量出血，或长期慢性出血，以致气虚血

亏；或脾虚不能运化，导致冲任血虚，血海不足，故月经延期而来。

（三）阴虚：素体阴虚内热，热灼津液，以致水亏血少，月经后期而至。

（四）气滞：情志不舒，气机郁滞，气滞则血行不畅，冲任受阻，血海不能按时满盈，月经因而后期。

（五）血瘀：瘀血内蓄，形成症积，阻碍血行，故经行后期。

（六）痰阻：《坤元是保》说：“妇人肥胖，经或二、三月一行者，痰气盛而脂脂闭塞经脉也。”经脉为痰湿所阻，故月经后期而至。

【辨证施治】 月经后期，一般分为血寒，血虚，阴虚，气滞，血瘀，痰阻，而血寒又有虚实之分。经色暗红而量少，小腹绞痛有块，属实寒；经色淡而量少，质清稀，腹痛绵绵，属虚寒；经色淡红而量少，小腹空痛属血虚；经色正常而量少，小腹作痛且胀属气滞；经色淡粘而多，属痰阻。治疗可分别应用温经散寒、养血益气、行气开郁、祛瘀行滞等法。

（一）实寒后期：

1. 临床表现：经行后期，色暗红而量少，有块，小腹绞痛，得热痛减；面色苍白，形寒肢冷，舌淡苔薄白，脉沉紧。

2. 主证分析：多因经期及产褥期，感受寒邪，血寒则凝滞，血行不畅，故经行后期，量少，色暗而有块，小腹绞痛

得热则减，面色苍白，形寒肢冷，苔薄白，均为寒邪在里之象，脉沉为在里，紧为寒束，寒搏于内故脉沉紧。

3. 治疗法则：温经散寒。

4. 处方用药：温经汤（《金匮要略》）。

吴茱萸、肉桂、川芎各6克，党参12克，当归、芍药、丹皮、麦冬、阿胶（烔化）、半夏各9克，炙甘草8克。水煎2次分服。

方中吴茱萸、肉桂温经散寒；当归、芍药、阿胶补血养阴；川芎、丹皮活血祛瘀；寒邪在里，必损脾气，故以党参、半夏、甘草益气和胃，以资生化之源；麦冬甘润以防辛热化燥。诸药合用，有温通经脉，养血祛瘀作用，可使血得温则行，血行则瘀去，瘀去则新生，而经自调矣。

如血量过多，加艾叶炭12克；腹痛拒按，挟有血块，加生蒲黄、炒五灵脂各9克；四肢厥冷者加熟附子6克。

（二）虚寒后期：

1. 临床表现：经行后期，色暗红量少不爽，腹痛绵绵，喜暖喜按；面色㿔白或萎黄，头晕气短，腰酸乏力，怕凉喜热，四肢厥冷，或口鼻气冷，或大便溏薄。舌质淡，苔薄白，脉沉迟而微。

2. 主证分析：阳气不足，阴寒内生，阳虚不能温煦胞宫，冲任失调，气虚血亏，故月经延后，量少不爽，色暗，腹痛绵绵，喜暖喜按；头为诸阳之会，阳虚不能上荣，则面色㿔白或萎黄，头目眩晕；阳虚气弱，故气短，口鼻气冷；腰为肾之府，肾阳不足，故腰酸乏力；脾肾阳虚，故怕冷喜

热，四肢厥冷，大便溏薄，舌淡苔薄，脉沉迟而微，为阳虚不能鼓动血行所致。

3. 治疗法则：温经扶阳，佐以养血。

4. 处方用药：大营煎（《景岳全书》）加味。

熟地30克，当归15克，党参、枸杞、杜仲各12克，炒白术、怀牛膝各9克，肉桂、附子、炙甘草各6克。水煎2次分服。

按：本方是大营煎加党参、白术、附子。

方中熟地、当归补血养血；枸杞、杜仲补肝肾，强筋骨；怀牛膝既通且补；附子、肉桂扶阳散寒；党参、白术、甘草健脾和中益气。

如腰痛重者加续断12克，桑寄生30克；子宫小者加紫石英15～30克。

如属慢性疾患，久病缓图，可服艾附暖宫丸（《寿世保元》）

艾叶、当归各90克，制香附180克，吴茱萸、川芎、白芍、黄芪各60克，续断45克，生地黄30克，肉桂15克。共研细末，而糊打丸，梧子大。每次6克，日服3次，空腹淡醋汤或温开水送下。适于子宫虚寒不孕，月经不调，肚腹时痛，胸膈服闷，体倦食减，腰酸带下等症。

（三）血虚后期：

1. 临床表现：月经延后，量少而色淡，小腹空痛，面色苍白或萎黄，身体瘦弱，皮肤不润，头晕，眼花，心悸。舌质淡红无苔，脉象虚细。

2.主证分析：由于久病或亡血，营血亏耗，血海不能按时满盈，故月经后期，量少色淡；血虚胞脉失养，故小腹空痛；血虚不能内充经脉，外润皮肤，故身体瘦弱，面色萎黄，皮肤不润；血虚不能上荣于脑则头晕，不能养肝则眼花，不能养心则心悸，不荣于舌则舌淡而无苔，不充于脉故脉虚而细。

3.治疗法则：补血益气。

4.处方用药：人参养荣汤；（《太平和剂局方》）

党参、炙黄芪各15克，熟地18克，当归、白术、茯苓各12克，白芍、五味子各9克，肉桂4.5克，远志、陈皮、炙甘草各6克，生姜3片，大枣4枚（劈）。水煎2次外服。

方中熟地、当归、芍药养血；党参、黄芪、白术、茯苓、炙甘草补气，气生则血生；远志补肾以达于心，肉桂导诸药入营生血，五味子补肺，肺主气以运血；陈皮、姜枣以和胃。

此外，用八珍汤（《正体类要》）加香附、葛根，陈皮治血虚后期，效亦显著。

熟地、党参各15克，葛根12克，当归、炒白芍、炒白术、茯苓、制香附各9克，川芎、陈皮、炙甘草各6克，红枣4枚，生姜3片。水煎2次分服。

为了巩固疗效，十全大补丸（《医学发明》）可以常服。熟地、炙黄芪、党参各150克，当归、炒白芍、炒白术、茯苓各90克，川芎、肉桂、炙甘草各60克。共研细末，炼蜜为丸，每丸重9克。每次2丸，日服2次，生姜、红枣煎汤

或温开水送下。

（四）阴虚后期：

1.临床表现：月经后期，经色深红量少，质稠而粘；颜面潮红，口干欲饮，心烦。舌红，苔微黄而燥，脉细数。

2.主证分析：水亏热炽，经血损耗，故经色深红而质稠，经期延迟；素体阴虚，阴虚则火炎，故颜面潮红；火热灼烁津液，则口干欲饮；水亏血少，水火不能相济，故心烦。舌红苔黄，脉细数，乃阴虚热盛之征。

3.治疗法则：滋阴清热，佐以行滞。

4.处方用药：一阴煎（《景岳全书》）加味。

生地黄30克，熟地黄18克，丹参15克，白芍12克，麦冬、知母、地骨皮、牛膝各9克，生甘草3克。水煎2次分服。

按：本方是一阴煎加知母、地骨皮。

方中熟地、生地、白芍养阴清热；麦冬、知母、地骨皮甘寒生津，润燥泻火；丹参、牛膝活血通经；甘草调和诸药。

（五）气滞后期：

1.临床表现：月经后期，量少，色正常，小腹胀痛，精神郁闷，胸痞不舒，乳胀胁痛。舌质黯红，苔正常或薄黄，脉弦涩。

2.主证分析：忧思愤怒则伤肝，以致肝气郁滞，气滞血亦滞，血行不畅，故月经后期，量少，少腹胀痛，肝气以疏达为顺，气郁不宣，故胸闷不舒，乳胀胁痛。舌黯红，苔薄黄，脉弦涩，均为气滞之象。

3. 治疗法则：舒肝行气开郁。

4. 处方用药：逍遥散（《太平和剂局方》）加味。

柴胡、当归、白芍、炒白术、香附、乌药、郁金各9克，茯苓12克，炙甘草4.5克，薄荷1.5克，煨姜2片。水煎2次分服。

按：本方是逍遥散加香附、乌药、郁金。

方中柴胡、香附、乌药、郁金四味相配，以加强疏肝行气解郁之力；当归、白芍养血和营以柔肝；茯苓、白术、甘草、煨姜健脾和中，以资化源；佐以薄荷协同柴胡调达肝气。肝气调达，经血通畅，则经自调。

此外，柴胡四物汤加香附、郁金、丹皮，以舒解肝脾郁结，治气滞月经后期亦有效。

常服成药，可用七制香附丸。

（六）血瘀后期：

1. 临床表现：经行后期，少腹胀痛，按之更甚，经色紫黑有块，块下即觉痛减。舌质紫黯，脉象细涩。

2. 主证分析：“痛甚于胀者谓之血，胀甚于痛者谓之气。”今瘀血内蓄，血滞气亦滞，故少腹胀痛，按之更甚；瘀血随经水下排，故经色紫黑有块，块下瘀去，因之痛减。舌质紫黯，脉细涩，均瘀血内聚之征。

3. 治疗法则：活血祛瘀。

4. 处方用药：轻者用过期饮，瘀重体实者用抵当汤加味。

（1）过期饮（《济阴纲目》）。

熟地12克，当归、赤芍、炒桃仁、红花、香附、莪术各9克，川芎6克，肉桂4.5克，木通、甘草各1克。水煎2次分服。

本方为四物汤加味所组成。四物汤具有补血活血作用，但将方中补血养阴的白芍换为活血祛瘀的赤芍，再加入桃仁、红花、莪术，则使全方突出了活血化瘀的作用。由于血滞气亦滞，故配香附以调气；肉桂、木通寒热相伍，以温通血行；甘草调和诸药。共奏活血化瘀兼以理气之效。

若瘀血而发热者，可加丹皮、山梔各9克。

常服成药，益母草膏（见赤白带下）。

（2）抵挡汤（《伤寒论》）加味。

虻虫、水蛭、川芎各6克，生大黄、桃仁、当归、红花各9克。水煎2次分服。

按：本方是抵挡汤加当归、川芎、红花。

本方是攻逐瘀血的重剂。方中虻虫、水蛭破血症，化积聚，都是攻逐瘀血的峻药；又配桃仁、红花活血行瘀；大黄荡涤热邪，导瘀下行；当归养血，以防过于伤血，添此一味，虽寓补于破，但仍属攻逐猛剂，故非体质强实者，不可浪投。

七、痰阻后期：

1.临床表现：月经后期，甚或数月一行，色淡而粘，带下多而色白，身体肥胖，胸闷，脘胀，食少，痰多，精神疲倦，心悸气短，口中淡腻。舌苔白腻，脉滑。

2.主证分析：脂肪闭塞胞宫，故经血色淡而粘，带下绵

绵；痰湿壅阻气机，则胸闷脘胀；痰湿聚于脾胃，则食少痰多；痰湿凌心，则心悸气短，精神疲倦。苔腻脉滑亦痰湿内阻之征。

3. 治疗法则：祛痰行滞。

4. 处方用药：启宫丸（《医方集解》）加味。

炒白术、制苍术、半夏、制香附各9克，炒神曲12克，茯苓30克，橘红、远志、川芎、炙甘草各6克。水煎2次分服。

按：本方是启宫丸加苍术、远志。

方中二术、半夏、橘红燥湿除痰，香附、神曲理气消滞，川芎散瘀活血，则壅者通，塞者启矣。茯苓、甘草亦以去湿和中，助其生气。加远志以祛痰宁神。

兼血虚者，可用芎归二陈汤（丹溪方）以养血健脾燥湿。

当归12克，茯苓30克，半夏、陈皮各9克，川芎、甘草各6克。水煎2次分服。

平时伴有消化不良，大便溏薄者，加白术、扁豆各12克。

月经先后无定期

月经不按周期来潮，或先或后，称为“月经先后无定期”，又称“经乱”。

【病因病机】导致本病的主要原因是肝气郁结，气血失

调，损伤冲任，或瘀血留滞等。临床以肝郁、脾虚、肾虚、瘀血为多见。

（一）肝郁：肝司血海而主疏泄，喜条达，若愤怒伤肝，精神抑郁，则使肝气逆乱，致血海蓄溢失常而经来无定。

（二）脾虚：脾统血，脾气虚弱，健运失常，以致气血失调，则月经周期紊乱。

（三）肾虚：素体肾气不足，或房事不节，或孕育过多，损伤冲任，以致肾失闭藏，血海蓄溢失常，则经期前后参差。

（四）瘀血：瘀血阻滞，可使月经后期，若瘀血不去，而新血不得归经，亦可使经期超前。

【辨证施治】一般以经量或多或少，无块，色质如常，小腹胀连胸胁，属肝郁；经量多色淡，胃呆便溏，属脾虚；经量少，色淡质清，少腹空坠，腰痛者，属肾虚；经来乍多乍少，色紫黯有块，小腹痛者，属瘀血。

本证治法以调理气血为主，不可过用香燥或滋腻之品，以防耗气滞血。

（一）肝郁经行先后无定期：

1. 临床表现：经行或先或后，行而不畅，经前或经刚来时小腹胀痛，连及胸胁，胸痞不舒，乳房胀痛，时欲叹息。舌苔薄白，脉弦。

2. 主证分析：郁怒伤肝，气乱则血乱，血海蓄溢失常，故月经先后无定期，情志不舒，气机郁滞，则经血来而不畅，肝脉布两胁，故经前或经来小腹胀痛，引及两胁；肝气

郁阻胸阳，故胸痞不舒，叹气能舒达肝气，故时欲叹息；病无寒热，则舌苔正常。脉弦乃肝气郁滞之象。

3. 治疗法则：舒肝解郁，和血调经。

4. 处方用药：逍遥散（《和剂局方》）。

北柴胡、当归、白芍、炒白术各9克，茯苓12克，生甘草3克，煨姜2片，薄荷1.5克。水煎2次分服。

方中柴胡疏肝解郁；当归、白芍养血平肝；茯苓、白术、甘草和中健脾；佐煨姜、薄荷之辛散协柴胡以增强疏肝作用。

若经来腹痛挟有瘀块者，加泽兰、炒桃仁各12克。有热者去煨姜加丹皮、栀子各9克。

常服成药。可用逍遥丸，每次6克，日服2次，温开水送下。

（二）脾虚月经先后无定期：

1. 临床表现：经行或先或后，经色淡红，量多，面色萎黄，精神倦怠，四肢无力，或身面浮肿，头晕心悸，口淡乏味，大便溏薄。舌淡苔白腻，脉象迟缓无力。

2. 主证分析：脾主运化，主统血，为气血生化之源，脾虚水谷不化，气血失调，统摄无权，冲任不固，故经行或先或后，色淡红而量多；脾虚血少，不能上荣于面，故面色萎黄；脾主肌肉、四肢，为“后天之本”，脾失健运，肌肉失养，清阳不布，故精神倦怠，四肢无力，身面浮肿；脾虚生化之源不足，不能上奉于头，心亦失养，故头晕心悸，脾开窍于口，脾失健运则口淡乏味，大便溏薄。舌淡，苔白腻，

脉缓无力，皆脾虚之象。

3. 治疗法则：补气健脾，和胃渗湿。

4. 处方用药：参苓白术散（《和剂局方》）。

党参、薏仁各15克，炒白术9克，茯苓、莲子、扁豆各12克，炒山药30克，桔梗、甘草各6克，砂仁3克。水煎2次分服。

本方是参术苓草四君子汤加味组成。四君子汤补气健脾；辅扁豆、山药、薏仁、莲子以加强补脾渗湿的作用；加陈皮以和胃，砂仁以醒脾，桔梗以宣肺，三者配伍则调畅气机，以防大队补药之呆滞，这样就大大增强了四君子汤的补益作用，并加强了健脾渗湿、行气和胃的作用。补其虚，除其湿，调其气，行其滞，则月经自调。

若舌苔厚腻，脘闷泛哕者，加藿香、佩兰各9克。

（三）肾虚经行先后无定期：

1. 临床表现：经期或前或后，量少色淡，质清稀；面色晦黯，头晕耳鸣，腰酸膝软，小腹空坠，夜尿频。舌质淡，苔薄白，脉沉弱。此型往往生殖器官及第二性征发育欠佳。

2. 主证分析：肾气不足，冲任失调，胞宫蓄溢失常，以致经行无定期；肾藏精，五脏精气均上荣于面，肾虚则面色晦黯；肾阴虚则经血量少；肾阳虚则经色淡而清稀；肾主骨生髓通于脑，开窍于耳，脑为髓海，肾虚则髓海不足，清窍不利，故头晕、耳鸣；腰为肾之府，小腹为胞宫所居之地，而胞脉又系于肾，肾虚则腰酸膝软，小腹空坠；肾司二阴，肾虚则不能制约，故夜间尿频。舌淡苔薄，脉沉弱，均为肾

阳不足，精血亏虚之象。

3. 治疗法则：补肾气，调冲任。

4. 处方用药：定经汤（《傅青主女科》）加味。

熟地24克，炒山药、菟丝子、补骨脂、当归、白芍、茯苓、续断、紫石英各12克，淫羊藿9克，柴胡6克，芥穗炭3克。水煎2次分服。

按：本方是定经汤加补骨脂、淫羊藿、紫石英、续断。

方中熟地，山药补肾阴；菟丝子益阴而固阳；当归、白芍养肝补血；茯苓健脾利湿；续断补肝肾，强腰膝，活经络，补而能通，行而不泄；紫石英、淫羊藿以温肾阳；芥穗炭止血化瘀，柴胡疏肝升阳，二味皆具疏发条达之性；以免峻补之剂滞气留血。

（四）血瘀经行先后无定期；

1. 临床表现：经来时先时后，乍多乍少，色紫黯有块，少腹疼痛拒按；舌黯红或有瘀血点，脉弦或涩。

2. 主证分析：瘀血停留，胞脉受阻，滞而不畅，故月经来潮无定期，其量乍多乍少；热灼经血，瘀滞凝聚，故色紫有块；瘀血停滞，经脉不通，故少腹拒按；舌黯红有瘀点，脉弦或涩，皆瘀血之征。

3. 治疗法则：活血祛瘀。

4. 处方用药：桃红四物汤（《医宗金鉴》）。

炒桃仁、草红花、赤芍、当归各9克，生地15克，川芎6克。水煎2次分服。

本方为四物汤加桃仁、红花所组成，适于偏热血瘀之

证。四物汤具有补血活血作用，但将方中补血养阴的白芍换为活血祛瘀的赤芍，将补血滋阴的熟地改为凉血消瘀的生地，则使原方的补血作用，转变为侧重于活血凉血为主。再加入活血祛瘀的桃仁、红花为主药，则使全方突出了活血化瘀的作用。由于桃仁、红花的活血作用比较平稳，再与四物汤配合，则成为一首比较平和有效的活血祛瘀剂。瘀血去净，月经自然正常。

若血热不明显，或兼血虚者，方中生地、赤芍仍改为熟地、白芍。若淤热较甚心烦掌热者，可加丹皮、山梔各9克。若经前腹痛，经行不畅块多者，可加炒五灵脂、生蒲黄各9克。若经前腹胀者，可加制香附9克。

常用成药，益母草膏，每次1汤匙，日3次，开水冲兑服。

月经过多

月经周期不变，而经量及持续时间超过正常范围者，即为“月经过多”。经量过多常与月经先期合并出现。

【病因病机】月经过多的主要原因，是气虚和血热所致。血热则迫血妄行，流溢失常；气虚则摄纳无权，血随气陷。两者均可出现月经量多。

（一）气虚：素体虚弱，或久病体虚，或忧思伤脾，中气不足，统摄无权，冲任不固，血随气陷，以致月经过多。

（二）血热：素体阳盛，或过食辛辣温燥之品，或情志抑郁，郁而化火，或外邪化热，热伤冲任，迫血妄行，而致

经血过多。

【辨证施治】一般经血量多而色淡，质稀，气短懒言者，属气虚；经血量多色红，质稠有块，而赤心烦，为血热。前者宜补气摄血，后者当清热凉血。凡血热量多，在经期用药时加入马齿苋、坤草炭均能缩短经期、减少出血量。因为马齿苋和坤草均有较强的促使子宫收缩的作用，服后由于子宫收缩增强，使子宫内膜脱落迅速、小血管闭塞，所以经期缩短出血量少。有人报道，马齿苋的促宫缩作用超过麦角，因而一切子宫出血用之皆效。

（一）气虚月经过多：

1.临床表现：月经量多，或过期不止，色淡而清稀如水，无块；面色㿔白，气短懒言，心悸怔忡，形寒畏冷，小腹空坠，肢软无力，舌质淡红。苔薄白而润，脉象缓弱。

2.主证分析：气虚下陷，冲任不固，故经血量多或过期不止；气为阳，气虚则阳气不足，不能化血为赤，故经血色淡而质稀如水；气虚下陷，阳气不布，故气短懒言，形寒畏冷，小腹空坠，肢软无力；出血过多；心失所养，故心悸怔忡。面色㿔白，舌质淡，苔薄白而润，脉缓弱，均为气虚之征。

3.治疗法则：补气摄血，升阳举陷。

4.处方用药：举元煎（《景岳全书》）加味。

炙黄芪30克，党参15克，乌贼骨12克，炒白术、阿胶（烔化）、艾叶炭、升麻各9克，炙甘草6克。水煎2次分服。

按：本方是举元煎加乌贼骨、阿胶、艾炭。

方中党参、黄芪、白术、炙草补脾益气，升麻升阳举陷；加阿胶、艾叶、乌贼骨以育阴暖宫而摄血。

经量过多可加益母草炭、仙鹤草各15克，促使子宫收缩，缩短经期，减少血量。

常用成药：补中益气丸，每次6克，日2~3次，温开水送下。

（二）血热月经过多：

1.临床表现：经来量多或逾期不止，色深红或紫而粘稠，间有小血块，腰腹胀痛，心烦口渴，面红唇干，小便短黄，大便干结。舌红，苔黄，脉象滑数有力。

2.主证分析：气火偏盛，热伤冲任，迫血妄行，故月经量多或过期不止；血为热灼则色紫红而粘稠。间有小血块；热迫血壅气滞，故腰腹胀痛；心烦口渴，面红唇干，大便干，小便黄，均为热盛伤津所致。舌红，苔黄，脉滑有力，乃为热邪内盛之象。

3.治疗法则：凉血固经。

4.处方用药：先期汤（《济阴纲目》）加减。

生地15克，当归、白芍、知母、阿胶（烊化）各9克，黄柏、黄芩各6克，川芎2.4克，艾叶、香附、甘草各8克，马齿苋30克。水煎2次分服。

按：本方是先期汤去黄连，加马齿苋。

方中知母、黄芩、黄柏清热泻火；生地、白芍凉血养阴；当归、川芎、香附活血理气止痛；阿胶、艾叶止血固

经，配马齿苋不仅加强清热凉血之力，且更增缩宫止血之效；甘草调和诸药，以防寒凉凝滞。

若无腰腹胀痛及血块者，去当归、川芎、香附，加党参9克以固气摄血。

若阴虚潮热，五心烦热，面色潮红而经量过多不止者，宜滋阴清热。用固经丸（《女科准绳》）加味。

炙龟板15克，生白芍12克，黄芩、黄柏、椿根皮各9克，制香附6克，益母草炭、马齿苋各30克。水煎2次分服。

按：本方是固经丸加益母草、马齿苋。

方中龟板、白芍咸酸滋阴敛阴，黄芩、黄柏苦寒泻火，共奏养阴清热凉血之效；椿皮、益母草、马齿苋苦酸涩寒固下以止血；香附辛平调气以防滞。

月经过少

月经周期正常，而经血量少，或经期持续仅1~2天，甚或点滴即净者，称为“月经过少”。常合并月经后期。又多为闭经之前驱症状。

【病因病机】本病的发病机理，有虚实两种。虚者血源不足，无余可下；实者血海受阻，经行不畅。临床常见有血虚、肾虚、血瘀三种类型。

（一）血虚：素体虚弱，或久病阴血不足，或脾虚不能运化水谷以生血，血海空虚，而致月经量少。如《万氏妇科》说：“瘦人经水来少者，责其血虚也。”

(二)肾虚：禀赋先天肾气不足，或多孕多产，或房事不节，损伤冲任，血海不充，以致月经量少。

(三)血瘀：多因邪客于胞宫，或因气滞而血瘀，冲任受阻，瘀血内停，血行不畅，故经量减少。

【辨证施治】一般以经来过少，或点滴即止，色淡质稀，小腹空坠者属血虚，经行量少，色紫黑有块，小腹胀痛拒按者，属血瘀。若月经进行性减少，且有阴虚症状，或原发性不孕症者，多为子宫内膜结核，应进一步明确诊断，并结合抗痨治疗。

此外，根据“经本于肾”的理论，在治疗血虚月经过少时，加用益肾药紫石英、枸杞子、女贞子之类可增强疗效。

(一)血虚月经过少：

1.临床表现：经色淡红量少，甚或点滴即止，面色萎黄，头晕，眼花，耳鸣，心悸，腰膝酸软，手足不温，小腹空痛，皮肤干燥不润。舌淡苔薄白，脉虚细。

2.主证分析：阴血不足，血海空虚，故月经色淡量少或点滴即止；血虚不能上荣于面，故面色萎黄；血虚不能上奏于脑，故头晕、眼花，耳鸣；血不养心，则心悸；血少不能滋养皮肤，故皮肤干燥。舌淡，苔薄白，脉虚细，均系血虚的表现。

3.治疗法则：益气补血，兼滋化源。

4.处方用药：人参滋血汤（《产宝百问》）加味。

党参、炒山药各30克，当归、白芍、茯苓、枸杞各12克，熟地18克，紫石英15克，川芎6克。水煎2次分服。

按：本方是人参滋血汤加枸杞、紫石英。

方中四物汤补营养血；党参、山药、茯苓健脾益气，以滋生化之源，气生则血长，补血之效更按；紫石英、枸杞子强心养肝滋肾，以增强补精益血之功。使精充血足，则经自调。

（二）肾虚月经过少：

1. 临床表现：经来量少，色鲜红或淡红，腰膝酸软，足跟痛，或头晕耳鸣。舌淡少津，脉沉细。

2. 主证分析：肾虚精血不足，故经来量少，色红或淡；肾主骨生髓，脑为髓之海，肾虚则髓海不足，故见头晕耳鸣，腰膝酸软，足跟痛。舌淡少津，脉沉细，均为肾虚之象。

3. 治疗法则：滋补肝肾，养血调经。

4. 处方用药：当归地黄饮（《景岳全书》）加味。

熟地24克，炒山药30克，当归、杜仲、怀牛膝、枸杞子各12克，女贞子9克，陈皮、炙甘草各6克。水煎2次服。

按：本方是当归地黄饮加女贞子、陈皮。

方中熟地、女贞子、枸杞子滋补肝肾；杜仲补肾强腰；怀牛膝既能强筋健骨，又能活血通脉；山药、陈皮、甘草健脾和胃，以顾后天，而资化源。

若伴有形寒肢冷，小腹凉痛，方中可酌加肉桂6克，菟丝子12克，以补肾助阳。

（三）血瘀月经过少：

1. 临床表现：经来量少，色紫黑有块，小腹胀痛拒按，

血块排出其痛稍减。可见舌质紫黯，或有瘀点，脉弦或涩。

2.主证分析：瘀血内停，经脉受阻，血行不畅，故经来量少有块，小腹胀痛拒按；血块排出，瘀滞稍通，故疼痛减轻。舌质黯，有瘀点，脉弦或涩，俱为瘀血阻滞之象。

3.治疗法则：活血行瘀。

4.处方用药：桃红四物汤（《医宗金鉴》）加味。

熟地18克，当归、炒白芍各12克，桃仁、红花、制香附、乌药各9克，川芎6克。水煎2次分服。

按：本方是桃红四物汤加香附、乌药。

本方适于偏气滞血瘀之证。方中四物汤养血活血，桃仁、红花祛瘀生新，香附、乌药行气止痛，使血充气行，气行则血行，而经自调。

第二节 痛 经

妇女在月经前后或经期，出现小腹及腰部疼痛，甚至剧痛难忍，影响劳动、工作和学习者，称为“痛经”，亦称“经行腹痛”。痛经是妇女常见病之一，尤以青年妇女为多见。如果仅感小腹或腰部轻微胀痛不适，这是常有的现象，不作痛经论。

近代医学把痛经分为原发性和继发性两种。月经初潮后即有疼痛，而经双合诊检查未发现盆腔器官有明显异常者，称“原发性痛经”；如盆腔生殖器官有炎症，子宫内膜异位症及肿瘤等器质性病变而痛经者，称“继发性痛经”。故在

治疗继发性痛经时，应注意辨证与辨病相结合。

【病因病机】痛经主要由于气血运行不畅所致。因经水为血所化，而血又随气运行，若气血充沛，气顺血和，则经行通畅无阻，自无疼痛之患。若气血不足，或气滞血瘀，使经行涩滞不畅，不通则痛。临床常见的有气滞血瘀，寒湿凝滞、气血虚弱、肝肾亏损等四种。

（一）气滞血瘀：多因情志不舒，肝气郁结，气机不畅，血不能随气流通，以致经血滞于胞中而作痛。

（二）寒湿瘀滞：久居潮湿之地，或因经期冒雨涉水，或过食生冷，寒湿之邪客于胞宫，血得寒则凝，以致经行不畅而作痛。

（三）气血虚弱：平素体质虚弱，气血不足，行经之后血海空虚，胞脉失养而作痛；或体虚阳气不振，不能运血，经行涩而不畅；或大病久病之后，气血两亏，冲任俱虚，运行无力而引起痛经。

（四）肝肾亏损：禀赋素弱，肝肾不足，或早婚多产，房室不节，肝肾亏损，以致精亏血少，冲任不足，经行之后胞脉愈虚，故经后小腹绵绵作痛。

【辨证施治】本病以月经周期性的小腹疼痛为主证。但必须根据疼痛的时间、部位、性质等，结合全身症状，辨别其寒、热、虚、实。一般在经前或行经期疼痛者为实，经后作痛者为虚；痛而拒按者为实，按之痛减者为虚。得热痛甚者热，得热痛减者为寒；刺痛为热，绞痛为寒。胀甚于痛者属气滞，痛甚于胀者属血瘀。疼痛部位多在下腹正中，重

者可放射至腰骶部或腹股内前侧。有时伴有恶心，呕吐及胃脘作痛等症。必要时应结合妇科检查，以进一步明确诊断。

对于痛经的治疗，一般应于经来潮前三、五天开始服药，方可取得理想效果。需持续二至三个周期，疗效方能巩固。

（一）气滞血瘀痛经：

1. 临床表现：经前或行经时小腹胀痛，拒按，行经量少，或行而不畅，经色紫黑或夹有血块，块下痛减；胸胁或乳房胀痛。舌质正常或紫黯，舌边有瘀点，苔薄，脉象沉弦或沉涩。

2. 主证分析：气滞则经行不畅，故经前或经期小腹胀痛，拒按，胸胁乳房胀痛；血瘀则量少不畅，色黯有瘀块；瘀血排出后，气血暂通，故块下痛减。舌质紫黯有瘀点，脉象沉涩，均为气滞血瘀之象。

3. 治疗法则：行气活血，祛瘀止痛。

4. 处方用药：血府逐瘀汤（《医林改错》）加减。

当归、赤芍、炒桃仁、红花、川牛膝、金铃子各9克，制香附12克，益母草15克，川芎、柴胡、枳壳、元胡索粉（2次冲）、甘草各6克。水煎2次分服。

按：本方是血府逐瘀汤去生地、桔梗，加香附、益母草、金铃子、延胡索、甘草。

本方是以桃红四物汤去地黄合四逆散加味而成。方中当归、赤芍、川芎、桃仁、红花、益母草活血祛瘀；牛膝引血下行，金铃子、元胡索疏肝理气止痛；柴胡、枳壳一升一降，二者

配伍，疏和解结，以除胸胁痞闷；香附调气消胀，以加强止痛作用；甘草和中止痛。诸药合用具有行气活血、祛瘀止痛之效，故对气滞血瘀之痛经，效果良好。

✎(二)寒湿凝滞痛经：

1.临床表现：经前或行经时小腹冷痛或绞痛，按之痛甚，得热痛减；经血量少，行而不爽，色黯夹有血块，或如黑豆汁；畏寒，便溏，甚或手足不温。舌青紫，苔白腻，脉象沉紧。

2.主证分析：寒湿之邪客于胞宫，血与寒结，冲任阻滞，经血流行不畅，故小腹冷痛或绞痛；得热则寒气散，瘀滞稍通故痛减；血得寒则凝涩，故经量少、色黯、有块；寒湿内阻，故经色不鲜，如黑豆水样；寒湿之邪易伤阳气，脾阳不振，运化失常，故畏寒便溏；阳气不能透达四肢，故手足不温。舌紫苔白腻，脉沉紧，均为寒湿内阻，气血瘀滞之象。

3.治疗法则：温经散寒，燥湿止痛。

1.处方用药：温经汤（见月经后期）去麦冬、丹皮，加制苍术9克，茯苓12克，炮姜炭8克，以增强温经祛湿的作用。

(三)气血虚弱痛经：

1.临床表现：经期或经后小腹绵绵作痛，喜温喜按，面色苍白，头晕心悸，精神倦怠，语言低微，月经量少，色淡质稀。舌淡苔薄白，脉虚细。

2.主证分析：气血虚弱，血海不足，胞脉失养，故经期

或经后小腹绵绵作痛，而喜按；血虚不能上荣于面，故面色苍白；不能营心，则心悸；气血两虚不能上奉于脑，故头晕；气血两虚，支援无依，故精神倦怠，语音低微，月经量少而色淡。舌淡苔薄白，脉虚细，亦是气血俱虚之象。

3. 治疗法则：补气养血。

处方用药：十全大补汤（《医学发明》）加味。

熟地、党参、炙黄芪各15克，当归、炒白芍、炒白术、茯苓各9克，肉桂、炙甘草各5克，延胡索粉6克（2次冲），生姜3片，大枣4枚（劈）。水煎2次分服。

按：本方是十全大补汤加延胡索。

方中八珍汤补气养血；加黄芪增强补气之力；气虚及阳，配肉桂以温经扶阳，鼓动血行；延胡索以理气止痛；生姜二味和胃进食，以促进药物之吸收。如此配伍，可使阳生阴长，气充血盈，则诸症自愈。

本方可制成丸剂或膏剂，常服。

（四）肝肾亏虚痛经：

1. 临床表现：经来量少色淡，经期小腹疼痛，腰酸膝软，头晕耳鸣。舌淡苔薄白，脉沉细。

2. 主证分析：肝藏血，肾藏精，肝肾亏虚，经血不足，经行之后，胞脉更为空虚，故小腹作痛，经行量少而色淡；腰为肾之府，肾气不足则腰酸膝软；肾主骨生髓，脑为髓海，肾开窍于耳，故肾虚则头晕耳鸣。舌淡苔薄，脉沉细，为肝肾亏损，精血不足之征。

3. 治疗法则：调补肝肾。

4. 处方用药：调肝汤（《傅青主女科》）加味。

熟地24克，炒山药30克，阿胶12克（烊化），当归、白芍、山萸肉、巴戟天、艾叶各9克，炙甘草6克。水煎2次分服。

按：本方是调肝汤加熟地、艾叶。

方中熟地、山药、阿胶滋阴补肾；当归、白芍养血柔肝；山萸肉补肝肾而助精气；巴戟天、艾叶温肾气，而益冲任；甘草调和诸药而止痛。本方有调补肝肾的作用，肝得其养，肾得其补，则经痛自止。

若腰痛重者，加续断、杜仲各12克。小腹两侧痛加小茴香、橘核各9克，两胁疼痛者加金铃子、郁金各9克。夜尿频数清长者加益智仁9克，桑螵蛸12克。

【痛经简易方】

（一）生姜、红糖各15克，焦山楂12克。水煎服。

（二）生蒲黄、炒五灵脂各9克，酒丹参30克。水煎服。

（三）艾叶9克，红糖15克。水煎服。

（四）益母草30克，红糖15克。水煎服。

第三节 经 闭

发育正常的女子，一般在14岁左右，月经即应来潮。若超过18岁月经仍未来潮，或既往曾有过正常月经而又中断8个月以上者，称为“经闭”，又叫“闭经”或“不月”。前

者称原发性经闭，后者称继发性经闭。二者均属病理性经闭。至于妊娠期、哺乳期和绝经后的停经，以及暗经，均属生理性经闭，是正常现象，不属经闭范围。

本书所述都是功能失调所致的经闭。凡先天性无子宫、无阴道或处女膜闭锁等器质性病变所致的经闭，非药物治疗所能奏效，不属本节讨论范围。

【病因病机】闭经为生殖系统及有关内分泌系统功能失调的表现，也可能是身体其他脏器疾病的前驱症状或结果。但其原因归纳起来不外虚实两端。虚者，多因肝肾阴亏，精血不足；或因气血衰弱，血海空虚，无血可下。实者，多因气滞血瘀，寒气凝结；或痰湿壅阻，均可导致冲任不通，经血不得下行而经闭。

（一）肝肾阴亏：先天肾气不足；或房事不节；或多育多产，损及肝肾，以致精亏血少，冲脉失养，而致经闭。如《医学正传》云：“月水全借肾水施化，肾水既乏，则经血日以干涸。”

（二）气血虚弱：饮食劳倦，损伤脾气，化源不足；或因大病、久病，吐衄脱血；或多产及产后失血；或因久患虫积伤血；或因误服汗下攻克之药等，都能使冲任血少，血海空虚，发为经闭。如《兰室秘藏》云：“妇人脾胃久虚，或形羸气血俱虚，而致经水断绝不行。”

（三）气滞血瘀：情志内伤，肝气郁结，气机不利，血滞不行而致经闭。如《内经》云：“二阳之病发心脾，有不得隐曲，女子不月。”《妇科大全》说：“忧愁思虑，恼怒

怨恨，气郁血滞而经不行。”

（四）寒气凝结：经期过食生冷，或冒雨涉水，或经期、产后血室正开，调摄失宜，外感寒邪，血为寒凝，冲任受阻，而致经闭。如《妇人良方》谓：“寒气客于血室，血凝不利。”

（五）痰湿壅阻：肥胖之人，多痰多湿，或脾阳失运，湿聚成痰，痰湿滞于冲任，胞脉闭塞，而至月经不行。如《女科切要》说：“肥人经闭，必是痰湿与脂膜壅塞之故。”

此外，也有因生活、环境、风土习惯的改变而导致经闭者。

【辨证施治】对于经闭的辨证，首应分清是原发性经闭，还是继发性经闭。原发性经闭，应结合妇科检查，排除先天性畸形等器质性病变；继发性经闭，应排除早孕。

经闭证型虽多，但不外虚、实两类。一般以胸胁胀满，小腹胀痛、拒按者为实；面色无华，精神不振，头晕肢软，胃呆纳少，心悸失眠，腹部柔软而无胀痛者为虚。临床以虚证多见。

本病的治疗，应遵“虚者补之，实者通之”的原则。切勿一见经闭，不分虚实，滥用通利之法，致误病机。

（一）肝肾阴亏经闭：

1. 临床表现：月经初潮较迟，量少色红或淡，渐至经闭，面色晦黯，头晕耳鸣，间有头痛，腰膝酸软，大便干燥。舌淡无苔，脉细而缓。甚则可见两颧潮红，手足心热，潮红盗汗，心烦不寐，皮肤干燥，或有咳嗽唾血，咳痰不

爽，气短，甚至喘促不安，唇红口干。舌苔薄黄而燥，或光滑无苔，脉虚细而数。

2.主证分析：肝藏血，肾藏精，精血不足，冲任空虚，故月经闭止；肾主骨生髓，脑为髓海，腰为肾之府，肾虚则头晕耳鸣，头痛，腰膝酸；精血不足，不能上荣于面，故面色晦黯；心开窍于舌，阴血亏虚，心失所养，故舌淡无苔；阴津亏乏，不能濡润肠道，则大便干燥；血虚不能充于脉，故脉细而缓。

如进一步发展为津血亏损，阴虚生内热，虚热上浮，营血不宁，卫气不固，则两颧潮红，手足心热，心烦不寐，潮热盗汗，唇舌俱红，口干，苔黄燥或光滑无苔；津亏血枯不能润泽肌肤，则皮肤干燥；津竭火炽，灼伤肺脏，则咯血，咳痰不爽，气短，甚至喘促不安；血枯津竭，血脉不充，故脉细而虚，邪火内盛，则脉数，此乃阴虚火旺之象。

3.治疗法则：滋补肝肾，养血调经。

4.处方用药：小营煎（《景岳全书》）加减。

熟地15克，炒山药24克，当归、枸杞子、阿胶（烊化）各12克，炒白芍、女贞子、杜仲、怀牛膝各9克，鸡血藤30克。水煎2次分服。

按：本方是小营煎去甘草，加阿胶、杜仲、女贞子、怀膝、鸡血藤。

方中熟地、当归、阿胶补血养血，山药滋肾益脾，培育生化之源；白芍、女贞子、枸杞子敛阴补肾柔肝，怀牛膝既补且通，配杜仲能强壮腰膝，伍鸡血藤能养血通经。

若大便干燥者，可加肉苁蓉18克，以润肠通便。

如阴亏火旺，津乏血枯者，宜滋养肝肾，壮水制火，用补肾地黄丸（《素庵医要》）。

熟地18克，炒山药、制龟板、炒枣仁各12克，山萸肉、丹皮、茯苓、知母、麦冬、当归、白芍各9克，泽泻、黄柏各6克，远志4.5克。水煎二次分服。亦可研末炼蜜为丸，梧子大，每服9克，日服3次，温开水送下。

方中用知柏地黄汤滋水泻火，配龟板加强滋阴潜阳之力；当归、白芍柔肝养血；麦冬以滋水之上源而清上焦浮热；枣仁、远志宁心安神。

如咳痰不爽，咳血者，可去黄柏加百合、仙鹤草各30克，补心肺以止血；气短喘促者，去知母、黄柏等苦寒药加五味子6克，敛肺肾而定喘；服药后津液渐复，可去知母、黄柏加党参12克，白术9克，益气扶脾，使中焦健运，化生之门旺盛，则恢复较易。

如经闭由于营阴暗耗，心火偏亢，而兼见心悸、失眠、多梦者，宜养心阴，和血脉。用柏子仁丸（《妇人良方》）。

柏子仁12克，熟地18克，泽兰叶、续断各15克，生卷柏、川牛膝各9克。水煎二次分服。亦可研末炼蜜为丸，梧子大。每服9克，日3次，温开水送下。

方中柏子仁、熟地养心滋肾，使水火相济；续断补肾强腰膝，泽兰、卷柏、牛膝活血通经。

本方最适于室女心阴亏耗，心火旺盛，血枯而经闭者。

（二）气血虚弱经闭：

1.临床表现：月经由量少渐至停闭，数月不行，面色萎黄，爪甲苍白，头目眩晕，心悸怔忡，倦怠气短，食欲不振，或腹胀便溏，唇舌色淡，苔薄白，脉细缓无力。

2.主证分析：失血之后，或久病失养，或虫积内伤，或脾气虚弱，以致气血亏虚，血海无余，故经闭不行；血虚不能上荣于面及四肢筋脉，故面色萎黄，爪甲苍白；血虚不能上奉于脑，故头晕目眩；血虚心失所养，则心悸怔忡；脾虚中阳不振，则倦怠气短，食欲不振；脾虚失于健运，则腹胀便溏。舌淡，苔薄，脉细缓，均乃气血两亏之征。

3.治疗法则：益气扶脾，养血调经。

4.处方用药：六君子汤（《医学正传》）合当归补血汤（《内外伤辨惑论》）。

炙黄芪24克，党参15克，茯苓12克，炒白术、当归、半夏各9克，陈皮、炙甘草各6克，生姜3片，红枣4枚（劈）。水煎2次分服。

方中参、术、苓、草，健脾益气，由于有形之血生于无形之气，故重用黄芪大补脾胃元气，以资生化之源；配当归补血和营，则更为有力；脾恶湿，佐半夏、陈皮理气燥湿，使姜枣以和胃进食。脾旺健运，气生血长而经自调。

如因虫积引起的血虚经闭，临床可伴有多食善饥，或喜食泥土、石渣、生米、食盐等异物，面色苍黄，皮肤不润，脘腹时痛，有时按之有块。在治疗上应按“急则治标，缓则治本”的原则，或先驱虫，或先扶正，或攻补兼施。对虫症的治疗，应按内科驱虫处理。虫净之后，再服八珍汤等补气

养血，月经自调。

（三）气滞血瘀经闭：

1.临床表现：月经数月不行，精神抑郁，烦躁易怒，胸脘痞满，或两胁撑胀，小腹胀痛或拒按，舌质多紫黯，舌边有瘀点，脉沉弦或沉涩。

2.主证分析：气以宣通为顺，气机郁滞，则血不能下行，以致冲任不通，经闭不行；气滞不宣，则精神郁闷，烦躁易怒，胸胁胀痛；瘀血内停，积于血海，冲任受阻，则小腹胀痛拒按。舌质紫黯边有瘀点，脉沉弦或沉涩，均为气滞血瘀之象。

3.治疗法则：理气行滞，活血通经。

4.处方用药：乌药散（《妇人良方》）加减。

乌药、香附、柴胡、莪术、当归、红花各9克，丹参15克，桃仁、泽兰、牛膝各12克，木香4.5克，桂心3克。水煎2次分服。

按：本方是乌药散去青皮，加红花、香附，泽兰、丹参、牛膝。

方中乌药、莪术行气破血；柴胡、香附、木香舒肝脾之郁；丹参、桃仁、红花、泽兰活血祛瘀；当归养血和血；桂心鼓动气血；牛膝引血下行。气疏血活，则经自通。

有热象者，去桂心，易丹皮9克以凉血。

若停经未久，瘀滞未甚者，可用红花桃仁煎（《素庵医要》）加减。

桃仁、焦山楂各12克，丹参、红花、当归、赤芍、生蒲

黄、制香附、金铃子各9克，元胡粉（2次冲）、川芎各6克。水煎2次分服。

按：本方是红花桃仁煎去生地、青皮，加金铃子、山楂、蒲黄。

方中当归、赤芍、川芎养血活血；丹参、桃仁、红花、焦楂、蒲黄行血逐瘀；香附、金铃子、延胡索舒肝理气止痛。

本方亦系理气化滞活血之剂，但较上方效力缓和。

如经行不畅而腹痛，渐至停闭，形体羸瘦，面色苍黯，皮肤干糙，状如麸片，口燥不欲饮水，胸腹胀满，有如喘状，少腹拘急，胀硬疼痛拒按，痛连腰髀或连肩背，小便微难，大便燥结，舌质黯红或有赤紫斑点，脉象沉结而涩者，宜消症通经，祛瘀生新。用大黄蟅虫丸（《金匮要略》）。

大黄、生地各300克，桃仁、杏仁、白芍各120克，甘草90克，黄芩60克，虻虫、水蛭、蛭螬各45克，蟅虫、干漆各30克。

上药共研细末，炼蜜为丸，每丸重3克，每次1丸，日服1～2次，空腹温黄酒或温开水送下。

本方所治是属体虚瘀血内结之症。体虚羸瘦，经络的营养和卫气的运行受到影响，因而血行凝滞，产生瘀血（干血）。瘀血停结于内，则为经闭腹痛或经血不调；血积不能濡养肌肤，故肌肤甲错；不能营奉于面目，故面目黯黑；血瘀结块，积于小腹，故腹痛拒按；其他如腰髀肩背牵引疼痛，亦属血瘀不能濡养所致。此症体虚证实，不祛其瘀则新

血不生，正气亦无由恢复。故本方以祛瘀为主，用大黄、桃仁、干漆以通其血闭，合麝虫、水蛭、虻虫、蛭蟪等虫类活血通络之品，以增强消瘀破症之力；祛邪勿忘扶正，故又以地黄、芍药、甘草濡养血脉，和中缓急，并以杏仁、黄芩宣肺气以解郁热；用酒送服以行药势，共为佐使。全方组成的主要特点，是破血之力虽猛，但用药针对瘀血这一主证，避免了刚燥而性偏柔润，正如尤在泾所说：“润以濡其干，虫以动其瘀，通以去其闭”之义。全方作用，主在祛瘀生新，瘀血去则新血生，正气复。原书所谓“缓中补虚”即是此意，非此丸不能补虚也。

本方所治之经闭，必须确属久瘀蓄积，证如上述者，方为合宜。

（四）寒气凝结经闭：

1. 临床表现：月经停闭，面色苍青，腰酸腹痛，怕冷喜温，带下稀白。舌质黯红，苔薄白，脉象沉迟而紧，或沉涩。

2. 主证分析：寒邪凝结，血行受阻，故月经停闭；寒为阴邪，阻遏阳气，阳气不能宣达，故面色苍青不泽，腰酸腹痛，怕冷喜温。舌黯苔薄，脉沉迟紧或沉涩，均系寒阻血瘀之征。

3. 治疗法则：温经散寒，和血化瘀。

4. 处方用药：和血通经汤加减。

熟地、当归各12克，醋三棱、醋莪术、红花、小茴香各9克，肉桂、熟附片、苏木各6克，木香4.5克。水煎2次

分服。

方中熟地、当归养血和血；三棱、莪术、红花活血行瘀；肉桂、附子温经散寒以扶阳；小茴香、木香理气止痛；苏木既能活血祛瘀，又善止痛，为妇女经闭常用之品。诸药组合，使寒散气顺，血活瘀祛，则经血自行。

如适值经期感受风寒，经水忽然减少或停止，恶风畏寒，少腹冷痛。治宜辛温取汗，用吴茱萸汤（《证治准绳》）。

当归、防风各9克，吴茱萸、姜半夏、麦冬、藁本、茯苓、干姜、丹皮各6克，肉桂、木香、炙甘草各3克，细辛1.5克。水煎2次分服。

方中当归养血和血；防风、藁本、细辛辛温发散，祛风解表；干姜、肉桂温经散寒；半夏辛开降气；茯苓利水健脾；麦冬、丹皮、甘草凉润，二者生津化痰，以防辛温药物之燥烈伤阴。表解寒散，经水自下。

本方乃为经期感受风寒，寒邪内中，腹痛经闭，既有表寒，又有里寒者而设，由于外淫初受，胞中不虚，故组方无须重剂，取“轻可去实”之义。

（五）痰湿壅阻经闭：

1. 临床表现：经期屡愆，经水淡而反多，渐至闭止；形体肥胖，胸脘满闷；纳少痰多，时欲呕恶，神疲倦怠，带多色白。舌苔白腻，脉象濡滑。

2. 主证分析：肥胖之人，多痰多湿，痰湿壅阻经络，气血不畅，冲任不利，故经水淡而反多，渐至闭止；痰湿困

脾，脾阳不宣，故胸脘满闷；湿聚中焦，浊气蕴结，故痰多纳少，时欲呕恶；脾主四肢、主肌肉，脾阳不振，不能鼓动气血，故神疲体倦。带多色白，舌苔白腻，脉象濡滑，俱系痰湿内阻之象。

3. 治疗法则：燥湿祛痰。

4. 处方用药：苍附导痰丸（《叶天士女科》）。

制苍术、制香附、姜半夏、茯苓、制南星各 9 克，炒枳壳、陈皮各 6 克，炙甘草 4.5 克，生姜 3 片。水煎 2 次分服。

方中苍术、南星、半夏、茯苓燥湿化痰健脾；痰滞气亦滞，故配香附、枳壳行气解郁；陈皮、甘草、生姜和胃止呕。

本病是痰湿壅阻所导致的经闭，治病必求其本，故治法上则着重燥湿化痰，无须配用活血通经之品。脾健湿除，则月经自来。

第四节 崩 漏

妇女不在行经期间，阴道不规则的出血，称为“崩漏”，亦称“崩中漏下”。一般以来势急，出血量多的称“崩”；来势缓，出血量少的称“漏”。崩与漏的症状表现虽然不同，但其发病机理是相同的，在疾病发生发展的过程中，常可相互转化。如血崩日久，气血大衰，可变为漏；久漏不止，病势日进，亦能成崩。从轻重程度上来看，正如《济生方》所说：“崩漏之疾，本乎一证，轻者谓之漏下，甚者谓

之崩中。”

崩漏是多种妇科疾病所表现的共有症状，如功能性子宫出血及生殖器官炎症、子宫肿瘤，血小板减少，再生障碍性贫血等所引起的阴道出血，都属崩漏范围。

崩漏是妇科的常见病，以青春期、更年期或大小产后为多见，尤其是更年期出现本病，应作妇科检查，予以足够的重视。

【病因病机】 本病发生的主要机理，是冲任损伤，不能固摄经血所致。导致冲任损伤的原因，大抵可分为脾虚、肾虚、血热、血瘀、气郁、湿热等六种。

（一）脾虚：素体脾虚，或思虑过度，或饮食劳倦，损伤脾气，脾虚下陷，统摄失司，致冲任不固而发崩漏。

（二）肾虚：素体肾气不足，或因早婚、多产、房室不节，损伤肾气，以致封藏不固，冲任失摄，成为崩漏。其中又有阴虚、阳虚、阴阳俱虚之别。偏阴虚者，乃元阴不足，虚火妄动，使精血不守；偏阳虚者，是命门火衰，不能温煦胞宫，而使精血不固，阴阳两虚者，为肾失封藏，气血不得维系，血随气下，而成崩漏。

（三）血热：素体阳盛，或感热邪，或过食辛辣助阳之品，或情绪过激，肝火内炽，热伤冲任，迫血妄行，致成崩漏。

（四）血瘀：经期产后，余血未尽，即行房事，损伤冲任，或感受外邪，侵袭胞脉，以致余血未尽，新血不得归经，而致崩漏。

（五）气郁：肝藏血，喜条达。如精神过激，性情暴躁，恼怒愤懑，致伤肝气，肝气郁结，失于疏泄，气机逆乱，血不归经，遂成崩漏。

（六）湿热：湿热带下，经久不愈，湿热下迫，则崩漏不止。其中又有偏湿重、热重之分。

【辨证施治】 崩漏的发病情况缓急不同，出血新久亦有差异，故在治法上，应根据“急则治其标，缓则治其本”的原则，灵活掌握塞流、澄源、复旧三法。

塞流，即是止血，崩症大出血时，必先塞其流断其血，否则，会造成脱症。但止血方法，又须视其寒、热、虚、实，分别施治，不可专事止涩。

澄源，即澄清本源之意，是通过各种诊断方法，明确病因病机之所在，这是治疗崩漏的重要关键，必须审慎。切忌不问原因，概投寒凉或温补之剂，以犯虚虚实实之戒。

复旧，即调理善后，恢复机体功能，增进身体健康。视其脾肾虚损情况，或先调脾以固后天，取其补后天以养先天；或先补肾以滋先天，取其补先天以助后天。使其本固血充，则经自调。

根据临床经验，在崩漏大出血时，以补气摄血法配宫缩药、止血药疗效显著；而在恢复月经周期时，补肾固本法多能建功。血止后，须继续调治，连续3个月月经正常者，方为痊愈。

（一）脾虚崩漏：

1. 临床表现：下血量多或淋漓不断，血色淡红，质稀

薄，面虚浮，色苍白，气短懒言，精神倦怠，胃呆纳差或腹胀便溏。舌质淡红，舌体胖嫩，边有齿印，苔薄润或腻，脉虚大或沉弱无力。

2. 主证分析：脾主统血，脾虚则统摄无权，冲任不固，故下血量多或淋漓不断；脾虚，化源力减，血失温煦，故色淡而质薄；中气不足，则气短懒言，精神倦怠；脾阳不运，则面虚浮色苍白，胃呆纳差，腹胀便溏。苔薄润或腻，脉虚大或沉弱，均为脾虚失血之象。

3. 治疗法则：益气温中，升阳固摄。

4. 处方用药：举元煎（《景岳全书》）加味。

党参、炙黄芪各15~30克，熟地15克，炒白术、棕榈炭各12克，茜草炭9克，煅龙骨、煅牡蛎各24克，炮姜炭1.5克，升麻、炙甘草各6克。水煎2次分服。

按：本方是举元煎加熟地、棕榈、茜草、龙骨、牡蛎。

方中党参、黄芪、白术、甘草健脾大补中气；配升麻、炮姜温中升阳以提气；熟地养血；棕榈、龙骨、牡蛎固涩摄血；茜草炭既能止血，又能祛瘀，以防固摄留瘀之弊。

如暴崩出血过多，头晕心悸，额汗如珠，面唇灰白，口眼懈开，四肢厥冷，呼吸低微，神识昏沉，甚则昏厥，脉象微细欲绝，甚则浮大无根，虚甚欲脱者。治宜峻补元气，用独参汤。

红参30克。水煎趁热顿服，日2~3次。

红参为末适量合面煮粥，食之尤佳。

（二）肾虚崩漏：

1. 肾阴虚：

(1) 临床表现：出血量少或淋漓不断，色鲜红；头晕耳鸣，五心烦热，失眠盗汗，腰腿酸软，或腰痛、脚跟痛。舌质红，苔少或无苔，脉细数无力。

(2) 主证分析：肾藏精，精生血，精血不足，冲任亏损，故出血量少或淋漓不断；阴虚生内热，内热炽盛，煎灼阴液，故血色鲜红；阴虚不能上荣于脑，故头晕耳鸣；阴虚不能敛阳，阳浮于外，则见五心烦热，两颧潮红，失眠盗汗；腰为肾之府，肾主骨，肾精不足，故腰腿酸软，脚跟作痛。舌红，少苔，脉细数无力，均为肾阴亏损之象。

(3) 治疗法则：滋阴补肾，填精固血。

(4) 处方用药：六味地黄汤（《小儿药证直诀》）加减。

熟地、炒山药各30克，女贞子、旱莲草、枸杞子、阿胶、制龟板、茯苓各12克，丹皮、泽泻各9克，仙鹤草各30克。水煎2次分服。

按：本方是六味地黄汤去山萸，加女贞子，旱莲草、仙鹤草、枸杞、阿胶、龟板。

方中以熟地滋阴补肾，填精益髓而生血；枸杞补肝肾而生精；山药健脾兼能固精，用以治本；阴虚则火炎，故又以泽泻泻肾火，丹皮泻肝火，茯苓渗脾湿，用以治标；女贞、旱莲、阿胶、龟板养阴补血止血，仙鹤草功专止血，并能强心，对脱力劳伤之出血，更有助益。综合诸药，有补肾填精、固冲止血的作用。肾得其滋，精得其填，血得其固，则

崩漏自止。

2. 肾阳虚：

(1) 临床表现：出血量多或淋漓不断，其色淡红；面色㿔白，少腹冷痛，喜热敷，精神萎靡，形寒怕冷，腰背酸痛，小便频数而清，尿后余沥，甚或不禁，大便溏薄。舌淡苔薄白，脉沉细或迟弱。

(2) 主证分析：肾阳亏损，命门火衰，失其封藏固摄之权，故月经量多或淋漓不断；阳气不振，不能温化血液，阳虚不华于面，故面色㿔白；阳衰火微，阴气独胜，故形寒怕冷，少腹冷痛；得热则舒，故喜热敷；阳气不充，不能振奋气血，故精神萎靡；肾阳虚则腰脊不能支持，故腰背酸痛；肾与膀胱相表里，肾阳衰则膀胱阳气不化，括约功能失调，则小便频数，或尿后余沥；肾虚不能温脾，脾失健运，故大便溏薄。舌淡苔白，脉细弱或沉迟，乃肾阳虚衰之征。

(3) 治疗法则：补肾助阳，温经止血。

(4) 处方用药：右归丸（《景岳全书》）加减。

熟地、炒山药各24克，菟丝子18克，枸杞子、续断、艾叶炭、阿胶、乌贼骨各12克，熟附子6克，炮姜炭3克。水煎2次分服。

按：本方是右归丸去鹿胶、山萸、肉桂、当归，加续断、阿胶、艾叶、乌贼骨、炮姜。

善养阳者，必于阴中求阳。故方中用熟地、山药、枸杞、阿胶补肝肾之阴以填精生血为主；辅附子、炮姜温经散寒以助阳；佐艾叶、乌贼骨等温经敛涩之品，以止血固脱；

菟丝子既可补阳，又能益阴，禀性中和，不仅于阳虚尿频之症，为常用之药，对脾肾阳虚之便溏，尤为适宜；续断一味，取其强壮腰脊，并具有止崩漏作用。诸药组合，能补肾助阳以治本，温经止血以治标，标本兼顾，则经血自调。

3. 肾阴阳两虚：

肾阴阳两虚，即肾阴阳俱虚。多是疾病发展到严重阶段，阴损及阳，或阳损及阴，而出现阴虚与阳虚的症候同时并见的病理现象。此时，应根据临床表现，具体分析，综合上述两法，灵活运用。

（三）血热崩漏：

1. 临床表现：出血量多或淋漓不止，血色深红，或紫黑挟块，质稠粘；面赤口干，烦躁不宁，渴欲凉饮。舌质红，苔黄，脉洪数或滑数。

2. 主证分析：素体阳盛，或感受热邪，冲任为热邪所迫，以致血热妄行，故出血量多，色深红；血得热则胶结，故紫黑粘稠有块；热扰心神，故烦躁不安；热邪内炽，津液耗损，故面赤口干，渴欲凉饮。舌红苔黄，脉洪数或滑数，为血热炽盛之象。

3. 治疗法则：清热凉血，固经止血。

4. 处方用药：清热固经汤（《简明中医妇科学》）加减。

大生地、生牡蛎各24克，制龟板、生地榆各12克，生藕节、棕榈炭、焦山栀、生黄芩、麦冬、地骨皮各9克，生甘草4.5克。水煎2次分服。

按：本方是清热固经汤去阿胶，加麦冬。

方中生地、地骨皮、麦冬养阴清热，使热去而不伤津；地榆、槭子、黄芩清热凉血；龟板、牡蛎育阴潜阳；阿胶养血止血，棕榈收敛止血，藕节化瘀止血。诸药配合，共奏养阴生津、凉血清热、止血而不留瘀之效。

（四）血瘀崩漏：

1. 临床表现：突然大量下血或淋漓不断，色紫挟有瘀块；小腹疼痛拒按，瘀块排出则疼痛减轻。或舌边有瘀点，脉沉涩或沉紧。

2. 辨证分析：瘀血阻滞经脉，新血不守，血不循经，故见出血量多或淋漓不止；离经之血蓄积胞宫，则色紫成块；胞脉瘀阻不通，故小腹疼痛拒按；血块排出，瘀滞暂通，故疼痛减轻。舌质黯红或舌边尖有瘀点，脉沉涩或沉紧，均是瘀血阻滞之象。

3. 治疗法则：化瘀止血，理气止痛。

4. 处方用药：桃红四物汤（《医宗金鉴》）加味。

熟地、制香附各12克，当归、炒白芍、炒桃仁、红花、炒五灵脂、蒲黄炭、茜草炭、小蓟炭各9克，川芎8克。水煎2次分服。

按：本方是桃红四物汤加灵脂、蒲黄、茜草、小蓟、香附。

方中四物汤养血活血；桃仁、红花活血化瘀；蒲黄、灵脂化瘀止痛；血瘀气亦滞，故用香附理气，气顺瘀去则痛自止；茜草炭、小蓟炭均具止血之功，而无留瘀之弊。如此配

合，使瘀血去，新血生，则出血自止。

（五）气郁崩漏：

1. 临床表现：经量或多或少，淋漓不断，色黯红或有血块；胸闷胁痛，乳房、少腹胀痛，胃纳不甘，或呕哕吞酸，头痛。舌质黯红，苔薄白或薄黄，脉弦。

2. 主证分析：暴怒愤懑，损伤肝气，肝气郁结，失于疏泄，气机逆乱，血不归经，故崩漏下血，或多或少，经色黯红；若离经之血停蓄胞宫，可见血块；肝经之脉布两胁过少腹，肝气郁结，气不宜畅，故胸闷胁痛，少腹胀痛；乳房为肝胃所属，气结则乳房胀痛。气有余则化火，肝火犯胃，胃失和降，则胃纳不甘，呕哕吞酸；气火上逆，则头痛。舌黯，苔薄白，脉弦，是肝气郁结之象。肝郁化火则苔黄。

3. 治疗法则：理气行滞，开郁止血。

4. 处方用药：平肝开郁止血汤（《傅青主女科》）加味。

北柴胡、当归、炒白芍、炒白术、丹皮、生地、香附、茯苓、棕榈炭各9克，芥穗炭、生甘草各6克、三七粉3克（冲），薄荷1.5克。水煎2次分服。

按：本方是平肝开郁止血汤加茯苓、香附、棕榈炭、薄荷。

方中柴胡、香附、薄荷疏肝理气开郁；当归、白芍养肝和血；茯苓、白术、甘草健脾补中，以资化源；生地凉血止血，丹皮、三七活血化瘀止血；棕榈炭、芥穗炭辛涩并用，止血而不留瘀。诸药配合，具有疏肝理气，和血化瘀止血的

作用。

如肝火犯胃而呕哕吞酸者，可加吴萸1克，黄连3克，以清肝和胃。

（六）湿热崩漏：

1. 湿重于热者：

（1）临床表现：下血量多或淋漓不止，挟有粘腻水浆，平时带粘量多；面色垢黄，或面目浮肿，头胀眩重，腰重或痛，胸脘痞闷，口内粘腻，饮食减少，少腹胀满或胀痛，困倦乏力，小便不利，大便溏薄。舌苔白腻，脉象濡滑。

（2）主证分析：湿热带下，迫血妄行，故崩漏不止，挟有粘腻水浆，带下绵绵而量多；湿浊不泽，浸渍肌肤，故面色垢黄，面目浮肿，头胀眩重，腰重或痛；湿困脾阳，阳气不宣，故胸闷口腻，胃呆纳少，少腹胀满；阳气不振，则困倦乏力；湿滞膀胱，气化不敏，则小便不利；健运失司，则大便溏薄。苔腻，脉濡滑，乃湿邪偏重之象。

（3）治疗法则：祛湿清热，调经止血。

（4）处方用药：调经升阳除湿汤（李东垣方）。

制苍术、炙黄芪各9克，独活、防风、藁本、蔓荆子、升麻、柴胡、当归各6克，羌活、炙甘草各3克。水煎2次分服。

方中苍术、黄芪、柴胡、升麻、甘草燥湿健脾，益气升阳；羌活、独活、防风、藁本、蔓荆子多是辛苦燥散之品，用以增强升提除湿散热之力；少佐当归之润以和血。使湿祛热清，血自归经。故用于湿热带下湿邪偏重者，疗效颇好。

即治疗带下如崩之症，亦是良方。

2. 热重于湿者：

(1) 临床表现：下血量多或淋漓不止，血色紫红，腥秽稠粘，面色垢腻兼红，或身热自汗，口苦而腻，渴不欲饮，心烦少寐，或少腹热痛，按之痛甚，大便秘结或溏泄不畅，小溲黄赤不爽。舌质红绛，舌苔黄腻，脉象滑数。

(2) 主证分析：湿热交织，秽浊不清，故崩漏不止，血色紫红，味腥质稠，面色垢腻而兼红；湿热蕴蒸，故身热汗出；热伤津液，则口中干苦；湿居中焦，则口中粘腻，虽渴而不欲饮；热灼心阴，故心烦少寐；湿热下注，滞留不去，故少腹热痛，小溲黄赤不爽；加热伤津液，津不能濡润肠道，则大便秘结；如湿浊逗迫肠道，则大便溏泻。舌绛红，苔黄腻，脉滑数，乃热重于湿之征。

(3) 治疗法则：清热渗湿，调经止血。

(4) 处方用药：黄连解毒汤（《儒门事亲》）加味。

黄芩、栀子、蒲黄炭、艾叶炭各9克，黄柏6克，黄连3克，生地黄15克。水煎2次分服。

按：本方是黄连解毒汤加生地、蒲黄、艾叶炭。

方中芩连栀柏四味苦寒清热燥湿，并解热毒；蒲黄炭化瘀止血，艾叶炭祛湿止血，生地甘寒凉血，且防苦燥药之伤阴耗津。综合全方，可使热清湿除，瘀祛血止，月经自然正常来潮。

第五节 经行吐衄

月经来潮期间或月经前后2~3天内，出现有规律的吐血或衄血，称为“经行吐衄”。其规律性与月经周期相一致，而且常合并月经量少或经闭。似乎是经血倒行逆上，故亦称“倒经”或“逆经”。现代医学称为“代偿性月经”，在代偿性月经中，1/3为鼻衄。

【病困病机】 产生行经吐衄的发病机理，主要为血热气逆所致。因气为血帅，血随气行，血的升降运行，皆赖于气。气热则血热而妄行，气逆则血逆而上溢。临床常见的发病因素，有肝经郁火和阴虚肺燥两种。

（一）肝经郁火：平素情志不舒，肝气抑郁，肝气郁久则化火，气逆火热，迫血妄行。因肝藏血而司血海，冲为血海，附属于肝，经行之时，冲气较盛，冲气随肝气而上逆，气升血亦升，因而引起吐衄。

（二）阴虚肺燥：平素阴虚，阴虚则阳盛，而生内热，虚火上炎，迫血妄行。冲任蕴热，经行之期，冲脉较盛，火随血动，灼肺耗津，损伤血络，致成吐衄。

【辨证施治】 本病的治法，应本“热者清之”、“逆者平之”的原则，以清热降逆，引血下行为主。不可用苦寒及攻下药，以免伤气伤血。

（一）肝经郁火经行吐衄：

1. 临床表现：经前或经期吐血衄血，量多色红；烦躁易

怒，两胁作胀，口苦咽干，头晕耳鸣，月经提前，渐至量少或闭止。舌红苔黄，脉弦数。

2. 主证分析：证属肝经郁火，经期及经前血随冲气上逆，伤及阴络，而致吐血衄血，量多色红；热迫血行，故月经提前；吐衄血行于上，故经血随之减少，或闭止；肝火上扰，故见口苦咽干，头晕耳鸣；热扰于内，则烦躁易怒；两胁为肝经所布，肝郁不舒，则两胁胀痛。舌红苔黄，脉弦数，皆为肝郁火热之征。

3. 治疗法则：清肝泻热，降逆止血。

4. 处方用药：清经四物汤（《古今医鉴》）加减。

生地黄、白茅根各30克，生白芍、川牛膝各15克，郁金、当归、阿胶、丹皮、黄芩、金铃子各9克。生甘草1.5克。水煎2次分服。

按：本方是清经四物汤去川芎、黄连、黄柏、知母、香附、艾叶，加丹皮、郁金、金铃子、牛膝。

方中生地、丹皮、白芍凉血平肝；郁金、金铃子泻肝火，解郁结；黄芩清肺火；当归、阿胶养血和血；白茅根凉血止血；牛膝引血下行；生甘草既能清火，又可调和诸药。共奏清肝解郁、凉血降逆之效。

（二）阴虚肺燥经行吐衄：

1. 临床表现：经期或经后吐血衄血，量少色红，平时头晕耳鸣，潮热咳嗽，五心烦热，唇红而干，舌质红绛，苔花剥或无苔，脉细数。

2. 主证分析：心阴不足，心火亢盛，火盛灼金，损伤肺络，

故见经期吐血衄血，阴亏血虚，津液亏乏，故衄血量少而色红；阴虚阳盛，则头晕耳鸣，时有潮热；阴虚肺燥，损耗津液，故潮热咳嗽，五心烦热，唇干色红。舌质红绛，苔花剥或无苔，脉细数，均为阴虚肺燥之象。

3. 治疗法则：养阴润肺，清热止血。

4. 处方用药：活血润燥生津汤（《丹溪心法》）加减。

生地黄、白茅根各30克，生白芍、花粉、旱莲草各12克，知母、天冬、麦冬、当归各9克。水煎2次分服。

方中生地滋阴凉血，白芍敛阴柔肝；知母、天冬、麦冬、花粉甘寒滋润，养阴生津；白茅根、旱莲草凉血止血；当归和血以引血归经。热去阴生，则肺燥除而血自止。

第六节 经行发热

在每次月经来潮期间，或月经前后，出现发热症状者，称为“经行发热”。有单纯发热者，有恶寒发热者，亦有往来寒热者，均属此证。

【病因病机】《女科经纶》载：以行经潮热有定时的为内伤，潮热没有定时的为外感。指出本病成因有外感和内伤两种。而内伤发热又有实证和虚证的区别，成因亦各有不同。

（一）外感：经行前后，或正值经期，感受外邪，因而发热。

（二）内伤：《医宗金鉴》以时热、潮热，热在经前的

为血热；《济阴纲目》以经前潮热的为血虚有滞。此外，如忧思过度，郁怒伤肝，亦可能因郁火而成经行发热。这些血热、虚滞、郁火都是本病实证的病因。

阴虚不足，血脉空虚，是阴虚生内热的缘故；气虚或气血两虚，亦能导致经行发热，都是本病虚证的病因。

【辨证施治】 经期有外感表证而发热者，按照先表后里的原则，先解其表，然后调经，或解表的同时兼顾调经。另外，经期经后，因经行血去，身体必虚，此时，如感受外邪，虽属实证，但治疗当中，在一般非特别邪实急于治标的情况下，应驱邪扶正，补散并施，方为妥善，否则，容易造成邪虽排除而正气损伤的不良后果。内伤发热，应根据虚实情况，清其热，化其滞，解其郁，或滋其阴，益其气。总宜顾其血，调其经，勿使津血有伤，更勿犯虚虚实实之戒。

（一）外感经行发热：

1.临床表现：经来之时，恶风发热，有汗，头项强痛，身体疼痛，腰酸骨楚，或咳嗽鼻塞。舌苔薄白，脉象浮缓。

2.主证分析：外感风邪，邪正相搏于肌表，故出现恶风发热汗出，头痛身痛等一系列表证；肺主皮毛，开窍于鼻，风邪袭表，肺气不畅，故见鼻塞咳嗽。苔薄白，脉浮缓，是表虚外感风邪之征象。

3.治疗法则：解肌透表，养血和营。

4.处方用药：桂枝四物汤（《医宗金鉴》）。

桂枝、白芍各9克，熟地、当归、川芎各6克，炙甘草8克，生姜3片，红枣4枚（劈）。水煎2次分服。服后多

饮开水，以助微微出汗。

方中以桂枝汤调和营卫，治太阳病发热恶风，有汗，脉浮缓等表证；以四物汤养血和血。本方应用于血虚经行发热而有外感的，颇为合拍。

兼鼻塞咳嗽者，加苍耳子、苦桔梗各9克，苦杏仁6克。以宣肺止咳。

若经来之时，出现恶寒发热，无汗，口不渴，头痛身痛，或伴有咳嗽气喘，脉浮紧者，可用麻黄四物汤（《医宗金鉴》）。

麻黄、桂枝、苦杏仁、熟地、当归、白芍、川芎各6克，炙甘草3克。水煎2次分服。服后复被取微汗。

方中麻黄既能疏表发汗以散风寒，又能宣利肺气以平咳嗽；桂枝助麻黄发汗解表之力，并可温煦四肢，解除肌体酸痛；杏仁宣肺平喘；甘草调和诸药；四物汤养血和血。表解寒祛，其热自除。

若经水适来适断，往来寒热，胸胁苦满，口苦咽干，脉弦者，此乃病在少阳热入血室之候，治以和解少阳，扶正祛邪。用小柴胡汤（《伤寒论》）加味。

北柴胡、黄芩、半夏各9克，党参、生地各12克，炙甘草3克，生姜3片，红枣4枚（劈）。水煎2次分服。

按：本方是小柴胡汤加生地。

伤寒传入少阳，少阳位于半表半里，邪入少阳，有进一步入里化热的可能，而正气抗邪，有鼓邪外出之势，正邪相争，病邪出入未定，则出现寒热往来等证。方中柴胡透达少

阳之表邪，黄芩清少阳之里热，二药配合，解除寒热往来，口苦咽干；半夏、生姜和胃降逆，并助柴胡疏解胸胁苦满；生地凉血清热；党参、甘草扶正和中，使邪气不得复转入里；大枣配生姜不但能助半夏以和胃，更有调和营卫，协助柴胡解表的作用。如此配伍，则使表里和解，少阳枢转，而寒热自除，经血调顺。

（二）血热行经发热：

1. 临床表现：经前或临经发生潮热，经来量多，色鲜红或紫；面赤心烦，渴喜凉饮，头目眩晕，睡眠不安。舌红，苔黄，脉洪数或滑数。

2. 主证分析：素体阳盛，或感受热邪，致冲盛血动，而经前或经期发生潮热；热邪内迫故经量多；热灼液耗，故血色鲜红或紫；内热上炎，则面赤，头晕目眩；热邪伤津，故口渴饮冷；热扰心神，则睡眠不安。舌红、苔黄，脉洪数，均为血热内炽之征。

3. 治疗法则：清热凉血。

4. 处方用药：加味地骨皮饮（《医宗金鉴》）。

生地12克，当归、白芍、地骨皮、丹皮各9克，川芎、胡黄连各3克。水煎2次分服。

方中生地、当归、白芍凉血养血；地骨皮、丹皮、胡连清热凉血；川芎活血化瘀。血凉瘀散，身热自消。

阴血亏虚，骨蒸潮热之经行发热，亦可使用本方。

（三）虚滞经行发热：

1. 临床表现：临经潮热，经来量少色紫，头目眩晕，大

便燥结。舌质淡红，脉弦涩。

2.主证分析：素体肝血不足，血行不利，滞而成瘀，临到经期，瘀而化热，故经量少而色紫；血滞气亦滞，血虚气滞不能上荣于脑，故头目晕弦；血虚则津亏失润，故大便燥结。舌淡，脉弦涩，是血虚挟滞之象。

3.治疗法则：养血调经，化滞退热。

4.处方用药：逍遥散（《和剂局方》）加味。

当归、白芍、茯苓、白术、丹皮、桃仁、柴胡各9克，延胡索、炙甘草各6克，薄荷3克，煨姜1片。水煎2次分服。

按：本方是逍遥散加丹皮、桃仁、元胡。

方中当归、白芍养血和营以柔肝；茯苓、白术、甘草、煨姜健脾和中以资生化之源；柴胡疏肝，薄荷佐柴胡调达肝气以行滞；丹皮、桃仁凉血化瘀；元胡既能行血中之气，又能行气中之血，气行血活，有助于退热。

（四）郁火经行发热：

1.临床表现：行经之际，往来寒热，经行不畅，精神抑郁，胸闷不舒，头昏目眩，口燥咽干，饮食无味，脉来弦数。

2.主证分析：忧思过度，郁怒伤肝，肝郁气滞，郁而化火，经行之际，郁热外达，故往来寒热，经行不畅；肝气不舒，气郁不宣，故精神抑郁不乐，胸闷不舒；郁火上冲，故头昏目眩；火热灼津，则口燥咽干；肝气郁滞，影响脾胃运化，故口中无味。脉弦数为肝郁化火之征。

3. 治疗法则：疏肝解郁，凉血清热。

4. 处方用药：丹栀逍遥散（《医统》）。

即上方逍遥散加丹皮、栀子各9克。水煎2次分服。

逍遥散疏肝解郁，养血和脾，加丹皮、栀子凉血泻火以除热。

本证通过上方治疗，热退之后，宜用归脾汤滋养心脾，以作善后调理。

（五）气虚经行发热：

1. 临床表现：经后发热，肢体无力，精神倦怠，少气懒言，语声低微，胃呆纳少，或自汗，心悸，头晕，小便清或频。舌淡苔白，脉虚弱或虚大。

2. 主证分析：脾胃为气血生化之源，脾胃虚衰则气血不足，其他脏腑亦气血不足而虚弱。伤食劳倦，损及脾胃，则气血虚而生火热，经行之后，气血益虚，故而发热。脾主四肢，主肌肉，脾胃气虚，支持无源，故肢体倦怠，少气无力而懒言，心悸头晕；运化无权，则胃呆纳少；内热蒸腾，迫津出泄，故自汗；气虚失于固摄，故小便清长而频数。苔白，脉虚，是气虚的表现。

3. 治疗法则：补中益气，甘温除热。

4. 处方用药：补中益气汤（《脾胃论》）。

黄芪18~30克，党参15克，炒白术12克，当归9克，陈皮、炙甘草、北柴胡、升麻各6克。水煎2次分服。

方中重用黄芪补气益肺以固表，参、术、草益气健脾而和中，盖肺主一身之气，脾为气血生化之源，二脏强健，则

正气自充。补气易于滞气，故用陈皮理气以防滞，脾虚则清阳失摄而下陷，故佐柴胡、升麻助参、芪以升举清阳，“火郁以发之”，同时借升柴轻轻疏散之功以达表除热，气生于血，故配当归以补血，可使气补阳升而不致化燥以耗血，亦即补阳宜兼和阴之义。诸药配合，具有补中益气、甘温除热之效。

若经期或经后身体发热，见面色苍白，形体消瘦，肌肤萎黄，精神困倦，食欲不振等症属气血两虚者，宜补气益血，用八珍汤（《证治准绳》）。

本方由四君子汤合四物汤和姜枣组成。服之可使气血双补，阴阳兼顾，阳生阴长，气运血生。气血充足，则虚热自消。实乃治本之图。

（六）肾虚经行发热：

1. 临床表现：月经过后而发潮热，面色苍白或苍黄，形体虚弱，颧红唇赤，头昏耳鸣，虚烦少寐，腰膝酸软，足跟痛。舌质红，苔少，脉细数。

2. 主证分析：酒色劳伤过度，或久病之后，真阴亏损，阴虚生内热，水亏则火浮。行经之后，阴分益虚，故而发生潮热；虚火上炎，则颧红唇赤；阴虚无以泽其面，故面色苍白或苍黄；肾主骨，生髓，开窍于耳，肾阴虚则头昏耳鸣；腰为肾之府，肾虚则腰膝酸软，足跟痛；如心肾不交，则虚烦少寐。舌红苔少，脉细数，是阴虚火热之象。

3. 治疗法则：滋阴补肾。

4. 处方用药：六味地黄汤（《小儿药证直诀》）加味。

熟地24克，炒山药、枸杞子、女贞子各12克，山萸肉、丹皮、茯苓、泽泻、旱莲草各9克。水煎2次分服。

六味地黄汤是补阴的基础方剂，加枸杞、女贞、旱莲草更增加其养阴凉血清热之力。阴复火敛，则身热自退。

第七节 经行泄泻

妇女在月经来潮期间，大便泄泻，次数增多，经行即泄，经净即止，称为“经行泄泻”。

【病因病机】 脾气素虚或肾阳不足，当行经之时脾肾更虚，脾气下陷，命门火衰，腹泻即作。临床上常见的有脾虚和肾阳两种。而脾虚之中，又有兼寒、兼热和肝气犯脾之不同。

（一）脾虚：《女科经纶》说：“有妇人经行，必先泻二、三日，然后经下，诊其脉，皆濡弱，此脾虚也。脾主血属湿，经水将动，脾血先已流注血海，然后下流为经。脾血既亏，则虚而不能运行其湿。”说明脾胃素虚者，经行之时脾气益虚，不能运化水谷，水谷之气不能化生精微，而化为湿浊，随脾气下陷而成泄泻。《医宗金鉴》说：“鸭溏清彻冷痛，乃虚寒；肌热渴泻，乃虚热。”《沈氏女科辑要笺正》谓：“亦有肝木侮土者。”这指出经行之时，血虚肝旺，肝气犯脾，脾失健运，亦可导致经行泄泻。

（二）肾虚：脾阳根于肾阳，肾阳素虚者，经行之际，气血下注冲任，气血虚弱，肾阳益衰，不能上温脾土，致运

化失常，湿浊下注而为泄泻。

【辨证施治】 辨证时，除注意全身症状外，大便的色质及大便时间，均有一定的参考价值。若日夜俱泻，其便完谷不化，多属脾虚；惟五更泄泻，其便质清色淡，多属肾虚。

（一）脾虚经行泄泻：

1.临床表现：经行期间，大便泄泻，面色萎黄，精神疲倦，四肢乏力，腹胀或浮肿，口淡无味。舌质淡，苔白腻，脉濡弱。

2.主证分析：脾胃素虚，经行之时运化衰减，湿自内生，故经行泄泻；脾虚中阳不振，故面色萎黄，精神疲倦，四肢乏力；由于脾阳不振，湿浊内停则腹胀，湿邪泛滥则浮肿；脾开窍于口，脾虚则口淡无味。舌淡苔白腻，脉濡弱，是脾虚湿盛之征。

3.治疗法则：健脾益气，渗湿止泻。

4.处方用药：参苓白术散（《和剂局方》）。

党参、炒山药、炒扁豆各12克，炒薏仁18克，炒白术、茯苓、莲子肉各9克，桔梗、陈皮各6克，砂仁3克，炙甘草6克。水煎2次分服。

本方是四君子汤加味组成。四君子汤补气健脾，加扁豆、山药、薏仁、莲肉是加强补脾渗湿的作用；加陈皮以和胃，加砂仁以醒脾，加桔梗以宣肺，三者配伍则调气化滞之力尤强，这样就大大增加了四君子汤的补益作用，并加强了健脾渗湿、行气和胃的作用。当此之时，补其虚，除其湿，

行其滞，调其气，两和脾胃，则泄泻自愈。

若脾虚兼寒的，与前述主证相似，但泻出物澄彻清冷，腹中冷痛，痛喜热按，舌质淡，苔白腻，脉象沉迟无力。治宜温中健脾。用理中汤（《伤寒论》）。

党参15克，炒白术12克，干姜、炙甘草各6克。水煎服。

方中干姜温中祛寒，恢复脾阳为主药；辅以党参补气健脾，振奋脾胃功能；佐白术健脾燥湿；使以甘草调和诸药而兼补脾和中。四药合用，具有温中祛寒，补气健脾之功。

如兼见阳虚较甚，四肢厥冷，下利不止，脉微者，可加熟附子6克，以回阳救逆。

若脾虚兼热者，除见前述脾虚主证外，兼见面色微红，身热口渴，舌苔薄黄，脉象虚数等症。治宜健脾解热。用七味白术散（《小儿药证直诀》）。

党参、葛根各12克，炒白术、茯苓、藿香各9克，木香4.5克，炙甘草3克。水煎2次分服。

本方由四君子加葛根、藿香、木香组成。方中参、苓、术、草益气，苓、术健脾，共扶“后天之本”；葛根甘平，既能入阳明解肌热，又能鼓动胃气以上行，升提止泻；藿香、木香芳香化湿，调气畅中。故经期脾虚身热，口渴腹泻者，最为适宜。

按一般患肌热口渴泄泻者，在内科处理上是葛根黄芩黄连汤证，但在经期患是病者，乃虚热证，不能用黄芩、黄连，当用七味白术散。

若平素肝强脾弱，经行之际，脾气益虚，此时肝气犯脾，肝脾不和，证见大便泄泻，肠鸣腹痛，腹痛必泻，泻下不多，泻后痛减，每因情绪影响而发作，舌苔多见薄白，脉弦。治宜泄肝补脾，止痛止泻。用痛泻要方（《景岳全书》）。

炒白术，炒白芍各15克，陈皮9克，防风6克。水煎服。

“痛泻”一症，多由肝脾不和所致。脾虚运化失常，故腹痛肠鸣，大便泄泻；肝旺脾弱则泻必腹痛而脉弦。正如吴鹤皋说：“泻责之脾，痛责之肝，肝责之实，脾责之虚，脾虚肝实，故令痛泻。”方中用白术健脾止泻，陈皮和胃理气以辅之；白芍平肝止痛；防风辛甘升散，以搜除脾家之湿邪。四药相配，调和肝脾，宣畅气机。肝平脾健，痛泻自止。

如水泻者，可加升麻6克，以升举脾阳。

如反复不愈者，可加乌梅肉、木瓜各12克，炙甘草6克等酸敛甘缓之品，以增强止泻之力。

（二）肾虚经行泄泻：

1. 临床表现：经前或经期，大便溏薄，面色晦暗，头晕耳鸣，腰膝酸软，形寒畏冷，小便清长。舌质淡，苔白滑，脉沉迟或沉细无力。

2. 主证分析：肾司二便，肾阳虚衰，不能温煦脾阳，脾肾阳虚，无以制水，经行之际，脾肾益虚，故经前或经期大便泄泻，或黎明腹泻，肾阳不足，不荣于面，故面色晦暗；

不能温煦周身，故形寒畏冷；不能温化膀胱，故小便清长；腰为肾之府，腰膝属肾，肾虚则腰膝酸软。舌质淡，苔白滑，脉沉迟或沉细，均肾阳亏虚之象。

3. 治疗法则：温肾暖脾，固肠止泻。

4. 处方用药：健固汤（《傅青主女科》）合四神丸（《内科摘要》）。

党参12克，炒白术、茯苓、补骨脂、肉豆蔻、巴戟肉各9克，炒薏仁18克，五味子6克，吴茱萸3克，生姜3片，大枣4枚（劈）。水煎2次分服。

方中参、术、苓、薏、枣健脾渗湿，养胃和中；补骨脂、巴戟肉温补肾阳；肉豆蔻暖脾止泻，行气消食；吴茱萸合生姜温中祛寒；五味子收敛止泻。诸药合用，对脾肾阳虚之腹泻，卓有成效。

第八节 经前便血

每月行经之前，大便下血，而且是周期性的，称为“经前便血”，也叫“错经”。

【病因病机】 经前便血，并非经血不循故道，径自大便而下，而是因大便已经出血，影响到经量减少，甚至不来。导致经前便血的原因，可有血热和脏虚两种。

（一）血热：平素过食辛辣燥血之物，或恣饮酒浆，肠中积热；胞宫与大肠同居下腹，经行之前，胞中气血俱盛，容易引起肠中郁热，因而迫使大便下血。

(二) 脏虚：薛立斋说：“或因劳心，虚火妄动，月经错行。”但脾虚不能统血，肝虚不能藏血，肾虚不能制火，均能导致经前便血。

【辨证施治】 对本病要辨虚实。在治法上，应本着“虚者补之”、“实者泻之”的原则，化裁运用，但在止血之中，切勿过用固涩，以防瘀滞。

(一) 血热经前便血：

1. 临床表现：经前大便下血，血色深红；口苦咽干，面赤唇燥，头晕心烦，渴喜冷饮，大便干，小便黄；月经量少，质粘稠，色紫红。舌红苔黄，脉象滑数。

2. 主证分析：因热伏肠中，热迫血行，故大便下血，色深红；胞宫与直肠同居下腹，经行之前胞中气血俱盛，引动肠中伏热，迫血妄行，故经前易大便下血；热邪上扰清窍，故头晕，热扰神明则心烦；热邪内盛，灼耗津液，故口苦咽干，面赤唇燥，渴喜冷饮，大便干，小便黄；血从大肠而出，胞中余血减少，故月经量少；血为热灼，则经血色紫红而粘稠。舌红苔黄，脉滑数，均为邪热内盛之征。

3. 治疗法则：清热凉血止血。

4. 处方用药：约营煎（《景岳全书》）。

生地15克，续断、地榆炭各12克，白芍、黄芩、槐花、乌梅各9克，黑芥穗4.5克，生甘草8克。水煎2次分服。

方中生地滋阴清热，凉血止血；白芍敛阴补血，肺与大肠相表里，故用黄芩以清肺肠之热；地榆、槐花、乌梅专入大肠凉血固下而止血；续断补肝肾，具有补而不滞、行而

有止的特性，为下焦血分药，止血而不留瘀，芥穗炒炭，性变苦涩，既能止血，亦能散瘀，尤为肠道便血常用之品；甘草生用，其性偏凉，能清热解毒，缓急止痛，并能调和诸药。本方具有寒不伤阳，收而不涩之义。大便血止，则经血自调。

（二）脏虚经前便血：

1. 临床表现：经前便血量多；面色苍白，头晕目眩，耳鸣或聋，心悸怔忡，精神疲倦，少气乏力，腰酸腿软，平素带下绵绵，大便或溏，小溲频数。舌淡，苔少，脉象虚细。

2. 主证分析：诸脏俱虚，血不统藏，经血错乱，因而血从便下而量多；血虚不荣于头面，故面色苍白，头晕目眩；气生于血，血虚则气亦虚，气血两虚，不能支持，故精神疲倦，少气乏力；耳鸣耳聋，腰酸腿软，小溲频数，是肾虚之候；带下绵绵，大便溏薄，乃脾虚之征。舌淡，苔少，脉虚细，是脏虚之象。

3. 治疗法则：滋肾补肝，健脾调经。

4. 处方用药：顺经两安汤（《傅青主女科》）

熟地、党参各15克，当归、白芍、麦冬、炒白术各12克，山萸肉、巴戟肉各9克，芥穗炭6克，升麻3克。水煎2次分服。

方中熟地、当归、白芍、山萸肉滋肾敛肝补血；党参、白术益气健脾；麦冬甘苦凉润，养血滋阴以制火；在一派阴柔滋补的药物之中，又恐滞气抑阳，故用甘温能补、辛温能散的巴戟，专入肾家鼓舞阳气；芥穗炭止血化瘀；升麻升提

中气以举陷。本方能益气补血，滋肾敛肝，扶脾止血，乃阴阳两顾之剂。用于经前便血，日久属虚者，具有良效。

如大便溏薄，去麦冬加茯苓12克，以淡渗利湿。

第九节 经前期紧张证

经前期紧张证是指行经前所出现的一些全身症状，如头痛脑胀、腰痛腿软，胸胁胀满、乳房胀痛、乳头痛、心悸、夜寐不安、思想不集中、浮肿、腹胀、消化不良、尿急尿频及神经过敏等。典型的症状往往出现在经前7~14天，逐渐加重，行经前2~3天达到高峰，行经后明显消失。重者影响日常工作及生活。有时被误诊为其他脏器疾病，故应加注意。

【病因病机】 本病多发生在35岁以上的妇女，即生育旺盛期过后，或伴有不孕症，月经失调的患者。现代医学有多种学说，如月经毒素，纯精神因素，对卵巢激素产生的变态反应，雌激素与孕激素比值平衡失调，抗利尿激素功能亢进，醛固酮分泌增加等，属于多病因的代谢障碍，因而有类似更年期综合征的水盐代谢紊乱，植物神经系统的障碍，在月经前期出现。

祖国医学分析，认为月经为冲任脉所管理，而冲任又与肝肾相关，胞脉上系于心。若素体肾脾虚弱，或因七情所伤，以及过劳、饮食不节、起居失常等影响了机体的气血运行，造成机体内潜伏着一定的肝郁气滞，心脾肾虚的机制，

始至经前期，当冲任脉盛，经脉活动加速之际，原有潜伏病机，随即出现，于是发生上述一系列症候，一旦月经过后，冲任脉气平复，症状又复不显。临床多见的有肝郁气滞，心脾两虚，肾阴阳两虚等三类。

（一）肝气郁滞：平素情志不舒，郁怒伤肝，失于条达，肝气横逆，疏泄无权，气机不利，血行不畅，则为胀为痛，为聚为痞。如肝郁化火，则上扰清窍，如肝强脾弱，则腹痛泄泻。

（二）心脾两虚：思虑伤神，劳心过度，或饮食不节，久病失养，脾不健运，导致心脾两虚。

（三）肾虚：肾虚又有阴虚、阳虚之别。肾阴虚者，多因思劳过度，房室不节，或久病之后，真阴亏耗；肾阳虚者，多因禀赋薄弱，久病不愈，或房劳伤肾，下元亏损，命门火衰。

【辨证施治】 对症状不重者，可注意生活调节，如饮食适当限制水盐，经前避免精神刺激及过度疲劳，平时坚持参加劳动，保持精神愉快，一般不需药物治疗。若症状严重，影响工作及日常生活，则应加以调治。

（一）肝郁气滞经前紧张证：

1. 临床表现：经前乳胀、乳头痛，甚至不能触衣；大晕头痛，小腹胀痛连及胸胁，烦躁易怒，胃纳不佳，或有不同程度的水肿；经量或多或少，色暗，多伴有痛经。舌苔正常，脉弦。

2. 主证分析：郁怒伤肝，肝气郁滞，气机不畅，经脉壅

滞，肝经走乳头、胸胁、少腹，故出现乳胀乳头痛，少腹痛连及胸胁；肝失条达，故烦躁易怒；肝气横逆侵及脾胃，脾胃虚弱故胃纳不佳、腹胀、浮肿；若肝郁化火，上扰清窍，则出现头晕头痛。脉弦为肝郁气滞之征。

3. 治疗法则：舒肝理气，活血通络。

4. 处方用药：柴胡疏肝散（《景岳全书》）加味。

北柴胡、炒白芍、制香附、当归、郁金、金铃子各9克、陈皮、枳壳各6克，川芎4.5克，丝瓜络12克，炙甘草3克。水煎2次分服。

按：本方是柴胡疏肝散加郁金、金铃子、陈皮、丝瓜络。

方中柴胡疏肝解郁；香附、川芎、金铃子行气止痛；郁金辛苦降，入气分以行气解郁，入血分能凉血破瘀，为血中之气药，配之益增其止痛之功；当归、芍药养血柔肝；陈皮、甘草和中理脾；加丝瓜络以增强其宣通经络的作用。

如乳房胀痛不能触衣有块者，可加橘核、王不留行各9克，以通络散结。

如肝郁化火，上扰清窍，出现头晕头痛，口苦口干者，可去辛窜之川芎，加丹皮、栀子、夏枯草各9克，以清热泻火。

如见脾虚肝旺，肝木犯脾，腹痛必泻者，宜补土泻木，用痛泻要方（见经行泄泻）。

（二）心脾虚经前紧张证：

1. 临床表现：面色萎黄，经前心悸，夜寐不安，神疲乏

力，四肢清冷，水肿，白带清稀量多，或有经来先期量多而色淡。舌质淡，苔白滑，脉沉细无力。

2.主证分析：心主神明，脾主运化，心虚则神不内守，故心悸，夜寐不安；脾虚不能充沛肌肤，则面色萎黄，神疲畏冷；水湿内聚则水肿，白带量多而清稀；脾虚不能统血，则月经先期量多色淡。舌淡苔白滑，脉沉细无力，均为心脾气虚之象。

3.治疗法则：养心安神，健脾利湿。

4.处方用药：归脾汤（见月经先期）。

若湿重浮肿、加泽兰、泽泻、车前子各9克，以利湿消肿。

（三）肾虚经前紧张证：

1.肾阴虚：

（1）临床表现：头晕脑胀，腰膝酸软，或脚跟痛，低热，五心烦热，颧红，口干，盗汗，尿量多，小便黄。舌红少苔，脉虚细而数。

（2）主证分析：肾主骨生髓，脑为髓海，肾阴虚则髓海不足，故头晕脑胀；肾主骨，腰为肾之府，肾阴虚，故见腰膝酸软，或脚跟痛；肾阴不足，热由内生，故低热，五心烦热；虚火上炎，故颧红，口干；阴虚者，睡后阳无所附，汗液随之外越，故有盗汗；阴虚则阳亢，蒸动肾关，膀胱气化不固，故尿量多。尿黄，舌红少苔，脉细数，均是阴虚内热之象。

（3）治疗法则：滋肾育阴。

(4) 处方用药：左归丸(《景岳全书》)加减。

熟地、炒山药各24克，枸杞子、旱莲草、怀牛膝各12克，山茱萸、女贞子、肥知母各9克。水煎2次分服。

按本方是左归丸去龟胶、鹿胶、菟丝子，加女贞子、旱莲草、知母。

方中熟地、山茱萸、枸杞、女贞、旱莲滋补肝肾之阴，使水旺足以制火；山药养脾肾之阴，脾润可以养肺滋肾；知母滋阴泻火；怀牛膝强腰肾，健筋骨。

如潮热者，加白薇12克，地骨皮9克，以清虚热。

如尿量增多者，加益智仁、覆盆子各12克，以固肾缩尿。

2. 肾阳虚：

(1) 临床表现：面色淡白，腰脊酸痛，腿软乏力，形寒怕冷，或尿少、尿频，身面浮肿，或食少便稀。苔白，脉沉弱。

(2) 主证分析：肾阳不足，不华于面，则面色淡白；督脉贯脊络肾面督诸阳，肾阳不足，故腰脊酸痛，腿乏无力；阳虚不能温煦肌肤，故形寒畏冷；阳虚肾关不开，膀胱气化不利，水液下泄欠畅，泛滥于肌表，则尿少，尿频，身面浮肿；肾阳衰不能助动脾阳，致健运功能衰弱，故食少便溏。苔白，脉沉弱，亦肾阳虚衰之征。

(3) 治疗法则：温肾扶阳。

(4) 处方用药：右归丸(《景岳全书》)。

熟地、炒山药各24克，菟丝子、续断、茯苓各12克，山

萸肉 9 克，熟附子、肉桂各 6 克。水煎 2 次分服。

按：本方是右归丸去杜仲、鹿胶，加续断、茯苓。

方中熟地、山药、山萸肉培补肾阴；续断补肾健骨；茯苓健脾行水；附子、肉桂、菟丝子以壮肾阳。

如腰腿酸痛甚者，加狗脊 12 克，补骨脂 9 克；尿少浮肿者，加车前子 12 克（包煎），泽泻 9 克。

第十节 经断前后诸证

妇女在 49 岁前后（45~52 之间），月经终止，称为“经断”或“经绝”。在月经将绝未绝的 1、2 年间，是“任脉虚，太冲脉衰少，天癸竭”，以至月经停止的过渡时期。在这一期间，月经周期或先或后，经量或多或少，大多数没有其他全身症状，这是正常的生理现象。但有些妇女出现烦躁、易怒、精神萎靡，忧郁、情志失常、头昏目眩、耳鸣心悸、失眠、腰痛、手心热、阵发性面红汗出、口干、食欲减退等症。这些症候又常三三两两同时出现，甚至延续 1、2 年之久，影响工作和身体健康，故称为“经断前后诸证”。

现代医学认为，妇女 45~52 岁是由壮年到老年的过渡时期，称为更年期。卵巢功能开始减退直至消失，相应发生月经紊乱，至月经闭止，同时生殖器官开始萎缩，内分泌失调，出现一些植物神经功能紊乱的现象，称为“更年期综合征”，即祖国医学所说的“经断前后诸证”。

【病因病机】 妇女将届经断之年，由于先天之肾气渐

衰，任脉虚，太冲脉衰少，天癸将竭这些生理变化，身体往往出现一种肾阴不足，阳失潜藏；或肾阳虚衰，经脉失于温养的阴阳显著不平衡现象。少数妇女由于平素体质较弱，或兼有精神因素，或有其他因素的影响，一时不能适应这种生理变化，因而出现一些脏腑功能紊乱的症候。

【辨证施治】 产生本病的主要原因是阴虚阳浮，冲任虚损。所以临床表现主要是心肾肝脾诸脏亏乏的症候。但肾虚是致病之本，其中又有肾阴虚、肾阳虚和阴阳俱虚的表现，而尤以肾阴虚为多见。其总的治疗原则是“补其不足，不可伐其有余”。阴虚者忌辛燥，忌苦寒，宜甘润壮水之剂，以补阴配阳，使虚火降而阳归于阴，所谓“壮水之主，以制阳光”。阳虚者忌凉润，忌辛散，宜甘温益气之品，以补阳配阴，使阴散而阴从于阳，所谓“益火之源，以消阴翳”。至于阴阳俱虚，则精气两伤，就宜阴阳双补。总之，尚须从整体观念出发，重视脏腑气血的相互关系，辨证求因，审因论治，才能收到良好的效果。此外，患者要注意调情志，慎起居，以避免外界不良因素的影响。

（一）肾阴虚经断诸证：

1. 临床表现：阵发性面部潮红，烦躁易怒或忧郁，手足心烦热，头晕，头痛，耳鸣，多汗，口干燥，胃纳差，腰酸骨痛，大便燥结。月经往往量少，色鲜红或紫红。舌质红，苔少，脉弦细略数。

2. 主证分析：肾阴不足，水不养肝，肝火上逆，故面红，烦热，易怒，口干，多汗，纳减；髓海亏虚，则头晕耳

鸣，腰酸骨痛；热灼津伤，故便燥，经少而色红。舌红，苔少，脉细数，亦阴虚内热之征。

3. 治疗法则：滋阴潜阳，补益肝肾。

4. 处方用药：六味地黄汤（《小儿药证直诀》）加减。

熟地、生地各15克，炒山药、炒白芍，钩藤各12克，丹皮、茯苓、泽泻、菊花各9克，生龙骨、生牡蛎各30克。水煎2次分服。

按：本方是六味地黄汤去山萸，加生地、白芍、钩藤、菊花、龙骨、牡蛎。

方中六味地黄汤以补肾阴，加生地以增强益阴清热作用；龙骨、牡蛎育阴潜阳；白芍敛阴和营；钩藤、菊花以平肝。使阴平阳秘，而诸证自除。

（二）肾阳虚经断诸证：

1. 临床表现：面色淡白，精神萎靡，体倦乏力，畏寒肢冷，腰脊酸痛，阴部重坠，或有浮肿，饮食无味，大便稀薄，尿少夜频。月经往往量多、色淡，白带多、质稀。舌淡，苔薄白，脉沉弱。

2. 主证分析：肾阳虚，阳气不能外达，故畏寒肢冷，面色淡白；阳气不振，则体倦乏力，精神萎靡；腰为肾之府，督脉贯脊络肾而督诸阳，肾阳不足，故腰脊酸痛；肾阳虚则气化失司，水液不能外排，则尿少浮肿；不能温养脾胃，则食少便溏；阴坠，经带量多，为阳气下陷所致。苔白，脉弱，亦阳虚之候。

3. 治疗法则：温肾助阳。

4. 处方用药：右归丸（《景岳全书》）加减。

熟地24克，炒山药、枸杞子、菟丝子、鹿角胶、续断、党参各12克，补骨脂、淫羊藿各9克，熟附子、仙茅各6克，肉桂3克。水煎2次分服。

按：本方是右归丸去山萸、当归，加续断、党参、补骨脂、淫羊藿、仙茅。

方中熟地、鹿角胶补血生精益髓；补骨脂、枸杞、续断温补肝肾；党参、山药补脾益气；仙茅、淫羊藿、附子、肉桂温肾助阳。使肝肾脾等脏得养，则冲任气盛，诸证可愈。

（三）肾阴阳两虚经断诸证：

1. 临床表现：出现经断前后诸证，颧红唇赤，虚烦少寐，潮热盗汗，腰膝酸软，头昏目眩，耳鸣心悸，敏感易怒，血压升高，以及其他慢性病见有肾阴、肾阳不足而虚火上炎等见症者。

2. 主证分析、经断前后，先天之肾气渐衰，任冲虚损，癸水将竭，阴损及阳，则现阴阳两虚。阴虚生内热，水亏则火炎，浮阳上越，则颧红唇赤；热扰心神，故虚烦少寐；阴虚阳浮，故午后潮热；睡后阳无所附，故迫汗外出；肾虚不荣于脑，故头昏目眩耳鸣；水不济火，则心悸；水不涵木，肝火妄动，肝阳上亢，则血压升高。综合诸证，皆阴阳俱虚，虚火上炎所致。

3. 治疗法则：益肾阴，温肾阳，泻虚火，调冲任。

4. 处方用药：二仙汤（上海曙光医院经验方）。

仙灵脾12克，仙茅、巴戟肉、当归、知母各9克，黄柏

5克。水煎2次分服。

本方配伍之特点是壮阳药与滋阴泻火药同用，以针对阴阳俱虚于下，而又虚火（包括肝火、肾火）浮炎于上的复杂症候而设。方中以仙茅、仙灵脾（淫羊藿）、巴戟肉温补肾阳；以黄柏、知母泻火而滋肾保阴，并以当归之温润养血而调冲任。

本方最初用以治疗更年期高血压及更年期综合征，能明显改善症状，并能使血压下降。以后推广至其他疾病，如肾炎、肾盂肾炎、尿路感染、闭经，以及更年期精神分裂症等病程中出现肾虚火旺之症候，以此方为基础，均可加减治疗。

（四）心肾两虚经断诸证：

1.临床表现：心悸失眠，烦躁不安，多梦易惊，失眠健忘，精神紧张，不耐思虑，口干咽燥，口舌生疮，大便干秘。舌红少苔，脉细数。

2.主证分析：肾阴亏耗，不能上济心火，则心火亢盛，心阴益损，心肾不交，水火不济，因而出现上述心肾阴虚火炎诸证。

3.治疗法则：滋阴清热，宁心安神。

4.处方用药：补心丹（《摄生秘剖》）。

党参、玄参、丹参、茯苓各15克，生地120克，当归、炒枣仁、柏子仁、五味子、天冬、麦冬各30克，远志、桔梗各15克。共为细面，炼蜜为丸，梧桐子大，朱砂9克为衣。每次9克，日服2～3次，空腹温开水送下。亦可酌减剂量

改汤剂内服。

心肾亏虚，阴血不足，则心失所养而见上述诸证。正如《内经》所说“阴气者，静则藏神，燥则消亡”，即指此而言。故本方选用多种养心安神之品组合而成。方中生地、玄参、麦冬、天冬滋心肾之阴以清热，使心神不为虚热所扰；丹参、当归补血养心；党参、茯苓补益心气；配远志、枣仁、柏子仁、朱砂宁心安神；五味子能养阴生津以收敛心气之耗散，又能敛汗；桔梗宣导胸中之气，以防大量滋补之腻滞，并使药力作用于上焦。合成补心安神、滋阴清热之剂。

（五）心阴虚经断诸证：

1.临床表现：精神抑郁，恍惚不定，知觉过敏，善惊喜静，情绪易于波动，睡眠不安；发作时，自觉烦闷急躁，或悲伤欲哭，或言行失常，或喜怒不节，或强直性痉挛。并多见口干，大便难。舌红少苔，脉细而数。

2.主证分析：多因忧思过度而心阴受损，以致经血内亏，不能濡养五脏，心阴耗，心阳偏亢，则阴阳平衡失调，浮火妄动，扰动心神，神不守舍，故出现上述不能自主的神志症状。

3.治疗法则：养心安神，和中缓急。

4.处方用药：甘麦大枣汤（《金匱要略》）加味。

北小麦、生百合各30克，生甘草、炒枣仁、生杭芍、生地黄各12克，黑芝麻15克，柏子仁、麦冬各9克，红大枣10枚（劈）。水煎2次分服。

按：本方是甘麦大枣汤加百合、白芍、枣仁、生地、黑

芝麻、柏子仁。

本病虽属虚证，不宜大补，虽有虚火，不宜苦降。故方中主以小麦味甘微寒，调养心阴而安心神，此即《内经》“心病者，宜食麦”，以小麦之甘平，养心缓急之意；取甘草、大枣甘平之味，以润燥缓急；百合、枣仁、柏子仁养心肝以安神；芍药敛阴以和脾；生地、麦冬养心阴生津润燥以止口渴；配黑芝麻养肝肾润燥以通便。诸药配合，有甘润滋养，和中缓急，安神定志之效。

第二章 带下病

“带下”二字，最早见于《内经》，如《素问·骨空论》中说：“任脉为病，男子内结七疝，女子带下，症瘕聚。”但在古典医籍中，“带下”又有广义，狭义之分。

广义的带下，是泛指妇科的经、带、胎、产诸病而言。因这些病都是发生在束带下的部位。如《史记·扁鹊仓公列传》即称擅治妇科疾病医生为“带下医”。

狭义的带下，是指妇女阴道内流出的分泌物而言。这种分泌物，是粘稠的液体，如涕如唾，绵绵不断，故称“带下”，因这种分泌物大多是白色的，所以通常也称为“白带”。

狭义的带下，又有生理和病理的不同。女子随着发育成熟，阴道内常有少量的白色透明无臭的分泌物，以湿润阴道，并作为御防物质，抵抗外来病邪的侵入。这种分泌物，当青春期、月经前后、排卵期或妊娠期稍有增加，这属正常的生理现象，称为生理性带下，不作病论。如妇女阴道内的分泌物异常增多，或色、质、味发生改变，并伴有某些症状者，则属病理性带下，即称“带下病”，这是本章讨论的主要内容。

带下病的类型，古籍分列甚多，有白带、白崩、黄带、赤带、赤白带、青带、黑带、五色带、白浊、白淫等。然临

床上最常见的是白带、黄带、赤带和赤白带四种。为了对古典医籍关于本病的描述有个概括的了解，故将常见与少见的所有类型均分别予以介绍。

在此必须强调指出的是，对带下病的治疗，还须结合妇科检查作出明确的诊断为好。现代医学不把带下异常当作一种病，而是把带下异常当作各种疾病的一个症状。因为内分泌异常、生殖器官炎症（阴道炎、宫颈炎、盆腔炎）、肿瘤（子宫颈癌、子宫体癌、子宫粘膜下肌瘤）等，均可出现不同类型的带下。所以对带下病的诊治，中西医结合尤为必要。

第一节 白 带

妇女阴道内分泌出来的稠粘、色白或如蛋清样而有腥味的液体，称为“白带”。

【病因病机】白带的病因病机，说法很多。如缪仲淳说：“白带，多是脾虚，肝气郁则脾受伤，脾伤则湿土之气下陷，是脾精不守，不能输为荣血而下白滑之物。”这是说明因气郁脾虚而造成带下。赵养葵则说：“带者奇经八脉之一也……八脉俱属肾经……下焦肾气损虚，带脉漏下。”而《景岳全书》说：“阳气虚寒，脉见微涩，色白清冷，腹痛多寒。”《济阴纲目》说：“本病由劳伤冲任，风冷据于胞中，气多于血，气倍生寒，血不化赤，遂成白带。”朱丹溪、薛己认为是湿痰下注。据上所述，可知白带病机不一。

归纳起来，可分脾虚、肾虚、风冷、痰湿等。

【辨证施治】凡属带下，总不离于湿。故带证病机，与脾密切相关，脾失健运，是产生白带病的内在原因，故治疗多以健脾、升阳、除湿为主。并结合临床见证，又有补肾、温经、祛痰、固涩止带等法。

（一）脾虚白带：

1.临床表现：带下色白或淡黄，有味，如蛋清样，连续不断；面色萎黄，四肢不温，精神疲倦，纳少腹胀，或大便溏薄，或面部下肢浮肿。舌淡，苔薄白腻，脉缓而弱。

2.主证分析：脾虚气弱，不能化湿，水湿之气，陷而为带；脾虚中阳不振，则面色不荣而呈萎黄，四肢不温；脾失健运，则纳少腹胀；脾虚不能化湿，转输失职，故大便溏薄，面肢浮肿。舌淡，苔白腻，脉缓弱，亦为脾气衰弱之征。

3.治疗法则：健脾益气，升阳除湿。

4.处方用药：完带汤（《傅青主女科》）。

白术15克，山药30克，党参12克，白芍、苍术、车前子各9克，陈皮、炒芥穗、柴胡、甘草各3克。水煎2次分服。

方中党参、白术、甘草补脾益气，苍术、白术健脾燥湿；白芍、柴胡、陈皮疏肝解郁，理气升阳；车前子利水除湿；炒芥穗入血分祛风胜湿。全方乃脾、肾、肝三经同治，具有健脾除湿升阳之功。

如腰痛者加杜仲、川断、菟丝子各12克。腹痛者加艾

叶、香附各9克。带下日久不止者，加鹿角霜、乌贼骨、巴戟天各9克。

（二）肾虚白带：

1.临床表现：带下清冷，量多，质稀如水，淋漓不断；面色晦暗，腰痛如折，小腹部有凉感，大便溏薄，小便清长。舌质淡，苔白，脉象沉迟。

2.主证分析：肾阳不足，寒湿内停，带脉失约，任脉不固，精液滑脱而下，故带下清冷量多，质稀如水；肾阳不足，命门火衰，不能下暖膀胱，上温脾阳，故小便清长，大便溏薄；腰为肾之府，肾虚失养，则腰痛如折；小腹为胞宫所居之地，肾虚不能温暖胞宫，故小腹有凉感。舌质淡，苔薄白，脉沉迟，均属肾阳虚衰之征。

3.治法法则：温补肾阳，除湿止带。

4.处方用药：内补丸（《女科切要》）。

鹿茸12克（可用鹿角霜30克代），炙黄芪60克，菟丝子、沙苑子、桑螵蛸、肉苁蓉各45克，白蒺藜，紫菀各30克，附子、肉桂各18克。上十味共研细末，炼蜜为丸、每丸重9克。每次2丸，日服2次，温开水送下。

方中鹿茸大补元阳，生精髓，益血脉；菟丝子补肝肾，固任脉；肉苁蓉壮肾阳；沙苑子温肾止腰痛；白蒺藜行气疏肝；肺肾相生，故用紫菀以温肺；桑螵蛸收涩固精；黄芪补气，附子，肉桂壮阳。全方有温肾壮阳益精止带之效。

（三）风冷白带：

1.临床表现：白带量多，清稀如水，面色苍白，形寒肢

冷，小腹急痛，小便清长。舌淡，苔白，脉沉迟无力。

2.主证分析：素体虚弱，冲任亏损，下元不足，感受风冷，阳气不振，故见上述诸证。

3.治疗法则：温经散寒，祛湿止带。

4.处方用药：加味吴茱萸汤（《证治准绳》）。

吴茱萸、北细辛各8克，当归、半夏、麦冬各9克、茯苓12克，丹皮6克，肉桂、干姜、防风、木香、炙甘草各5克。水煎2次分服。

方中用吴萸、肉桂、干姜之温热，以驱下焦寒邪；细辛、防风之辛温，以除外感风冷；半夏、茯苓和中渗湿；当归、木香调血理气；佐麦冬之甘凉，丹皮之辛凉，以防诸温药之燥热伤阴，而丹皮又具化瘀之功；甘草缓急止痛。诸药配合，具有辛温散寒，苦温渗湿，而无伤阴之效。

本方对冲任虚衰，月经不调，或崩漏下血，小腹疼痛等症之属于下焦虚寒者，用之亦效。

（四）痰湿白带：

1.临床表现：白带量多，形如痰涎，有腥味；身体肥胖，精神疲倦，头重眩晕，胸闷腹胀，口中淡腻，食量减少，痰多泛恶。舌质淡，苔白腻，脉弦滑。

2.主证分析：胖人多湿，湿邪下注，故带多如涎而有味；湿为阴邪，湿困脾阳，清阳不升，故神疲头重；湿滞中焦，气不宣畅，故胸闷腹胀，痰多纳少。口舌淡腻，脉弦滑，俱系湿盛痰阻之表现。

3.治疗法则：健脾渗湿，化气利水。

4.处方用药：胃苓汤（《证治准绳》）。

炒白术12克，制苍术、茯苓、猪苓、泽泻各9克，陈皮6克，桂枝、厚朴各4.5克，生甘草3克，大枣2枚，生姜2片。水煎2次分服。

脾为生痰之源，故方中用苍白二术健脾祛湿为主药；辅以二苓、泽泻通调水道，泄水利湿，以增强排湿下行之力；佐厚朴、陈皮消胀除满，理气和胃，且均能燥湿；桂枝一味，辛甘化阳，既能温通阳气，资助膀胱的气化功能，又能促使渗湿利水药物充分发挥作用；甘草、姜、枣调和脾胃，助其健运。诸药合用，使脾健湿除，带下自止。

第二节 白 崩

白崩一症，也是阴道中流出的一种白色如米泔样的粘液，其量较白带为多，状如崩冲，故称“白崩”。实际上就是严重的白带。

【病因病机】《巢氏病源》说：“白崩者，是劳伤胞络而气极，而为白崩也。”这是说因劳伤脾肾，使元气虚极而形成白崩。《妇科玉尺》说：“白崩多由思虑过度所致也。”这是指思考忧郁则伤脾土，脾伤则湿气不能运化而形成白崩。

【辨证施治】白崩的治法，可以参照白带的治法，但因比白带严重而病势较急，且身体素虚，因而在治疗时应偏重固涩。其临床见证多属脾肾虚损型。

（一）临床表现：白带质稀量多，其下如注；体质迅速

衰疲，头晕心悸，气短懒言，腰膝酸软。舌苔薄白，脉沉迟而细。

（二）主证分析：脾虚失运，水湿下迫，肾虚带脉失约，任脉不固，故带下量多如注；脾虚则化源不足，肾虚则精亏血少，气血两虚，不能奉养全身，故见头晕心悸，气短懒言，腰膝酸软等症。苔薄白，脉沉迟，是脾肾俱虚之候。

（三）治疗法则：健脾补肾，益气固涩。

4. 处方用药：四君子汤（局方）合苡菟丹（《和剂局方》）加味。

党参、炒山药各30克，炒白术、茯苓、莲子肉、金樱子、桑螵蛸各15克，菟丝子、巴戟肉各24克，五味子、炙甘草各6克。水煎2次分服。

按：本方是四君子汤（参、术、苓、草）、苡菟丹（茯苓、菟丝子、五味、莲子、山药）加桑螵蛸、金樱子、巴戟肉。

方中四君子益气健脾；山药、莲子、金樱子、桑螵蛸、五味子健脾固肾，并有涩精止带之效；菟丝、巴戟以温肾助阳。

若脾肾阳虚甚者，兼见口唇发青，四肢厥冷，可加熟附子9克，以回阳救逆。

按：白崩较白带更为严重，所以用药重在固涩。但此症系平素体虚，汤剂难见速效，王道之功，虚证缓图，据“丸者缓也”的原则，对本病的治疗，应制丸剂常服为宜。

第三节 黄 带

妇女带下色如黄茶浓汁，或黄绿色，质粘稠而臭秽者，称为“黄带”。

【病因病机】黄带多由脾脏湿盛所引起，脾土不健运而水湿蕴积，日久湿热化合，浸淫任脉而成黄带。张景岳谓：

“妇人带下色黄者属脾。”《傅青主女科》说：“有带下而色黄者，宛如黄茶浓汁，其气秽臭，所谓黄带也。”《妇科易知录》说：“任脉积湿，湿盛主热，因不能生精化血，故腐败而成黄带。”《女科证治约旨》说：“因思虑伤脾，脾土不旺，湿热停聚，郁而化黄，其气臭秽，致成黄带。”这些是古人认为造成黄带的原因。但亦有感受湿毒而引起者。在临床上须分别处理，才能达到治愈的目的。

【辨证施治】治疗黄带的方法，当以清热化湿解毒为主，虽有因思虑伤脾而导致黄带者，总与脾土不旺，湿热易于停聚是分不开的。若日久不愈，转属虚证，则宜健脾益气为主。

（一）湿热黄带：

1. 临床表现：带下量多，色黄如脓，粘稠，秽臭，阴部瘙痒，小便短赤或频数。舌质红，苔黄腻，脉滑数。

2. 主证分析：湿热蕴结，损伤任、带二脉，以致秽浊之液下注，故色黄如脓、量多、粘臭；湿热浸淫，腐蚀阴部，故见阴痒；湿遏热伏，膀胱受灼，津液损耗，故小便短赤频数。舌红，苔黄，脉滑数，皆为湿热内蕴之象。

3. 治疗法则：清热利湿止带。

4. 处方用药：易黄汤（《傅青主女科》）加味。

炒山药、芡实各30克，土茯苓、赤茯苓、白茅根各15克，滑石12克，白果肉、前车子各9克，黄柏6克，生甘草3克。水煎2次分服。

按：本方是易黄汤加土茯苓、赤茯苓、茅根、滑石、甘草。

方中山药、芡实健脾固肾；茅根、车前、滑石清热利水；土茯苓祛湿解毒；黄柏清热燥湿；白果止带除浊；生甘草清热泻火，并调和诸药，以防过利伤阴。

（二）湿毒黄带：

1. 临床表现：带下量多，色黄绿如脓，或挟血液，或浑浊如米泔，有秽臭气；阴中瘙痒，或灼热肿痛，或小腹疼痛，小便赤涩尿痛，口苦咽干。舌质红，苔黄腻，脉滑数。

2. 主证分析：湿毒内侵，损伤冲任二脉，以致蕴而生热，秽浊下流，故带下色黄绿如脓，或浊如米泔，如伤及血络，则带中挟血；湿热毒邪，浸淫阴部，故气秽阴痒，灼热肿痛；湿毒波及膀胱，故小腹拘痛，溲赤短少，尿道涩痛，灼热伤阴，津液损耗，故口苦咽干。舌红苔黄，脉滑数，亦是湿毒内蕴之征。

3. 治疗法则：清热利湿解毒。

4. 处方用药：止带方（《世补斋·不谢方》）加减。

茯苓、茵陈、银花、蒲公英各15克，土茯苓30克，车前子、泽泻、赤芍、丹皮、山栀子、黄柏、连翘、川牛膝各9克。水煎2次分服。

按：本方是止带方去猪苓，加土茯苓、银花、连翘、公英、梔子、黄柏等一派清热燥湿解毒之品，以消除病源；湿阻血亦滞，故用赤芍、丹皮凉血化瘀；牛膝引药下行。毒解湿除，带下自愈。

以上两型，均有阴痒见症，可选用后列外治方，以减轻症状，缩短疗程。

【外治方】

（一）冲洗液：蒲公英450克，黄柏360克，荆芥180克，紫草270克，蛇床子450克，白矾45克。

制法和用法：除白矾外，将上药反复熬煎成6000毫升，然后放白矾在药液内溶解，过滤，加入5%石炭酸30毫升，瓶装备用。每次用药液100毫升加温开水400毫升，共成500毫升，以妇科冲洗器用药液冲洗阴道、宫颈。具有消炎抑菌、清洁阴道、止带之效。

（二）擦剂：白藓皮粉、蒲公英粉、半边莲粉、蛇床子粉各45克，樟脑9克，95%酒精60毫升。

制法和用法：将樟脑溶于60毫升酒精中，上药混合过筛，与樟脑酒调匀。先以妇科冲洗器冲洗宫颈、阴道，然后擦于宫颈面上，隔日冲洗及用药1次，10次为一疗程。具有消炎、抑菌、止痒作用。

（三）坐盆熏洗方：防风、荆芥、黄柏、苦参各9克，蛇床子、地肤子各12克，银花15克，白矾6克（用药液溶化）。每次1剂，煎水熏洗。每日2次。具有止带止痒的作用。

第四节 赤 带

妇女带下色红而浊粘有臭味者，称为“赤带”。

【病因病机】赤带一证，亦不能离乎湿。古人云：“色赤属心，心属火，见赤者，火热之故也。”因此，大都认为系湿热为患。缪仲淳说：“赤带多因心肝二火，时炽不已，久而阴血渐虚，中气渐损，遂下赤带。”他认为是血虚火旺之故。而傅青主则谓：“带脉通于肾，肾气通于肝，妇人忧思伤脾，又加郁怒伤肝，于是肝经之郁火内炽，下克脾土，脾土不能运化，致湿热之气蕴结于带脉之间，而肝血亦渗于带脉之内，皆脾受伤，运化无力，湿热之气，与血俱下，所以似血非血之形象，现于其色。”总之，赤带的成因，有因湿热为患的，有因心肝火盛以致阴血亏损的，也有因气虚不得摄血的，大概初起者以湿热和心肝火炽的实证居多，久病者则气血亏损的虚证为多。

现代医学认为阴道的血性分泌有：排卵期出血、生殖器官炎症、肿瘤等，卵巢功能失常时，或月经前后，以及分娩、流产、阴道手术或经期不禁房事，直接感染病邪，也可造成赤带。

【辨证施治】赤带的治法，湿热盛者，宜清热利湿，但临证时需辨别湿重于热，或热重于湿，不可执一而论；阴虚火盛者，宜滋阴清火；气血虚弱者，宜益气养血。应根据辨证施治的原则，灵活化裁，方可中的。

（一）湿热赤带：

1. 临床表现：带下色赤量多，似血非血，浊粘腥臭，淋漓不断；烦躁不安，小便短赤，口苦咽干。舌红，苔厚腻或带黄色，脉滑数。

2. 主证分析：湿热蕴结，损伤任带二脉，以致带下色赤，气臭；湿热之邪内扰心神，故烦躁不安；热耗津液，故口苦，咽干，小便短赤。舌红，苔黄腻，脉滑数，皆湿邪内踞化热之象。

3. 治疗法则：凉血解毒，健脾利湿。

4. 处方用药：加减清胞饮（《中医妇科手册》）。

茯苓15克，车前子12克，当归、白芍、黄芩、栀子、生侧柏、地骨皮各9克，黄柏、陈皮各6克，生甘草3克。水煎2次分服。

按：本方是加减清胞饮去知母加侧柏叶。

方中茯苓、车前健脾利湿；当归、白芍敛肝阴，和营血；黄芩、黄柏、栀子苦寒燥湿泻热；地骨皮凉血泻火，以除烦渴；生侧柏既能燥湿，又能凉血止血；生甘草泻火解毒，且能缓解尿痛。

若带下色赤，稠粘秽臭，淋漓不断，兼见精神抑郁，烦躁易怒，胸闷不畅，乳房作胀，头晕目眩，口苦，咽干，舌红，苔黄腻，脉滑者，乃肝郁化火，湿热互结，流注下焦，损伤任带之候。治宜泻肝清热，利湿止带。用龙胆泻肝汤（《和剂局方》）。

龙胆草6克，柴胡、黄芩、栀子、生地、当归、车前

子、泽泻各9克，木通、生甘草各6克。水煎2次分服。

本症是由肝胆实火和湿热下注所致。故方中以龙胆草大苦大寒，泻肝胆实火，除下焦湿热为主；黄芩、栀子泻火清热，协胆草益增其泻火之力为辅；木通、泽泻、车前清热利湿，助胆草清利下焦湿热，使从小便而出；当归、生地养血益阴以和肝，与上药配伍，意在泻中有补，疏中有养，使泻火之药不致苦燥伤阴，亦可防止因肝胆火盛而耗伤阴液，以使邪去而不伤正，俱以为佐；由于肝胆性喜条达，火邪内郁而肝气不舒，故又用柴胡疏畅肝胆之气，甘草协和诸药，缓急调中，皆为之使。诸药配合，而有泻肝火利湿热的作用。

（二）阴虚赤带：

1. 临床表现：带下色赤，似血非血；头眩眼花，心悸少寐，心烦口渴，大便干燥。舌绛少苔，脉象细数。

2. 主证分析：阴血亏虚，心火内炽，中气渐损，遂下赤带；虚火上炎，则头眩眼花；内热扰心，故心悸烦躁而少寐；阴虚热灼，津液亏耗，故口渴便秘。舌绛少苔，脉象细数，乃血虚有热之征。

3. 治疗法则：滋阴清热。

4. 处方用药：保阴煎（《沈氏尊生书》）加味。

生地、熟地各15克，炒山药30克，续断12克，麦冬、当归、炒白芍、黄芩各9克，黄柏16克，生甘草3克。水煎2次分服。

按：本方是保阴煎加麦冬。

方中二地、归、芍滋阴养肝以和血，麦冬清心润肺以除

烦渴；山药益脾固肾以止带；续断补肝益肾以止血；黄芩、黄柏清热燥湿；生甘草和中泻火。全方具有补而不滞，清而不伐之效。阴血得充，虚热得除，则赤带自愈。

若血虚肝旺，证见赤带，粘稠腥臭，胸闷胁痛，乳房胀痛，性情急躁，易于动怒，脉象弦细或弦数者，宜补血制火，用清肝止淋汤（《傅青主女科》）。

熟地、黑小豆各30克，生地、当归、炒白芍各15克，阿胶珠、丹皮各9克，黄柏、牛膝各6克，香附3克，红枣2枚（劈）。水煎2次分服。

方中二地、归、芍滋阴养肝以和血；黑小豆养血平肝，补阴除热；阿胶养阴润燥，补血止血；佐丹皮凉血化瘀以防大补之滞血，佐香附疏肝理气以防骤补之滞气；少量苦寒之黄柏以泻火；牛膝引药下行；红枣甘平以和胃。

原注云：“此方但主补肝之血，全不利脾之湿者，以赤带之为病，火重而湿轻也，火之旺由血之衰，故补血即足以制火，第少加清火之味。”

（三）气虚赤带：

1. 临床表现：带下色赤，量少清稀，缠绵久延，淋漓不止；精神倦怠，胃呆纳少。舌淡苔白，脉象细弱。

2. 主证分析：中气不足，不能摄血，故带下色赤，缠绵久延；气虚不支，故精神疲倦；脾虚失运，故胃呆纳少。舌淡苔白，脉细弱，均气血不足之象。

3. 治疗法则：补中益气，祛湿止带。

4. 处方用药：补中益气汤（《脾胃论》）加味。

炙黄芪30克，党参15克，炒白术12克，茯苓、半夏、当归、白芍各9克，陈皮、柴胡、升麻、炙甘草各6克，炮姜炭1.5克。水煎2次分服。

按：本方是补中益气汤加芍药、茯苓、半夏、炮姜。

本症乃久病致虚，中气不足，不能摄血之候，应宗“虚者补之”、“陷者举之”、“劳者温之”的原则为治。故用补中益气汤调补脾肺，升阳益气为主。加白芍配当归以敛阴养血；加半夏、茯苓伍白术以增强和胃除湿之力；加炮姜以温中摄血。如此气血双顾，气足阳升，血充湿祛，则赤带自止。

第五节 赤白带

妇女带下而见赤白相杂味臭者，叫做“赤白带”。

【病因病机】赤白带下为妇科常见病，病因较为复杂。《医宗金鉴》说：“赤白带下时臭，乃湿热腐化也。”《张氏医通》说：“赤白带下积久不愈，必有瘀血留着于内。”《妇科玉尺》说：“妇人多思虑怒，损伤心脾，血不归经，而患赤白带下。”又说：“脉见沉微，赤白带下，腹中痛，阴中亦痛，经水愆期，子宫虚冷也。”“内火盛，阴虚烦热而赤白带下。”以上所说，是古人对赤白带下病因病机的认识，归纳起来，大概可分为湿热、血瘀、气郁、虚寒、虚热五种。

【辨证施治】治疗的方法，与上述诸种带下相同，应辨证求因，然后对症投药。

（一）湿热赤白带：

1.临床表现：带下赤白相杂而量多，粘腻秽臭；胸脘痞闷，胃呆纳少，少腹胀胀，阴户瘙痒。舌红苔腻，脉滑而数。

2.主证分析：湿热互结，湿滞气亦滞，故胸闷胃呆；湿热下注，故带量多，少腹胀胀；湿热之物，浸淫局部，故阴户瘙痒。舌红苔腻，脉滑数，均湿热内蕴之征。

3.治疗法则：清热化湿。

4.处方用药：胜湿丸（《女科指要》）。

制苍术30克，炒地榆、醋炙樗根皮、炒白芍、飞滑石各60克，炒枳壳9克，炮姜炭、生甘草各15克。共研细末，神曲糊为丸，绿豆大。每次9克，日服2次，白开水送下。亦可适量改为汤剂煎服。

方中苍术燥湿健脾；白芍敛阴和营；地榆苦寒性降而酸涩，具有凉血收敛止血之功；樗根皮苦涩性寒，能燥湿清热，固下止血；滑石甘寒，清热利湿；枳壳苦凉，降气宽中，消痞除胀；炮姜炭辛热，温经止血，湿热之证而用辛热之品，是属反佐之法，意在防止大量寒凉而伤阳，且与之相伍，实得相反相成之妙；生甘草清热解毒，并调和诸药。

若湿热过重，带下恶臭，阴中肿痛腐烂者，宜清热解毒，用八仙饮（《产科发蒙》）加味。

土茯苓、鱼腥草、银花各30克，茯苓15克，当归、生大

黄各 9 克，木通、陈皮、川芎、生甘草各 6 克。水煎 2 次分服。

按：本方是八仙饮加鱼腥草、甘草。

方中土茯苓、鱼腥草、银花、生大黄等大量相配，有较强的清热解毒作用；当归、川芎活血化瘀；茯苓渗湿利水，木通清热导湿，合大黄使湿热毒邪，从二便排出；生甘草清热解毒，缓急止痛。

（二）血瘀赤白带：

1. 临床表现：带下赤白；少腹满痛，行经困难，或经行超前，或一月两潮。舌质紫黯，脉象迟涩。

2. 主证分析：瘀血留着，湿运不利，故带下赤白；瘀血内阻，血行不畅，故腹痛胀满，月经不调。舌黯，脉涩为血瘀之表现。

3. 治疗法则：活血化瘀。

4. 处方用药：桃仁散（《证治准绳》）。

炒桃仁、当归、赤芍、川牛膝、党参、丹皮、蒲黄各 9 克，生地、泽兰各 15 克，川芎、肉桂各 6 克，生甘草 3 克。水煎 2 次分服。

方中生地、当归以养血；赤芍、桃仁、川芎、蒲黄、泽兰、丹皮活血化瘀；牛膝活血通经；配肉桂之辛热以鼓舞血行，并防寒凉伤阳；党参、甘草补中益气。全方组合，实寓补于破之中，使邪去而不伤正。

或用益母膏（《惠直堂经验方》）。

益母草 5000 克。煎 2 次，去渣，将 2 次药汁合兑再熬，

待浓，入红糖适量收膏瓶贮备用。每次1茶匙，日3次，黄酒或温开水冲服。

若正产、滑胎，或人工流产后，赤白带下，缠绵不断，淋漓不净，少腹时痛者，宜和血化瘀，温经止痛。用生化汤（《傅青主女科》）。

当归30克，川芎、桃仁各9克，炮姜炭、炙甘草各3克。水煎服。

方中重用当归补血活血为主药，辅以川芎行气活血，配桃仁则活血祛瘀，伍炮姜则温经止血，合甘草则和中止痛。本方具有化瘀生新作用，故以“生化”为名。

（三）气郁赤白带：

1.临床表现：赤白带下；胸胁胀痛。乳房作胀，饮食不香，或少腹胀痛。苔薄白，脉弦而数。

2.主证分析：肝气郁结，郁而化火，故带下赤白；气滞不舒，故胸腹胀痛；肝木克脾，健运失权，则饮食不香。脉弦数，是肝郁化热之征。

3.治疗法则：疏肝和脾，凉血泻火。

4.处方用药：丹栀逍遥散（见月经先期）。或用苦楝丸（《济阴纲目》）。

川楝子（即金铃子）、小茴香、当归各6克。共研细末，黄酒合神曲打糊为丸，绿豆大。每次6克，日服3次，黄酒适量或温水送下。

川楝子苦寒性降，能疏泄肝热，解郁止痛；小茴香辛温芳香，能疏肝理气，温脾开胃；当归甘补辛散，苦泄温通，

既能补血，又能活血，兼行气止痛，为血病之良品。盖肝气得舒，郁火得散，血得归经，则带下自愈。三药配合，药简力宏。故原书指出：“此方治赤白带下甚妙。”

（四）虚热赤白带：

1. 临床表现：带下赤白量多；面色无华，时或颧红，头目眩晕，精神不振，五心烦热，心悸少寐。舌淡红少苔，脉虚细而数。

2. 主证分析：阴血亏损，虚而生热，热扰血络，故带下赤白相兼；血虚不荣于面，则面色无华；阴虚则潮热，故两颧有时发红；热扰心神，故五心烦热，心悸少寐。舌淡少苔，脉虚细而数，乃血虚有热之象。

3. 治疗法则：补阴血，除虚热。

4. 处方用药：柴芩四物汤（《和剂局方》）加味。

熟地、生地各15克，当归、炒白芍、女贞子、旱莲草各9克，北柴胡、黄芩、川芎各6克。水煎2次分服。

按：本方是柴芩四物汤加女贞子、旱莲草、生地。

方中四物汤补肝养血，生地、旱莲、女贞补肝肾之阴以除蒸热；柴胡疏解气机之壅滞，以制诸阴药之呆腻；黄芩苦寒直折以解内热之留恋。阴血得补，虚热自除，带下可期而愈。

（五）虚寒赤白带：

1. 临床表现：赤白带下，延久不止。证见面色苍白或萎黄，唇色淡白，头晕目眩，形寒肢冷，腰酸乏力，腹痛绵绵，喜得热按。舌淡苔白，脉象沉紧而细。

2. 主证分析：带下久延，阴损及阳，气虚滑脱，故带下

不止；阳气虚衰，不荣于面，故面色苍白或萎黄，唇色淡白；清阳不升，则头目眩晕；脾阳虚则四肢欠温，形寒怕冷；肾阳虚则腰酸乏力；寒邪内滞，则腹痛不休，喜热喜按。舌淡苔白，脉沉紧而细，为阳虚寒盛之象。

3. 治疗法则：温经祛寒，固涩止带。

4. 处方用药：鹤顶丸（《女科准绳》）加味。

当归、黄芪、煅龙骨、煅牡蛎、煅赤石脂各60克，炒吴萸、炮干姜、熟附子、艾叶炭各30克。共为细末，醋泛为丸，绿豆大。每次9克，日服2~3次，温开水送下。亦可适量改为汤剂煎服。

按：本方是鹤顶丸加黄芪。

方中当归、黄芪益气补血；附子、炮姜、吴萸、艾叶温经扶阳，祛寒止血；黄芪配附子升阳；续断强腰膝，健筋骨，并能止血；龙牡、石脂皆煅用，以加强固脱止带之效。

第六节 青 带

妇女带下色如绿豆汁，粘腻不断而味臭者，称为“青带”。

【病因病机】青带在临床上比较少见。病因是肝经湿热所致。《傅青主女科》说：“夫青带乃肝经湿热。”《妇科易知录》说：“肝经湿热停住中焦，走于胞宫，郁逆之气，积久腐化酝酿而成。”

据临床所见，滴虫性阴道炎有时表现为青带。因滴虫性

带下本为黄绿色，如加上少量血性分泌物即呈绿豆汁状。赤带合并绿脓杆菌感染者，也会出现青带。

【辨证施治】 排除滴虫性带下（见杂病阴道炎项下）外，对本病的治法，主要是解肝经之火，利膀胱之湿为主。若日久不愈，则宜补益肝肾。

（一）湿热青带：

1.临床表现：带下青色如绿豆汁，或黄白带青，且有臭气；面色苍黄，精神抑郁，胸胁闷痛，食欲不振。舌质红黯，舌苔黄腻，脉象弦涩而数。

2.主证分析：肝经湿热下注，故带下色青或黄白带青；肝郁气滞，故精神不爽，胸胁闷痛；肝木横逆，克制脾土，故食欲不振。舌质红黯，舌苔黄腻，脉象弦涩而数，乃湿热蕴结之象。

3.治疗法则：疏肝泻热，祛湿止带。

4.处方用药：逍遥散加减方（《傅青主女科》）。

茯苓、生甘草、茵陈各15克，栀子、炒白芍各9克，柴胡、陈皮各6克。水煎2次分服。

原书注解：此方解肝木之火，利膀胱之水。煎服二剂而色淡，四剂而青绿之色绝，不必过剂矣。夫逍遥散之立法也，乃解肝郁之药耳，何治青带如此神欤？盖湿热之留于肝经，因肝气之郁也，郁则必逆，惟逍遥散能解其郁逆而使之逍遥，而又益以茵陈之利湿，栀子之清热，郁逆既解，肝气得清，湿热自去，此方之所以奇而效捷也。倘仅以清热利湿治带，而置肝气不问，带安得而止哉。

（二）虚损青带：

1. 临床表现：青带久下不止；头痛绵绵，眩晕耳鸣，目昏涩紧，视物不清，作痛畏明，咽喉干燥。舌红苔少，脉弦细兼数。

2. 主证分析：肝病日久，久病及肾，致肝肾两虚，肾主骨生髓，脑为髓之海，肾虚不能养脑，故头痛目眩耳鸣；肝受血而能视，今肝阴亏损，不能上奉于目，故目昏涩紧，视物不清，作痛畏明；阴亏津乏，则咽喉干燥。舌红苔少，脉弦细兼数，乃肝肾阴虚之候。

3. 治疗法则：补益肝肾。

4. 处方用药：济阴地黄丸（《证治准绳》）。

熟地黄、炒山药、枸杞子、肉苁蓉、当归、山茱萸、菊花、麦冬、巴戟肉、五味子各等份。共研细末，炼蜜为丸，梧子大。每次9克，日服3次，温开水送下。亦可适量改为汤剂煎服。

方中熟地、山药、山萸、枸杞补益肝肾之阴；阳生则阴长，故辅苁蓉、巴戟以扶肾阳；菊花平肝明目；肺为水之上源，金水相生，故佐麦冬、五味以敛浮火而滋肺阴。总之是乃足三阴并补之方，对三阴亏损，虚火上炎所致诸证，自能奏效。治病必求其本，本固而标除，带下自愈。

第七节 黑 带

妇女带下色如黑豆汁，或粘或稀而腥臭者，称为“黑

带”。

古人所说的黑带，似是赤带中夹有黑色。但晋代书籍中对崩漏带下，分析不清，如《脉经》上说：“黑崩者形如衃血。”其他如“黄崩”、“青崩”等名称，实际上是“黄带”、“青带”的异名，那么“黑崩”自然是指黑带而言。

现在临床上所观察到的黑带，多为器质性病变所致，如粘膜下子宫肌瘤，子宫颈癌、阴道癌等。故治疗时应排除上述器质性病变。

【病因病机】《傅青主女科》说：“夫黑带者，乃火热之极也。”《巢氏病源》则说：“漏下黑者，是肾脏虚损，故漏下而挟黑也。”根据古人的认识，黑带的病因是热极和肾虚两类。

【辨证施治】

（一）火热黑带：

1.临床表现：带下色黑，粘稠臭秽；面色苍赤，心烦口渴，或阴中肿痛，或小溲赤涩刺痛。舌绛苔剥，脉数弦大。

2.主证分析：火热熏蒸，故带下色黑，粘稠臭秽，面色苍赤；热灼津伤，则口渴；热扰心神，则心烦；湿热蕴毒，则阴肿尿痛。舌绛苔剥，脉数弦大，乃火热伤阴之征。

3.治疗法则：清热泻火。

4.处方用药：利火汤（《傅青主女科》方）。

生大黄、生山梔、肥知母、茯苓、车前子、王不留行、刘寄奴各9克，黄连8克，炒白术15克，生石膏24克。水煎2次分服。

方中大黄、黄连、栀子苦寒直折以泻盛极之火热；知母、石膏滋阴泻火以保津；白术、茯苓、车前健脾导湿；王不留、刘寄奴活血通经，清热消肿，利湿通淋。诸药组合，标本两顾，对火极带下，尤为恰贴。

（二）肾虚黑带：

1. 临床表现：带下赤色之中挟有黑色，且有臭气；面色苍白有时颧部发红，头目眩晕，心悸烦热，夜寐不安，午后潮热，咽干口渴或咽痛，腰膝酸痛，皮肤干枯，大便干结，小溲短黄。舌质红绛，舌苔花剥或少苔，脉象细数。

2. 主证分析：阴亏火旺，带液被灼，故色黑气臭；虚火上炎，则颧红，头眩；热扰心神，则夜寐不安，心悸烦热；阴虚则潮热；肾虚则腰膝酸痛；阴亏失润，故皮肤干枯，便秘溲黄。舌绛，苔剥，脉细数，俱阴虚火旺之征。

3. 治疗法则：滋肾阴，泻相火。

4. 处方用药：加味固阴煎（《女科证治约旨》）。

生地黄18克，炒白芍、炒山药各12克，知母、茯神、秋石、阿胶珠各9克，黄柏6克，生龙骨、生牡蛎各30克。水煎2次分服。

方中生地、白芍、山药养肝肾、滋阴液；知母养阴生津，以退蒸热；秋石滋阴液，除伏热，并能通淋利水；阿胶补阴血，黄柏燥湿热；茯神、龙骨、牡蛎益阴潜阳，镇心安神。本方对命门火旺，肾水受煎，下焦所郁之湿热而引起的黑带，当具效验。

第八节 五色带

妇女带下青、黄、赤、白、黑五色相杂有秽臭恶气，时下不止者，称为“五色带”。

五色带，在《脉经》上称为“五崩”，及至《巢氏病源》始有五色带下之名。《医宗金鉴》说：“若是内溃，则所下之物，杂见五色，似乎脓血，若更有脏腐败气，且时下不止而多者，是危证也，其命必倾矣。”从这里可以看出古人早已认为五色带是一种严重的疾病。

根据现在临床观察到的五色带下，大多是生殖器官的肿瘤，或恶性肿瘤合并感染所致。兹将前人的病因证治予以介绍，姑作参考。

【病因病机】 《巢氏病源》说：“五脏俱虚者，故其色随秽液而下，为带下五色。”《世医得效方》也说：“五脏俱虚，五色并下，是皆血之为病也。”《医宗金鉴》则说：“若是内溃，则所下之物，杂见五色。”根据古人的学说，有因五脏俱虚的，也有因湿热为病者。

【辨证施治】

（一）脏虚五色带：

1. 临床表现：五色带下，久而不止，面色苍白，精神倦怠，畏寒怕冷，头目眩晕，腰酸乏力，大便溏薄。舌淡苔薄，脉象沉迟无力。

2. 主证分析：气血俱虚，中阳下陷，故带下五色，久而

不止；血不荣于面，故面色苍白；阳气不振，则倦怠怕冷，头眩腰酸；脾阳虚衰，运化无权，故大便溏薄。舌淡苔薄，脉沉迟无力，乃气血俱虚之候。

3. 治疗法则：补虚固湿。

4. 处方用药：胃风散（《易简方》）。

人参、炒白术、茯苓、当归、炒白芍、川芎、肉桂各等份。轧为粗散，每服15克，加粟米100粒，水煎空腹温服。

《女科指要》云：“风入胞门，遍传脏腑，乃致带下五色焉。人参扶元气，白术燥湿健脾，当归养血以荣脉，白芍敛阴以益阴，茯苓渗伏结之湿，川芎行血中之气，肉桂暖血御风，粟米益脾以壮胃也。水煎温服，使脾胃内强，则外邪不复逗留，而脏腑之气自然肃清，何带致五色之患哉？”

外用吴茱萸浴汤（《女科指要》）。

吴茱萸、木香、丁香、五味子、杜仲各15克，蛇床子30克。水煎汤，乘热熏洗。

原注云：“寒湿袭虚，伤脏气而带下五色，服煎药不能速者，立此洗法以重之。”

（二）湿热五色带：

1. 临床表现：带下五色，粘腻如脓，秽臭异常；胸闷纳少，口苦粘腻，少腹胀痛，小溲黄浊。舌苔黄腻，脉滑数。

2. 主证分析：湿热内蕴，迫浊下注，则带下五色，脓臭异常；湿热相阻，气机不畅，故口苦粘腻，胸闷纳少，少腹胀痛，小溲浊黄。苔黄腻，脉滑数，是湿热内蕴之象。

3. 治疗法则：清热利湿，排脓解毒。

4. 处方用药：五味消毒饮（《医宗金鉴》）加减。

银花、鱼腥草、冬瓜仁各30克，蒲公英、地丁、连翘、生薏仁、生地榆各15克，野菊花，黄柏各9克，生甘草6克。水煎2次分服。

按：本方是五味消毒饮去天葵子、加连翘、地榆、黄柏、薏仁、冬瓜子、鱼腥草、甘草。

方中银花、连翘、野菊、地丁、公英、鱼腥草俱是清热解毒之品；地榆、黄柏清热燥湿，止血消肿；薏仁、冬瓜仁利湿止带，排脓消痈；生甘草泻火解毒，并调和诸药，以防寒凉伤胃。

第九节 白 浊

妇女从尿道中流出一种秽浊如脓粘稠分泌物，叫做“白浊”。

古人更有白浊、赤浊的分别，其实赤浊是白浊中混有血液，原是同一病证。白浊初起时，小便时尿道涩痛，如火灼刀割，浊液下流，状如米泔，或如粉糊，或如疮脓，或如目眵。淋漓不断，所以古人又称“淋浊”。

但女子白浊，与白带容易混淆不清，在问诊时，应详为追询以往病史，注意初起时有无小便涩痛，尿液浑浊，自易解别清楚。

【病因病机】《医学心悟》说：“白浊之因有二：一由肾虚败精流注，一由湿热渗入膀胱。”这是白浊病的两大原

因。《通俗妇科学》说：“或其夫与不洁之妇交接，因而累及其妻。”这说明在旧社会因宿娼等不洁交媾，感染而来。但临床上现已少见。

【辨证施治】

（一）湿热毒邪白浊：

1. 临床表现：白浊黄白如脓，或浊中夹有血液，小便赤涩，刺痛难忍，溲色黄脓浑浊或溲中夹血。

2. 主证分析：湿热下注，毒邪感染，致尿道焮肿，或溃烂，排尿困难，尿道受激，故浊液淋漓，溲时刺痛，或夹有血液。

3. 治疗法则：清热利湿解毒。

4. 处方用药：龙胆泻肝汤（见湿热赤带）。或用琥珀分清泄浊丸（验方）。

琥珀30克，生大黄300克。共研为细末，用鸡蛋清24个，杵为丸，梧子大，朱砂为衣。每次9克，日服2～3次。空服温开水送下。

（二）肾虚白浊：

1. 临床表现：白浊下流，淋漓不断，形如凝脂，小便频数清白，溺时不痛，尿后遗有余沥，疲倦乏力，腰膝软弱。脉迟无力。

2. 主证分析：肾虚失摄，精液不固，故白浊下流，淋漓不断，溲有余沥，非热非毒，不肿不溃，故小便清白，溺时不痛，肾虚不支，则疲惫腰软。脉迟无力，乃肾虚之征。

3. 治疗法则：补肾固摄。

4.处方用药：六味地黄丸合萆薢分清饮加味。

熟地24克，炒山药、粉萆薢、桑螵蛸各12克，乌药、益智仁、山萸肉、丹皮、茯苓、泽泻各9克，节菖蒲6克。水煎2次分服。

按：本方是六味地黄汤合萆薢分清饮加桑螵蛸。

方中六味地黄汤滋阴补肾；萆薢利湿去浊；益智仁、桑螵蛸温肾阳，缩小便；乌药温肾化气，菖蒲化浊通窍。诸药配合，有益肾利湿，分清去浊的作用。本方通中有涩，利湿又能固肾气；涩中有通；缩尿又能分清去浊，通涩并用，更适于肾气虚弱，湿浊下注的白浊症。

第十节 白 淫

妇女从阴中流出白色无臭的液体，叫做“白淫”。

考古代文献记载，白淫和白浊大都混淆在一起，实际是两种疾病，不能混为一谈。

【病因病机】《素问·痿论》说：“思想无穷，所愿不得，意淫于外，入房太甚，宗筋弛纵，发为筋痿，及为白淫。”这是说由于情欲不遂，思念太过，及房室过度引起白淫。《女科指要》说：“白淫乃思想无穷，情欲不遂，一时放白，寡妇尼姑此症居多，乃郁火也。”根据古人的认识，其病因不外郁火和肾虚两种。如无任何症状表现，偶尔发生白淫，不为病态。

【辨证施治】

（一）郁火白淫：

1. 临床表现：时下白淫，烦躁不安，或有潮热。舌质红苔薄，脉弦数。

2. 主证分析：情欲不遂，肝火抑郁，故见白淫时下，烦躁不安，潮热等症。舌红苔薄，脉弦数，乃肝火内炽之象。

3. 治疗法则：开郁泻火。

4. 处方用药：丹栀逍遥散（见月经先期）。

若火盛伤及气阴，证见心烦少寐，掌心灼热，咽喉干燥，腰腿酸软，夜有梦交，舌红或溃烂，中心光剥，脉象细数。宜清心泻火，用清心莲子饮（《和剂局方》）。

莲子肉、党参、炙黄芪、赤茯苓各12克，地骨皮、麦冬、黄芩、车前子各9克，北柴胡6克，炙甘草3克。水煎2次分服。

气阴两虚，阴虚则心火上炎，心烦口苦咽干，口舌生疮，气虚则中气不足，湿热蕴积，而下白淫。故方中用党参、黄芪、甘草补气而清虚火；麦冬、黄芩清上焦心肺之热；地骨皮退肝肾之虚热，与疏肝胆之火的柴胡相伍，不独能加强清除虚热的作用，且李东垣用此二味（地骨皮汤）以治心移热于小肠，口舌糜烂之症；赤苓、车前清利膀胱湿热；莲子（原方系石莲子，无真货，故用莲子）益肾固精，交通心肾。气阴既复，心火得泻，肾气得固，则白淫自止。

（二）肾虚白淫：

1. 临床表现：无梦交现象，而阴中象性欲冲动时的粘液下注，不时发作；面色苍白，头晕目眩，两颧红赤，心中烦

热，腰腿酸软。舌中心光剥，或有裂纹，脉象虚细。

2.主证分析：肾虚不固，故白淫不时下流，髓虚不能养脑，不华于面，故头晕目眩，面色苍白；虚火上炎，则颧赤心烦；腰为肾之府，肾虚则腰腿酸软。舌苔光剥，脉虚细，为肾虚之征。

3.治疗法则：补肾益气，固涩下元。

4.处方用药：固精丸（《济生方》）。

煅龙骨、煅牡蛎、菟丝饼、炒韭子、煅白石脂、桑螵蛸、焙五味子各90克，茯苓30克。共为细末，炼蜜为丸，每丸重9克。每次1丸，日服3次，淡盐汤送下。

方中龙骨、牡蛎、石脂俱甘咸酸涩收敛固摄之品，煅制更增其固摄之效；桑螵蛸、菟丝子、韭菜子补肾助阳，固精缩尿；茯苓淡渗除湿，五味子入心肾，酸敛以收浮阳，并能涩精止遗。病机是肾虚失摄，滑脱不固，故药用补益精气以治本，大量固涩以治标，标本兼顾，白淫自止。

第三章 妊娠病

妇女妊娠期间，发生与妊娠有关的疾病，称为“妊娠病”，古书统称“胎前病”。由于妊娠期生理上的特殊变化，带来一些妊娠期的特有疾病，这些疾病的诊断与治疗，比其他疾病更为重要，因为它影响孕妇的健康，又会影响胎儿的发育，所以应给予高度重视。

诊治妊娠病，必须首先明确是否妊娠，尤其是早期妊娠的诊断尤为重要。倘若误孕为病，妄肆攻伐，或误病为孕，养痍贻患，其后果是严重的。祖国医学诊断早期妊娠，除注意停经史及早孕反应外，特别重视脉象，如《素问·阴阳别论》说：“阴搏阳别，谓之有子。”《素问·平人氣象论》说：“妇人手少阴脉动甚者妊子也。”在《素问·腹中论》中也说：“何以知怀子之且生也，身有病而无邪脉也。”后代医籍对妊娠脉的研究更为细致，如《济阴纲目》诊妇人有妊歌中，描写妊娠脉的特点是：“寸微关滑尺带数，流利往来并雀啄。”确是非常宝贵的经验。以现代医学的观点分析，妊娠时的滑数脉，是有科学根据的。因妊娠后血容量增加，而且心跳加快，故脉滑数。但是，还必须指出，现今有人只凭滑数脉，就诊断为妊娠，未免有些偏执。还应结合妇科检查及尿妊娠试验，就更较确切，因脉滑数并不一定都是妊娠，

正如《濒湖脉学》滑脉主病诗所说：“滑脉为阳元气衰，痰生百病食生灾。上为吐逆下蓄血，女脉调时定有胎。”

常见的妊娠病有：妊娠呕吐、妊娠肿胀，胎气上逆，流产，子痫、难产等；较少见的有：子淋、转胞，子烦、子瘕、子悬等。为了对妊娠病有个较全面的了解，本章就这些疾病分别加以论述。

妊娠病的发病机理是：受孕期间，首先要供给胎儿血液营养，因而形成阴血的偏虚；其次是胎儿逐渐增大，影响气机升降，又易形成气滞痰郁等疾患。此外，亦有因脾胃虚弱，生化之源不足，或肾气亏损，胎元不固所致的，临证时应仔细观察。

妊娠病的治疗原则应是治病与安胎并举，治法以补肾健脾为主。补肾为固胎之本，健脾乃益血之源，本固血充，则胎自安。

使用药物时，应注意妊娠期的用药特点，凡有毒峻下、滑利、破血、耗气等药物，都应禁用或慎用。但在病情需要的情况下，亦可适当选用，所谓“有故无殒，亦无殒也。”但必须严格掌握剂量，以免伤胎。

第一节 妊娠呕吐

约有半数孕妇，在妊娠早期（5～12周），食欲减退、择食、并有清晨恶心呕吐等现象，在短时期即可停止，对健康影响不大，通常不需治疗而自愈。此种现象称“妊娠反

应”，不为病态。但是，如果呕吐逐渐加重，不仅在清晨或进食之后，每天反复多次，严重影响身体健康者，称为“妊娠呕吐”。再甚者，呕吐剧烈，饮食不进，造成电解质紊乱及代谢失调，尿酮体阳性，称为“妊娠剧吐”或“恶性妊娠呕吐”。古人因其恶心而阻碍饮食，所以称之为“恶阻”，也叫“子病”、“病儿”、“食病”、“阻病”。若不及时治疗，对母子健康均有严重影响。

【病因病机】 妊娠呕吐的产生，与孕妇的体质及神经类型有一定的关系。从生理上来说，“冲为血海”，“妊主胞胎”，因此，妇女妊娠与冲任二脉关系密切。妇女妊娠之后，月经停闭，血海之血专供养胎，血分遂感不足，相对气分有余，因而气血不调。冲脉的循行路径起于胞宫，挟脐上行，冲气不得下泄，上逆而犯胃。在这种生理改变的情况下，由于孕妇一时不能适应，便出现恶心、呕吐等反应，所以初孕妇比经孕妇发病率高。一般可有以下三种情况：

（一）胃虚：胃气主降，妊娠之后，冲脉之气较盛，冲脉隶于阳明，其气上逆犯胃，胃失和降，反随逆气上冲而致呕吐。

（二）肝热：平素肝阳偏亢，或郁怒伤肝，肝失条达。孕后血聚下以养胎，肝血益虚，阴虚阳盛，肝火上炎。肝脉挟胃贯肝膈，肝热横逆犯胃而致恶心呕吐。

（三）痰滞：脾阳不振，运化失职，湿聚而成痰饮。妊娠之后，经血停闭，冲脉之气上逆，痰饮随逆气上冲而致恶心呕吐。

【辨证施治】 因妊娠呕吐主要是脾胃虚弱所引起，故治疗时以健脾和胃，降逆止呕为主，同时亦应注意解除思想顾虑及饮食调节。

（一）胃虚妊娠呕吐：

1. 临床表现：妊娠早期，恶心呕吐，脘腹胀闷，厌闻食气，全身无力，怠惰嗜睡。舌淡苔白，脉缓滑无力。

2. 主证分析：由于胃气素虚，食欲不振，怀孕之后，血聚养胎，血盛于下，冲脉之气上逆，胃虚不降，反随逆气上冲，故恶心呕吐。胃与脾相表里，胃虚脾亦虚，脾胃俱虚，中阳不振，浊气失降，故脘腹胀闷，全身乏力，怠惰嗜睡。舌淡苔白，脉缓无力，亦为脾胃气虚之征。

3. 治疗法则：健脾和胃，调气降逆。

4. 处方用药：香砂六君子汤（《名医方论》）加味。

党参12克，白术、茯苓、姜半夏、藿香、竹茹各9克、陈皮6克，木香5克，砂仁、甘草各3克，生姜3片，大枣3枚。水煎2遍，多次分服。

按：本方是香砂六君子汤加藿香，竹茹。

方中党参、白术、茯苓、甘草健脾胃，和中气；半夏、陈皮、生姜、竹茹降逆止呕；砂仁、木香、藿香芳香化浊，并能理气，以增强止呕之效；大枣补脾和营，养心安神，且有矫味作用。

有热象者，去生姜加黄芩9克；呕吐物中有血者，加生地15克；腰痛者，加川断15克。

（二）肝热妊娠呕吐：

1. 临床表现：妊娠呕吐，呕吐苦水或酸水，脘闷胁痛，暖气叹息，头胀而晕，精神抑郁，面色苍黯，小便短黄，大便干结。舌质红，苔微黄，脉弦滑。

2. 主证分析：证属肝郁气滞，肝火上炎，逆而犯胃所致。因肝脉挟胃贯膈，肝气上逆犯胃，故胸满呕逆；肝与胆相表里，肝气上逆，肝胆火亦随之而升，故呕苦吐酸，脘闷胁痛；肝气郁结，而气机又欲得疏达，故时时暖气叹息；肝火上炎，逆走空窍，故头胀而眩；肝郁化热，热灼津液，阴液耗伤，故大便干结，小便短黄。舌红苔黄，脉弦，亦为肝火上逆之象。

3. 治疗法则：清肝和胃，降逆止呕。

4. 处方用药：苏叶黄连汤（《温热经纬》）加味。

紫苏叶 6 克、黄连 3 克，姜半夏、竹茹、生杷叶各 9 克，陈皮 6 克。水煎服。

按：本方是苏叶黄连汤加半夏、陈皮，杷叶、竹茹。

方中苏叶芳香和胃；黄连、竹茹、杷叶清热止呕；半夏、陈皮理气止呕。

如热甚伤津，舌红口干，去半夏加麦冬 9 克；头晕甚者，去苏叶，加白菊花 9 克，钩藤 12 克。

（三）痰滞妊娠呕吐：

1. 临床表现：妊娠初期、呕吐痰涎，胸闷胃呆，心悸气短，四肢乏力，口中淡腻，舌胖，苔白而腻，脉滑。

2. 主证分析：素有痰饮停滞中焦，孕后血壅气盛，冲脉之气上逆，饮随气上，故恶心呕吐痰涎；痰饮阻塞中焦，

脾阳不振，水谷不化，故胸满胃呆，口中淡腻，饮邪上凌心肺，则心悸气短。舌胖，苔白腻，脉象滑，为痰饮内停之征。

3. 治疗法则：健脾除湿，化痰止呕。

4. 处方用病：小半夏茯苓汤（《金匱要略》）

姜半夏15克，茯苓30克，生姜9克。水煎服。

方中半夏、生姜降逆化痰止呕；茯苓健脾利水、除湿，水行则饮去。

如有胃热，则见呕吐黄水，心中烦热，喜吃冷饮，可加竹茹9克，黄连1.8克。

【简易方】

（一）灶心土60~120克。水煎过滤服，每日2~3次。

（二）黄芩、竹茹各9克，生姜6克。水煎服。

第二节 妊娠肿胀

妊娠6个月以后，孕妇常有足踝部轻度浮肿，这是常见的现象，若无其他症状则不必治疗。若肿胀逐渐波及四肢、外阴、下腹部，同时尿量减少，体重异常增加（每月增加过0.5公斤或每月超过2.3公斤）者，称为“妊娠肿胀”。古书中还有“子肿”、“子满”、“子气”、“脆脚”、“皱脚”等名称。《医宗金鉴》说：“自膝至足肿，小水长者，名曰子气。头目遍身浮肿，小水短少者，名曰子肿。遍身俱肿，腹胀而喘，在6、7月时者，名曰子满。但两脚肿而胀厚者属

湿，名曰皱脚。皮薄者属水，名曰脆脚。”以上名称虽多，实际上都属于妊娠肿胀。

【病因病机】本病的产生主要由于脾肾阳虚所致。其次为气滞所引起。

（一）脾虚：古人认为脾虚是妊娠肿胀最重要的原因。如《产宝》说：“妊娠肿满，脏气本虚，因妊重虚，土不克水。”《圣济总录》说：“妊娠脾胃气虚，经血壅闭，则水气不化。”因脾虚转输失职，不能制水，水湿停聚，流于四末则肢肿，阻遏气化则腹胀。

（二）肾虚：素体肾虚，孕后阴血聚于下，有碍肾阳敷布，不能化气行水，水遂泛滥而为肿。正如《沈氏女科辑要笺正》说：“妊身发肿，良由真阴凝聚，以养胎元，肾家阳气不能敷布，则水道泛滥莫制。”

（三）气滞：情志不舒，气机不畅，加之孕后胎体渐长，有碍气机升降，而致气滞肿胀。

【辨证施治】妊娠肿胀有气肿水肿之分。水肿者，皮薄而色白而光亮，按之凹陷，不易平复；气肿者，皮厚而色不变，随按随起，不留痕迹。

本病的治疗，以健脾渗湿，温肾扶阳为主，但又不宜用温燥、滑利之品，以免伤胎。

（一）脾虚妊娠肿胀：

1. 临床表现：妊娠晚期，面目四肢浮肿，严重者可遍及全身，肤色浅黄，皮薄而光亮，精神疲乏，少气懒言，四肢不温，口淡无味，食欲不振，大便溏，小便少。舌质

淡，苔薄白而润，脉缓滑无力。

2.主证分析：脾主运化，又主四肢和肌肉。脾阳不运，水湿停聚，浸渍肌肉，故面目四肢浮肿；脾阳虚中气不足，则精神疲乏，少气懒言，四肢不温；中焦运化失司，故胃纳不佳，大便溏薄；水聚皮下则皮薄而光亮。肤色淡黄，舌淡，苔薄白而腻，脉缓滑无力，均属脾虚中阳不振之征。

3.治疗法则：健脾行水。

4.处方用药：白术散（《全生指迷》）。

生白术12克，茯苓皮30克，大腹皮12克，生姜皮、陈皮各9克。水煎2次分服。

方中白术、苓皮健脾渗湿行水，姜皮理气行水，大腹皮下气宽中以行水，陈皮调气和中。全方具有健脾理气行水的作用。

若纳少腹胀，加砂仁、木香各6克。水肿严重者，加车前子、桑白皮各9克，赤小豆30克。合并高血压病者，加钩藤15克，菊花9克。

（二）肾虚妊娠肿胀：

1.临床表现：妊娠晚期，面浮肢肿，腰酸乏力，下肢逆冷，心悸气短，头晕耳鸣。舌淡，苔白润，脉沉迟。

2.主证分析：肾阳不足，阳气不布，上不能达于头面，下不能达于四肢，水湿乘虚而聚，故面浮肢肿，下肢逆冷，腰为肾之府，肾虚则腰酸乏力；脑为髓海，肾虚髓海不足，则头晕耳鸣；水气上凌心肺，则心悸气短。舌淡，苔白润，脉沉迟，亦为阳虚之候。

3. 治疗法则：温阳化气行水。

4. 处方用药：真武汤（《伤寒论》）。

熟附子 6～9 克，生姜 9 克，茯苓 30 克，白术 12 克，白芍 9 克。水煎服。

方中附子温肾阳以化气行水，茯苓、白术、生姜运脾阳以利水；白芍敛阴气，与附子同用能引药入阴以消水气。方中附子辛温有毒，对胎不利，如非肢冷厥逆者不宜用，可以桂枝代之。

若浮肿重，加车前子 9 克，此药利水而不伤肾，为妊娠期理想的利水药。腰痛重，加川断 15 克，杜仲 12 克，菟丝子 9 克。合并高血压者，加钩藤 15 克，菊花 9 克，青赭子 15 克。

（三）气滞妊娠肿胀：

1. 临床表现：妊娠中后期，下肢浮肿，重者全身皆肿，肤色不变，随按随起，胸闷胁胀，厌食纳少，头晕胀痛。舌苔厚腻，脉弦滑。

2 主证分析：由于气机郁滞，升降失常，阳气不升，浊阴下滞，故下肢先肿，湿浊日增，则全身皆肿。证因气滞而肿胀，故肤色不变，且随按随起；清阳不升，浊阴上逆，故头晕胀痛；气滞不宣，故胸闷胁胀；浊停中焦，则厌食纳少，苔厚腻。脉弦为气滞所致，滑象为妊娠之候。

3. 治疗法则：理气行滞，健脾利湿。

4. 处方用药：天仙藤散（《妇人良方》）加味。

天仙藤（即青木香藤，微炒）、香附、陈皮、乌药、车

前子、木瓜各9克，生姜6克，紫苏叶、生甘草各8克。水煎2次分服。

按：本方是天仙藤散加车前子。

方中天仙藤、香附理气行滞；陈皮、生姜温中行气；乌药顺下焦之滞气；木瓜行气除湿；苏叶行气宽中；甘草调和诸药；加车前子以增强利水之效。

湿重者可合用四苓散（《丹溪心法》）：白术15克，茯苓、泽泻、猪苓各9克，以增强健脾利湿之效。

附：羊水过多症

停蓄于胞宫之水，称为“羊水”。正常妊娠时羊水量逐日增加，约在妊娠7个月达到最高容量（1000～1500毫升），若羊水量达到或超过2000毫升，现代医学即称为“羊水过多症”。根据发病速度，临床上有急性和慢性之分，急性羊水过多症，多发生在妊娠中期（4～6个月），羊水急剧增加，数日之内子宫即异常增大，使病人感到严重不适，如心慌气短，紫绀及不能平卧等。慢性羊水过多症，以妊娠后期为多见，羊水增强较缓慢，引起的临床症状轻微，有些可继续至足月。根据其临床表现，⁴此症符合祖国医学之“胎水肿满”。

羊水过多症可引起早产或死产（因脐带脱垂、胎位异常所致），在分娩时亦常引起子宫收缩无力，胎盘早期剥离，或产后大出血等症。

【病因病机】本病产生的主要机理是脾阳素虚，妊娠期

间，阴血聚以养胎，有碍脾阳健运，以致水湿不行，积留胞中所致。

现代医学认为此症病因复杂，羊膜分泌力增强，回吸收减少是主要的原因。临床所见，胎儿畸形、双胎以及孕妇糖尿病，肾功能不全，妊娠中毒症等，皆可出现羊水过多症。

【辨证施治】羊水过多症的处理，首先应明确有无胎儿畸形，有胎儿畸形者，应采取高位破膜引产。无胎儿畸形者，可辨证施治。

（一）临床表现：妊娠中后期，腹部异常增大（子宫增大超过妊娠月份），胎位不清，胎心遥远，胸中满闷，心悸气短，喘逆不安，唇颊青紫，腹胀作痛，下肢及外阴部水肿，小便量少。舌质淡，苔薄白而润，脉滑。

（二）主证分析：脾主运化，脾阳虚则不能运化水湿，水湿停聚胞中，故腹部异常增大，腹胀作痛；因胎水肿满，故胎位不清，胎心遥远；脾失健运，湿浊下注，故下肢及外阴水肿；水气上凌心肺，故胸中满闷，心悸气短，喘逆不安；阳虚血运不畅，故唇颊青紫。舌淡，苔白润，脉滑，亦属脾阳虚衰之征。

（三）治疗法则：健脾行水。

（四）处方用药：

1.茯苓导水汤（《医宗金鉴》）。

茯苓30克，白术15克，木瓜12克，槟榔、猪苓、泽泻、苏梗、桑白皮、大腹皮各9克，砂仁6克。水煎2次分服。

方中四苓健脾行水；木香、砂仁、陈皮、苏梗以化中、下二焦之滞气；大腹皮、桑白皮消胀行水；槟榔利气行水；木瓜舒筋除湿。

喘逆者加苦葶苈子9克，腿肿甚者加防己9克。

2. 鲤鱼汤（《千金要方》）加味。

鲤鱼1条（250克以上，去鳞肠），白术15克，生姜、白芍、当归各9克，茯苓30克，陈皮6克，肉桂1.5克。

按：本方是鲤鱼汤加陈皮、肉桂。

先取鲤鱼，加水1200毫升，将鲤鱼煮熟，去鱼存汤，用以煎药，约煎至300毫升，每日1剂，饭前空腹服，可连服3～4剂，并食鱼肉。

方中鲤鱼行水消肿，白术、茯苓、陈皮健脾理气渗湿以行水；当归、白芍和血养胎。肉桂温阳化气，以助行水之力。如此组合，则行水而不伤胎。

若经上述治疗效果不显著，胎儿畸形可能性大，以高位破膜引产为宜。

第三节 妊娠小便淋痛

妇女妊娠期间，小便频数，点滴而下，并有疼痛者，称为“妊娠小便淋痛”，古称“子淋”，亦称“妊娠小便难。”符合现代医学的妊娠期膀胱炎、尿道炎，也包括淋病在内。

【病因病机】本病发生的机理，主要是膀胱气化不行。《素问·灵兰秘典论》说：“膀胱者，州都之官，津液藏

焉，气化则能出矣。”膀胱气化不行，水道不利，则小便淋沥而下。导致气化不行的原因，以火热、湿热、阴虚、气虚等为多见。

（一）火热：阳气素盛，妊娠后血聚养胎，不能上承，心火偏亢，移热于小肠，随同水液传入膀胱，由于热伤膀胱则小便淋漓而痛。亦有过食辛辣温燥食物及药物，热郁于内，引动心火而致者。

（二）湿热：因摄生不慎，湿热内侵，蕴结膀胱，灼伤津液，致小便淋涩疼痛。

（三）阴虚：平素阴虚，孕后血聚而养胎，阴液愈亏。肾与膀胱相表里，肾阴不足，则命门火旺，膀胱为热邪所灼，水液涩少，则尿下淋漓。

（四）气虚：体质较弱，中气素虚，不能升提胎体，膀胱受压，气虚不能制约水液，则小便淋漓不尽。

【辨证施治】妊娠小便淋痛，虽多有热，但治宜清润为主，不宜过于通利，以免损伤胎元，引起流产。气虚下陷者，自当益气升阳，又切忌通利，以犯虚虚之戒。

（一）火热妊娠小便淋痛：

1. 临床表现：妊娠期间，小便频数而短，色黄而赤，排尿时艰涩不利，且有热痛之感，心烦不安，口苦而渴，或口舌生疮。舌红苔黄而燥，脉象滑数。

2. 主证分析：热聚于内，水液为热邪煎灼，故尿色黄赤，量少，频数淋漓，艰涩疼痛；邪火上炎，则心火不安，舌为心之苗，心火亢盛，则舌红或口舌生疮；热盛伤津，则口

渴苔黄而燥；血遇热则行速，故脉象滑数。

3. 治疗法则：泻火润燥通淋。

4. 处方用药：导赤散（《小儿药证直诀》）加味。

生地30克，木通、甘草梢各6克，淡竹叶、车前子、黄芩各9克。水煎2次分服。

按：本方是导赤散加车前、黄芩。

方中生地凉血养阴；淡竹叶清心泻火；木通降心火而行为水；甘草梢泻火缓痛，导心与小肠之火下行膀胱而从小便排出；增车前子以加强清热利尿之效，配黄芩取其清热安胎之功。

如热甚者再加栀子9克以清心泻火。小便血淋涩痛甚者，加小蓟、生地各9克，以凉血止血；口渴甚者可加麦冬、花粉各9克，以生津液。有人因花粉注射液可以引产，故孕妇不敢服用，其实花粉口服并无下胎作用，已经临床证实。

（二）湿热妊娠小便淋痛：

1. 临床表现：妊娠期间，突感小便频数而急，尿黄赤，艰涩不利，灼热刺痛，面色垢黄，口渴不欲多饮，胸闷纳少。舌质红，苔黄腻，脉滑数。

2. 主证分析：湿与热搏，蕴结膀胱，气化不行，水道不利，故小便频数而短，尿黄赤，灼热刺痛；脾胃湿热，熏蒸于上，故面色垢黄；热灼津液，则口干欲饮，但湿聚中焦，故又不欲多饮；湿困脾胃，阳气不伸，故胸闷纳少。舌红苔黄腻，脉滑数，皆为湿热内蕴之候。

3. 治疗法则：清热利湿通淋。

4. 处方用药：五淋散（《和剂局方》）加味。

焦山槿、黄芩、当归、炒白芍、生地、泽泻、车前子各9克，赤苓12克，生甘草稍6克。水煎2次分服。

按：本方是五淋散加生地、黄芩、泽泻、车前子。

方中槿子、黄芩清热泻火通淋为主；辅以赤苓、泽泻、车前渗湿利水；佐当归、白芍、生地养血安胎，使邪去而不伤正，祛病而不动胎；甘草稍既能泻火缓痛，又可调和苦寒之味。

按：一般治五淋的方剂，多用瞿麦、牛膝、滑石、大黄等药，但都有动胎的流弊，本方养血而清利湿热，治病而不致动胎，用治妊娠子淋属于湿热者，确系稳妥而有效的方剂。

（三）阴虚妊娠小便淋痛：

2. 临床表现：妊娠期间，小便频数涩痛，量少而色黄，两颧潮红，手足心热，心烦不寐，大便不畅。舌红而干，脉细数。

2. 主证分析：证属阴虚内热，水液亏耗，故小便淋痛，量少而色黄，大便不畅。火势上炎，故两颧潮红，心烦不寐。手足心热，舌红而干，脉细数，均为阴虚内热之象。

3. 治疗法则：滋阴润燥通淋。

4. 处方用药：六味地黄汤（《小儿药证直诀》）加减。

生地15克，炒山药12克，丹皮、茯苓、车前子、山萸肉、麦冬、黄芩各9克。水煎2次分服。

按：本方是六味地黄汤去泽泻，加麦冬、车前、黄芩。

方中生地益血滋阴；丹皮泻血中之热；麦冬生津；山药、山茱萸益肾养阴；茯苓、车前子行水通淋。共奏养阴润燥滋水通淋之功。加黄芩清热而安胎。

（四）气虚妊娠小便淋痛：

1. 临床表现：妊娠期间，小便频数，解时不能制约，解后疼痛，尿量不减，色白而清，气短无力。舌淡，脉虚弱。

2. 主证分析：妊娠气虚不能升提胎体，胎重下迫膀胱，则水行不利，故小便淋漓而下；气虚失于固摄，故欲解不能控制，尿出难禁；尿排出后膀胱空虚，缺乏气的温养，因而作痛；病非热邪所伤，津液未亏，故尿量不减，色白而清，气短无力，舌淡脉虚弱，均为气虚之征。

3. 治疗法则：益气止淋。

4. 处方用药：益气止淋汤（《女科正宗》）加味。

黄芪、党参各15克，白术、麦冬、茯苓、益智仁各9克，升麻、甘草各6克。水煎2次分服。

方中黄芪、党参、白术、茯苓、甘草益气补脾，麦冬生津以补水液；加升麻升提阳气，辅助黄芪、党参上举胎体；益智仁固肾气而摄小便。

【简易方】

（一）金钱草15克，石韦、海金沙各9克。水煎服。适于内热小便淋痛者。

（二）补中益气丸（成药），每服9克，每日3次，温

开水送下。适于气虚小便淋痛者。

第四节 妊娠小便不通

妊娠期间，饮食如常，小便不通，小腹胀满，甚或胀急疼痛，心烦不得卧，称为“妊娠小便不通”，古称“转胞”。《金匱要略》说：“妇人病，饮食如故，烦热不得卧，而反倚息者，何也？此名转胞，不得溺也。”

【病因病机】孕妇素体虚弱，中气不足，不能上举胞胎，胎位下移，挤压膀胱；或肾气不足，不能温化膀胱之水，以致溺不得出。临床常见的有气虚和肾虚两种。

（一）气虚：妇人素体虚弱，中气不足，妊娠后期胎儿渐大，气虚则无力举胎，胞胎下坠，压迫膀胱，水道不通，尿不得出。

（二）肾虚：因胞脉系于肾，若肾气素虚，孕后肾气愈虚，无力系胞，胞胎下压膀胱；或肾虚不能温煦膀胱化气行水，致尿不得出。

【辨证施治】小便不通，膀胱积尿过多之后，亦可出现小便频数或尿出不禁之候，此时需与子淋相鉴别。《沈氏女科辑要笺正》说：“小便频数，不爽且痛，乃谓之淋。……转胞亦是小溲频数，不能畅达，但不必热，不必痛，则胎长而压迫膀胱之旁，府气不得自如。”这便明确指出：转胞者，膀胱积尿多，下腹胀；子淋者，膀胱积尿少，下腹不胀。更重要的是转胞排尿无涩痛感，而子淋则排尿涩痛。

（一）气虚妊娠小便不通：

1.临床表现：妊娠期间，小便不通，或频数而量少，小腹胀急而疼痛，神疲无力，头重眩晕，心悸气短，坐卧不安，大便不畅。舌淡苔薄，脉虚缓而滑。

2.主证分析：胎在母体赖气载之，气虚则无力载胎，胞胎下压膀胱，水道不通，尿不得出，或频而少；膀胱居于小腹，膀胱积尿盈满，故小腹胀急疼痛，坐卧不安；气虚下陷，清阳不升，故神疲无力，头重眩晕，心悸气短，气虚传导失职，故大便不畅。舌淡苔薄，脉虚缓滑，均为中阳不运之征。

3.治疗法则：补气养血，升陷举胎。

4.处方用药：补中益气汤（《脾胃论》）加味。

炙黄芪18克，党参15克，炒白术12克，当归、桔梗各9克，桂枝、陈皮、通草、升麻、柴胡、炙甘草各6克。水煎2次分服。

按：本方是补中益气汤加桂枝、桔梗、通草。

方中黄芪、党参、白术、甘草益气健脾升阳；当归养血保胎；升麻、柴胡升举下陷之气；陈皮、桔梗宣畅肺气，开上以启下；桂枝、通草化气行水而通便。共奏益气升阳举胎导溺之效。

（二）肾虚妊娠小便不通：

1.临床表现：妊娠期间，小便不通，或频数量少，小腹胀痛，坐卧不宁，头晕，腰酸膝软，面色晦黯，畏寒肢冷。舌质淡，苔薄而润，脉沉迟无力。

2.主证分析：肾阳不足，不能化气行水，故小便不通，或频数不畅；肾虚系胞无力，胎压膀胱，水道闭塞而致小便不通；膀胱积尿过多，则小腹胀痛，坐卧不宁；肾阳虚，水气不化，上犯清窍，故头晕、面色晦黯；肾主骨，肾虚则骨不坚，故腰酸腿软；肾阳虚，不能鼓动气血，温养四肢，故畏寒肢冷。舌淡，脉象沉迟无力，乃肾虚之象。

3.治法法则：温肾扶阳，化气行水。

4.处方用药：肾气丸（《金匮要略》）加减。

熟地18克，炒山药、菟丝子、续断各12克，茯苓、山萸肉、巴戟肉、泽泻各9克，肉桂6克。水煎2次分服。

按：本方是金匮肾气丸去丹皮、附子，加菟丝、巴戟、续断。

方中熟地、山药、山萸肉滋补肝肾；泽泻、茯苓利尿行水；肉桂温阳化气，续断、菟丝、巴戟温肾行水且能安胎。

【外治法】

（一）甘遂24克，研为细末，用面糊捏成饼，敷贴脐下，另用甘草18克，煎汤频服，小便立通。（《古今医鉴》）。

（二）冬葵子、滑石、梔子各等份为末，田螺肉捣膏，或葱汁调膏，贴脐中，立通（《万病回春》）。

【托胎法】令妇人仰卧于凳上，将足后凳头，渐渐抬高，如是片时，胎自举而溺出如注（《女科指南》）。

第五节 妊娠心烦

妊娠期间，孕妇出现时时烦闷不安，抑郁不乐，心悸胆怯或烦躁易怒等症，称为“妊娠心烦”，古称“子烦”。

【病因病机】子烦由多种病因引起。如《产宝》说：“夫妊娠而子烦者，是肺脏虚而热乘于心，则令心烦也。停痰积饮，在心胸之间，或冲于心，亦令烦也。若热而烦者，但热而已。若有痰饮而烦者，呕吐涎沫，恶食气，烦躁不安也。大凡妊娠之人，既停痰积饮，又寒热相杂，气郁不舒，或烦躁，或呕吐涎沫，剧则胎动不安，均为子烦也。”《沈氏女科辑要》说得更为简捷明了：“子烦病因：曰痰，曰火，曰阴虚。”

（一）阴虚：平素阴血不足，孕后血聚养胎，则阴血更亏，以致心火偏亢，神明不宁，烦闷不安。

（二）肝郁：愤怒伤肝，肝郁气滞，郁而化火，火性上炎，热扰心神，以致烦闷不宁。

（三）痰火：胸中素有痰饮停滞，孕后阳气偏胜，阳盛则热，痰热相搏，上干心肺而致烦闷。

【辨证施治】本病分阴虚、肝郁、痰火三种，属阴虚者烦而不满；属肝郁者，两胁胀痛；属痰火者，胸多痞满。

（一）阴虚妊娠心烦：

1. 临床表现：妊娠期间，心中烦闷不安，坐卧不宁，手足心热，或午后潮热，口干便秘，小便短赤。舌红，少苔

或无苔，脉细数而滑。

2.主证分析：心主神明，心火亢盛，神明不安，故烦闷不宁；阴虚生内热，故手足心热，午后潮热；热灼津液，故口干便秘，小便短赤。舌红，少苔或无苔，脉细数，均为阴虚内热之象，滑脉为有孕之征。

3.治疗法则：清热养阴，安神除烦。

4.处方用药：人参麦冬散（《妇人秘科》）加减。

北沙参、麦冬、竹茹各12克，茯苓、黄芩、知母各9克，生地15克，生甘草3克，莲子心1.5克。水煎2次分服。

按：本方是人参麦冬散去人参，加沙参、莲子心。

方中沙参养阴生津；生地滋肾益阴而济心火；麦冬润肺生津，养心除烦；知母清热泻火，滋阴退蒸，生津止渴；黄芩、竹茹清热除烦；甘草调和诸药，全方共奏清热养阴，安神除烦之效。

若便秘者，加柏子仁9克，润肠通便。口渴甚者，加花粉9克，生津止渴。

（二）肝郁妊娠心烦：

1.临床表现：妊娠期间，心烦不安，郁闷不乐，或烦躁易怒，两胁胀痛。舌质红，苔薄白或黄干，脉弦数。

2.主证分析：肝郁化热，热扰神明，故心烦不安；肝主情志，肝郁不舒，则闷闷不乐，心烦易怒；肝脉布胁贯膈，肝郁则经脉不利，气机受阻，故两胁胀痛；肝郁化火，热灼津液，故舌红，苔黄干。脉弦数为肝郁化热之征。

3.治疗法则：疏肝解郁，清热除烦。

4. 处方用药：丹栀逍遥散（《女科撮要》）加减。

柴胡、香附、当归、白芍、白术、茯苓、栀子、黄芩、竹茹各9克，炙甘草6克，薄荷3克。水煎2次分服。

按：本方是丹栀逍遥散去丹皮、生姜加黄芩、竹茹、香附。

方中柴胡、香附疏肝解郁；当归、白芍补血和血；因肝病侮脾，故用白术、茯苓和中健脾；栀子、黄芩、竹茹清热泻火除烦；佐薄荷一味协同柴胡增强疏肝之力。且香附、黄芩俱有安胎之效。

（三）痰火妊娠心烦：

1. 临床表现：妊娠期间，烦闷不安，心悸胆怯，头晕腕闷，恶心呕吐。舌苔黄腻，脉滑数。

2. 主证分析：素有痰湿停滞，积久化热，痰火迫于心脾，则烦闷不安，心悸胆怯；心火偏盛，子病及母（心与肝为子母关系），肝气挟痰火上逆，而致头晕恶心呕吐；痰火内蕴，中焦清气不升，浊气不降，故中脘满闷。苔黄腻，脉滑，均为痰热内盛所致。

3. 治疗法则：清热涤痰，宁心安神。

4. 处方用药：竹沥汤（《千金要方》）加味。

竹沥30克（冲兑），麦冬、黄芩各9克，茯苓15克，橘红6克，防风4.5克。水煎2次分服。

按：本方是竹沥汤加橘红。

方中竹沥清心肺胃三经之火而涤痰涤烦，并能定惊透络；麦冬清心除烦；茯苓、橘红安神除痰；黄芩泻火燥湿并能安胎；脾为生痰之源，故用防风一味以发散脾家之郁火及

搜剔脾家之湿邪，配茯苓、橘红以增强豁痰之力。全方共奏清热涤痰、宁心除烦之效。

【简易方】

（一）竹茹汤：青竹茹30克，水煎徐徐服之。适于肝郁胃热之妊娠心烦（《妇人良方》）。

（二）竹沥30克，温开水冲兑，时时服之。适于痰火内蕴之妊娠心烦（《千金要方》）。

第六节 妊娠失音

妊娠末期，孕妇声音嘶哑，甚至不能出声者，称为“妊娠失音”，古称“子瘖”。

本病最早见于《素问·奇病论》：“黄帝问曰：人有重身，九月而暗，此为何也？岐伯对曰：胞之络脉绝也。帝曰：何以言之？岐伯曰：胞络者系于肾，少阴之脉，贯肾系舌本，故不能言。帝曰：治之奈何？岐伯曰：无治也，当十月复。”之后，医家多遵内经之旨而无治法。如《医宗金鉴》说：“妊娠九月，孕妇声音细哑不响，谓之子瘖……少阴之脉，终于舌本，九月肾脉养胎，至其胎盛阻遏其脉，不能上至舌本，故声音细哑，待分娩之后，肾脉上通，其音自出矣。”现对此病，如无其他不适，可不治而顺其自然，若伴有其他症状者，则应随证治之。

【病因病机】本病主要由肾阴不足所致。因为声出于肺，根于肾，而发于舌本。如肾阴素亏，孕后阴血养胎，则

肾阴更亏，不能上荣于舌本而致失音。

【辨证施治】

（一）临床表现：妊娠末期，声音嘶哑，甚至不能出声，头晕耳鸣，面颊潮红，手心灼热，身体瘦弱，皮肤干燥，腰腿酸软，足跟疼痛，心悸而烦，大便干结，小便少黄。舌质红，苔花剥，脉细数。

（二）主证分析：肾脉上贯肝膈，入肺中，循喉咙，挟舌本。肾阴亏损，不能上荣舌本，故声音嘶哑喉咙干燥；阴亏火旺，故面颊潮红，头晕耳鸣，手心灼热；阴亏津少，故皮肤干燥，大便干小便黄；水不济火，心火亢盛，心神不宁，故心悸而烦。舌红，苔花剥，脉细数，均为肾阳不足之征。

（三）治疗法则：滋肾益阴。

（四）处方用药：六味地黄汤（《小儿药证直诀》）合增液汤（《温病条辨》）。

熟地、生地各15克，山药12克，山茱萸、泽泻、茯苓、丹皮、麦冬、玄参各9克。水煎2次分服。

方中六味地黄汤滋补肾阴，生地、玄参、麦冬生津润肺，使津液充足上荣于舌，则声音自出。

如因外感风寒而失音者，可按内科处理。

第七节 妊娠咳嗽

妊娠期间，咳嗽不已，甚或五心烦热，胎动不安者，称为“妊娠咳嗽”，古称“子嗽”。若久嗽不愈，且伴有潮热

盗汗，痰中带血，形体消瘦者，则为“癆嗽”，古称“抱儿癆”，即现代医学所谓的“肺结核”。

“子嗽”、“抱儿癆”是妊娠期中的一种合并症。

【病因病机】本病的产生，主要由于素体阴虚，肺阴不足，孕后血聚于下以养胎，则血虚而阴液更亏。阴虚火旺，虚火上炎，灼肺伤津；或房劳过度，或风寒袭肺等，均可导致肺燥而咳。临床常见的有肺虚、肾虚、风寒三种。

【辨证施治】

（一）肺虚妊娠咳嗽：

1. 临床表现：妊娠期间，干咳无痰，日久不止，或痰少而带血，午后发热，面颊潮红，口干咽燥，手足心热，头晕目眩。舌红少苔，或苔薄黄而干，脉虚细而数。

2. 主证分析：阴虚液亏，虚火内生，灼肺伤津，肺失濡润，故干咳无痰；津液耗伤，故口干咽燥；热伤肺络，则痰中带血；虚火上炎，故头晕目眩；午后潮热，手足心热，舌红少苔，脉虚细而数，均为阴虚内热之征。

3. 治疗法则：养阴清肺，润燥止咳。

4. 处方用药：百合固金汤（《医方集解》）加减。

炙百合30克，炙百部、桑叶各12克，玄参、麦冬、阿胶（烔化）、白芍、苦桔梗各9克，生地、黑芝麻15克，川贝粉（冲服）、生甘草各6克。水煎2次冲服。

按：本方是百合固金汤去熟地、当归，加百部、桑叶、阿胶、黑芝麻。

方中百合、百部润肺止咳，麦冬、玄参养阴清肺，白芍

养血敛阴；生地、芝麻以滋补肝肾之阴；贝母化痰止咳；桑叶、桔梗、甘草清肺利咽；阿胶助白芍养血止血。全方重在养阴、润肺、滋肾，使金水相生，阴津充足，虚火自平，则咳嗽自愈。

若咯血重者，加仙鹤草30克，白茅根15克，以加强润养止血之力；若潮热重者，加地骨皮9克，清泻肺火，凉血退蒸。

（二）肾虚妊娠咳嗽：

1.临床表现：妊娠期间，干咳无痰，或痰少，或胸憋气喘，头晕耳鸣，腰酸乏力，咳而失溺。舌红，苔少，脉沉细而数。

2.主证分析：禀赋素弱，孕后肾气更虚，失其升清降浊之职，水液上迫于肺而为咳；肾虚不能纳气，则胸憋气喘；肾阴亏虚，不能上荣于脑，则头晕耳鸣；腰为肾之府，肾虚腰失所养，则腰酸无力；肾司二便，主纳气，肾虚不固，则咳而失溺。舌红，苔少，脉沉细而数，均乃肾虚之象。

3.治疗法则：补肾润肺，纳气止咳。

4.处方用药：九仙散（《医学心悟》）加减。

党参15克，麦冬、阿胶（烊化）、款冬花、桑白皮、五味子、苦桔梗、苦杏仁各9克，炙罂粟壳、川贝粉（二次冲兑）各6克，胡桃仁4枚（分2次嚼服），生姜8片，大枣3枚。水煎2次分服。

按：本方是九仙散去乌梅，加麦冬、杏仁、胡桃仁。

方中党参以补气，阿胶以补肺，喘则气耗，用五味子、

罂粟壳、胡桃仁之甘酸涩敛，以收纳肺肾耗散之气；复以麦冬、杏仁润肺止咳；冬花、川贝、桑皮止咳平喘，兼以化痰；桔梗宣肺理气，以防补敛药物之呆滞；姜枣调和脾胃，促进药效之吸收。合用具有补益肺肾，纳气止咳之效。

（三）风寒妊娠咳嗽：

1. 临床表现：妊娠期间，发热恶寒，头痛，咳嗽痰稀，鼻塞流涕。舌苔薄白，脉浮滑。

2. 主证分析：外感风寒，束于肌表，营卫失调，故恶寒发热，头痛；风寒犯肺，郁于气道，肺气不宣，故咳嗽痰稀，鼻塞流涕。苔薄白，脉浮滑，为邪束肌表之候。

3. 治疗法则：温散风寒，宣肺止咳。

4. 处方用药：杏苏散（《温病条辨》）。

苦杏仁、紫苏叶、制半夏、前胡、桔梗、茯苓各9克，枳壳、陈皮各6克，生甘草3克，生姜8片，大枣8枚。水煎2次分服。

方中苏叶、杏仁温散风寒，宣肺达表，微发其汗；前胡、半夏、茯苓、橘皮理气化痰止咳；桔梗、枳壳一升一降，开提肺气，以助止咳之力；甘草、姜枣，调和营卫，协和诸药。共收发表宣化之功，使表解痰化，肺气畅和，诸症自愈。

第八节 妊娠痢证

妊娠后期，或正值分娩时，或分娩之后（一般在产后24

小时之内)，忽然仆倒，项背强直，四肢抽搐，牙关紧闭，口吐白沫，神志昏迷，稍时自醒，醒后复发，称为“妊娠痫证”，古称“子痫”、“子冒”。

本病是妊娠期间的严重疾病，如不及时抢救，反复发作后则昏迷不醒，可导致孕妇及胎儿的死亡。临床时须特别注意。

子痫在发病之前，如出现头痛头晕，眼花目眩，上腹不适，胸闷恶心，小便短少等前驱症状；而临床检查发现高血压、水肿、蛋白尿等，现代医学称为“先兆子痫”。此时，就应采取积极治疗措施，对预防子痫的发生有着重要的意义。本节拟将“先兆子痫”和“子痫”分别予以介绍。

先兆子痫

先兆子痫，往往由妊娠水肿或妊娠高血压未经及时治疗发展而成。妊娠后期，经检查发现上述体征时，即应考虑本病。这属于晚期妊娠中毒症。

【病因病机】平素脾阳不足或肝肾阴虚，在妊娠后期，胎儿逐渐长大，影响肝、脾、肾三脏。脾气不足，运化失常，水湿停蓄而成水肿。如平素肝肾阴虚，而孕育胎儿本靠肝肾之精气，此时肝肾之阴益感不足，阴不足则阳亢，故有高血压症状出现。若肾虚气化失司，尿中还可混有蛋白等物质。一般可分为阳虚和阴虚两种类型。

【辨证施治】先兆子痫以高血压、水肿、蛋白尿（或有管型和红细胞）为主证。同时伴有一些其他全身症候。

（一）阳虚先兆子痫：

1.临床表现：面色苍白，下肢腹部水肿明显，或兼面目浮肿，怕冷，自汗，短气，食欲不振，甚或恶心，大便溏薄，腰酸，尿频量少。舌质淡，舌体胖，舌边有齿印，苔薄白，脉缓滑无力。

2.主证分析：脾气不足，运化失常，水湿停聚，故现浮肿、气短、胃呆、便溏；脾阳不振，不能温煦肢体，故怕冷；气虚则卫表不固，故自汗；肾虚则气化失司，故尿频量少。舌脉表现，亦属阳气亏虚之征象。

3.治疗法则：健脾行水，扶肾助阳。

4.处方用药：白术散（《全生指迷》）合五苓散（《伤寒论》）加味。

生白术15克，茯苓皮30克，大腹皮12克，猪苓、泽泻、淫羊藿各9克，生姜皮、陈皮、紫苏、桂枝各6克。水煎2次分服。

按：本方是白术散合五苓散加淫羊藿、紫苏。

方中白术健脾化湿，并能安胎；诸皮及猪苓、泽泻利湿行水；桂枝通阳化气，促使水湿运行；淫羊藿扶肾阳以助气化；苏叶伍陈皮和胃止呕，并能下气，气行则水行，水行则肿消。

本方具有较强的利水作用，能减轻脑水肿，故可避免子痫的发生。

如兼气喘者，可加葶苈子9克，大枣5枚。

（二）阴虚先兆子痫：

1.临床表现：颜面色红，头晕目眩，心悸失眠，胸闷烦热，口干欲饮，大便干结，小便短黄。舌质红，苔微黄而干，脉弦细滑数。

2.主证分析：肝肾阴虚则阳亢，阳越于上，故头晕目眩，颜面色红；阴血亏虚，血不养心，故心悸失眠；阴虚生内热，故胸闷烦热；热灼津液，故口干欲饮，便结尿黄。舌红，脉弦数，为阴虚内热之候。

3.治疗法则：育阴潜阳，凉肝熄风。

4.处方用药：羚羊钩藤汤（《通俗伤寒论》）加味。

羚羊角粉5克（分2次冲），生地30克，钩藤15克，桑叶、生杭芍、女贞子、旱莲草、竹茹各12克，川贝、茯苓、菊花各9克，生甘草8克。水煎2次分服。

按：本方是羚羊钩藤汤加女贞、旱莲。

方中以羚羊角、钩藤、桑叶、菊花凉肝熄风；生地、生芍、女贞、旱莲滋肾养阴，柔肝潜阳；川贝清热化痰；茯苓宁心安神；竹茹清热除烦，祛痰通络；甘草缓急和中。

若血压过高者，加生石决明30克，以增强潜镇之功。

子 痫

妊娠子痫是由先兆子痫未得及时处理，或处理不当，或治疗无效，病情继续发展而成。亦属于晚期妊娠中毒症。

【病因病机】《素问·至真要大论》说：“诸风掉眩，皆属于肝。”《医宗金鉴》说：“肝心二经风热所致。”《产科心法》说：“孕妇血虚，风邪入肝。”《中国医学大

辞典》说：“肝脏血少，而木火内动。”综上所述，子痫的主要病因是：平素肝肾阴虚，而气偏亢，孕后血聚养胎，阴血更亏，阴虚阳亢，阳气上浮，则出现眩晕昏迷，阴虚血不养筋，可导致肝风内动而抽搐。

【辨证施治】

（一）临床表现：发作前往往出现剧烈头痛、眩晕、视物模糊、恶心、四肢震颤、下肢浮肿等症。发作时忽然仆倒，昏不知人，四肢抽搐，双目直视，牙关紧闭，口吐白沫，面色青紫，脉弦数有力等。一般抽搐停止后进入昏睡状态，以后逐渐清醒，经过情况不复记忆，仅觉全身酸痛。常反复发作，发作次数越多越频，昏迷时间越长或持续昏迷者，往往预后不良。

（二）主证分析：阴虚阳亢，肝风内动，浮阳上越，神无所主，故骤然仆倒，昏不知人；阴血亏虚，筋失濡养，则四肢抽搐；气血并走于上，故见直视、口噤等症；痰随气上，则口吐白沫；发作时气血郁阻，故面色青紫。脉弦数有力，为阴虚阳越之征。逐渐清醒或持续昏迷，是表明病情的轻重程度。

（三）治疗法则：发作时采取紧急综合措施，如输氧，吸痰，放开口器以防唇舌咬伤，加强护理以防坠床等。

1. 应急处理：

（1）昏迷：针刺人中、百会、风池、涌泉。

（2）口噤：针刺下关、颊车。

（3）抽搐：针刺曲池、合谷、承山、太冲。

2.处方用药：宜育阴潜阳，养血熄风。用羚羊钩藤汤加减。

羚羊角粉5克（分2次冲），钩藤15克，白蒺藜、菊花、生白芍各12克，阿胶9克（烊化），生石决、生龟板、生龙骨、生牡蛎各30克，桑寄生18克，全蝎6克。水煎2次分服。

按：本方是羚羊钩藤汤去桑叶、川贝、茯苓、生地、竹茹、甘草，加白蒺藜、龟板、生石决、龙骨、牡蛎、阿胶、寄生。

方中羚角、钩藤、菊花、白蒺藜、白芍清热凉肝，熄风止痉；寄生、阿胶养血安胎；用大量龟板、石决、龙骨、牡蛎以加强育阴潜阳之力；佐全蝎以增强止痉之功。

如神志昏迷持续不醒，加安宫牛黄丸或局方至宝丹1粒，水化鼻饲；如喉间痰声漉漉，用竹沥60克研调鼻饲。配合“人工冬眠疗法”，对控制抽搐可起到良好的效果。

第九节 妊娠腹痛

妊娠期间，小腹或大腹疼痛，反复发作，称为“妊娠腹痛”。前人认为产生腹痛的原因为胞脉阻滞，因此，又称“胞阻”。

【病因病机】产生妊娠腹痛的机理，主要是气血运行不畅所致。如《金匮心典》说：“胞阻者，胞脉阻滞，血少而气不行也。”但造成本病的原因很多，如《金匮要略》说：

“妇人怀妊六七月，脉弦发热，其胎愈胀，腹痛恶寒者，少腹如扇，所以然者，子脏开故也。”又“有妊娠下血者，假令妊娠腹中痛，为胞阻。”《妇人良方》说：“妊娠心腹痛，或宿有冷痛，或新触风寒，皆因脏虚而发动……多是风寒湿冷痰饮与脏气相系，故令腹痛。”又说：“妊娠四五月后，每常胸腹间气刺满痛或肠鸣，以致呕逆食减，此由愤怒忧思过度。”综合起来，其病因大致可分为虚寒、血虚、气郁三种。

（一）虚寒：胞脉系于肾，如阳气素虚，妊娠之后，肾阳益虚，阳虚则阴寒内盛，以致子脏寒冷，寒则血凝气滞，运行不畅，故小腹冷痛。

（二）血虚：素体血虚，妊娠之后血聚养胎，阴血益感亏乏，血少则气行不利，以致胞脉受阻，因而腹痛。

（三）气郁：肝主藏血，而司血海，性喜条达。孕后血聚于下以养胎，则肝血自虚，加之愤怒忧思，肝气易郁，肝郁则气滞，气滞则血行不畅，以致胞脉受阻而腹痛。

【辨证施治】本病是以妊娠而伴腹痛为主证。治宜调气血、止腹痛为主，佐以安胎之法。务使胞脉通畅，“通则不痛”。但不宜过用辛温香燥、破血耗气之品，以免伤胎。

（一）虚寒妊娠腹痛：

1. 临床表现：妊娠期间，小腹冷痛，喜热按，面色㿔白，精神疲倦，形寒肢冷，纳少便溏。舌苔薄白，脉象沉迟或虚大。

2. 主证分析：肾阳虚，阴寒内盛，阳气不能外达，故

面色晄白，形寒肢冷，阳虚胞宫失于温煦，故小腹冷痛，喜热喜按；肾阳虚，不能上助脾阳，故纳少便溏。舌苔薄白，脉沉迟或虚大，均为虚寒之象。

3. 治疗法则：暖宫扶阳，止痛安胎。

4. 处方用药：附子汤（《伤寒论》）加味。

党参15克，炒白术、茯苓各12克，炙甘草、熟附片各6克，炒白芍9克，水煎2次分服。

按：本方是附子汤加甘草。

方中参、术、苓、草健脾益气，附子扶阳祛寒，芍药敛阴以防附子之燥，配甘草缓急止痛。

（二）血虚妊娠腹痛：

1. 临床表现：妊娠小腹绵绵作痛，按之痛减，面色苍白或萎黄，头目眩晕，心悸怔忡。舌质淡红，苔花剥，脉虚细。

2. 主证分析：由于血虚气滞，经脉失养，胞脉受阻，故小腹绵绵作痛，且按之痛减；血虚不能上荣于脑，则头晕目眩；不能外荣于表，则面色萎黄；不能内养于心，则心悸怔忡。舌质淡红，脉虚细，均为血虚之象。

3. 治疗法则：养血安胎。

4. 处方用药：胶艾汤（《金匱要略》）加味。

熟地18克，当归、白芍、阿胶（烊化）各9克，艾叶6克，桑寄生30克，川芎、炙甘草各4.5克。水煎2次分服。

按：本方是胶艾汤加桑寄生。

方中地、芍、归、芎即后世四物汤，有补血调经之功；芍

芍药甘草汤即芍药甘草汤，有缓急止痛之效，阿胶专于补血，艾叶长于暖宫，二者为治疗血虚腹痛之要药，加寄生益增其养血安胎的作用。

若血虚兼脾虚火湿不化者，则见目下浮肿，腿足微肿，大便溏薄，小便短少，舌苔白腻等症。宜养血佐以健脾渗湿，用当归芍药散（《金匮要略》）。

当归、芍药、泽泻各9克，炒白术、茯苓各12克，川芎4.5克。水煎服。

脾为中土，生化之源，脾过燥不能生血，故以芍药归芍滋润之；脾过湿亦不能生血，故以苓术泻淡渗之。燥湿得宜，则中气治而血自生，血得补而痛自止。

（三）气郁妊娠腹痛：

1. 临床表现：妊娠期间，精神抑郁，烦躁易怒，胸胁少腹胀满疼痛，胀甚于痛，食少噯气。苔薄腻，脉弦。

2. 主证分析：肝脉布胁肋，上胸贯膈，肝郁气滞，血行不畅，经脉受阻，故胸腹胀满疼痛；肝气宜于条达，肝气不舒，故烦躁易怒；肝气犯脾，脾失运化，故食少噯气；脾不化湿，则舌苔薄腻。脉弦为肝郁气滞之征。

3. 治法法则：疏肝和脾，理气安胎。

4. 处方用药：逍遥散（见月经后期）加苏梗宽中行气安胎。

若肝郁化火，则见面色潮红，头胀眩晕，头痛潮热，口苦咽干，大便干燥，小便黄赤，可加丹皮、山梔。

第十节 胎气上逆

妊娠期间，孕妇出现严重的胸腹胀满，甚至喘急疼痛，坐卧不安者，称为“胎气上逆”，古书称为“子悬”。

【病因病机】妇人平素阴虚，孕后又赖肾水养胎，则肾阴更加不足。水不济火，则心火偏亢；水不涵木，则肝木气盛而克脾土。因此，则阴亏于下而气浮于上，致使胎气不安，随气上逆而致本病。

【辨证施治】

(一)临床表现：妊娠期间，胸闷腹胀，甚至作痛，呼吸喘促，烦躁不安，坐卧不宁。苔薄黄，脉弦滑。

(二)主证分析：肝主疏泄，性喜条达，肾阴不足，肝气偏盛，横冲脾胃，故胸闷腹胀，时感作痛；肾阴不足，则心火亢盛，故烦躁不安，坐卧不宁；火热灼肺，肺失清降，则呼吸喘促。苔薄黄，脉弦滑，均属内热与肝气过旺之象。

(三)治疗法则：理气清热，柔肝养脾。

(四)处方用药：紫苏饮（《普济本事方》）加减。

紫苏叶6克，陈皮、大腹皮、当归、白芍、党参、黄芩、香附各9克，甘草3克。水煎2次分服。

按：本方是紫苏饮去川芎，加黄芩、香附。

方中紫苏、陈皮、大腹皮宽中下气；当归、白芍养血柔肝；党参、甘草益气扶脾。加黄芩清热安胎，加香附理气安胎。

上方服后，若标病已经解除，应滋阴益血以培根本，可用阿胶养血汤。

生地、桑寄生各15克，阿胶（烔化）、北沙参、麦冬、女贞子、旱莲草各9克。水煎2次分服。

方中阿胶、生地以养血；沙参、麦冬以滋阴；合女贞、旱莲、寄生培养肝肾以安胎。

【简易方】姜半夏9克，厚朴6克。水煎服。

第十一节 流 产

凡妊娠28周（7个月）前终止者，均称为“流产”。

若怀孕以后，阴道不时少量下血，或时下时止，或淋漓不断，但无腰酸、腹痛、小腹胀坠等现象者，称为“胎漏”，亦称“胞漏”或“漏胎”。如先感胎动下坠，继而有轻度的腰酸腹胀，或阴道有少许出血者，称为“胎动不安”，在现代医学中统称“先兆流产”。

如胎漏、胎动不安等先兆流产表现的诸症，迁延日久，病势日进，出血量超正常月经量，流产势必发生，妊娠不能继续，不宜投药姑息，称为“难免流产”。

胎漏、胎动不安，进一步发展，可有堕胎、小产之虞。一般在怀孕3个月以内，胎儿尚未成形而堕者，古称“堕胎”，今称“早期流产”，在三个月以后，胎儿已成形而堕者，古称“小产”或“半产”，今称“晚期流产”。现代医学统称为“自然流产”。

如在堕胎或小产之后，下次受孕，仍如期而堕，或屡孕屡堕，超过三次以上者，古称“滑胎”，今称“习惯性流产”。

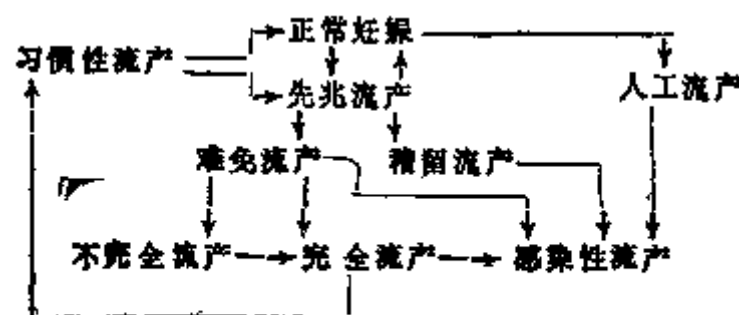
若胚胎死亡而仍稽留于子宫腔内者（一般指胚胎停止发育后2个月尚未自然排出者），古称“死胎不下”，亦称“死胎”、“胎死腹中”。现代医学称为“稽留流产”、“过期流产”。

若流产之后，整个胎盘或部分胎盘稽留宫腔，致阴道大量流血者，称为“不完全流产”。

经过先兆流产及难免流产过程，在短时期内胚胎组织完全排出者，称“完全流产”。

在流产过程中或流产后的短时间内发生感染，称为“感染性流产”。

综上所述，流产的情况各有不同，故其处理原则也就各有差异。本节采用了现代医学对流产的分类方法，按祖国医学的理法方药进行辨证施治，现分别叙述如下。



流产转化示意图

先兆流产

先兆流产包括：胎漏与胎动不安。胎漏又叫“胞漏”，是妊娠后，阴道时有流血或血性分泌物，而腹不痛的病证；胎动不安又简称“胎动”，指胎儿频频躁动，腹中疼痛，并有下坠感，甚则阴道流血的病证。

【病因病机】引起先兆流产的原因甚多，如《女科经纶》说：“妊娠胎动不安者，由冲任经虚，受胎不实也；亦有饮酒房室过度，损动不安者；有忤触伤仆，而动不安；有怒气伤肝，或郁结不舒，触动血脉不安；有过服暖药，并忌禁之药，动而不安；有因母病而胎动者。”根据古书记载及临床体会，将常见病因分列于下。

（一）肾虚：禀赋素弱，先天不足，肾气虚怯，或早婚，纵欲不节，耗伤肾气。肾为生胎之元，乃胎脉之所系，肾虚则冲任不固，胎失所系，而致胎漏，胎动不安。

（二）气血虚弱：平素体质较弱，脾胃亦虚，脾胃为气血生化之源，化源不足，以致气血虚弱，冲任不固。气虚不能摄血载胎，血虚不能滋养胎元，而致胎漏、胎动不安。

（三）血热：素体阳盛，或嗜食辛辣，或过服暖宫药物，或肝郁化热，复加孕后血聚下以养胎，阴虚阳盛，以致血热，热扰冲任，迫血妄行，引起胎漏、胎动不安。

（四）外伤：孕后起居不慎，劳力过度，跌仆闪挫，损伤气血，气血紊乱，冲任不固，胎元受损，发为胎漏、胎动不安。

【辨证施治】先兆流产常发生在妊娠早期，主要表现为下腹疼痛及阴道流血（腹痛不重，流血不多），妇科检查时子宫大小与停经月份相符，子宫口未开大，羊膜囊未破裂，妊娠试验阳性，在明确诊断后，应即进行治疗，经过合理保胎处理，多可继续妊娠至足月分娩。

（一）肾虚先兆流产：

1.临床表现：妊娠期间，腰部酸痛，小腹下坠，阴道流血，伴有头晕耳鸣，两腿酸软，小便频数，甚至失禁。舌质淡红，苔薄白，脉沉细弱。

2.主证分析：肾气不足，冲任不固，胎失所系，因而小腹下坠，阴道流血；腰为肾之府，肾虚则腰部酸痛；肾主骨生髓，脑为髓海，肾虚则骨不坚，髓不满，故两腿酸软，头晕；肾开窍于耳，肾虚则耳鸣；肾与膀胱相表里，肾虚则膀胱失约，故尿频数，甚至失禁。舌淡红，苔薄白，脉沉细弱，亦为肾气虚弱，血脉不足之象。

3.治疗法则：益肾气，安胎元。

4.处方用药：寿胎丸（《医学衷中参西录》）加味。

桑寄生30克，菟丝子18克，续断15克，阿胶（烔化），杜仲各12克。水煎2次分服。

按：本方是寿胎丸加杜仲。

方中菟丝子补肾益精；桑寄生益肾养血安胎；续断补肝肾，强筋骨，且能止血；阿胶养血止血；杜仲以增强补肝肾强筋骨安胎之效。

气虚者加党参、黄芪各15克，白术9克，下血者加艾叶

炭、棕榈炭各9克，腹胀纳少者加砂仁3克，苏梗9克，陈皮6克，腹痛者加香附9克，小便频数或失禁者加益智仁9克。

香附、陈皮均有抑制子宫收缩的作用，故保胎效果良好。

（二）气血虚弱先兆流产：

1. 临床表现：妊娠期间，胎动下坠，腰酸腹痛，阴道流血，精神萎靡，周身乏力，面色㿔白，皮肤不润。舌质淡，苔薄白，脉细滑或沉弱。

2. 主证分析：气虚不能摄血载胎，以致阴道流血，胎动不安；中气下陷，冲任不固，则腰酸腹坠；气虚阳不展布，则面色㿔白，精神萎靡；胎赖血以成长，血虚则胎失所养，故胎动不安；血虚不荣于肌肤，故皮肤不润。舌质淡，苔薄白，脉细滑或沉弱，亦气血虚弱之征。

3. 治疗法则：补气养血安胎。

4. 处方用药：泰山磐石散（《景岳全书》）减味。

党参、黄芪各15克，川断30克，熟地12克，白术、白芍、黄芩、当归各9克，砂仁6克，炙甘草8克，糯米1撮。水煎2次分服。

按：本方是泰山磐石散去川芎。

方中黄芪、党参、白术、甘草扶阳益气以载胎；熟地、当归、白芍补血养胎；砂仁理气安胎；川断补益肝肾而固胎；黄芩泻热，与术、芍合用，尤为安胎要药；糯米温养脾胃。本方取名为“泰山磐石散”者，是古人形容调补气血以固胎元的作用。

腹痛者加香附 9 克，纳少腹胀者加陈皮 9 克，气虚下坠者加升麻 9 克。

(三) 血热先兆流产：

1. 临床表现：妊娠期间，阴道流血，血色鲜红，胎动下坠，小腹作痛，口干咽燥，渴喜冷饮，或身热心烦，大便干，小便黄。舌质红，苔黄而干，脉滑数。

2. 主证分析：热扰冲任，迫血妄行，损伤胎元，以致下血鲜红，胎动下坠，小腹作痛，热扰于心则心烦，热灼津液，故口干咽燥，渴喜冷饮，大便干，小便黄。舌红，苔黄而干，脉数，均为血热之象。

3. 治疗法则：清热凉血，益阴安胎。

4. 处方用药：保阴煎（《景岳全书》）加味。

生地 30 克，熟地、续断各 15 克，炒山药 12 克，炒白芍、黄芩、苎麻根各 9 克，黄柏 6 克，生甘草 3 克。水煎 2 次分服。

按：本方是保阴煎加苎麻根。

方中生地、黄芩、黄柏养阴清热凉血，配苎麻根并能止血安胎；熟地、白芍滋阴养血；续断益肾安胎；甘草清热泻火，合白芍且有缓急止痛作用。

腹痛重者加香附 9 克。胃纳不甘腹胀者加陈皮 6 克。腰酸者加杜仲 12 克。

(四) 外伤先兆流产：

1. 临床表现：妊娠期间，有明显受伤史，受伤后腹痛腰酸，胎漏下血，脉滑无力。

2.主证分析：跌仆闪挫，或劳力过度，损伤气血，冲任失守，胎元不固，故腹痛腰酸、胎漏下血。脉滑无力，为气血俱伤之象。

3.治疗法则：益气养血，固肾安胎。

4.处方用药：寿胎丸加味。

桑寄生30克，川断、党参、黄芪各15克，菟丝子、杜仲各12克，阿胶、白术、香附、苏梗、苎麻根各9克，陈皮、砂仁各6克。水煎2次分服。

方中川断、杜仲、寄生、菟丝子固肾安胎；党参、黄芪、白术补气载胎；阿胶养血止血；苎麻根止血安胎；外伤腹痛必有气血郁滞，故加香附、砂仁、陈皮、苏梗理气安胎，气血得通，则腹痛自解。

难免流产

难免流产，亦称“不可避免流产”、“必然流产”。是由先兆流产发展而来，因病势日进，流产势必发生，妊娠已不能继续。

【病因病机】病因与先兆流产相同，只是肾虚、气血虚、血热、外伤等程度比先兆流产更为严重。

【辨证施治】治疗本病，应根据停经时间长短而定。一般只用于妊娠2个月（8周）以内者。此时多数胚胎组织已死亡，绒毛发育不全与母体联系不牢固，用药后容易完全剥离排出。停经月份较大者则应手术治疗。

（一）临床表现：开始有先兆流产的表现，但出血时间长，

出血量增多，超过正常月经量，或伴有液体（羊水）流出，而且腹痛阵发性加剧。妇科检查，子宫口已开。

（二）主证分析：肾虚日进，冲任不固，故腹痛加剧，阴道流血量多。

（三）治疗法则：若停经月份较大，出血量甚多，全身状况不良者，应手术治疗（清宫术）；若停经月份较小，病人全身状况尚好，而又不愿接受手术治疗者，宜温通冲任，活血催胎。

（四）处方用药：脱花煎（《景岳全书》）加味。

当归、川牛膝各15克，川芎、红花、车前子（布包）各9克，肉桂6克，益母草、马齿苋各30克。水煎2次分服。

按：本方是脱花煎加益母草、马齿苋。

方中当归、川芎活血行血；红花破血祛瘀；肉桂温血脉以助血行；牛膝引血下行；佐车前子以滑利下胎；坤草、马齿苋增强子宫收缩之力，以促使胚胎迅速排出。

习惯性流产

妇人怀孕，连续三次以上自然流产者，称为“习惯性流产”。古称“滑胎”。其特点是往往流产发生在同一月份。古人认为妇女怀孕十月，每月均有一条经脉养胎，即所谓“分经养胎”（这是指养胎的一经，其负荷比其他经较重的意思），一旦流产，则该经络已受损伤，因而下次又复如前期而小产。如明·王纶说：“妇人半产多在三个月及五个月，除跌仆损伤不拘外，若前次三个月而堕，则下次如期复

然，盖先于此时受伤，故后期必应乘其虚也。”

【病因病机】本病产生的原因，基本上同先兆流产。《妇人良方》说：“夫胎乃阳施阴化，营卫调和，经养完全，十月而产。若血气虚损，不能养胎，所以致堕。”《景岳全书》说：“凡妊娠之数见堕胎者，必以气脉亏损而然，而亏损之由，有禀质之素弱者；有年力之衰残者；有忧怒劳苦而困其精力者；有色欲不慎，而盗损其精气者。此外，如跌仆饮食之类，皆能伤其气脉。”从而可见，凡禀赋虚弱，忧思劳倦，房事不节，起居饮食失宜，都能导致气血虚损，血气虚则提摄不固，血虚则养胎不牢，所以多能导致习惯性流产。笔者认为肾气亏衰而致堕胎、小产者，颇为多见。总之，本病的成因，可概括为气血虚弱、肾气不固、内热伤损等三类。

【辨证施治】习惯性流产的患者，在非孕期间应查清滑胎原因，根据治病必求其本的原则，预先调治。勿急于求子，应坚持避孕1~2年，恢复元气之后，再孕为宜。

（一）气血虚弱习惯性流产：

1. 临床表现：妊娠胎动下坠，腰部及少腹坠胀，身体疲倦，面色淡黄，皮肤不润。舌淡苔薄白，脉软缓无力。

2. 主证分析：气虚不能提携，血虚不能养胎，故胎动下坠；气虚下陷，影响冲任，故腰部及少腹坠胀；气血不能荣养肌肤，故面色淡黄，身体疲倦，皮肤不润。舌淡苔白，脉软缓无力，均为气血亏损之象。

3. 治疗法则：补气养血，固冲安胎。

4. 处方用药：八珍汤（《正体类要》）加味。

党参、炙黄芪、炒山药各15克，熟地、炒白术、当归、续断各12克，茯苓、白芍各9克，川芎、炙甘草各6克，生姜3片，红枣4枚（劈）。水煎2次分服。

按：本方是八珍汤加黄芪、山药、续断。

方中四君子汤以补气，四物汤以补血，加黄芪以增强补气升提之力；山药、续断益肾健脾以固冲任。诸药合用，可达补气益血，固冲保胎之作用。

如下元不固而带下量多者，黄芪、茯苓各增至30克；虚而兼寒者加炮姜6克；虚而兼热者加黄芩9克。

（二）肾虚不固习惯性流产：

1. 临床表现：妊娠期间，胎动不安，腰部酸痛，小腹下坠，或有阴道流血，头晕耳鸣，两腿酸软，小便频数。舌淡，苔白滑，脉沉弱。

2. 主证分析：腰为肾之府，肾虚冲任失养，故腰部酸痛，小腹下坠，阴道流血，屡孕屡堕；肾主骨生髓，开窍于耳，脑为髓之海，肾虚则骨不坚，髓不满，故头晕耳鸣，两腿酸软；肾司二便，与膀胱相表里，肾虚膀胱失约，故小便频数。舌淡，苔白滑，脉沉弱，皆为肾气衰弱之候。

3. 治疗法则：补肾固冲安胎。

4. 处方用药：补肾固冲丸。

菟丝子240克，熟地150克，阿胶120克，鹿角霜、炒白术、枸杞子、巴戟肉、杜仲、续断各90克，当归60克，砂仁15克，大枣肉50枚。

制法：除熟地、阿胶、枸杞、大枣肉外，共研细末。另将熟地、枸杞煎熬三次，去渣，以液溶化阿胶，使成稀糊状；另将大枣肉（蒸熟）捣烂，再将药液及枣肉调匀，并加适量煮过的白蜜，制成小丸如梧子大，瓶贮备服。

服法：每次9克，每日3次。经期停药，2个月为一疗程。

方中熟地、枸杞补肾阴；巴戟、鹿角霜补肾阳；菟丝子益阴而固阳；当归、阿胶以补血；杜仲、续断补肝肾、壮筋骨、强腰膝、固冲以保胎；白术、大枣以健脾；砂仁理气，并防诸药之滋腻碍胃。

兼肝火盛者，应兼滋肝阴，加白芍、女贞子、旱莲草各60克，生地90克；肝气郁结者，加柴胡、白芍各60克。

习惯性流产属于冲任亏损，肾气不固，以致屡孕屡堕者，须在未孕之前配制此丸加以调治，并在调治期间停止受孕、节制房事，以巩固体质。

如已受孕，可服补肾安胎饮加减。

桑寄生30克，菟丝子15克，杜仲、党参、狗脊各12克，炒白术、阿胶（烔化）、艾叶炭、益智仁各9克。水煎2次分服。

按：本方是补肾安胎饮去补骨脂，加桑寄生。

从习惯性流产月份前2周开始服用，隔日1剂，连续服过习惯性流产月份4周。

方中党参、白术益气安胎；杜仲、续断补肝肾，强腰膝以保胎；狗脊、益智仁补肾固冲；阿胶、艾叶养血止血；桑

寄生养血益精，并能安胎。

如子宫颈机能不全而引起的习惯性流产，可服补中益气汤。

（三）血热损伤习惯性流产：

1.临床表现：胎动不安，小腹作痛，或阴道下血，心烦不宁，咽干口渴，小便短黄。舌质红，苔薄黄，脉滑数。

2.主证分析：热伏冲任，内扰胞宫，致胎动不安，小腹作痛；热迫血行，故阴道下血；热邪乘心，则心烦不宁；热灼津液，则咽干口渴，小便短黄。舌红苔黄，脉滑数，均系血热之象。

3.治疗法则：清热养阴，凉血安胎。

4.处方用药：凉胎饮（《景岳全书》）加减。

生地24克，白芍12克，旱莲草15克，炒白术、黄芩、当归、石斛各9克，黄柏、生甘草各6克，桑寄生30克。水煎2次分服。

按：本方是凉胎饮去茯苓、枳壳，加旱莲草、黄柏、桑寄生。

方中生地、黄芩、黄柏清热凉血，当归、白芍、旱莲草养血敛阴；白术配黄芩能健脾安胎；石斛养阴生津以护液，寄生补血益肾以保胎。全方有清热凉血，养血止血，固冲安胎的作用。热清血止，胎孕自可保全。

【简易方】

（一）杜仲、续断、桑寄生各60克。共研细末，水泛为丸。每次9克，日服3次，孕后服过流产期。

(二)炒杜仲、炙黄芪各9克，炒白术、当归各6克。
水煎服，每周3剂，孕后服过流产期。

(三)胎产金丹(成药)，每次1丸，日服2次。

【预防】

(一)加强锻炼，增强体质。对上述患者，应早期投药，及时治疗。

(二)妊娠期间，积极预防各种传染病及其他感染，保持健康。

(三)注意劳动保护，防止外伤。

(四)有习惯性流产者，首先应解除精神紧张，平时要节制性生活，妊娠期应避免房事。

稽留流产

稽留流产，亦称“过期流产”，古称“胎死不下”、“胎死腹中”，指胚胎死亡而仍稽留于宫腔内者。一般规定胚胎停止发育后2个月未自然排出者，称为“稽留流产”。

【病因病机】由于肾虚、气血虚、血热，外伤等因素，使胎死腹中，而又因胎盘胎膜与宫壁粘着过牢，或宫缩乏力，不能将死胎排出体外而稽留于宫腔。

【辨证施治】

(一)临床表现：曾经有先兆流产的症状，妊娠反应及胎动消失，阴道或有少量暗红色液体流出，子宫小于妊娠月份，有时出现口臭，恶心，腰腹胀满，小腹发凉，面色青黯，口唇尤著。舌质紫黯，脉沉涩。

(二)主证分析：由于胎死腹中，故妊娠反应及胎动消失，子宫小于妊娠月份；瘀血内阻，气机不畅，故腰腹胀满，阴道流血，小腰发凉；胎死血瘀，瘀久腐臭上蒸脾胃，故口臭，恶心；血瘀经脉流通不畅，故唇黯，舌紫，脉沉涩。

(三)治疗法则：行气活血祛瘀。但限于停经时间较短，子宫较小者。若停经月份较长，子宫超过二个月妊娠大者，以引产为宜。

(四)处方用药：

1. 脱花煎（见难免流产）加益母草30克，厚朴9克。

2. 桂枝茯苓丸（《金匮要略》）加味。

桂枝、茯苓、丹皮、赤芍、酒大黄、枳壳各9克，炒桃仁15克，益母草30克。水煎2次分服。

按：本方是桂枝茯苓丸加枳壳、大黄、益母草。

方中桂枝温通血脉，赤芍行血中之滞；丹皮消瘀血；桃仁破血结；茯苓下行，与桂枝同用能入阴通阳；酒大黄、枳壳、益母草以增强化瘀催下之力。合用共奏活血化瘀，消症催胎之效。

不完全流产

【病因病机】不完全流产常发生在较晚期妊娠（10周以后），此时胎盘正在发育或已形成，流产时胎儿及部分胎盘排出，部分胎盘胎膜仍附在子宫壁上，子宫不能很好地收缩，以致阴道流血，量甚多。

【辨证施治】

(一) 临床表现：妊娠期间，先有先兆流产的表现，经保胎治疗或未经治疗，腹痛加重，阴道流血量增多，继之有胎儿、胎盘部分排出。虽有胎物排出，但仍有腹痛拒按，且流血不止，或反复阴道流血，并夹有血块及伴有较多的液体。妇科检查：子宫口未闭，宫缩欠佳，或有胎盘组织阻塞宫颈。

(二) 主证分析：由于妊娠月份较大，胎盘牢固不易剥脱，瘀血内阻，气机不畅，故有腹痛拒按，流血不止（瘀血不去，新血不得归经）；或由于气虚宫缩乏力，无力排出胎盘胎膜，故见流血不止（属气虚血瘀）。

(三) 治疗法则：如停经月份较大，出血量甚多，病人处于休克状态，应立即输血输液，并给子宫收缩剂，待休克纠正行清宫术；若停经月份不大，病人情况尚好者，可服药促进胎盘组织排出（药物性刮宫）。

(四) 处方用药：佛手散（《普济本事方》）加味。

当归30克，川芎9克，川牛膝15克，益母草、马齿苋各30克。水煎2次分服。

按：本方是佛手散加牛膝、马齿苋、益母草。

方中当归、川芎行气和血；牛膝引血下行；益母草、马齿苋增强宫缩以便排出残留的胚胎组织。

若偏气虚者，加党参、黄芪各30克；偏血瘀者，加生蒲黄、炒五灵脂各9克。

完全流产

完全流产，是指通过先兆流产及难免流产过程，在短时间内胚胎组织完全排出者。

【病因病机】停经月份较小，胎盘尚未完全形成，与宫壁附着不牢，子宫收缩强烈，即可将胚胎组织完全排出。

【辨证施治】完全流产，因胚胎组织完全排出，腹痛消失，流血停止，身体可逐渐恢复健康，一般不需作特别处理。倘若仍有腹痛及阴道有少量瘀血流出者，则须调治，以促使子宫的恢复。

（一）临床表现：经过剧烈腹痛及阴道较多的流血，胚胎组织已全部排出体外，腹痛消失，阴道流血逐渐停止。妇科检查：子宫收缩良好。

（二）主证分析：由于胎盘组织已全部排出体外，瘀滞解除，气血得通，故腹痛消失，流血停止。

（三）治疗法则：活血化瘀，佐以益气。

（四）处方用药：生化汤（《傅青主女科》）加味。

当归24克，川芎、桃仁各9克，炮姜炭、炙甘草各8克，益母草、党参各15克。水煎兑黄酒30毫升，童便1盅，2次分服。

按：本方是生化汤加益母草、党参。

方中当归、川芎行血和血；桃仁、益母草活血化瘀；炮姜温经止痛；党参、甘草以补气；黄酒温散以助药力，失血必伤阴，故佐童便益阴止血。

感染性流产

在流产过程中，或流产后的短时间内发生感染，称为“感染性流产”。

【病因病机】流产过程中，正气虚衰，抗邪之力下降，出血时间过长，胚胎组织排出不净，器械消毒不严，或手术不按无菌操作而感染毒邪。

【辨证施治】

（一）临床表现：发烧恶寒，下腹疼痛而拒按，赤白带下，色浊味臭。血液化验：白细胞总数及中性粒细胞均增高。

（二）主证分析：正气与病邪相搏，故发热恶寒；血瘀于内，气机壅滞，故腹拒按；热伤胞络，故见赤白带下，色浊而臭。

（三）治法方药：清热解毒。

（四）处方用药：五味消毒饮（《医宗金鉴》）合银花薏苡饮（《中医妇科治疗学》）加味。

银花、蒲公英、紫地丁各15克，薏苡（鱼腥草）、土茯苓各30克，野菊花12克，天葵子9克，黄柏、荆芥、生甘草各6克。水煎2次分服。

按：五味消毒饮是银花、公英、地丁、野菊、天葵子组成；银花薏苡饮是银花、薏苡、土茯苓、荆芥、甘草组成。

方中银花、公英、地丁、天葵、野菊五味，均有较强的清热解毒作用；鱼腥草、土茯苓利湿解毒；荆芥散瘀解毒；生甘草清热泻火；加黄柏以增强燥湿泻热解毒之力。

第十二节 难 产

妊娠足月，临产时胎儿不能顺利娩出者，称为“难产”，亦称“产难”。证见腹部阵痛，腰酸腹胀，小腹重坠，胞水与血俱下，而胎儿又不娩出。其中，产时儿手先下者，称为“横产”；儿足先下者，称“倒产”或“逆产”；若产时用力过早，疲乏，久坐椅褥，仍未产出者，称为“坐产”。

现代医学认为，难产的主要原因，有产力异常（主要是子宫收缩力，其次是腹肌及膈肌收缩力），产道异常（骨产道异常，指骨盆狭小、骨盆畸形；软产道异常，指生殖器官及盆腔其他器官病变），胎儿、胎位异常（巨大儿、畸形儿及胎位异常）。产道异常、胎儿巨大、畸形所致难产，须手术治疗，不予介绍。本节只介绍产力异常所引起的难产。

【病因病机】 产力异常性难产，主要机理是气血虚弱或气血瘀滞。

（一）**气血虚弱**：平素体质虚弱，正气不足，或产时用力过早，耗气伤血，致子宫收缩乏力，造成难产。正如《胎产心法》所说：“素常虚弱，用力太早，及早欲出，母已无力，令儿停住，产户干涩，产亦艰难。”

（二）**气滞血瘀**：孕期过度安逸，久坐久卧，气不运行，血不畅流，或惊恐忧惧，过度紧张，以致气郁血滞，造成难产。如《医宗金鉴》说：“难产之由，非只一端，或胎前喜安逸不耐劳碌，或贪睡眠，皆令气滞难产；或临产惊恐气怯

……或胞伤血出，血壅产道。”

【辨证施治】 遇有难产患者，首先明确是产力异常、产道异常，或胎儿胎位异常。只有产力异常属于子宫收缩乏力引起的难产，方可用药。

（一）气血虚弱难产：

1. 临床表现：产时腹部阵痛微弱，间隔时间长，持续时间短，久产不下（总产程可超过24小时），面色苍白，精神疲倦，心悸气短。舌淡，苔薄白，脉虚大或沉细而弱。

2. 主证分析：气血虚弱，宫缩乏力，故腹部阵痛微弱，间隔时间长而持续时间短，久产不下；气血俱虚，不足以荣于全身，故面色苍白，精神疲倦，心悸气短。舌淡，苔薄白，脉虚大或沉细弱，均为气血俱虚之候。

3. 治疗法则：大补气血。

4. 处方用药：蔡松汀难产方。

炙黄芪30克，党参、当归各18克，炒杭芍、川芎、茯神各9克，枸杞子、醋龟板各15克。只煎头煎顿服。

方中参芪大补元气；归、芍、芎养血活血；茯神健脑宁心；枸杞滋养肝肾；龟板填精补血，润胎催产。

（二）气滞血瘀难产：

1. 临床表现：腹痛较重，宫缩较强（与前者相比而言），但间歇不匀（或宫缩不协调），久产不下，产程延长，面色紫黯，精神紧张，烦躁易怒，或精神抑郁，时欲叹气，胸脘胀闷。舌质黯红，脉沉实而乱。

2. 主证分析：《妇人良方》说：“妇人以血为主，推气

顺血和，胎安则产顺。”由于气滞血瘀，气血运行受阻，胎儿欲下不能，故腹痛重，而久产不下；气阻凝滞，气机不畅，升降失常，故面色紫暗，胸膈胀闷，因欲暖气；血瘀则舌质黯，脉沉实为气滞血瘀之征，脉乱是临产之兆。

3. 治疗法则：理气活血，祛瘀催产。

4. 处方用药：催生饮（《济阴纲目》）加味。

当归、川牛膝各15克，大腹皮、炒枳壳、川芎、白芷各9克，益母草30克。水煎2次分服。

按：本方是催生饮加益母草。

方中当归、川芎、益母草活血化瘀；大腹皮、枳壳宽中下气；白芷芳香通窍；川牛膝引药下行。药理研究证明，川芎、当归、益母草、枳壳、牛膝均有促使子宫收缩的作用，故治宫缩乏力有显效。

【简易方】

（一）束胎丸（《沈氏尊生书》）：炒白术、炒枳壳各等份。共为细末，水渍拌蒸熟，丸如梧子大，每次12克，日服3次，温汤送下。原书指证：缩胎易产。

（二）枳壳瘦胎散（《济阴纲目》）：炒枳壳、生甘草各30克，制香附45克。共研细末，每次8克，日服3次，温汤调下。原书指证：治孕妇八、九月胎气壅满，服之滑胎易产。

【针刺法】 合谷、三阴交、支沟、太冲。均取双侧穴位，强刺，留针。

附：转胎方

妊娠 7 个月，行产前检查，发现胎位异常时，可用下列转胎法。

(一)艾灸至阴穴：取双侧至阴穴，以艾条灸之，每次约 10 分钟，每日 1～2 次，灸后立即膝胸卧位 10 分钟左右，七天后复查。此法已广泛应用，疗效肯定。

(二)针刺至阴穴：安徽省芜湖市中心医院试用针刺至阴穴矫正胎位不正 10 例，均转为头位，最长二天转为头位。针刺后留针 15 分钟，每隔 5 分钟捻转 1 次，手法不宜过重，需让患者哈气，放松腹肌，以利胎儿转动（见《中西医结合治疗妇产科常见病经验汇编》，人民卫生出版社，1979 年 7 月，190 页）

(三)保胎无忧散（明太医传方）：当归（酒洗）、生黄芪、菟丝子（酒泡）各 4.5 克，白芍 3.6 克，川芎 2.4 克，厚朴（姜汁炒）2.1 克，枳壳（麸炒）18 克，荆芥穗、羌活、大腹皮、艾叶、生甘草各 1.5 克，川贝、生姜各 3 克。水煎清晨空腹服。

无锡市第三人民医院将此方按法炮制，矫正胎位异常 219 例，有效率达 86.7% 以上。

(四)转胎汤（原名十三太保汤）：炙黄芪、川芎、当归、菟丝子各 4.5 克，炒白芍 3 克，姜厚朴、紫苏叶、川贝、艾叶、荆芥各 2.1 克，炒枳壳 1.8 克，羌活、炙甘草各 1.5 克。水煎服。每日 1 剂，连服 3 剂为一疗程，最多连服 9 剂。江

西省宜春地区人民医院纠正胎位104例，成功87例，占83.7%，一般3～6剂可生效。

(五)八珍汤加减：熟地、当归、炒白芍、党参、炒白术、炙黄芪、续断各9克，川芎、甘草各6克。水煎2次分服。每日1剂，早晚空腹服下，3剂为一疗程，一般服2个疗程。江西省德兴县卫生局科研组矫正胎位73例，总有效率为82.59%。

第四章 产后病

产后6~8周内，称为产褥期，在产褥期发生与分娩有关的疾病，称为“产后病”。

由于分娩时的产创和出血，以及临产用力等，造成气血亏虚，元气受损，从而导致“百节空虚”，抗病力弱，稍有病邪侵袭而发生各种疾病。一旦发病，则病重难疗。正如《妇人良方》说：“犯时微若秋毫，成病重如山岳。”故对产后病的诊治必须高度重视。

产后病的发病机理，古医籍记载较多，现可归纳为三种：一是冲任损伤，亡血伤津；二是瘀血内阻，败血妄行；三是外淫，饮食房劳所伤。

古人在诊断产后病时，除了运用四诊八纲辨证外，特别强调产后“三审”之法：即先审少腹痛与不痛，恶露之多少，以辨有无瘀血阻滞；次审大便通与不通，以验津液之盛衰；三审乳汁行与不行以及饮食之多少，以辨胃气之强弱。

古人对产后病还有三急、三冲、三病之说。呕吐、盗汗、泄泻为三急，三者并见，其病危急。因产后气血大伤，再加上吐、下泻、汗出，益亡其津液，必致虚脱衰竭，危及生命。三冲是败血上冲，冲心、冲肺、冲胃。冲心者十难救一，冲肺者十全一二，冲胃者五死五生。这是古人对产后瘀

血症预后不良的看法。《金匱要略》又有“新产妇人有三病，一者病痉，二者病郁冒，三者大便难”的记载。这三病的临床表现虽不同，但病机则一，都是在亡血伤津的情况下产生的。

产后病的治疗，较早的医家有的主张补虚，有的主张逐瘀。至明清医家的认识比较客观。如《医宗金鉴·妇科心法要诀》说：“胎前无不足，产后无有余，此言其常也。然胎前虽多有余之证，亦当详察其亦有不足之时；产后虽多不足之病，亦当详审其每挟有余之证也。”《景岳全书》说：“产后气血俱去，诚多虚证。然有虚者，有不虚者，有全实者。凡此三者，但当随证随人，辨其虚实，以常法治疗，不得有诚心概行大补，以致助邪。”又说：“产后既有表邪，不得不解；既有火邪，不得不清；既有内伤停清，不得不开通消导……遇此等实证，若用大补，是养虎为患，误矣。”总之，对产后病的治疗，应根据亡血伤津，瘀血内阻，多虚多瘀的特点，本着“勿拘于产后，亦勿忘于产后”的原则，细心体察，针对病情，虚者宜补，实者宜攻，寒者宜温，热者宜清，但选方用药必须照顾气血，开郁勿过耗散，消导必先扶脾，寒证不宜过用辛燥，热证不宜过用寒凉。总宜审慎，灵活掌握。

临床常见的产后病有：胞衣不下，恶露不止，恶露不下，产后小便不通，产后小便频数与失禁，产后血晕，产后发热，产后发痉，产后大便难，产后汗出，产后腹痛，产后身痛，乳汁不行，乳汁自出等。上述都是本章所讨论的内容。

第一节 胞衣不下

胞衣，亦称胎衣，即胎盘与胎膜。凡胎儿娩出后半小时，胎盘尚未排出者，称“胞衣不下”，亦称“息胞”，现代医学称为“胎盘滞留”。

【病因病机】 在正常情况下，当胎儿娩出后，子宫肌的有力收缩，能使整个子宫腔迅速缩小，并在腹部压力稍有增加的协同动作下，胞衣即能顺利娩出。若气血运行不畅，胞宫活动力减弱，就不能使胞衣排下。导致气血运行不畅的因素，大致可分为气虚、血瘀、寒凝三种。

（一）气虚：妇人素体虚弱，元气不足，或产程过长，用力过度，疲惫不堪，或子宫过大，如双胞胎，羊水过多等，使宫体过度松弛，以致收缩不良，因而胞衣不能顺利排出。

（二）血瘀：胎儿娩出后，由于瘀血阻滞胞脉，胞宫功能失常，而不能将胞衣排出。

（三）寒凝：临产或产时调摄失宜，感受寒邪，致使气血凝滞，因而胞衣不下。

【辨证施治】 本病的主要症状是胎衣不下且大量流血，流血多者常可出现休克症状，如处理延迟或不当，可直接危害产妇的健康和生命。但也有一些病例因胎盘尚未剥离，而出血很少，甚至没有外出血症状，但绝不能因出血少而大意，要注意到胎盘粘连和植入性胎盘的可能性。

目前此证在一般医院均采用注射宫缩剂或手术剥离胎盘法。在没有上述条件的情况下，中药治疗还是必要的。其治疗原则，分别以补气养血，活血化瘀，温经行滞为主。使气充血足寒散瘀去，则子宫机能恢复，胞衣自然排出。切勿使用攻伐或阴凝之品，以免耗气滞血。此外，可配合外治法（附后），以辅助内服药之不足。

若大量出血出现休克或虚脱，应中西医结合及时处理。

（一）气虚胞衣不下：

1. 临床表现：胎儿娩出半小时之后，胞衣不下，少腹微胀，下腹有块按之不痛、不坚，阴道流血量多而色淡，头晕心悸，气短神疲，面色㿔白，舌淡苔薄，脉细弱无力。

2. 主证分析：素体虚弱，加之产时用力过度，或产程过长，耗气伤血，无力将胞衣排出，故胞衣不下；阳气不足，不能摄血，故阴道流血量多而色淡；胞衣稽留，胞宫未复，故按之有块而不痛、不坚；血虚不能上荣于头面，故头晕，面色㿔白；中阳不振，心血亏耗，故心悸神疲。舌淡苔薄，脉细弱，均为气血虚弱之象。

3. 治疗法则：补气养血，佐以行瘀。

4. 处方用药：生化汤（《傅青主女科》）加味。

当归、党参各24克，炙黄芪15克，川芎、炒桃仁各9克，炮姜炭3克，益母草30克，炙甘草6克。水煎顿服。

按：此方是生化汤加党参、黄芪、益母草。

方中当归、党参、黄芪补气养血；炮姜、甘草温脾以资化源；川芎、桃仁、益母草活血化瘀。如此配合，则行中有

补，能生能化，可使气血充足，运行通畅，尤其重用益母草能促使子宫收缩，更有利于胞衣排出。

（二）血瘀胞衣不下：

1. 临床表现：妇人分娩之后，胞衣不下，小腹剧痛，坚硬有块，按之更痛，出血量少、色黯，胸腹胀满，食欲不振。舌质紫黯，脉弦涩有力。

2. 主证分析：瘀血蓄积胞衣之内，阻滞胞宫的功能活动，故小腹剧痛，有块拒按，恶露量少、色黯；瘀血内停，气机不畅，故胸腹胀闷，食欲不振。舌质紫黯，脉弦涩有力，俱瘀血阻滞之候。

3. 治疗法则：活血化瘀。

4. 处方用药：失笑散（《和剂局方》）合花蕊石散（《和剂局方》）。

炒蒲黄、炒五灵脂炭各15克，水煎去渣取汁，兑入黄酒16毫升，童便1小杯，冲服花蕊石散6克。

花蕊石散：花蕊石500克，硫黄120克。共研细面，入瓦罐内，盐泥封固，晒干，置于砖上，以炭火煅12小时，待冷取研细。装瓶备用。

方中蒲黄、五灵脂均有化瘀止痛的特殊效用；花蕊石酸涩平无毒，能下死胎，落胞衣，并能化瘀，配合温性之硫黄，其效益彰。

如花蕊石散炮制不便，单服失笑散兑入黄酒、童便亦可。

（三）寒凝胞衣不下：

1.临床表现：胎儿娩出后胞衣不下，小腹冷痛拒按，按之有硬块，阴道流血量少，色黯红，面色苍白，痛重时伴有呕恶。舌淡、苔白，脉沉弦而涩。

2.主证分析：产时感受寒邪，血为寒凝，故胞衣不下，腹冷痛拒按，阴道流血量少；因胞衣不下，子宫未复，故按之有块且硬；寒气上逆犯胃，故痛时伴有呕恶；寒邪闭塞，阳气受阻，故面色苍白。舌质淡，苔薄白，脉沉弦而涩，均为寒凝血滞之征。

3.治疗法则：温经散寒，活血化瘀。

4.处方用药：黑神散（《和剂局方》）加味。

熟地12克，当归24克，炒杭芍、川芎、生蒲黄各9克，川牛膝15克，炮姜、肉桂、炙甘草各6克，益母草、黑大豆、黄酒（冲兑）各30克。水煎顿服。

按：本方是黑神散加牛膝、川芎、益母草、黄酒。

方中肉桂、炮姜温经散寒以通血脉；地黄、当归、白芍养血和血；川芎、蒲黄活血行滞；牛膝引血下行；益母草化瘀消症；熟地伍黑豆滋补肝肾；甘草益脾和中；加黄酒以助活血散寒之力。寒散血活，胞衣自下。另外，方中益母草、蒲黄、牛膝均有促使子宫收缩作用，故易使胎盘剥离而迅速排出体外。

【外治法】

（一）蓖麻子仁30克，捣成泥状，用酒调敷于双足涌泉穴。

（二）因寒凝血滞者，艾叶炒热熨少腹。

(三)针灸：取中极（脐下4寸），先针后灸。

第二节 恶露不止

妇女分娩后2~3周内，有少量暗红色的血性液体从阴道内排出，称为“恶露”。恶露随产后日数的增加而逐渐减少，一般在2周左右即可排尽。如果超过3周，恶露仍然淋漓不断，或继续流血，称为“恶露不止”，又叫“恶露不绝”、“恶露不尽”。若迁延日久，常致血亏液竭，而发生其他病变。

【病因病机】《胎产新法》说：“产后恶露不止，非如崩漏暴下之多也，由于产时伤其经血，虚损不足，不能收摄，或恶露不尽，则好血难安，相并而下，日久不止。”说明虚损及瘀血是恶露不绝的原因。张仲景认为恶露不绝，有因于血热者，有因于气虚者。总其发病因素，有气虚、血热、血瘀等。

(一)气虚：患者平时体质虚弱，正气不足，又加产时气血耗损，气虚不能摄纳，血失统摄，导致恶露不止。

(二)血热：产妇平时阴虚，产时伤血，使阴血更亏，而致阴虚内热，或因肝郁化热，或因产后过用辛辣温燥之品，或邪毒内侵与血相搏，蕴而化热，热迫于血，冲任失守，导致恶露不绝。

(三)血瘀：新产之后，胞脉正虚，风寒乘虚侵袭胞中，外邪与血相搏，壅滞郁结，瘀血内阻，行而不畅，以致恶露

淋漓量少，久下不止。

【辨证施治】 产后恶露不止，有虚实寒热之分。辨证时，除病人的自觉症状外，恶露的色质气味有重要的参考价值。恶露量多，色淡红，质清稀而无臭味者，多属气虚；恶露色红或紫，质粘稠而有腥臭者，多属血热；恶露色紫有块者，多属血瘀。临床时，结合妇科检查及化验结果，可进一步明确诊断。

如分娩后有大量出血或出血不止，应考虑是否胎盘残留、产道损伤或宫缩乏力性出血（如产后血崩，可按血崩处理），或行诊断性刮宫术，以排除绒毛膜上皮癌。

（一）气虚恶露不止：

1. 临床表现：产后恶露不止，淋漓不断，色淡红，质稀，量多，无臭味，时觉小腹下坠，精神疲乏，少气懒言，面色觥白。舌质淡红，苔薄白，脉缓弱。妇科检查：子宫较大而软，多为子宫复旧不全。

2. 主证分析：素体虚弱，或产时失血过多，气虚失摄，子宫乏力，收缩不良，以致恶露过期不止而量多；气虚生寒，血失温煦，故色淡，质稀而不臭；气虚下陷，故小腹空坠；精神疲乏，面色觥白，舌淡脉缓弱，亦气血虚弱之征。

3. 治疗法则：补气摄血。

4. 处方用药：补中益气汤（《脾胃论》）加味。

党参、炙黄芪各15克，炒白术12克，当归、阿胶（烔化）、艾叶炭各9克，陈皮、炙甘草、柴胡、升麻各6克，益母草30克。水煎2次分服。

按：本方是补中益气汤加阿胶、艾叶、益母草。

方中党参、黄芪、白术、甘草补中益气；当归、阿胶、艾炭温养奇经以摄血；陈皮以和中；升麻、柴胡以升阳。使元气旺而血归经，胞宫暖而冲任固。益母草促进宫缩，祛瘀生新以止血。

（二）血热恶露不止：

1. 临床表现：恶露过期不止，量多色鲜红或深红，质稠而臭，甚或挟脓样白带，面色潮红，口舌干燥，或有发热，小便黄。舌质红，苔黄或黄腻，脉虚细而数。妇科检查：多有产褥感染情况。

2. 主证分析：产后阴液耗损，阴虚则生内热，热扰冲任，迫血妄行，故恶露过期不止，色红质稠而有臭味；热邪上扰，则面色潮红；热伤津液，则口干舌燥，舌质红，脉虚细而数，为阴虚血热之象。产后正气虚损，血室正升，邪毒易于侵入，可导致生殖器官炎症，故有脓样白带。

3. 治疗法则：清热解毒，养阴止血。

4. 处方用药：保阴煎（《景岳全书》）加减。

生地30克，白芍12克，续断、蒲黄炭、黄芩、黄柏各9克，生甘草6克，旱莲草、鱼腥草各15克，马齿苋30克。水煎2次分服。

按：本方是保阴煎去熟地、山药，加蒲黄、旱莲草、鱼腥草、马齿苋。

方中生地、白芍、旱莲草养阴清热；黄芩、黄柏、鱼腥草清热解毒；蒲黄合旱莲以止血；续断既补肝肾，又能止

血，甘草调和诸药，马齿苋既清热解毒，又能促使子宫收缩，从而止血止带。

若肝郁血热，两胁胀痛，精神郁闷，口干心烦，苔红脉弦，治以疏肝解郁，清热凉血为主，用丹栀逍遥散（见月经先期）加减。

（三）血瘀恶露不止：

1.临证表现：产后恶露淋漓不止，量少，色紫黑有血块，小腹疼痛拒按，或按之有块。舌质紫暗或瘀点，脉象弦涩或沉弦有力。此型常有胎盘胎膜剥落不全。

2.主证分析：瘀血阻滞胞中，经血运行失常，故恶露量少，淋漓不断，色紫有块；外邪与血相结，留结于脉，瘀血内阻，故小腹痛、拒按而有块。舌质紫暗有瘀点，脉弦涩，为瘀血内阻之征。

3.治疗法则：活血化瘀。

4.处方用药：生化汤（《傅青主女科》）加味。

当归15克，芥穗炭、川芎各6克，桃仁、生蒲黄、炒灵脂各9克，炮姜1.5克，炙甘草3克，益母草15克。水煎2次分服。

按：本方是生化汤加蒲黄、五灵脂、益母草、芥穗炭。

方中当归、川芎和血行血；桃仁、益母草活血化瘀；姜炭温经散寒止血；蒲黄、灵脂化瘀止痛；芥穗炭不仅散风止血而不留瘀，且能防产后外感风邪而发痉。

第三节 恶露不下

妇人产后，恶露停留于胞宫之内不能排出或排出甚少，并兼有其他症状者，称为“恶露不下”。

产后恶露当下不下，可引起血晕、腹痛、发热，甚至形成症瘕等证，应及时治疗。

如产后恶露不下，或下亦甚少，而全身情况良好，无腰腹痛、发热等症状表现者，不以病论。正如王孟英所谓：“恶露不来，腹无痛苦，勿乱投药饵，听之可也。”

【病因病机】 本病的主要机理，是由于气血运行不畅所致。气血运行不畅的原因，临床常见的有气滞、血瘀两种。

(一)气滞：产后情志不舒，肝气郁结，疏泄失职，气机不利，以致恶露当下不下。

(二)血瘀：产时或产后，当风受寒，或伤于生冷，恶露为寒所凝滞，故瘀结不下。

【辨证施治】 虽本病多由气滞血瘀所致，但因产后“百节空虚”，故临床所见，多属虚中挟实。如恶露不下，少腹胀甚于痛者，属气滞；而痛甚于胀者，属血瘀。治疗的原则以调气和血为主，不可过用辛温燥血之品，亦勿妄投攻破之剂。

(一)气滞恶露不下：

1.临床表现：产后恶露不下，或下亦甚少，小腹胀甚而

痛，胸肋胀满。舌质正常，苔薄白，脉弦。

2.主证分析：气为血帅，血随气行，气滞则余血浊液随之亦滞，故恶露不下或甚少；气机不畅，血行受阻，故少腹胀甚而痛；气郁不宣，则胸肋胀满，脉弦，亦为肝郁气滞之象。

3.治疗法则：理气解郁，佐以活血。

4.处方用药：乌药汤（《济阴纲目》）加味。

乌药、香附、当归、川楝子、元胡索各9克，木香、炙甘草各6克，益母草15克。水煎2次分服。

按：本方是乌药汤加川楝子、元胡索、益母草。

方中乌药善理胸腹寒冷逆滞之气，并通行上下，消胀止痛，为方中主药；辅以香附、木香、川楝子，一疏肝经郁气，一调肠胃气机，共奏行气止痛之效；当归、益母草、元胡活血通络；甘草和中缓急，以为佐使。

（二）血瘀恶露不下：

1.临床表现：产后恶露不下或下之甚少，色紫黯，小腹疼痛拒按，痛处有块。舌质青紫，脉涩。

2.主证分析：恶露为寒所凝，瘀结不下，故小腹有块，痛而拒按。舌紫，脉涩，亦为血瘀之象。

3.治疗法则：活血行瘀。

4.处方用药：生化汤（《傅青主女科》）加味。

当归24克，川芎6克，桃仁、香附、生蒲黄、五灵脂各9克，益母草15克，炙甘草6克，炮姜8克。水煎2次分服。

按：本方是生化汤加蒲黄、灵脂、香附、益母草。

方中重用当归补血活血为主药；辅川芎行气活血；配桃仁、益母草、蒲黄、灵脂以增强活血化瘀止痛之力；炮姜温经祛寒；甘草和中缓急；香附理气，以助血行。全方共奏活血化瘀行气止痛之效。

若产后恶露不下，伴有发热者，则按“产后发热”处理。

第四节 产后小便不通

产后尿闭，小腹胀急疼痛，甚则坐卧不安，称为“产后小便不通”。现代医学称为“产后尿潴留”。

正常产妇应于产后4～6小时内自动排尿，如产后8小时尚不能排尿时（膀胱内有尿而不能排出），则称为尿潴留。能排解一部分者，称为部分尿潴留。本病多发生于初产妇，特别是产程过长者占多数。

【病因病机】 本病的发生，不外虚实两端。虚者由于气化失职，不及州都，而致膀胱不利；实者肝郁不宣，气滞膀胱，而致水道不行。

（一）气虚：素体虚弱，产时劳力伤气，或产程过长；或产时产后流血过多，气随血耗，脾肺之气愈虚，不能通调水道、下输膀胱，导致膀胱闭塞，尿液潴留而不通。

（二）肾虚：早婚多产，房室不节，肾气素虚，复因分娩损伤肾气，以致肾阳不足，不能化气行水，水停膀胱，小便

不通。

(三)气滞：产后情志不舒，肝气郁结，气机阻滞，清浊升降失调，以致膀胱不利，小便不通。

【辨证施治】

(一)气虚小便不通：

1.临床表现：产后小便不通，小腹胀急，精神萎靡不振，言语低微无力，检查时小腹叩浊，导尿时尿液可达数千毫升。舌质淡，苔薄脉缓弱。

2.主证分析：肺为水之上源，肺主诸气。肺气虚，不能通调水道，下输膀胱，故小便不通；肺气虚则治节无权，膀胱气化不行，则尿液潴留，欲溺不能，故小腹胀急不安；精神萎靡不振，语言低微无力，舌淡，苔薄，脉缓弱，均属脾肺气虚之征。

3.治疗法则：补气润肺行气。

4.处方用药：补气通脬饮（《女科辑要》）。

黄芪30克，麦冬、通草各9克。水煎服。

方中黄芪入脾肺经，补气利尿；麦冬养阴滋阴；通草甘淡通利。三药合用共奏补气利尿生津之效。

若产后汗出过多，耗阴伤津，证见烦渴咽干，小便不利，检查时小腹不胀，无叩浊音（膀胱中尿量不多或无尿），为阴液不足之征，宜用生津止渴益水饮（《傅青主女科》）。

党参、黄芪各12克，麦冬、当归、茯苓、葛根各9克，白芍18克，五味子6克，升麻、炙甘草各8克。水煎2次分服。

方中以生脉散（党参、麦冬、五味子）合生地，补气滋阴生津；黄芪补气固表以敛汗；当归以和血；茯苓淡渗以降浊；升麻、葛根升清阳之气，以布阴津。全方组合，乃气津双顾，升降两调之剂。

（二）肾虚小便不通：

1. 临床表现：产后小便不通，小腹胀满而痛，腰部酸胀，坐卧不宁，面色黯晦，精神疲倦。舌质淡，苔白，脉沉迟。

2. 主证分析：肾司二阴，肾阳不足，不能化气行水，肾与膀胱相表里，命门火衰，不能温煦膀胱，则溺不得出，故小腹胀满而痛，坐卧不宁；精神疲倦，面色晦黯，舌质淡，苔白，脉沉迟，均为肾阳不足之征。

3. 治疗法则：温补肾阳，化气行水。

4. 处方用药：济生肾气丸（汤）（《济生方》）。

熟地24克，山药12克，山茱萸、泽泻、丹皮、茯苓、车前子、怀牛膝各9克，肉桂、附子各6克。水煎2次分服。

方中熟地补肾阴；山药滋肾补脾，山茱萸温肾益精；茯苓、泽泻、车前子利尿行水；肉桂温阳化气，附子温肾回阳；丹皮泻热凉血，并制附子、肉桂之辛燥；怀牛膝既通且补，以增行水之力。全方有温阳化气行水之效。

（三）气滞小便不通：

1. 临床表现：产后小便不通，小腹胀痛，烦闷不安，精神抑郁，两胁胀痛。舌质黯紫，苔薄白，脉弦。

2. 主证分析：恼怒伤肝，肝气郁结，则清浊升降之机壅

滞，故小便不通；膀胱积尿不得出，故小腹胀满而痛，烦闷不安；肝郁气滞，失于条达，故精神抑郁，两胁胀痛；气滞则血瘀，故舌质紫黯。脉弦为肝郁之征。

3. 治疗法则：理气行滞利尿。

4. 处方用药：木通散（《妇科玉尺》）。

木通 6 克，滑石 15 克，冬葵子 12 克，槟榔、枳壳各 9 克，甘草 3 克。水煎服。

方中木通、滑石、冬葵子通利小便；枳壳、槟榔理气行滞；甘草和中。全方具有理气行滞利尿的作用。

第五节 产后小便频数与失禁

产后小便过频，甚至日夜数十次，称为“小便频数”。若小便淋漓不断，不能如意约束者，称为“小便失禁”。

【病因病机】 产后小便频数与失禁，其共同的病机是膀胱不能制约。临床常见的病因有：气虚、肾虚、外伤三种。

（一）气虚：平素体质虚弱，肺气不足，产后气血耗伤，肺气更虚。肺主一身之气，通调水道，下输膀胱，因肺气虚不能制约水道，而小便频数。正如《金匱要略》中说：“肺痿……遗尿，小便频，此上虚不能制下也。”

（二）肾虚：禀赋素弱，肾气不足，产后复伤气血，更使肾气不固。肾司二便，与膀胱相表里，肾气不固，则膀胱失约，故小便频数，甚则失禁。薛立斋说：“产后遗尿，肾气

不固也。”

(三)膀胱破裂：产程过长或头盆不称，胎头压迫膀胱过久，局部血运不畅，循环受阻，组织坏死，形成尿痿。因难产而进行的手术操作也可直接损伤膀胱而致尿痿。在《经效产宝》中曾明确记载：“由产用气伤于膀胱，而冷侵入于胞，胞气决漏，不禁小便，故令遗失，多因产难之所致。”

【辨证施治】 本病的病因虽有气虚、肾虚与损伤之别，但其病机则一，故治疗时均以补气固涩为主，凡通利之品皆非所宜。新鲜的膀胱损伤，在服中药的同时，应持续用导尿管，使膀胱空虚，处于收缩状态，以利于组织的修复愈合。时间较久或损伤漏洞较大者，服食药物难以奏效。如尔丹溪所说：“尝见收生者不谨，损伤产妇尿脬致病淋漓，遂成废疾。”此种情况以手术缝合为宜。

(一)气虚小便失禁：

1.临床表现：产后小便频或失禁，胸闷气短，四肢无力，舌淡苔少，脉细弱。

2.主证分析：肺气虚则气不足以制下，是以津液不藏，膀胱失约而致小便不禁；气虚中阳不振，故胸闷气短，四肢乏力。舌淡脉弱，均为气虚血少之候。

3.治疗法则：补气固摄。

4.处方用药：补中益气汤（《脾胃论》）加味。

黄芪、党参各30克，当归、桔梗各9克，白术12克，升麻9克，柴胡、陈皮、炙甘草各6克，益智仁、覆盆子各15克。水煎2次分服。

本方是补中益气汤加益智仁、覆盆子、桔梗。

方中黄芪补气益肺升阳；党参、白术、甘草益气健脾和中；陈皮理气以防壅；升麻、柴胡助黄芪、党参以升阳举陷；当归补血；加益智仁、覆盆子补肾固气，以缩小便；桔梗升提肺气，宣胸快膈，使气化得以下通膀胱。开合并施，其效益彰。

（二）肾虚小便失禁：

1. 临床表现：产后小便频数，量多色清，或失禁自遗，夜间尤甚，面色晦黯，四肢畏冷，腰酸腿软。舌淡，苔润，脉沉迟。

2. 主证分析：肾为先天之本，元气之根，肾阳不足，命门火衰，不能温煦膀胱，而致膀胱失约，小便频数或失禁；肾为至阴之脏，入夜阴盛，故夜尿尤甚；肾主骨，肾阳虚则腰酸腿软，四肢畏冷，面色晦黯。舌淡，苔润，亦肾阳不足之征。

3. 治疗法则：补肾固脬。

4. 处方用药：固脬丸（《张氏医通》）加味。

桑螵蛸、菟丝子各15克，小茴香、熟附子各9克，食盐1.5克，煅牡蛎24克，覆盆子12克。水煎2次分服。

按：本方是固脬丸加牡蛎、覆盆子。

方中桑螵蛸补肾助阳，固精缩尿；菟丝子补肾益精，既可助阳，又可益阴；熟附子、小茴香温肾扶阳，并暖膀胱气化；牡蛎、覆盆子涩缩尿；食盐引经入肾。

（三）外伤小便失禁：

1.临床表现：产程过长，或难产手术操作之后，小便淋漓不断。检查时阴道内有尿液从破口处流出。舌苔正常，脉缓。

2.主证分析：产程过长，胎头压迫膀胱，组织坏死，或手术直接损伤膀胱，形成膀胱阴道瘘，故尿液淋漓不断。因无其他并发症，故舌脉正常。

3.治疗法则：补气固脬。

4.处方用药：黄芪当归散（《医宗金鉴》）。

黄芪30克，当归12服，党参15克，白术、白芍各9克，炙甘草、生姜各6克，大枣4枚（劈），猪尿胞1个。水煎2次分服。

方中黄芪、党参、白术、甘草补气，当归、白芍养血，生姜、大枣辛甘以化阳；猪尿胞温固膀胱，有同类相求以脏补脏之意。

本方对产后膀胱损伤破口较小而早期治疗者，疗效较好；如膀胱破口较大而又治疗较晚者，不可恃为有效之剂。

第六节 产后血晕

产妇分娩之后，突然头晕目眩，不能起坐，或心胸满闷，恶心欲呕，甚者口噤神昏，不省人事，称为“产后血晕”。

产后血晕，以产妇素体虚弱，再加分娩时间过久，用力过度，出血过多造成者比较多见，特别是初产妇患此症者居

多。

【病因病机】 本病的病因，有血虚、血瘀两种。

(一)血虚：产妇平素血虚气弱，复因产后失血过多，以致营阴下夺，气随血脱，血虚气脱不能上荣于脑，以致发生晕厥。

(二)血瘀：产后感受寒邪，恶露凝滞，气血流行不畅，阻闭清窍，因而突发晕厥。

以上两种，与《金匱要略》所论述的产后血虚阴亏，复感外邪，阳气上冒所形成的“郁冒”病，有所不同（郁冒病见产后发热）。

【辨证施治】 在患者血晕昏厥不省人事的时候，不论虚证实证，应先用下法进行抢救苏醒后，再辨证投药。①用铁器烧红淬醋，熏鼻；②针刺人中、中冲，并灸百会、关元穴。

(一)血虚产后血晕：

1.临床表现：产妇分娩后，出血过多，突然头目眩晕，不能起坐，心慌，愤闷不适，渐至昏不识人，口噤不语，甚则四肢厥冷，额头多汗，面色晄白。脉微弱或浮大而虚。

2.主证分析：由于失血过多，心失所养，神不守舍，故心慌，愤闷不适，昏不知人；出血过多，气随血脱，阳气不能达于四肢，则见肢冷；阴不内守，虚阳外越，故额头多汗。脉微欲绝或浮大而虚，亦为血虚气脱之征。

3.治疗法则：益气固脱。

4.处方用药：独参汤（《伤寒大全》）。

大力参30克，水煎徐徐灌下。

病由失血之后，气随血脱，但有形之血不能速生，无形之气当急固，故本血脱先益气的治则，采用人参一味峻补中气，中气旺盛，元气恢复，体内机能复振，自然厥回神苏。独参汤的特点是用量较重，补益元气力宏而长。如人参只用一般用量，只能起到一般补虚作用，就不能扶危救脱了。

回苏之后，继服补气解晕汤（《济阴纲目》）。

党参、生黄芪各30克，当归15克，荆芥穗6克，炮姜炭30克。水煎二次分服。

方中重用参、芪大补元气；当归以补血；芥炭、姜炭温经止血，并有防痉作用。

如四肢厥冷，头汗淋漓，可加熟附子9克以回阳救逆。

（二）血瘀产后血晕：

1.临床表现：产后恶露不下，或下亦很少，少腹阵痛拒按，甚则突然昏倒，神志不清，不省人事，呼吸迫促，牙关紧闭，面色暗红，口唇青紫，脉涩。

2.主证分析：产后寒邪袭于下，恶露凝滞，内蓄胞宫，则恶露不下，少腹阵痛拒按；瘀血不去，新血不能上奉心营，心神失守，则突然昏倒，神志不清，不省人事；瘀血内阻，气机不畅，经络受阻，故牙关紧闭，面色暗红，口唇青紫。脉涩乃血瘀气滞之象。

3.治疗法则：行血化瘀。

4.处方用药：失笑散（《和剂局方》）合荆芥散（《济

阴纲目》)。

炒五灵脂、炒蒲黄各15克，炒桃仁9克，荆芥穗6克。水煎取汁，兑入黄酒15毫升，童便1小杯，徐徐服下。

方中失笑散化瘀血，止疼痛，一向为治冲心闷绝之有效方剂；配桃仁增强活血之力；伍荆芥以理血故寒；佐黄酒以行药势；使以童便降火。

如呼吸急促而气喘者，可加苦杏仁9克，甘草6克，以降气平喘。

按：产后血晕一证，多由产后大失血而引起，如处理不及时，可危及生命。导致产后出血的原因，现代医学认为：常见的有子宫收缩无力、胎盘滞留、产道损伤以及凝血机制障碍等因素。应查明出血原因，对症治疗，以达到迅速止血的目的。如宫缩无力者，在补气养血剂中，酌加马齿苋、益母草等以增强宫缩能力；若胎盘胎膜残留者，应按：“胞衣不下”投药，或进行胞宫清理；产道损伤者，应缝合修补；凝血机制障碍者，在应用方剂中加入止血之品，如蒲黄炭、茜草炭、生侧柏、仙鹤草、卷柏炭之属等。

急性大出血者，在有输血条件的情况下，应输入新鲜血液，以保持应有的血容量。

第七节 产后发热

产后1、2日，由于阴血骤虚，有轻微发热，而不伴有其他症状者，不以病论。如持续发热不退，或突然高热，并

伴有其他症状者，称为“产后发热”。

【病因病机】 产后发热的原因很多，如《医宗金鉴》说：“产后发热之故，非止一端，如饮食太过，呕吐恶食者，则为伤食发热；若早起劳动，感受风寒，则为外感发热；若恶露不去，瘀血停留，则为瘀血发热；若去血过多，阴血不足，则为血虚发热；亦有因产时伤力劳乏发热者，三日蒸乳发热者。”临床常见的则有外感、血虚、血瘀、邪毒感染四种。

(一)外感：新产之后，气血骤虚，卫外之阳不固，腠理不密，以致风寒之邪乘虚而入，营卫不和，因而发热。

(二)血虚：产时失血过多，阴血暴虚，阳无所附，以阳浮于外而发热。

(三)血瘀：产后恶露不下，瘀血滞于胞宫，气机不利，营卫失调，而致发热。

(四)邪毒：由于产时产后耗气伤血、产道损伤，产时消毒不严，产后用物不洁，邪毒乘虚侵入胞宫而发热。即现代医学之“产后感染”。

【辨证施治】 产后发热，属外感、血虚、血瘀者，一般病情较轻，而感染邪毒者，往往高烧不退，若不及时处理，可出现中毒性休克、昏迷而危及生命。血瘀者亦往往是邪毒感染的早期或轻型，也应给予高度重视。

产后发热的治疗原则，应以调气血、和营卫为主。须知产后固多虚证，不宜过于发表攻里，但又不可不审病情，片面强调补虚，而忽视外感和里实之证，致犯虚虚实实之戒。

(一)外感产后发热：

1.临床表现：发热恶寒，头痛身痛，腰背酸楚，口干不渴，无汗，或兼有鼻塞流涕，咳嗽等症。苔白，脉浮。

2.主证分析：寒邪侵袭，首及太阳之表，太阳经脉，络于头目项背，故头痛背楚；正邪相争，则发热恶寒；里无热邪，故口干而不欲饮；腠理为寒邪所闭，故无汗；风寒袭肺，肺气失宣，故咳嗽流涕。苔白，脉浮，乃风寒袭表之征。

3.治疗法则：养血祛风。

4.处方用药：荆防四物汤（《医宗金鉴》）加味。

熟地12克，当归、炒白芍各9克，川芎、荆芥、防风各6克，苏叶4.5克。水煎2次分服。

按：本方是荆防四物汤加苏叶。

方中四物汤养血以顾产后之虚；荆芥、防风、苏叶以辛温解表，疏风散寒。

若见发热，微恶风寒，或但热不寒，头痛，咳嗽，口渴，微汗出或出汗，舌边红，苔薄白，脉浮数，为风热之邪乘虚侵袭肺卫，卫气被遏，开阖失司所致。治宜辛凉解表，疏风清热。方用银花蕺菜饮（《中医妇科治疗学》）加减。

银花、蕺菜（即鱼腥草）各15克，连翘、花粉各12克，荆芥穗、薄荷各4.5克，生甘草3克。水煎2次分服。

按：本方是银花蕺菜饮去土茯苓，加花粉、薄荷、连翘。

方中银花、连翘、蕺菜清热解毒；花粉生津止渴；荆

芥、薄荷疏解肺卫风热表邪；甘草调和诸药。

若寒热往来，呕不能食，周身无汗，但头汗出，大便坚，舌苔薄白，脉微弱者，此即《金匱要略》所谓的“郁冒”。治宜和解阴阳，用小柴胡汤（《伤寒论》）。

北柴胡、黄芩、半夏各9克，党参12克，炙甘草4.5克，生姜3片，大枣4枚（劈）。水煎服。

本方是治伤寒之邪传入少阳之主剂。少阳位于半表半里，故方中用柴胡透达少阳之表邪，黄芩清解少阳之里热，二药配合，解除寒热往来，为本方之主药；生姜、半夏和胃降逆，主治呕不能食；党参、甘草扶正和中，使邪气不得复转入里；大枣配生姜不但助半夏和胃止呕，更有调和营卫，协助柴胡疏解表邪的作用。在此用小柴胡汤扶正祛邪，和解阴阳，使上焦得通，津液得下，胃气因和，身濈然汗出，而诸证自解。

（二）血虚产后发热：

1. 临床表现：产后下血过多，身有微热，发热在午后或夜间稍增，自汗，面色微红，头晕目眩，耳鸣心悸，或四肢麻木。舌淡红，苔薄，脉细弱，或细数无力。

2. 主证分析：因失血过多，血虚则阳不守而外浮，故出现身热汗出；虚阳上浮，则面赤，头晕，目眩，耳鸣；血虚心失所养，故心悸；血虚不能濡养四肢，则手足麻木。舌淡红，苔薄白，脉细弱，亦为血虚之象。

3. 治疗法则：补气益血。

4. 处方用药：八珍汤（《证治准绳》）加味。

党参、黄芪各15克，生地、当归各12克，炒白术、茯苓、白芍、地骨皮各9克，川芎3克，甘草6克。水煎2次分服。

按：本方是八珍汤加地骨皮、黄芪。

方中党参、黄芪、白术、茯苓、甘草益气和卫；当归、白芍、川芎补血调营，气血充足，营卫和调，则自汗、发热自止；生地、地骨皮甘寒清降，善清虚热，清中带润，与补气养血药为伍，其退热之功更著。

若证见午后发热，两颧发红，渴喜冷饮，便燥尿赤，舌质红，苔黄而干，脉象细数者，为血虚阴亏之重症。治宜滋阴清热养血，方用加减一阴煎（《景岳全书》）。

生地30克，熟地15克，地骨皮、白芍各12克，知母、寸冬、丹皮各9克，生甘草6克。水煎2次分服。

方中生熟地、麦冬滋阴益血；白芍敛阴；知母、丹皮、地骨皮清热养阴。共奏滋阴清热养血之效。若兼潮热盗汗者，加青蒿9克，鳖甲15克。

（三）血瘀产后发热：

1.临床表现：产后发热，伴有恶露不下，或下亦甚少，色紫黯有块，小腹痛而拒按。舌质紫黯，脉弦涩。

2.主证分析：由于产后恶露不下或下亦甚少，瘀血内阻，营卫失调，故而发热；因瘀血滞于胞宫，故小腹痛而拒按，恶露色紫有块。舌紫，脉弦涩，亦为血瘀之象。

3.治疗法则：清热凉血，活血化瘀。

4.处方用药：清热调血汤（《古今医鉴》）。

生地15克，黄连3克，丹皮、白芍、当归、元胡、香

附、桃仁、红花、莪术各9克，川芎6克。水煎2次分服。

方中桃仁、红花、川芎、莪术活血化瘀而止痛；香附理气以助血行；生地、丹皮、黄连清热凉血；当归、白芍养血敛阴。全方共奏活血化瘀清热之功。

(四)邪毒感染产后发热：

1.临床表现：产后高热可达39~40℃，初时可有寒战，热型呈弛张状，烦躁口渴，面赤唇红，下腹痛而拒按，恶露量多或少，色紫黑如败酱，味秽臭，大便燥结，小便短赤，重者神昏、谵语，全身红疹。舌红或绛，苔黄而干或光绛无苔，脉洪滑而数或弦数。

2.主证分析：邪毒侵入胞宫，与瘀血互结，故恶露色如败酱而秽臭，小腹痛而拒按；正邪相争，故高热寒战；热盛耗伤津液，故口渴，便秘，尿赤；热入营血，数见皮肤红疹；若热入心包，则神昏谵语。舌红绛，苔黄干，脉洪滑数，均为实热之征。

3.治疗法则：清热凉血解毒。

4.处方用药：凉血解毒汤。

双花、白薇、生地各30克，连翘、地丁、地骨皮各15克，赤芍、丹皮各12克，益母草18克。水煎2次分服。

方中双花、连翘、地丁清热解毒；生地、丹皮、地骨皮、白薇滋阴凉血，清热泻火；赤芍、益母草活血化瘀。

若气津受伤者，加沙参、麦冬各12克；高热神昏者，可兼服紫雪丹1.5~3克；对胎盘、胎膜残留子宫腔内，或因宫颈口狭窄而恶露潴留，以致感染发热者，应在大量药物控

制感染的同时，以扩张颈管排除恶露、钳除胎盘胎膜，待高烧感染基本控制后，再作必要的刮宫术，以达完全治愈。

第八节 产后发痉

产褥期中，发生项背强直，四肢抽搐，甚则口噤不开，角弓反张者，称为“产后发痉”。俗名“产后风”。

【病因病机】 本病的发生，主要是因产后失血伤津，血亏液少，不能濡养筋脉所致。如缪希雍说：“去血过多，阴气暴虚，阴虚生热，热极生风，故外现风证，其实阴血不足，无以养筋所致。”此外，产后创伤，感染毒邪，故播于经络之间，以致经脉拘急，亦可导致发痉（包括破伤风）。现分阴亏血虚和邪毒感染进行讨论。

【辨证施治】

（一）阴亏血虚产后发痉：

1.临床表现：产后失血过多，骤然发痉，头项强直，牙关紧闭，四肢抽搐，面色苍白或萎黄，甚则腰背反折。舌淡红少苔或无苔，脉虚细。

2.主证分析：由于阴亏血虚，筋脉失养，肝风内动，所以出现四肢抽搐，头项强直，腰背反折；血虚不容于面，故面色苍白；经络失养，则筋急而牙关紧闭。舌淡，无苔，脉虚细，均为阴亏血虚之象。

3.治疗法则：养阴补血，柔肝熄风。

4.处方用药：三甲复脉汤（《温病条辨》）加味。

白芍、钩藤、生地各15克，当归、阿胶（烔化）、麦冬各9克，生龟板、生鳖甲各12克，生牡蛎30克，天麻、节菖蒲、炙甘草各6克。水煎2次分服。

按：本方是三甲复脉汤加天麻、钩藤、菖蒲。

方中当归、阿胶、生地、麦冬养血益阴；鳖甲、龟板、牡蛎、白芍育阴潜阳；天麻、钩藤镇肝熄风；甘草和中健脾；菖蒲取其芬香开窍，醒神回苏。

（二）感染邪毒产后发痉：

1. 临床表现：新产后，头项强痛，发热恶寒，面呈苦笑，开口受限，继而项背强直，角弓反张，牙关紧闭。舌质正常，苔薄白，脉浮而弦。

2. 主证分析：由于感染邪毒，邪初入侵，正邪相争，故发热恶寒，头项强痛；邪毒窜行经脉，引起项背肌肉痉挛性收缩，故项背强直，角弓反张；咬肌痉挛性收缩，则牙关紧闭，面呈苦笑。

3. 治疗法则：解毒镇痉，理血祛风。

4. 处方用药：轻证，用华佗愈风散（《普济本事方》）。荆芥穗（轻焙过）30克，研细末。每次6克，温黄酒调服。

重证，用上方合止痉散（经验方）。

全蝎2个，蜈蚣1条，僵蚕7个。桑寄生15克。共研细末。每次6克，温黄酒或温开水调服。

方中芥穗专理血中之风，且有止痉之功，用此一味力专而效速。全蝎、蜈蚣、僵蚕，均为解毒驱风止痉要药，桑寄

生为祛风益血之品，兼能润筋通络。此为近代止痉之专剂，故散名止痉。重证者，两方合用，则效力更宏。

第九节 产后大便难

产后饮食如常，而大便不畅，或数日不解，或大便干结疼痛，难以解出者，称为“产后大便难”。

【病因病机】 产后失血过多，营血骤虚，津液亏耗，或阴虚火旺，热灼津液，津少液枯，不能濡润肠道，以致传导不利，大便艰难。

【辨证施治】

(一)临床表现：产后大便干燥，数日不解，或解时难下，饮食如常，但腹无胀痛，皮肤不润，面色萎黄。舌淡，苔薄，脉细弦而涩。

(二)主证分析：由于产后失血伤津，津亏液枯，肠道失于润滑，传导失职，以致无水行舟而便难；证非外感里实，故饮食如常，腹无胀痛；血虚不荣于外，故面色萎黄，皮肤不润。舌淡，脉弦涩，为血少津亏之征。

(三)治疗法则：养血润燥。

(四)处方用药：四物汤（《和剂局方》）加味。

熟地24克，当归15克，白芍9克，川芎、升麻各3克，肉苁蓉30克，火麻仁、柏子仁各12克。水煎2次分服。

按：本方是四物汤加麻仁、柏仁、升麻、苁蓉。

方中四物养血润燥；肉苁蓉、火麻仁、柏子仁以滋补肾

精，滑肠通便；欲降之，先升之，故配升麻升提气机，以促进大便顺利排下。

如口干舌燥，手足心热，舌质红，苔薄黄，脉细数者，属阴虚火旺，治宜滋阴清热，润肠通便。用上方以生地易熟地，并加玄参、麦冬增液通便。

若大便艰难，头晕目眩，精神疲倦，气短而喘，动则汗出，脉大而虚者，乃产后气血两亏之候，宜补气养血，润肠通便。方用圣愈汤（《兰室秘藏》）加味。

熟地24克，党参、黄芪、当归各15克，炒白芍、苦杏仁、郁李仁各9克，苦桔梗、川芎各6克。水煎2次分服。

按：本方是圣愈汤加杏仁、郁李仁、苦桔梗。

方中四物汤补血；参、芪补气；杏仁、郁李仁润肠通便；肺与大肠相表里，故配桔梗开提肺气，以启上导下，易于排便。

第十节 产后汗出

妇人产褥期皮肤排泄功能旺盛，出汗多，夜间更甚，此称褥汗，是正常的生理现象，一般数日后自行好转，不必治疗。若数日之后，长久汗出持续不断，汗水浸透衣被者，称为“产后汗出”。产后汗出又有自汗与盗汗之不同。如产后不因服药及气候的影响而自然汗出者，称为“产后自汗”。若睡中汗出，而醒后即止者，称为“产后盗汗”。

【病因病机】 本病的主要机理，是产后气虚，卫表不

固；或阴虚热扰，浮阳外越，迫汗外泄所致。

(一)气虚：体质素弱，肺气不足，复因产时耗伤气血，使气益虚，肺主皮毛，肺气虚则卫表不固，腠理不密，故自汗。

(二)阴虚：产时失血过多，阴血骤虚，阴虚生内热，热扰于内，阳浮不敛，迫汗外泄，故盗汗。

【辨证施治】 本病着重在虚，但有气虚、阴虚之别，病机不同，治法自殊。气虚者宜益气固表；阴虚者宜滋阴敛汗。

(一)产后气虚自汗：

1.临床表现：产后数日汗出不止，时或恶风，气短懒言，倦怠乏力，面色㿠白。舌淡，苔薄，脉虚弱。

2.主证分析：产时失血过多，气随血耗，气虚则卫表不固，故自汗恶风；气虚不支，则倦怠无力，气短懒言，面色㿠白。舌淡，苔薄，脉虚弱，均为气虚之象。

3.治疗法则：补气固表止汗。

4.处方用药：玉屏风散（《世医得效方》）。

黄芪30克，白术12克，防风9克。共研细末。每次6克，日2～3次，温开水调服。

方中黄芪益气并升阳实卫，白术健脾，以资气血生化之源，且二药皆能固表止汗，合用功效倍增。佐防风达表而祛邪。黄芪得防风，则固表而不留邪；防风得黄芪，则驱邪而不伤正。相反相成，散而不越，补而不滞，散中寓补，补中兼疏。本方以服散剂为良，改汤剂则效果不著。

(二)产后阴虚盗汗：

1.临床表现：产后睡中汗出，醒来即止，面颊潮红，头晕耳鸣，腰膝酸软，五心烦热，午后热重。舌红，无苔，脉细数无力。

2.主证分析：产时伤血，阴血亏虚，阴虚生内热，迫汗外泄，故盗汗；阴虚阳浮于上，故面颊潮红，头晕耳鸣；热扰于内，则五心烦热。舌红，少苔，脉细数无力，均为阴虚内热之象。

3.治疗法则：滋阴潜阳，清热敛汗。

4.处方用药：当归六黄汤（《兰室秘藏》）加减。

生黄芪24克，熟地黄、生地黄各12克，当归、白芍、地骨皮各9克，生牡蛎、浮小麦各30克。水煎2次分服。

按：本方是当归六黄汤去黄芩、黄连、黄柏，加白芍、地骨皮、牡蛎、浮小麦。

方中当归、二地滋阴养血；辅黄芪补气强卫，固表止汗；地骨皮凉血退蒸；牡蛎、白芍敛阴潜阳；浮小麦益气除热止汗。共奏滋阴潜阳，清热除蒸，固表敛汗之效。

第十一节 产后腹痛

产妇分娩之后，下腹疼痛，称为“产后腹痛”，亦称“儿枕痛”。现代医学认为，由子宫收缩引起下腹疼痛，故称“宫缩痛”。此种疼痛多见于经产妇，特别在急产以后。一般发生在产后1～2天内，哺乳时特别明显。腹痛轻者，

可逐渐消失，不需治疗。

【病因病机】 产生本病的原因，主要是气血运行不畅。气血之所以运行不畅，多是血虚、寒凝所致。

(一)血虚：由于产时伤血过多，冲任空虚，胞脉失养而作痛，或因产程过长，耗气伤血，产后血少气弱，运行无力，血流不畅，迟滞而痛。正如张山雷所说：“失血太多，则气亦虚馁，滞而作痛。”

(二)寒凝：新产之后，正气虚弱，若起居不慎，寒邪乘虚侵入胞中，血为寒凝，以致腹痛。

【辨证施治】

(一)血虚产后腹痛：

1.临床表现：产后下腹隐隐疼痛而软，喜按，头晕耳鸣，腰腹坠痛，恶露淡少，大便燥结，舌质淡红，苔薄白，脉虚细。

2.主证分析：由于产后失血过多，经脉空虚、冲任失养，气血运动无力，故小腹隐隐疼痛而软，喜按；气血亏损，精髓不足，故头晕耳鸣，腰部坠胀，恶露淡少；血亏津少，肠道失润，故大便燥结。舌淡红，苔薄白，脉虚细，均为产后血虚之象。

3.治疗法则：补血益气。

4.处方用药：肠宁汤（《傅青主女科》）。

当归、熟地、阿胶、山药、续断各12克，党参15克，麦冬9克，炙甘草6克，肉桂1.5克。水煎2次分服。

方中当归、熟地、阿胶、麦冬养血滋阴；伤于血者必及

于气，故以党参补气，山药、甘草扶脾健中，续断补肾养肝，以益冲任之源；佐肉桂少许，取其温通之力，以促使气血运行。

若血燥便秘者，可去肉桂，加肉苁蓉18克，以温肾润肠。

若血虚兼寒者，腹痛得热痛减，面色苍白，手足逆冷，脉细而迟，可用当归建中汤（《千金翼方》）以养血散寒。

当归12克，白芍18克，桂枝、生姜各9克，甘草6克，大枣5枚，饴糖30克（烊化）。水煎服。

本方是小建中汤加当归。产后内脏虚寒，故用桂枝汤倍芍药加饴糖以建中散寒，腹中刺痛乃寒凝血行不畅所致，故加当归以养血活血。

（二）寒凝产后腹痛：

1.临床表现：产后小腹冷痛拒按，得热痛减，面色青白，四肢不温，痛甚欲呕。舌质黯淡，苔白滑，脉沉紧。

2.主证分析：寒为阴邪主收引，气血为寒邪凝滞，故小腹冷痛拒按，得热则温通而痛稍减；寒邪内闭，阳气不宣，故面色青白，四肢不温；寒邪伤胃，浊气失降，故欲呕。舌黯，为气血凝滞，脉沉是病邪在里，脉紧乃寒束之征。

3.治疗法则：温经散寒，行瘀活血。

4.处方用药：香桂丸（《医略久书》）加味。

当归12克，川芎、木香各6克，炮姜、肉桂、吴茱萸各8克，焦山楂12克，炙甘草6克。水煎2次分服。

按：本方是香桂丸加炮姜、吴萸、山楂、甘草。

方中当归、川芎、山楂活血散瘀；肉桂、炮姜、吴茱萸温经散寒；木香理气行滞；甘草调和诸药。寒散血活，腹痛自止。

【简易方】

(一)焦山楂30克，生姜8片，红糖30克。泡水代茶饮。

(二)益母草膏每次15克，白水冲服，日3次。

第十二节 产后身痛

妇人分娩之后的最初几天，由于产时过度用力，出现身体某部疼痛不适，属于正常现象。如在产褥期，经过适当的休息以后，仍有肢体疼痛，或某些关节酸痛及重着麻木者，谓之“产后身痛”。

【病因病机】 本病的发病机理，主要是产后血虚，经脉失养，或瘀血阻滞，以及风湿侵袭经络所致。

(一)血虚：由于产后出血过多，营血不足，百节空虚，筋脉失于濡养而作痛。

(二)血滞：产后瘀血未尽，阻滞经脉，经脉“不通则痛”。

(三)风湿：新产之后，气血两虚，营卫失调，或坐卧当风，或冷水洗浴，或居处潮湿，则风湿之邪乘虚而入，侵袭筋脉关节，气血运行不畅，滞而作痛。

【辨证施治】 本病的特点是，新产之后，气血本虚，虽扶外感，总是虚实夹杂，故在治疗方面，但宜扶正祛邪，

养血为主，随症佐以相应之品，或化痰，或除湿，切勿过用攻伐，重伤其阴。

(一)血虚产后身痛：

1.临床表现：遍身关节疼痛，肢体酸楚，麻木，头晕心悸。舌淡红，少苔，脉细无力。

2.主证分析：产后血虚，筋脉失养，故见遍身关节疼痛酸楚，血虚不能上奉于脑，故头晕；心失所养，则心悸。舌淡红，苔少，脉细无力，均乃血虚之征。

3.治疗法则：养血益气，温经通络。

4.处方用药：黄芪桂枝五物汤（《金匮要略》）加味。

生黄芪24克，当归12克，桂枝、白芍各9克，川芎6克，鸡血藤、桑枝各30克，生姜3大片，大枣4枚。水煎2次分服。

按：本方是黄芪桂枝五物汤加川芎、桑枝、鸡血藤。

方中当归、白芍、川芎、鸡血藤养血活血；黄芪益气以助血行；桂枝温经通络；桑枝能达四肢，利关节，并有通络镇痉作用；生姜、大枣调和营卫，并能开胃进食促进补剂之吸收。

若产后足跟痛为主，或伴头晕耳鸣者，是兼肾阴亏损之征，治宜滋阴补肾。方用六味地黄汤加味。

熟地24克，炒山药、杜仲、怀牛膝、山萸肉各12克，丹皮、茯苓、泽泻各9克。水煎2次分服。

按：本方是六味地黄汤加杜仲、怀牛膝。

方中六味地黄汤滋阴补肾；杜仲、牛膝能补肝肾，强筋

骨，利关节，止疼痛。合用为治足跟痛之有效方剂。

(二)血滞产后身痛：

1.临床表现。产后身体疼痛，多在腰骶部位，连及下腹，按之痛甚。面唇色紫，舌质黯或有瘀点，脉沉涩。

2.主证分析：瘀血内阻，经脉通行不畅，故而遍体作痛；新产之后，胞宫瘀血未尽，胞宫居于下腹，胞脉系于肾，腰为肾之府，故疼痛多在腰骶，且连及下腹。面唇色紫，舌质紫黯或有瘀点，脉沉涩，均为瘀血内阻之象。

3.治疗法则：益血化瘀，疏经通络。

4.处方用药：身痛逐瘀汤（《医林改错》）加味。

秦艽、香附、炒灵脂、红花、地龙各9克，桃仁、当归、牛膝各15克，川芎6克，羌活、没药、炙甘草各5克，桑寄生30克。水煎2次分服。

按：本方是身痛逐瘀汤加桑寄生。

方中当归、川芎养血行血；桃仁、红花活血化瘀；没药、灵脂行瘀止痛；秦艽、羌活、牛膝、地龙通经活络；香附理气，使气行血行；寄生祛风益血，润筋通络；甘草调和诸药。共奏养血祛瘀，通络止痛之效。

(三)风湿产后身痛：

1.临床表现：产后关节疼痛，伸屈不利，或痛无定处，或剧痛如刺，或肢体肿胀，重着不举，得风则舒，遇寒加重。舌淡，舌薄白，脉细缓或弦紧。

2.主证分析：新产之后，气血耗损，百节空虚，风寒湿邪易乘虚而入，滞留于筋脉关节，气血运行受阻，故关节疼

痛，伸屈不利；若偏风胜，风性善动，则痛无定处；若偏寒胜，寒性收引，则疼痛剧烈，犹如锥刺；若偏湿胜，湿性重浊，则肢体肿胀，沉重不能举动。血遇热则行，遇寒则凝，故疼痛得热则舒，遇寒加重。舌淡，脉细，为血虚之证；弦脉主痛，脉紧为寒束。

3. 治疗法则：温经散寒，祛风除湿。

4. 处方用药：独活寄生汤（《千金要方》）。

桑寄生30克，独活、秦艽、防风、熟地、白芍各9克，杜仲、牛膝、党参、当归各12克，茯苓15克，川芎、桂心、甘草各6克，细辛3克。水煎2次分服。

方中四物养血和血；党参、茯苓、甘草补气扶脾；独活、寄生、秦艽、防风祛风胜湿；细辛、桂心温经散寒止痛；杜仲、牛膝补肝肾，强筋骨。诸药配合为扶正祛邪之剂。

若风邪偏胜加羌活6克；寒邪偏胜加制川乌9克，湿邪偏胜加生薏仁18克，制苍术9克。

第十三节 乳汁不行

产后哺乳期，乳汁甚少或全无，称为“乳汁不行”，亦称“缺乳”。本病不仅出现于新产之后，在整个哺乳期均可出现。

【病因病机】 本病之发生，多由气血虚弱，或肝气郁结所致。

(一)气血虚弱：乳汁为气血所化。气血来源于后天脾胃水谷之精微。脾胃虚弱，则气血生化之源不足，或产后出血过多，气随血耗，均能因气血不足，而影响乳汁的生成。正如《景岳全书·妇人规》中所说：“妇人乳汁，乃冲任气血所化，故下则为经，上则为乳。若产后乳迟乳少，由气血不足，而犹或无乳者，其为冲任之虚弱无疑也。”《傅青主女科》说：“乳乃气血之所化而成也，无血固不能生乳汁，无气亦不能生乳汁。”

(二)肝郁气滞：乳头属肝经所司。如产后情志抑郁，或紧张不安，肝失条达，气机不畅，气血失调，经脉滞涩，阻碍乳汁运行，而导致本病。产后乳汁不行，因于精神影响者，为临床所常见。所以《儒门事亲》说：“或因啼哭悲怒郁结，气溢闭塞，以致乳脉不行。”

【辨证施治】 缺乳有虚实之不同，临床辨证，主要观察乳房有无胀痛，结合全身症状，辨别虚实。如乳房柔软而无胀痛者，多属气血俱虚；如胀满而痛，连及胸胁，或伴有身块者，多属肝郁气滞。治疗原则为虚者补之，实则散之，并佐以通乳之品。

(一)气血虚弱乳汁不行：

1.临床表现：产后乳汁不行，或行亦甚少，乳汁清稀，乳房柔软无胀痛感，面色不华，精神欠佳，皮肤干燥，纳少，便秘。舌质淡，苔薄白，脉象虚细。

2.主证分析：由于气血虚弱，乳汁生化之源不足，则乳少或无乳，乳房柔软而无胀感；气血衰少不营于外，故面色

不华，情神欠佳，皮肤不润；脾失健运，故纳少便黏。舌质淡，脉虚细，仍气血俱虚之象。

3. 治疗法则：补血益气，佐以通乳。

4. 处方用药：通乳丹（《傅青主女科》）。

党参、黄芪各15克，当归12克，麦冬、通草、桔梗各9克，猪蹄2只。先将猪蹄煮熟，去蹄留汤煎药，分2次温服。

方中党参、黄芪补中益气；当归、麦冬养血滋阴；桔梗、通草利气宣络；猪蹄补血通乳。全方有补气养血，疏通经络之效。

如无猪蹄，一般肉汤、排骨汤（去浮油）煎药，亦可取得同样效果。

（二）肝郁气滞乳汁不行：

1. 临床表现：产后乳汁不行或量少，乳房胀满而痛，甚者身热，精神抑郁，胸胁不舒，脘胀食少。舌质正常，苔薄黄，脉弦。

2. 主证分析：肝主疏泄，性喜条达。产后情志抑郁，肝气不舒，气机不畅，经脉运行受阻，故乳汁不行；肝经循布胁肋，肝郁气滞，则胸胁不舒，乳房胀痛；肝气犯胃，胃失和降，则脘闷食少。身热，苔黄，脉弦，乃肝郁化热之象。

3. 治疗法则：疏肝解郁，佐以通络。

4. 处方用药：下乳涌泉散（《清·太医院配方》）。

当归、白芍、柴胡、漏芦、王不留、花粉、炮山甲、桔梗、通草各9克，生地15克，木通、青皮、白芷、川芎、生

甘草各6克。水煎2次分服。

方中当归、白芍、川芎补血行血；花粉、生地补血滋阴；柴胡、青皮疏肝散结；桔梗、木通、通草理气通络；穿山甲、王不留、漏芦通络下乳；甘草调和诸药。全方有疏肝解郁，通络下乳之效。

如乳房焮肿微热者，酌加蒲公英15~30克，全瓜蒌12~24克，以清热散结。

初产妇，如乳头有乳痂而使乳腺管口不通者，可先用肥皂水清洗，再涂以香油，乳痂去后，乳汁自通。

【简易方】

(一)党参30克，王不留行15克，通草6克，牛乳30克。水煎服。每日1剂。

(二)王不留行30克，猪蹄1只。同炖。猪蹄炖烂后，去王不留，再加食盐少许，吃蹄喝汤。

以上二方均适用于气虚乳汁过少或缺乳者。

【外治法】 乳房胀痛，而局部红肿者，可用热毛巾湿敷，并用热水洗涤乳房，能收到宣通气血的效果。亦可用鲜蒲公英捣烂如泥外敷。

第十四节 乳汁自出

产妇乳汁，不经婴儿吸吮，自然流出者，称为“乳汁自出”。

若体质健壮，气血充足，乳房胀满而溢出一些乳汁，或

已到哺乳时间而没有及时哺乳，以致乳汁外溢自流者，均不属病态，不需服药。亦有胎前而乳汁自出者，称为“乳泣”这是气血亏虚之候，应及时治疗。

如产后停止哺乳仍长时间乳汁溢出，称为“乳溢”，往往同时持续闭经。现代医学称为闭经泌乳综合征。是由于垂体分泌过多的催乳素所致，其中垂体肿瘤是原因之一。应与哺乳期的乳汁自出相区别。

【病因病机】 乳汁自出的病机，不外虚实两端。总由气血两虚和肝经郁热引起。

(一)气血虚弱：产后气血俱虚，乳汁为气血所化生，气血来源于脾胃（按脏腑经络分属，乳房属胃经，乳头属肝经），气血虚弱，胃气不固，摄纳无权，故乳汁随化随出。

(二)肝经郁热：肝藏血、主疏泄，怒气伤肝，肝郁化火，肝火亢盛，疏泄太过，乳汁受热迫而妄行，故不待吮吮自行溢泄而出。

【辨证施治】 本病的辨证要点是虚实。气血虚弱者，乳房柔软，乳汁清稀量少；肝经郁热者，乳房胀硬，乳汁较浓量多。治疗应本着“虚则补之，热则清之”的原则。气血虚弱者，补气益血，佐以固摄；肝经郁热者，舒肝解郁，佐以清热。

如在非哺乳期，发生的闭经泌乳综合征，则应排除肿瘤，而后辨证用药。

(一)气血虚弱乳汁自出：

1.临床表现：乳汁自出，量少而清稀，乳房无胀满感，

面色苍白，皮肤不润，精神疲倦，心悸气短。舌质淡，少苔，脉细弱。

2.主证分析：血虚不能生化，故乳房不胀，乳汁量少而清稀；气虚不能摄纳，故乳汁自溢而出；气血双虚，不荣于面，故面色苍白，不荣于肌肤，故皮肤不润；血虚心失所养，故心悸；气虚不支，则神疲气短。舌质淡，脉细弱，均为气血俱虚之象。

3.治疗法则：补气益血，佐以固摄。

4.处方用药：十全大补汤（《和剂局方》）加减。

熟地、党参、炙黄芪各15克，当归、炒白芍、炒白术、茯苓、五味子各9克，炙甘草6克，芡实30克。水煎2次分服。

按：本方是十全大补汤去川芎、肉桂加五味子、芡实。

方中参、术、苓、草、黄芪健脾益气；当归、熟地、白芍益液养血；五味子、芡实固精涩敛。共奏补气固摄敛乳之效。

（二）肝经郁热乳汁自出：

1.临床表现：乳汁自出，乳房胀痛，乳汁量多，精神抑郁，烦躁易怒；甚则心悸少寐，便干尿赤。舌红，苔黄，脉弦数。

2.主证分析：肝郁化热，热则迫乳外溢，故乳汁自出；肝失条达，气机不畅，故精神抑郁，乳房胀满；肝郁化火，则烦躁易怒；扰动于心，则心悸少寐；热灼津液，故便干尿赤。舌红，苔黄，脉弦数，均为肝经郁热之征。

3. 治疗法则：疏肝解郁清热。

4. 处方用药：丹栀逍遥散（《医统正脉》）加减。

丹皮、栀子、北柴胡、当归、炒白术、茯苓各 9 克，生地黄、生白芍各 12 克，生甘草 6 克，生牡蛎 30 克。水煎 2 次分服。

按：本方是丹栀逍遥散去生姜、薄荷，加牡蛎、生地。

丹栀逍遥散去生姜、薄荷之辛散，以减疏泄之力，但仍具解郁清热之功；加生地以滋阴养血；生牡蛎平肝潜阳，固摄敛乳。热去郁解，则乳汁自安。

【简易方】 生黄芪 24 克，五味子 9 克。水煎服。适于气虚不摄之乳汁自出。

附：退 乳

产后不欲哺乳者，可行退乳。

（一）内服法：

1. 麦芽煎：炒麦芽 60 克。水煎服。

2. 兔怀汤：当归尾、赤芍、红花各 9 克，川牛膝 18 克。水煎服。

本方是通其月经，则乳汁自止之法。

（二）外敷法：芒硝 500 克，分装 2 个布袋内（布袋大小与乳房大小一致），敷于乳房，待芒硝湿硬后易之。

第五章 妇科杂病

妇科疾病以经带胎产为主，凡经带胎产范围以外的妇科疾病，都称为“妇科杂病”。但由于过去条件所限，对有些疾病还没有确切认识和发现，故妇科典籍中尚缺乏记载。然而，运用中医的理法方药诊治现代医学中的妇科疾病，同样收到显著的效果。为了从临床实用出发，除典籍中原有疾病外，又增添了一些被人们所熟知的现代医学病种，如阴道炎、盆腔炎、子宫肌瘤、子宫颈癌等十几种病。这些病与古代妇科典籍的病证有联系，但不能等同。如阴痒带下包括生殖器官炎症，但生殖器炎症也并非都有带下阴痒。又如症瘕积聚，可以包括子宫肌瘤，但除此之外还包括盆腔炎块等所有带包块特点的疾病。故将这些现代病种与古籍所载病证另立专节分别讨论。

第一节 症 瘕

症瘕是指腹内有结块，并伴有或胀或满或痛的一种病证。

症瘕与积聚，同病而异名，实则症即积，瘕即聚，故医籍常“症瘕积聚”并称。症与积，有形可征，痛有定处，坚硬不动，推揉不移；瘕与聚，时聚时散，痛无定处，痞满无

形，按揉可动。大抵症属血病，瘕属气病。但临床所见，每因气聚日久则血瘀成症，因此，气与血亦不能截然分开。

【病因病机】本病的发生，多因经期或产后，伤于风冷；或七情郁结，气机不畅，以致脏腑失调，气血不和而成。临床常见的有血瘀，气滞两种。

（一）血瘀：多因经期，产后血室正开，风寒乘虚侵袭胞宫，凝滞气血；或因房室不节，余血未净，精血相搏；或因愤怒伤肝，气血不和，气逆血留。均可导致血结成症。

（二）气滞：七情内伤，肝气郁结，气滞不畅，滞于小腹，聚而成瘕。

【辨证施治】本病的辨证，首先辨别属气、属血。病属气者，以理气行滞为主；病属血者，宜破瘀散结为主。但应视其病之新久，体之强弱，随证施治，采用先攻后补，或先补后攻，或攻补兼施等法，切忌猛攻、峻伐，以免损伤正气。无论血瘀或气滞，虽皆属实证，但在掌握行气破瘀的分寸上，还需遵循“大积大聚，衰其大半而止”的原则进行治疗，决不可毕其功于一役。

另外，凡症瘕之疾，多挟痰饮，痰与瘀相搏，每阻碍气机升降，故在处方时，当佐以茯苓、陈皮、半夏、昆布、海藻，海蛤之属，以软坚豁痰。所以武叔卿说：“盖痞气之中，未尝无饮，而血症，食症之内，未尝无痰，则痰食血，又未有不因气而后形病也。故消积之中，当兼行气消痰消瘀之药为是。”

（一）血瘀症证：

1.临床表现：症块坚硬，固定不移，疼痛拒按，面色晦暗，皮肤失润，月经延后，口燥不欲饮水。舌边瘀点，脉象沉涩。

2.主证分析：血瘀不行，凝结成症，故积块固定不移，痛而拒按；脉络阻滞，血运失常，上不荣于面，外不荣肌肤，故面色晦暗，肌肤不润；瘀血内阻，冲任失调，血海不充，故月经延后；瘀血内阻，津液不得上承，但内无热邪，故只口干而不饮水。舌边瘀点，脉象沉涩，均属瘀血内阻之征。

3.治疗法则：活血散结，破积消症。

4.处方用药：桂枝茯苓丸（《金匱要略》）。

桂枝、茯苓、丹皮、桃仁、白芍各等份。共研细末，炼蜜为丸，如梧子大。每次9克，每日2~3次，温开水送服。亦可改为汤剂（桂枝、桃仁、丹皮各9克，茯苓、白芍各12克）水煎服。

本方是祛瘀消症之轻剂。方中桂枝温通经脉；桃仁、丹皮破血祛瘀，消症散结；芍药和营血，并缓腹中拘急而止痛；盖血瘀之中，多挟水饮，故用茯苓健脾渗湿以安正气。丸之以蜜者，意在不使猛攻，缓缓显效。

根据临床经验，本方用途甚广，如经闭，痛经，难产，死胎不下，产后恶露不行，败血上攻，以及子宫肌瘤，子宫息肉，卵巢囊肿，盆腔炎块等，审属瘀血为患者，均可加减治之，常能获得满意的效果。

若症块顽固，上方久服，效果不著，可在汤剂中加入醋

三棱、醋莪术各12克，以增强逐瘀破症之力。亦可等份加入丸剂使用。

若瘀血内结，小腹硬满积痛，大便色黑易解，小便自利，其人如狂，舌质紫黯，或有斑点，脉沉涩有力属于证实体实者。宜破瘀逐血。用抵当汤或抵当丸（《伤寒论》）。

汤剂：水蛭、虻虫各6克，炒桃仁、酒洗大黄各9克。水煎服。

丸剂：水蛭、虻虫各4克，炒桃仁、生大黄（酒洗）各9克。共为细末，炼蜜和团，分为4丸，每服水煎1丸，若不下者，再服。

方中水蛭、虻虫为虫类破血药，其破血逐水之力峻猛，辅以大黄、桃仁，以增清热下瘀之效。合用为攻逐瘀血之重剂。至于汤丸的区别是：抵当汤力峻而效捷，适于蓄血重症而病势较急者；抵当丸药量较轻而作用较慢，宜于蓄血虽甚而病势较缓者。诚如方极云：“急则以汤，缓则以丸。”

若瘀血久积，邪实正虚，肌肤甲错者，宜祛瘀生新，消积破症。用大黄虻虫丸（见经闭）。

若症积而兼血虚，证见面色苍白带黄，形体消瘦，头眩心悸，眼花耳鸣，舌苔花剥，脉细涩者，宜养血活血，攻补两施。用增味四物散（《济阴纲目》）。

熟地、当归、芍药、川芎、醋三棱、醋莪术、肉桂、干漆（炒令烟尽）各等份。共为粗末，每服15克。水煎服。

本方是症积兼见血虚，邪气较深，正气已弱，不堪峻剂攻伐的攻补两施之剂。方中以四物汤补肝养血，三棱、莪

术、干漆破血逐瘀；肉桂鼓舞血行，促进积块之消散。

若寒气客于下焦，血气闭塞而成症，积块日益增大，状若怀子。兼见面色青灰，身体畏寒，腹冷痛，喜热敷，舌质带青，舌苔薄白，脉迟涩者，《灵枢》名为“石瘕”。宜温经行气，活血逐瘀。用见睨丹（《卫生宝鉴》）。

大黄（酒洗）、醋三棱各15克，熟附子12克，紫石英（研细飞过）、鬼箭羽、炒桃仁各9克，肉桂、元胡、木香、泽泻各6克，炒水蛭、花槟榔各7.5克，血竭（另研细）4.5克。上共研细末，黄酒合面粉打糊为丸，如梧子大。每服30丸，日1～2次，温黄酒或温开水送下。

方中大黄、水蛭、三棱、鬼箭、桃仁通经逐瘀，破症散结，诸药配合，具有猛攻峻伐之力；紫石英温宫暖血；附子、肉桂助阳散寒；元胡、木香、血竭活血行瘀，理气止痛；血症之中，未尝无饮，故用泽泻、槟榔以利尿除饮，以增强除症之力。如此组合，则寒散气行，瘀祛症除，诸症自愈。但须“衰其大半而止”，不可尽剂。

（二）气滞瘕证：

1.临床表现：少腹胀满，瘕聚不坚，推之可移，或上或下，时聚时散，痛无定处。苔薄润，脉沉弦。

2.主证分析：气机不畅，聚而成疾，故虽有积块而按之不坚，推之可移；气散则痛止，气聚则痛作，故痛无定处；气滞则血行不畅，故少腹胀满。脉沉弦，亦为气机不畅之象。

3.治疗法则：行气导滞。

4. 处方用药：大七气汤（《济生方》）。

制香附、青皮、陈皮、藿香、醋三棱、醋莪术、苦桔梗、肉桂、益智仁各45克，炙甘草22克。共为粗末，每服15克，水2盞，煎为1盞，清晨空腹服下。

方中香附、青皮疏肝达郁，条畅气机；木香理气和胃，佐三棱破血中之气，莪术逐气中之血，以助行气导滞之力；桔梗开提气机，以宣通上下；益智仁辛温气香，能温脾暖肾，宣中带涩，用之以防耗气；肉桂鼓舞血行，以助气化；甘草和中益气，缓急止痛。综合全方，虽具行气导滞之功，但无耗气伤正之弊。

若兼食积，症见胸脘痞满，吞酸泛恶，腹部胀硬疼痛，大便秘结，或溏泻不畅，舌苔厚腻，脉象弦涩。宜理气开郁，消食导滞。用开郁正元散（《济阴纲目》）。

制香附、青皮、陈皮、炒白术、茯苓、炒山楂、炒神曲、炒麦芽、桔梗、砂仁、海粉（海蛤可代）、延胡索、炙甘草各等份。共为粗末。每服30克，加生姜3片，水煎服。

方中香附、青皮、陈皮、砂仁疏肝和胃，理气开郁；白术、茯苓健脾渗湿；气滞痰亦滞，故用海粉软坚化痰；山楂、神曲、麦芽消食导滞，以复胃肠功能；桔梗宣畅气机，以除痞满，盖气郁则痛，血滞亦痛，延胡索既能行血中之气，又能行气中之血，气行血活，通则不痛，故用之以止痛；甘草和中缓急。本方之特点为理气导滞而不损脾胃。

第二节 子宫肌瘤

子宫肌瘤，是妇科常见的良性肿瘤，多发生于30岁以后生育年龄的妇女，根据肌瘤发生的部位不同，可分为粘膜下肌瘤、壁间肌瘤及浆膜下肌瘤三种。临床多表现为月经过多，经期延长，周期缩短，或不规则子宫出血，经期腹痛，亦常伴有贫血、尿频或大小便困难等症状。肌瘤较大者，在下腹部可摸到硬块。如果肌瘤生在子宫角部压迫输卵管，则成为不孕症的原因，因子宫肌瘤在下腹有硬块固定不移，推揉不散，痛有定处的特点，故属于祖国医学“症”的范围。

【病因病机】 子宫肌瘤主要由子宫平滑肌细胞增生而形成，与过多的雄性激素刺激有关。祖国医学认为，血行瘀阻是本病的主要原因。气滞血瘀、气虚血瘀均可导致本病，而病久失血，又可出现气血两虚。《景岳全书》说：“瘀阻留滞作症，惟妇人 有之，其证或由经期，或由产后，凡内伤生冷，或外受风寒，或患怒伤肝气逆而血留，或忧思伤脾气虚而血滞，或积劳积弱气弱而不行。”说明不论何种原因引起的血瘀，瘀阻不去，日渐成“症”。

【辨证施治】 本病一般可分为血瘀型及气血两虚型。血瘀者宜化瘀，气血虚者宜补气养血。经期出血过多时应加用止血药，血瘀者加化瘀止血药，气血虚者加固涩止血药。

（一）血瘀子宫肌瘤：

1. 临床表现：月经过多有血块，经期延长，或经期缩

短，或不规则子宫出血。常伴有痛经，平时白带多或有臭味。妇科检查：子宫异常增大，硬而不规则。舌质黯或有瘀点，苔正常，脉沉涩。

2.主证分析：血瘀胞宫，瘀久而“症”，故子宫异常增大，硬而不规则；瘀血阻滞经脉，血运失常，血失故道，离经之血外流，而致出血过多，经期延长，或不规则出血而有血块；血瘀内阻，不通则痛，故多伴有痛经；瘀久化热，可致带下量多而臭。舌质黯，脉沉涩，均为血瘀之象。

3.治疗法则：化瘀消症。

4.处方用药：桂枝茯苓丸（《金匱要略》）加味。

桂枝、莪术、当归尾各9克，茯苓、桃仁、赤芍、夏枯草、鳖甲、海藻各15克。水煎2次分服。

方中桃仁、丹皮、赤芍破血祛瘀，消症散结；桂枝温通血脉而消瘀血，盖症瘕积结，多挟痰水，故用茯苓健脾制水，加莪术、归尾、夏枯草、鳖甲、海藻以增加攻坚破结化瘀之力。

（二）气血两虚子宫肌瘤：

1.临床表现：突然血崩，下血甚多，或长期淋漓不断，血色淡，质清稀，面色㿔白，精神疲倦，气短懒言，不思饮食。舌淡，苔白，脉细或虚大。

2.主证分析：气虚下陷，血失统摄，故下血量多，或长期淋漓不止；失血过多，则血虚而致经色淡质稀；气血两亏，则面色㿔白，神倦懒言；中气不足，脾失健运，故纳谷不香。舌淡苔白，脉细或虚大，均为气血亏虚之象。

3. 治法：补气摄血；养血行血化瘀。

4. 处方用药：

(1) 举元煎（《景岳全书》）加味。

黄芪、党参各30克，白术、乌贼骨各12克，升麻、当归、艾叶炭各9克，炙甘草6克。水煎2次分服。

按：本方是举元煎加当归、艾叶、乌贼骨。

方中党参、黄芪、白术、甘草大补元气，配当归以补血，乌贼骨、艾炭以固摄止血，升麻升提下陷之气。

如经量过多者，当归酌减。经上方治疗贫血情况纠正后，继用下方：

(2) 桃红四物汤（《医宗金鉴》）加味。

当归15克，熟地24克，川芎6克，赤芍、桃仁、红花、丹皮、莪术各9克。水煎2次分服。

方中四物养血，桃仁、红花、丹皮、莪术活血破瘀消积。

（三）手术治疗的适应症：有下列情况之一者，应采取手术治疗。

1. 子宫肌瘤超过3个月妊娠大者；
2. 粘膜下子宫肌瘤；
3. 出血量多，经保守治疗无效者；
4. 有压迫症状者：压迫膀胱不能排出小便、压迫直肠不能排出大便、压迫输尿管造成肾性高血压者；
5. 子宫肌瘤生长迅速，有恶性变可能者。

第三节 子宫外孕

受精卵着床于子宫腔以外的组织，如输卵管、卵巢、腹腔等处形成妊娠者，称为“宫外孕”，亦称“异位妊娠”。临床上以输卵管妊娠最多见，占90%以上。祖国医籍中，并无本病的记载，从其症状与体征来看，可散见于“堕胎”、“痛经”、“经漏”、“症瘕”等的记载中。

宫外孕是妇产科常见的急腹症之一，严重危害着妇女的健康。过去，手术是本病的唯一根治方法。近年来经中西医共同研究，正确认识和处理宫外孕中止血与活血，补与泻、治标与治本的关系，采用以中药为主的非手术治法，取得显著成绩，使绝大多数患者避免手术痛苦，并保留了不少无子女妇女的再孕机会。

【病因病机】 本病的发生，是因卵子在输卵管受精后，由于通道被阻或行动迟缓，孕卵未到达子宫腔内已具备着床能力时，便植入输卵管的某一部分而发育，即成输卵管妊娠。阻碍孕卵顺利前进的主要原因，是输卵管内膜纤毛缺损、管壁纤维性增生或管腔狭窄、扭曲等。这种孕妇在妊娠之前，大多有过慢性输卵管炎或慢性盆腔炎。多有长久不孕的历史。输卵管妊娠时，孕卵发育至45~60天，体积如桂圆肉大，由于输卵管不可能容许其继续成长，故大多在停经2个月左右，便不可避免的出现输卵管妊娠流产或破裂，造成腹腔内不同程度的出血。此时，下腹某一侧突然剧痛。由于

出血蓄积在子宫、直肠陷凹及子宫、膀胱腹膜反折处，可出现肛门坠胀及排便感。如果出血不多，破裂处被血块包绕，或胚胎继续发育，则可形成包块。若腹腔内出血量大，或持续内出血不止，即可引起出血性休克。

【辨证施治】 宫外孕是妇科的急症、危症，及早作出正确的诊断非常重要。病史往往有长期不孕，短期停经，阴道流血，剧烈腹痛，二便下坠，休克等症。检查时，下腹部压痛反跳痛，阴道后穹窿饱满有触痛，子宫颈有抬举痛，子宫体正常或稍大，附件区有包块，明显触痛。出血多时，腹部有移动性浊音，后穹窿穿刺如能抽出不凝之血，则可确诊。待确诊后，应及时采取适当的治疗措施，对病人的预后极为重要。根据宫外孕的一系列症状和体征，按照祖国医学理论分析，是为少腹瘀血之实证。故治以活血化瘀为主，如血虚气脱者，又当急予补气固脱。临床上可分为已破损型和未破损型两类。

（一）已破损型：

1. 休克型（气血虚脱）宫外孕：

（1）临床表现：妇女停经2～3个月内，有妊娠反应，或尿妊娠试验阳性。孕妇发生下腹一侧绞痛或撕裂痛，疼痛可以持续性或反复发作，或突然发作。并伴有面色苍白，四肢厥逆，冷汗淋漓，头晕眼花，恶心呕吐，血压下降或不稳，有时烦躁不安，或表情淡漠，甚至昏厥。脉微欲绝，或细数无力。

（2）治疗法则：益气，回阳，救脱。

(3) 处方用药：参附汤（《校注妇人良方》）。

大力参30克，熟附子12克。急煎成浓汁，1次顿服。

本方所适应的症候，是大失血后，阴虚不能维阳，以及大汗、大下，伤亡津液，而导致的阳气暴脱。阳气暴脱，一则不能温通四肢，故手足厥冷；二则不能鼓动血流，故脉微；由于元气大亏，则阴液亦随阳气暴脱而外脱，故见冷汗淋漓，并见气息微弱。此时，“有形之血不能速生，无形之气所当急固”，故应血脱先益气，扶阳以救阴。若不急用大温大补之品，则不足回阳以救脱。方中用人参大补元气为主药，附子温壮真阳为辅佐，二药合用，具有回阳益气固脱的作用。方中药味虽少，但用量较重，药效迅速而力专。如是大温大补，使气旺阳壮，体内机能复振，自然厥回神苏。

若阴阳俱竭，阴不敛阳，浮阳上越，面色浮红，脉虚数或浮大无根者，可加龙骨、牡蛎各30克（参附龙牡救逆汤）以育阴潜阳。

如发病急，休克严重者，应立即采取输液、输血、给氧等措施。

休克症情缓解后（收缩压维持在90毫米汞柱以上），再用宫外孕Ⅰ号方（山西医学院附属第一医院）以活血化瘀。

丹参、赤芍各15克，炒桃仁9克。水煎服。

2. 不稳定型（少腹瘀血）宫外孕：

(1) 临床表现：此型是指宫外孕破损时间不长，病情尚不够稳定，有再次发生内出血的可能者，以及内出血不多，无休克征象；或内出血较多，曾有过休克情况，经抢救后病

情好转者。表现为腹痛拒按，但逐渐减轻，可触及界线不清之包块，或有少量阴道出血，淋漓不断，或稍停复来，血压稳定，此时可行穹窿穿刺，若抽出不凝固的血液，即可证实此病。

(2) 治疗法则：活血祛瘀止痛。

(3) 处方用药：宫外孕汤（山西医学院附院、山西省中医研究所）。

丹参、赤芍各15克，炒桃仁9克，制乳香、制没药各6克。水煎服。

按：本方是活血效灵丹去当归加桃仁、赤芍所组成。是治疗子宫外孕的经验方。

方中重用丹参、赤芍配桃仁活血祛瘀，使瘀祛则新生而血自止；乳香、没药祛瘀止痛。合而用之，则有活血祛瘀，消症止痛之作用。

3. 包块型（血症）宫外孕：

(1) 临床表现：宫外孕流产或破裂后，形成血肿包块，深按及双合诊检查可以触及。有按压痛，有时下腹部有坠胀及便意感，腹痛逐渐减轻，阴道流血基本停止。

(2) 治疗法则：消症散结。

(3) 处方用药：宫外孕Ⅱ号方（山西医学院附属第一医院）。

丹参、赤芍各15克，炒桃仁、醋三棱、醋莪术各9克。水煎服。

方中丹参、赤芍、桃仁活血化瘀；三棱、莪术消症散

结。

如身体虚弱者，可酌加党参、黄芪补气之品，以助气血运行之力。

若包块表浅而界限清楚者，可辅以消症散（经验方）外敷。

艾叶500克，透骨草250克，桑寄生、当归尾、五加皮、续断、白芷、赤芍各120克，追地风、千年健、川椒、羌活、独活、血竭、乳香、没药各60克。共研粗末，每250克1份，装入纱布袋中，封口。用时蒸15分钟，趁热外敷，每日1～2次，10天为一疗程。

若包块表浅而体弱，不宜久服攻积破瘀药者，可单用血竭散（验方）外敷。

血竭、松香各9克，樟脑、朱砂各6克，麝香0.06克（如缺可不用）。前4味共研细末，入瓷缸中加热即成糊状，匀涂白布上，然后将麝香撒于药面上，趁热贴于腹部包块处。2天换药1次。

（二）未破损型宫外孕：

1. 临床表现：此指输卵管妊娠尚未破损以前，患者往往表现有不同程度的早孕反应，或下腹一侧有隐痛和坠胀不适感。妇科检查可发现一侧输卵管略有膨大或有软性包块，有压痛。尿妊娠试验可为阳性。

2. 治疗法则：活血化瘀，消症杀胚。

3. 处方用药：宫外孕Ⅰ号方（见包块型）加味。

丹参、赤芍各15克，炒桃仁、醋三棱、醋莪术各9克，

川牛膝、天花粉各12克，猪牙皂3克，蜈蚣1条。水煎2次分服。

方中宫外孕Ⅱ号能活血化瘀，消症散结；加牛膝活血通经，引血下行；天花粉入血分，消瘀血，散结热，并有消肿块的作用；牙皂、蜈蚣性善走窜，又能软坚，是为消痰散结之良药，取其攻逐之迅速。如是加味，则大大增强了消症散结的功力。

可同时注射天花粉素。

天花粉系葫芦科植物栝楼的块根，将其用于中期妊娠引产，是从祖国医学中发掘出来的宝贵遗产。它起源于民间，经不断的研究、提纯，现已将天花粉的引产有效成分（即花粉素）提取出来，并已制成针剂，可做肌肉和羊膜腔内注射。经大量的临床资料观察证明，花粉素引产具有效率高，痛苦少，胎盘剥离完整，损伤及出血少，使用方便，药源丰富等优点，符合有效、安全、经济、方便等要求，现已广泛使用。

花粉素是一种植物蛋白，具有较强的抗原性，易引起过敏反应，因此在使用前必须先做皮试及肌肉试探性注射。因花粉素溶液的稳定性较差，故目前临床使用其冻干制剂，注射前须临时用生理盐水稀释，稀释后如发现溶液浑浊或有絮状沉淀，则不宜使用。

其适应症是：①妊娠12~24周，身体健康，无禁忌症者；②亦可用于死胎，过期流产等。

其禁忌症是：①对花粉素过敏，皮试阳性者；②患有传

染病、发热或白细胞计数升高者，暂不能使用，待治疗复查正常后方可应用；③有心、肺、肝、肾疾病伴有功能不全及严重贫血者。

使用方法及注意事项是：①用前必须做好体格检查及常规血尿检查；②要常规皮下试验。肌注：将花粉素5～8毫克（上海及武汉制品）用生理盐水稀释后做臀部肌注。羊膜腔内注射：将花粉素5～8毫克用生理盐水5毫升稀释；③注射花粉素后应卧床休息48小时，严格观察一般情况；④注意副作用，如有副反应，要及时处理。

（三）兼证（腑气不通）：在宫外孕的整个治疗过程中，必须重视对兼证的处理。最常见的兼证是腑实证，多伴见于休克型和不稳定型早期。而在宫外孕期间往往产生腑实的原因，主要是气血阻滞之后，脾胃运化失调，加之饮食不当，以及内出血的刺激引起胃肠功能紊乱所致。其主要表现为大便秘结，鼓肠腹胀，胃脘不适，甚则疼痛拒按，严重可引起腹痛加剧，不能静卧。必须及时处理，否则会影响治疗效果，或导致宫外孕的再次破裂。对腑实证的治疗，必须辨其寒热。如属热结者用寒下法，属寒结者用温下法。

1. 热结：

（1）腹部硬痛拒按，潮热自汗，口渴烦躁，大便不通。舌苔黄厚或干黄，脉沉实滑数有力。

（2）宜活血化瘀，泻热通腑。

（3）用宫外孕Ⅱ号方加生大黄9克，芒硝6克（冲化）。水四服。

如腹胀甚者，再加厚朴、枳实各9克。以宽肠理气消胀。

2. 寒结：

(1) 脘腹胀满，剧烈疼痛，喜热敷，肢冷畏寒，大便秘结。舌苔白腻，脉沉而弦紧。

(2) 宜温经散寒，通便止痛。

(3) 用大黄附子细辛汤（《金匱要略》）。

生大黄、熟附子各9克，细辛3克。水煎服。

本方适于素体阳虚，寒邪内结成实，肠道传送无力而大便秘结不行。故方用附子温经散寒为主药；细辛温散，助附子以增强其驱除寒邪之力为辅药；但以寒实内结，固宜温药以散其寒，同时需用下药以祛其结，故又作以大黄泻下通便，性味虽属苦寒，但配伍附子、细辛为大辛大热之品，则能制其寒性而存其走泄之性，三药合用，共奏温下之功。寒实积滞所致便秘，在非温不能散其寒，非下不能祛其结的情况下，应用本方，最为恰当。

若腹胀、泛恶、苔垢腻厚等积滞较重者，可加枳实、厚朴、六曲各9克，以宽肠消滞。

兼呕吐者加半夏9克，陈皮6克，以化湿止呕。

若素体虚弱，气虚乏力者，可加党参、黄芪各15克，以补气扶正。

寒除结散便通之后，仍当活血化瘀，并佐温经。用宫外孕Ⅱ号方加炮姜、肉桂各1.5克。

在非手术治疗的过程中，除密切注意病情的变化外，患

者宜绝对卧床休息，勿过早起床活动，尽量减少增加腹压的因素，禁止灌肠及盆腔检查。

（四）手术治疗的适应证：有下列情况之一者，可考虑手术治疗：

1.病人休克严重，虽经积极抢救，内出血多，不能控制者；

2.患者停经时间较长，孕卵仍活，疑为输卵管间质部妊娠，副角子宫妊娠者；

3.尿妊娠试验持续阳性，孕卵所在之处包块继续增大，考虑胚胎存活，曾用药物杀胚无效或对天花粉素针剂过敏不宜应用者；

4.要求绝育者。

第四节 子宫脱垂

子宫从正常位置沿阴道下降至坐骨棘水平以下，甚至脱出阴道口外者，称“子宫脱垂”。古称“阴挺”、“阴痔”、“阴脱”、“阴菌”“阴癰”、“阴挺下脱”等。因本病多发生于产后，故又称“产肠不收”或“子肠不收”。

【病因病机】 本病的发生，主要原因是气虚，中气下陷，冲任不固，不能收摄，或脾胃郁结，湿热下注，都可导致于宫脱垂。此外，慢性咳嗽，长久便秘，年老体衰等也易发生。

（一）气虚：素体虚弱，中气不足，或分娩用力过度，

或难产时间过久，或劳力太过，或抬高举重，或便秘努责等，均可导致气虚下陷，系胞无力，而致子宫脱垂。

（二）肾虚：产育过多，房事所伤，或产前长期站立工作，致肾气亏虚，带脉失约，冲任不固，无力维系胞宫，而使子宫脱垂。

（三）湿热：平素脾气虚弱，运化失司，湿邪蕴结，日久化热，湿热下注，致使子宫脱垂。或重度脱垂，又复感染湿热毒邪。

【辨证施治】 本病在辨证上，有气虚、肾虚、湿热之分。在脱出程度上又有一、二、三度之别：一度者，子宫颈下垂到坐骨棘水平以下，但不超越阴道口；二度者，子宫颈或子宫颈连同部分子宫体露出于阴道口外；三度者，子宫颈及整个子宫体均露出阴道口外。

在治法上，气虚者，宜益气升提；肾虚者，宜补肾固脱；湿热者，宜清热利湿。除药物治疗外，应注意生活起居营养等，并配合外治及针灸疗法，收效更好。

（一）气虚子宫脱垂：

1.临床表现：自觉阴道内有物脱出，小腹、阴道、会阴部有下坠感，行走及体力劳动时加重，卧床后可自行消失，精神疲倦，心悸气短，面色苍白，小便频数，白带量多。舌质淡，苔薄白，脉象浮而虚。

2.主证分析：由于气虚下陷，失于固摄，以致子宫下脱，卧则缩入，劳则坠出；气虚固摄无力，则小腹下坠，小便频数；中阳不足，脾胃虚弱，心失所养，肢体失于温煦，

故精神倦怠，心悸气短；气虚下陷，带脉失约，则白带量多。面色苍白，舌淡，脉浮而虚，皆为气虚之象。

3. 治疗法则：益气升提。

4. 处方用药：补中益气汤（《脾胃论》）。

炙黄芪30～60克，党参15～30克，当归9克，白术12克，升麻9～15克，柴胡、陈皮、炙甘草各6克。水煎2次分服。

方中黄芪、党参、白术、甘草大补元气；当归补血；陈皮理气；升麻、柴胡升举下陷之气。本方以大剂量升补，可奏速效。

若兼血虚者，加熟地、阿胶以补营血；腰酸胀者，加川断、杜仲、寄生以固肾气；白带多而质清稀者，加鹿角霜、乌贼骨以温固任督。

成药：补中益气丸，每次6克，日服3次，温开水送下。

（二）肾虚子宫脱垂：

1. 临床表现：自觉阴道有物脱出，腰酸腿软，头晕耳鸣，小腹下坠，小便频数，阴道干涩不适。舌质红，脉象沉细弱。

2. 主证分析：肾虚冲任不固，带脉失约，不能维系胞宫，故子宫脱垂，小腹下坠；肾气不足，下焦失固，膀胱失约，故小便频数；肾阴虚，阴血不足，髓海空虚，津液不充，则头晕耳鸣，阴道干涩。腰酸腿软，舌淡红，脉沉细弱，均为肾虚之征。

3. 治疗法则：补肾益气，升提固脱。

4. 处方用药：大补元煎（《景岳全书》）加味。

党参、金樱子、山药各30克，熟地18克，杜仲、菟丝子、枸杞子各12克，山茱萸、当归、升麻各9克，炙甘草6克。水煎2次分服。

按：本方是大补元煎加金樱子、菟丝子、升麻。

方中党参补气；当归、熟地养血滋阴；杜仲、山茱萸、枸杞子、菟丝子补肝肾；山药、炙甘草健脾和中；金樱子固涩；佐以升麻升提下陷之气。

若元气不足，命门火衰，多寒者，可酌加附子、肉桂、干姜之类以温肾助阳。

（三）湿热子宫脱垂：

1. 临床表现：子宫脱出，表面溃疡，出现外阴肿胀疼痛，黄水淋漓，身热心烦，小便短赤而灼热，或口苦而干。舌质红，苔黄而腻，脉滑数。

2. 主证分析：脾气素虚，运化失司，湿热下注；或摩擦损伤，外遭感染，损及脉络，致外阴肿痛，黄水淋漓；湿热下注，则小腹坠痛，尿短赤而痛；热灼津伤，则口苦而干。舌红苔黄而腻，脉滑数，均为湿热内蕴之象。

3. 治疗法则：健脾利湿，清热解毒。

4. 处方用药：四苓散合二妙散（《丹溪心法》）加味。

茵陈15克，炒白术、制苍术、茯苓、猪苓、生地、泽泻、黄柏、栀子各9克，银花、土茯苓各30克。水煎2次分服。

按：本方是四苓散（白术、茯苓、泽泻、猪苓）二炒散（苍术、黄柏）加茵陈、栀子、生地、银花、土茯苓。

方中苍白二术、茯苓、猪苓、泽泻健脾渗湿，以益后天之本；黄柏、栀子清热燥湿解毒，使湿热之邪，以小便排出；银花、土茯苓以增强清热解毒之功。生地清热生津，以防燥渗伤阴；借茵陈升发之力，以泻散湿邪。

【简易方】

（一）棉花根60克，炒枳壳30克。水煎服。

（二）金樱子60克。水煎服，连服3～4日。

【针刺法】

（一）主穴：

1. 维胞（关元旁开6寸，进针后大幅度捻转，病人即有子宫收缩感）。

2. 子宫穴（髂前上棘与耻骨结节联接线中点向内1横指，进针后向耻骨联合方向斜刺，深度以病人感到阴部发酸上抽感为止）。

3. 三阴交。

（二）配穴：长强、百会、阳陵泉。可同时灸百会穴。

有膀胱膨出者，可针刺关元透曲骨，或斜刺横骨（双）。有直肠膨出者，可针刺提肛肌穴，有往上抽动感为度。

每周行针2～3次，2～3周为一疗程。

【外治法】

（一）枳壳60克。煎汤乘热先熏后洗外阴部，每日1～2次。

(二) 乌梅15克、五倍子、石榴皮各9克。用法同上。

(三) 苦参、蛇床子各15克，生黄柏、白芷各9克，枯矾6克。用法同上，此方适用于湿热型。

【预防】

(一) 加强锻炼，增强体质。

(二) 大力宣传计划生育，提倡优生。

(三) 推广新法接生，提高接生技术，正确处理各个产程，及时缝合会阴及阴道裂伤，保证产假休息。

(四) 加强妇女劳动保护，认真做好“四期卫生”，避免超重劳动，和长期蹲、站位劳动。

(五) 保持大便通畅，积极治疗便秘。

(六) 治疗期间，要注意休息，避免房事。

第五节 不孕症

结婚后夫妇同居3年以上，未避孕而不受孕者，或曾经孕育而又3年以上未避孕而不再受孕者，统称“不孕症”。前者为“原发性不孕症”，《千金要方》称“全不产”，《脉经》称“无子”，后者为“继发性不孕症”，《千金要方》称“断绪”。

根据近代医学研究，受孕必须具备三个条件：①女方能排出正常的卵子；②男方能排含正常数量、形态和活动能力的精子；③精子和卵子能结合以及受精卵能够着床。文献报道，不孕症的原因比例，男女各占1/2。因男方因素而致的不

孕，称为“男性不孕症”，因女方因素而致的不孕，称为“女性不孕症”。本节重点介绍女性不孕症，并附男性不孕症。

【病因病机】 女子不孕的原因，可概括为两大类：一是属于先天性生理缺陷，有螺、纹、鼓、角、脉五种，古称“五不女”，古人认为，此非药物所能解决，是所谓“绝对性不孕”。一是属于病理性的变化而不孕，经过治疗后，仍有受孕的可能，此为“相对性不孕”。

因为受孕的机理，祖国医学认为“女子肾气盛，任脉通，太冲脉盛，月事以时下；男子肾气盛，精气溢泻，阴阳和，两精相搏，才能有子。”从而可知，妇女不孕主要是由于肾气不足，冲任气血失调所致。而导致阴亏阳损，冲任失调的因素，临床常见的有肾虚、血虚、血瘀、肝郁、痰湿等。

（一）肾虚：多因禀赋素弱，肾气不足，或早婚、房室不节，精血耗伤，肾阳亏损，失于温煦，冲任气衰，胞脉失养，胞宫因之不能摄精成孕；或经期摄生不慎，当风受寒，寒气客于胞中，以致宫寒而不孕。

（二）血虚：由于体质素弱，阴血不足，或因失血伤阴，以致冲任空虚，血少不能摄精成孕。或阴虚火旺，血为热灼，导致不孕。

（三）血瘀：经期或产褥期，摄生不慎，或行房事，邪入胞宫，造成血瘀，胞脉受阻，任脉不通，故而不孕。

（四）肝郁：情志不舒，肝气郁结，疏泄失常，气血不

和，冲任不能相资，以致不孕。

（五）痰湿：体质肥胖，痰湿内生，气机不畅，月经不调，故不成孕；或因驱脂过于丰满，阻塞胞宫不能摄精成孕。

【辨证施治】 在治疗前必须排除男方疾患。并进行双合诊检查，明确盆腔情况，再结合全身症状辨证施治。在治疗过程中，还宜调情志，节房事，慎起居。

（一）肾虚不孕：肾虚不孕症，属肾阳虚者多，肾阴虚者少。

1.临床表现：婚后多年不孕，月经初潮较晚，经期错后或不定期，经血量少，血色晦暗，精神疲倦，腰酸腿软，性欲低下甚至有反感，小便清长。舌苔薄白而润，脉沉细或沉迟。妇科检查，往往子宫较小，卵巢功能不足，有的为无排卵性月经。

2.主证分析：肾气不足，精亏血少，血海空虚，故月经初潮迟而后期，量少，色黯；肾气虚损，命门火衰，故精神疲倦，腰酸腿软，性欲低下；肾司二阴，肾虚则不能制约，故小便清长。舌质淡，苔薄白而润，脉沉细，皆为肾阳不足之征。

3.治疗法则：温肾养肝，调补冲任。

4.处方用药：温肾丸（《沈氏尊生书》）加减。

熟地、山萸肉、紫石英各90克，巴戟肉60克，杜仲、续断、炒山药、茯苓、当归、菟丝子、蛇床子、益智仁、川椒各30克，鹿茸15克。共研细末，加炼蜜500克为丸，每丸重9克。每次1丸，日服3次，温开水送下。

按：本方是温肾丸去生地、远志，加紫石英、川椒。

方中熟地、黄肉、山萸、当归滋肝补肾，养血调经，以益阴摄阳，使“阳得阴助而生化无穷”；鹿茸、巴戟、菟丝、蛇床、川椒温肾壮阳，填精补髓，俾“阴得阳生而泉源不竭”；杜仲、续断补肝肾，强腰膝，且有固血之功；益智仁温脾益火，缩尿固精，为免一派峻补之呆滞，复用茯苓之淡渗脾湿以和之；紫石英向为温补肝肾，治宫冷不孕之品，现经实验证明，它能兴奋卵巢之内分泌，对于性欲减弱之不孕者颇为有效。

如下焦真阳不足，腰痛如折，小腹畏寒，小便频数或不禁者，可加补骨脂60克，附子、肉桂各30克。以增强温肾壮阳，固精缩尿之力。

（二）血虚不孕：

1. 临床表现：婚后多年不孕，月经后期量少，色淡，或经闭，面色萎黄，形体衰弱，神疲力倦，头晕目眩，舌质淡，苔薄白，脉沉细。子宫内膜结核引起的月经过少，甚至经闭不孕者，亦属此类。

2. 主证分析：阴血不足，冲任空虚，血海不能按时满盈，故月经后期量少或经闭；阴血不足，不能荣养全身，故面色萎黄，月经色淡，形体衰弱，头晕目眩，神疲力倦。舌质淡，脉沉细，亦为血虚之象。

3. 治疗法则：益气养血，调补肝肾。

4. 处方用药：毓麟珠（《景岳全书》）加味。

熟地90克，党参、当归、菟丝子、紫石英各60克，炒白

芍、炒白术、茯苓、炒杜仲、鹿角霜各15克，川芎、炙甘草各30克，川椒15克。共研细末，加炼蜜550克为丸，每丸重9克。每次1丸，日服3次，温开水送下。

按：本方是毓麟珠加紫石英。

方中四物养血，四君补气；菟丝子、杜仲、鹿角霜、紫石英有温补肝肾，调补冲任，强阴益精之功；佐川椒以助肾火温督脉。全方既温养先天肾气以生精，又培补后天脾气以化血，使精血充足，冲任得养，胎孕乃成。

（三）血瘀不孕：

1. 临床表现：下腹隐痛、坠痛或有胀满感，经期加重，月经失调或经行不畅，或淋漓不断，有血块。舌质红或紫或有瘀斑，舌苔黄腻或薄白，脉沉弦或涩。此型多有附件炎引起的输卵管不通。妇科检查：附件区有压痛，增厚或有包块。

2. 主证分析：瘀血内停，经脉受阻，血行不畅，气机不利，则下腹隐痛、胀满，月经不调有血块。舌质红紫，有瘀斑，脉沉弦，乃血瘀之象。

3. 治疗法则：活血化瘀，理气止痛。

4. 处方用药：膈下逐瘀汤（《医林改错》）。

当归、赤芍、桃仁、红花、炒五灵脂、香附、乌药、丹皮各9克，元胡索、炒枳壳、川芎、生甘草各6克。水煎2次分服。

方中归、芍、桃、红、芎活血化瘀，灵脂、元胡理血中之气，化瘀而止痛；香附、乌药、枳壳疏肝行气；丹皮凉血行

瘀；甘草调和诸药。

若形寒肢凉，少腹冷痛，宜温经止痛，活血化瘀。用少腹逐瘀汤（《医林改错》）。

当归、赤芍、生蒲黄、炒五灵脂、元胡索各 9 克，川芎、小茴香各 6 克，没药 4.5 克，肉桂、炮干姜各 3 克。水煎 2 次分服。

方中当归、赤芍，川芎、蒲黄、灵脂、没药、元胡活血化瘀，理气止痛；茴香、肉桂、干姜温经散寒。

按：膈下逐瘀汤适于血瘀而偏热者，少腹逐瘀汤适于血瘀而偏寒者。

如输卵管不通，均可选加细辛，桂枝、山甲珠、路路通之属。

（四）肝郁不孕；

1. 临床表现：多年不孕，精神抑郁，月经量少延期，或先后无定期，经前乳房胀痛，胁肋撑胀或痛。舌质红，苔白微腻，脉弦。临床所见，此型常有内分泌失调，经前紧张综合征等。

2. 主证分析：情志不舒，则肝失条达，气血失调，冲任不能相资，故多年不孕；肝郁气滞，故经前乳胀，两胁胀痛，抑郁不乐；气滞血瘀，故月经后期量少。舌质红，脉弦，皆为肝郁之征。

3. 治疗法则：舒肝解郁，养血扶脾。

4. 处方用药：开郁种玉汤（《傅青主女科》）。

当归、炒白芍、炒白术、茯苓、丹皮、制香附、花粉各

9克。水煎2次分服。

方中当归、白芍养血柔肝，丹皮凉血化瘀，香附调气解郁，白术、茯苓益气扶脾，花粉清热生津。

如胸胁胀满痛甚者，去白术，加青皮6克，柴胡、玫瑰花各9克，以加舒肝解郁之力；如乳房胀痛者，可加橘叶、王不留各9克，以舒肝通络；如梦多而睡眠不安者，可加炒枣仁12克，夜交藤18克，以益肝宁神。

（五）痰湿不孕：

1.临床表现：多年不孕，形体肥胖，面色㿠白，头晕心悸，白带量多，月经不调。舌苔白腻，脉滑。此型因单纯性肥胖而不孕者少，合并内分泌紊乱如甲状腺机能低下，柯兴氏综合征，卵巢多囊病变等而不孕者多。除辨证施治外，还应参考基础代谢，17羟和17酮及雌激素水平，必要时做气腹造影，观察卵巢情况。

2.主证分析：胖人多痰湿，痰湿过盛，壅塞气机，冲任失调，或驱脂过丰，闭塞胞宫而致不孕。痰湿内阻，清阳不升，则面色㿠白而头晕；痰湿凌心，则心悸；脾气健运，湿浊下注，带脉失约，故白带量多。舌苔厚腻，脉滑，亦属痰湿内蕴之征。

3.治疗法则：燥湿化痰。

4.处方用药：启宫丸（《医方集解》）加减。

制半夏、制苍术，炒白术、茯苓、昆布、海藻各60克，制香附45克，陈皮、川芎、远志、炒神曲各30克。共研细末，水泛为丸，如小豆大。每次6克，日服3次，温开水送

下。

按：本方是启宫丸去甘草加昆布、海藻、苍术、远志。

方中半夏、茯苓、陈皮、苍术、白术燥湿化痰；远志祛痰宁心；昆布、海藻软坚化痰；神曲健脾消滞；香附、川芎理气和血，气行痰亦行，有助湿痰之运化。全方有健脾燥湿，调气化痰之效。

如经量过多，可去川芎，加黄芪、续断各60克，以补气固经；白带过多加土茯苓、扁豆各60克，以渗湿除带。

附：男性不孕症

夫妇结婚3年以上经检查系由男方因素所引起的不孕症，称“男性不孕症”。在旧中国，由于男尊女卑的封建礼教观念，每把不孕的责任完全责之于女方，因而造成“男病女治”的奇谈怪论。其实祖国医学很早就有“五不男”的记载。“五不男”即指天、漏、键、怯、变五种不孕症。天，即“天宦”，泛指男子先天性外生殖器官或睾丸缺损及第二性征发育不全；漏，即精液不固，常自遗泄；键，指阴茎及睾丸全部切除；怯，即阳痿；变，又称“人疝”，即两性畸形，俗称“阴阳人”。由于旧中国历史条件的限制，在祖国医籍中，治疗女性不孕症的理论、方药多有记叙，而治疗男性不孕症的理论、方药则甚少见。近几年来，我们根据祖国医学的理论，结合近代医学的临床病理及化验检查，使用中药治疗男性不孕症，每取得满意效果。

【病因病机】 临床上，可将男性不孕症归纳为三类：

即性机能障碍，精液异常，先天或后天性器质性病变等。

（一）性机能障碍：

1.阳痿：又称阳事不举，即阴茎不举，无法交合而致不孕，此由禀赋素弱，肾气不足，命门火衰；或房劳^{shí}过度，或误犯手淫^{shí}，致伤精气；或思虑忧郁，损伤心脾；或恐惧过度，损伤肾气所致。《景岳全书》云：“凡男子阳痿不起，多由命门火衰，精气虚冷，或以七情劳倦伤生阳之气多致此证。亦有湿热炽盛以致宗筋弛纵而为萎弱者。”

2.早泄：指男女尚未交合即排精者。因精子不能进入阴道而不孕。肾主藏精，开窍于二阴，肾气不足，封藏不固，故易早泄。或相火炽盛，肾水亏损太过，致阴虚火旺，肾失封藏而早泄。

3.遗精：亦名遗泄，或称失精。有梦而遗精的，名为“梦遗”；不因梦感或见色而精自滑出者，名为“滑精”。证虽不同，病因则一。主要是心肾不交，相火炽盛或肾气不固等所引起。遗精过频者，可致精子稀少而不孕。

4.不射精：虽能进行性生活，但性交过程中无精液排出，故不孕。此系命门火衰，或热灼肾阴所致。肾阳不足，命门火衰则无力排精；热灼肾阴，阴亏精少，则无精可排。

（二）精液异常：正常人的精液为白色或灰白色不透明的液体，平均为3～5毫升，排出体外后30分钟左右即自行液化，每毫升含精子总数0.6亿～2亿，活动精子占总数的60%以上，畸形者不超过20%。

1.无精子：多次精液检查（一般3次以上）均未发现有

精子者，称为“无精子”（如有时精子为“0”，有时发现有少数精子，则应属精子稀少）。临床上，又分真无精子和假无精子两种，前者指睾丸不能产生精子，后者指睾丸能产生精子，但因精道阻塞而精子不能排出。此乃先天禀赋不足或后天虚损太过所致。

2.精子稀少：多次精液检查，精子数均在每毫升0.6亿以下者，称“精子稀少”。少于此数并非不能受孕，而是受孕率降低。有人报道：生育能力正常的精液每毫升少于0.6亿者占15%，少于0.4亿者占7%。一般认为少于0.2亿者，不经治疗很难受孕。因为卵子排出时为一层放射冠和透明带所包围，精子所分泌的透明质酸酶能使透明带及放射冠的细胞分散，便于精子进入卵子。精子稀少则透明质酸酶浓度低，受孕机会自然减少。精子稀少的主要原因是肾气不足。祖国医籍中，男子因真阳不足而引起精气清冷，无生育能力者，称为“精冷”，即属于此类。

3.精液不液化：精液1小时不液化，大大束缚精子的活动能力，在阴道停留的时间愈久，精子死亡率愈高，故不易受孕。在正常情况下，前列腺液内有纤维蛋白原和纤维蛋白溶酶，后者使精液排出体外不久即液化。若因前列腺病而致纤维蛋白溶酶减少或缺乏，则造成精液液化时间延长或不液化（临床常见放置24小时亦不液化者）按祖国医学的理论分析，属肾火偏旺，热灼津液，以致精液粘稠而不液化。

4.死精子过多：死精子超过40%则影响受孕。肾气不足或肾火偏旺均可导致死精过多。近代医学研究，精子的活动与

精囊所分泌的果糖直接关系。精囊病变或人的身体健康状况欠佳时，精液中所含的果糖减少，因营养物质缺乏而精子死亡率增高。此外，维生素A和E的缺乏对精子的活动亦有很大影响。精囊炎符合肾火偏旺，健康状况不佳符合肾气不足。

（三）先天或后天性生殖器官器质性病变：如睾丸发育不全，隐睾，输精管阻塞，尿道下裂等均不能受孕。

【辨证施治】 先天性或后天性生殖器官器质性病变及其无精子者，均非药物所能奏效，不予赘述。仅就性机能障碍和精液异常所引起的不孕症加以讨论。在治疗中除服药外，尚需注意精神和饮食起居的调节以及性生活的节制。《济阴纲目》说：“聚精之道，一曰寡欲，二曰节劳，三曰息怒，四曰戒酒，五曰慎味。”《妇科玉尺》也说：“男子求嗣，所贵清心寡欲。”

（一）性机能障碍：

1. 阳痿（亦称阳事不举或阴痿）：

（1）临床表现：阳痿一症与无性欲或性欲低下常同时出现，除阴茎不举无法交合外，多见面色㿔白，头晕目眩、精神萎靡，腰足酸软，脉多沉细等肾阳虚衰征象。

（2）主证分析：由于青年时误犯手淫，或脾胃虚弱，气血生化之源不足，均能导致肾精亏损，肾阳不振，命门火衰，以致阳痿。肾精不足，髓海空虚，故头晕目眩，精神萎靡；腰为肾府，肾虚故腰腿酸软；肾阳亏虚，气血不足，故面色㿔白。舌淡，脉沉细弱，乃肾气虚损之象。

(3) 治疗法则：温补命门，益精扶阳。

(4) 处方用药：赞育丹（《景岳全书》）加味。

熟地120克，炙蜂房、肉苁蓉、枸杞子各90克，当归、白术、淫羊藿、巴戟肉、山萸肉、杜仲、韭子、蛇床子各60克，附子、肉桂、仙茅各30克。共研细末，加炼蜜1000克为丸，每丸重9克。每次1丸，日服3次，温开水送下。

按：本方是赞育丹加蜂房。

方中熟地、山萸肉滋肾益精；肉苁蓉补肾壮阳，具有温而不燥，润而不膩的特点；枸杞、杜仲补肝肾，强腰膝；当归养血，白术健脾；仙茅、巴戟、淫羊藿、韭子、蛇床子补肾阳；附子、肉桂散寒助阳。露蜂房性平，味苦咸微甘，无毒，具有兴阳益肾的作用，对阳痿不举及遗尿失禁之症，颇具效益。

若思虑过度，损伤心脾，或恐惧伤肾，证见阳痿，精神不振，胆怯多疑，寐不安宁者，宜补益心肾，用大补元煎（《景岳全书》）加味。

熟地18克，炒山药、山萸肉、枸杞子、炒枣仁、杜仲各12克，夜交藤、党参各15克，炒白术、当归各9克，炙甘草6克。水煎2次分服。

按：本方是大补元煎加枣仁、白术、夜交藤。

方中熟地、山药、山萸滋阴补肾；枸杞、杜仲补肾，强腰膝；党参、白术、甘草益气健脾；当归补血和血；枣仁、夜交藤，养心宁神。

如阴虚阳亢，虚火上炎，症兼潮热颧红，眩晕耳聋，可

加生龟板12克，生牡蛎30克，以滋阴潜阳。

若阳痿，两腿酸困，小便赤热，舌苔黄腻，脉沉滑，属于湿热下注者，宜清化湿热。用四妙散（《成方便读》）加味。

制苍术、黄柏、黄芩、川牛膝、半夏、茯苓、滑石各9克，生薏仁18克，生甘草3克。水煎2次分服。

按：本方是四妙散加半夏、茯苓、黄芩、滑石、甘草。

方中苍术、半夏、茯苓辛温健脾燥湿；黄柏、黄芩苦寒燥湿泻热；薏仁、牛膝祛湿热而利筋脉；滑石、甘草淡渗利水使湿热从小便排出。

若湿热去而阳痿不见好转者，再根据上述辨证分别阴阳，酌情施治。

本病亦可用以下简易方治疗：

蜂房散（《虫类药的应用》）。

蜂房（炙存性）60克，研末，每次6克，临睡前服。得效即停服。

本品有兴阳起痿作用。

抗痿灵（交通部通讯总站卫生所方）。

蜈蚣18克（晒干生用，不烘烤，不去头足），当归、炒白芍、炙甘草各60克。先将后3味晒干研细，蜈蚣另研细，然后二药粉混合研匀，分为40包（每包约4.5克，也可制成小水丸）。每次0.5～1包，早晚各服1次。空腹温白酒或黄酒送服。15天为一疗程，忌食生冷，并禁气恼。

方中蜈蚣为主药，辛温有毒，入肝经，能通经逐邪，其

走窜之力最速，内而脏腑，外而经络，凡气血凝聚之处，皆能开之。本品能使肝气条达，疏泄正常，经络流畅，气血自得通行。肝藏血，肝主筋，阴器为宗筋所聚，故辅当归、白芍养血和血，补肝柔肝，荣养宗筋，既能养血益精和调阴阳，又能监制蜈蚣辛温走窜伤阴之弊；甘草以解蜈蚣之毒。日人今井丰云说：“甘草为药草之王，和于百药之中，可以化百毒，用于性欲增进之药中，能增肾力而治内伤，为早衰阳痿之良药。”并使之培补后天养先天。四药协同，气血兼顾，经脏同治，性味和平，有补有通，寓通于补之中。共奏疏通肝经郁闭之功，阳痿之症自能告愈。

据报道本方用于737例中，近期治愈（指半年内）655例，占88.9%。一般服药后3~7天见效，最晚见效可在25天内。勃起坚而有力，同房能成功后，需服药10~15天，以资巩固。

2. 遗精：

（1）临床表现：梦中遗精，次日头昏眼花，心悸，精神不振，体倦无力，小便短黄而有热感。舌质红，脉象细数。

（2）主证分析：由于劳神过度，或心有妄想，所欲不遂，以致心阴暗耗，心火独亢，不能下交于肾，肾阴不能上交于心，阴亏火旺，扰动精室，故为梦遗；肾阴亏虚，虚火上扰，故头晕眼花；心阴虚而心失所养，故心悸；心火盛而移热于小肠，故小便短黄而有热感。舌质红，脉细数，乃阴虚热盛之象。

(3) 治疗法则：滋阴降火。

(4) 处方用药：三才封髓丹(《卫生宝鉴》)加味。

熟地、生龙骨、生牡蛎各30克，天冬12克，党参15克，黄柏9克，砂仁、菖蒲、远志、甘草各6克。水煎2次分服。

按：本方是封髓丹加龙骨、牡蛎、菖蒲、远志。

方中熟地、天冬、黄柏滋阴降火，启肾阴上交于心，肾阴足则心火自降；远志、菖蒲导心火下交于肾；党参、甘草益气补中，为交通心肾之枢纽；配龙骨、牡蛎滋阴潜阳，宁心涩精；佐砂仁和胃，以防寒凉滋腻碍消化。诸药配合，共奏滋阴降火，交通心肾之功。

若肾气不固，证见滑精频作，甚或情动即遗，见色流精，头昏目眩，精神萎靡，腰腿酸软。舌淡苔白，脉象沉弱。治宜补肾固精。用秘精丸(《济生方》)。

煅牡蛎、生龙骨、菟丝子、韭子、五味子、桑螵蛸、白茯苓、白石脂各等份。共研细末，酒糊为丸，梧子大。每次6克，日服3次。空腹淡盐汤送下。

若湿热内蕴，遗精频作，口苦或渴，小便热赤，舌苔黄腻，脉象濡数。治宜清化湿热。用湿热遗精方(经验方)。

粉萆薢、生薏仁各15克，茯苓12克，泽泻、苦参各9克，黄柏6克。水煎2次分服。

3. 不射精：

(1) 临床表现：性欲低下，勃起不坚，每次性交，均不见射精，且无性欲高潮之快感。腰腿酸软，精神萎靡，面

色眈白。此属肾阳虚衰之征。

(2) 治疗法则：温养肝肾，补益精气。

(3) 处方用药：加减羊睾丸汤（编者方）。

阳起石、黄芪各30克，淫羊藿、川牛膝、川续断各15克，巴戟天、胡芦巴、仙茅、菟丝子、枸杞子、鹿角霜各9克，泽泻、当归各12克，羊睾丸1对。水煎2次分服。

先将羊睾丸煮熟，用其汤煎药，饮药食羊睾。

方中阳起石、淫羊藿、巴戟天、胡芦巴、仙茅补肾壮阳强筋骨，菟丝子、川断、枸杞子、鹿角霜入肝肾，益精血，精液乃气血所化生，以黄芪、当归补气养血，使气充血和则精室盈满，泽泻、牛膝通精引下，使盈满之精易泄。羊睾丸同气相求，以益精填髓，用为之使。全方具壮阳益精，振奋气血之效。

若阳强不倒（即延长性交时间，甚至性交结束后，阴茎仍不软缩），交接之后，终不射精。身形健壮，或伴有神疲乏力，耳鸣腰酸，头昏目眩等肾阴亏虚之象。治宜滋阴降火。用知柏地黄丸（见经闭）酌加急性子、川牛膝，以通络散结。

若形体壮实，肌肉丰满，活动自如，无腰痛腿酸感，食睡正常，唯性交时少腹部有憋胀感而无精液射出，交后仍阳强不倒，反睡后遗精。苔薄白，舌质红，中根部有瘀斑，脉沉缓有力。是为瘀血阻滞之征。治宜活血化瘀，佐以通利。用逐瘀通精汤（经验方）。

当归尾30克，丹参15克，红花、赤芍、山甲珠各9克，

急性子、王不留、川牛膝各12克，川芎、炒枳壳各6克。水煎2次分服。

精通之后，宜滋补肝肾，以善其后。

按：临床上尚有一种性交高潮有快感及射精感，而尿道口却无精液排出者，这可能是精液进入膀胱，称为“精液倒流”。此种不孕，不得作不射精论治。

（二）精液异常：

1. 精子稀少：

（1）临床表现：精液检查，精子数在每毫升0.6亿以下，伴有精神疲乏，头晕耳鸣，健忘，腰酸等，或遗精、阳痿。亦有无任何症状表现者。

（2）主证分析：由于肾气不足生精功能低下，故精子过少，或素体阴素，或患遗精日久失治，致肾阴亏损，精子量少，不易成孕。精神疲倦，头晕耳鸣，健忘，腰酸等俱属肾阴不足之候。阳事不举则是肾阳虚衰之由。

（3）治疗法则：补肾益精。

（4）处方用药：五子衍宗丸（《丹溪心法》）。

枸杞子、菟丝子各240克，覆盆子120克，五味子60克，车前子30克。共研细末，加炼蜜650克为丸，每丸重9克。每次1丸，日服3次，温开水或黄酒送下。

方中重用枸杞、菟丝补肾益精为主药，且菟丝不仅益阴，且能扶阳，温而不燥，补而不滞，覆盆子、五味子固肾涩精，阴虚每火浮，故用车前子以泄肾中虚火。诸药配合，共有补肾益精，扶阳固涩之作用。

若伴有遗精者，加莲子肉、金樱子各60克，以加强固涩之力。

2. 精不液化：

(1) 临床表现：精液化验，1小时尚不液化，或精液中挟有脓细胞。患者或有前列腺炎和精囊炎史。

(2) 主证分析：由于房事过频，或屡犯手淫，因而阴精亏损，阴虚阳亢，津液被灼，导致精液稠粘，不易液化。

(3) 治疗法则：滋阴泄火，活血化痰。

(4) 处方用药：液化汤（编者方）。

生地、熟地各18克，知母、黄柏、赤芍、白芍、丹皮、天冬各9克，丹参15克，花粉、淫羊藿各12克，生甘草6克。水煎2次分服。

方中生地、熟地、知母、黄柏滋阴降火；丹参、丹皮、赤芍清热活血化痰；白芍敛阴和血；天冬、花粉增液生津；淫羊藿助阳以温化，并防寒凉之冰伏；甘草生用泻火，并调出诸药。

精液中挟有脓细胞者，可加银花15克。

3. 死精子过多：

(1) 临床表现：以往多有前列腺炎史。证见尿频、尿痛、尿急，尿道偶有分泌物；或伴有性欲低下、遗精早泄；或会阴隐痛，或排精不适等。亦有无任何明显症状，前列腺液检查白细胞增加（10个以上/高倍镜）而磷小体减少者。

(2) 治疗法则：①滋阴清热；②益精壮阳。

(3) 处方用药：

①死精Ⅰ号方（编者方）。此方适于有慢性前列腺炎者。

生地、蒲公英各15克，丹参、银花各24克，续断、当归各12克，知母、黄柏、赤芍、白芍各9克，生甘草6克。水煎2次分服。

方中生地、白芍、黄柏、知母滋阴泻火；丹参、赤芍、当归养血活血化瘀；银花、公英、甘草清热解毒；续断补益肝肾。

②死精Ⅱ号方（上海市北站医院方）。此方适于无任何明显症状表现，且无慢性前列腺炎者。

带子蜂房（炙）、阳起石、淫羊藿、补骨脂、全当归、党参、鹿角、炙龟板、桑寄生、韭子各50克，大熟地、制首乌、菟丝子、金樱子各60克。共研细粉。每次10克，日服2次，温开水送下。

方中熟地、首乌、当归、寄生养血益精，润筋通络；党参补中益气，以资生化之源；龟板滋阴补肾；蜂房、阳起石、淫羊藿、补骨脂、菟丝子、韭菜子俱壮阳助火之品，以扶命门，鼓动生机；金樱子收敛精气。全方共奏阴阳双补，以达阳生阴长之效。

第六节 脏 躁

妇人精神忧郁，烦躁不宁，无故悲泣，哭笑无常，喜怒无定，频作呵欠，叫做“脏躁”。与现代医学的“癔病”

(又名歇斯底里)相类似。多发生在青年和中年。发病急，病程短，但往往反复发作，每次发作时症状相似。

【病因病机】本病为内伤虚弱证。多因忧愁思虑过度，损伤心脾，心脾两伤则精血之化源不足；或因情志不舒，肝气郁结；或因突受惊恐，恐则精却。以致精血内亏不能濡养五脏，则阴阳平衡失调，浮火妄动，上扰心神而引起本病。

【辨证施治】本病系属内伤虚证，五志化火而成。虽属虚证，不宜大补，虽有虚火，不宜苦降。唯有甘平柔润，镇静安神之品，方为妥当。

(一)心神失养脏躁：

1.临床表现：精神不振，情志恍惚，情绪易于激动，心中烦乱，睡眠不安；发作时，哭笑无常，呵欠频作，不能自主；口干，便秘。舌红，苔薄白或中心光剥无苔，脉细弱而数或细弦。

2.主证分析：由于情志不畅，肝气郁结，气机不利，精血暗耗，不能营养心神，致使精神不振，情志恍惚，情绪易于激动；气逆于肺则悲哭，火郁于心则自笑，故悲伤欲哭，喜笑无常；心火内动，则心烦意乱，睡眠不安；精神疲倦，则呵欠频作；阴津不足，故口干便秘。舌红，苔薄白或中心光剥，脉细弱而数或细弦，均为心虚挟热之证。

3.治疗法则：养心宁神。

4.处方用药：甘麦大枣汤加味（见经断前后诸证心阴亏）。

(二)阴虚阳亢脏躁：

1.临床表现：烦躁不安，气逆胸痞，恶心嘈杂，意识朦胧，敏感多疑，哭笑无常；有时头晕头痛，甚至昏厥；或手舞足蹈，拘急痉挛，或咯吐白胶粘痰，喉间不爽，口燥咽干，渴欲饮水，以上诸证可交替出现。舌质红，脉弦细略数。

2.主证分析：素体阴虚，复受精神刺激，情绪抑郁，气郁则化火，火盛灼伤阴液，使心阴不足，影响神志，出现烦躁不安，敏感多疑，甚则意识朦胧，精神错乱；气郁不舒则胸闷，气逆于肺则悲哭，火郁于心则自笑；气火并走于上则头痛或昏厥。气火上升，灼耗津液，故咯痰胶粘，喉间如阻而不爽，口干咽燥渴欲饮水，甚或肝风内动而手舞足蹈，抽搐痉挛。舌质红，脉弦细，是属阴亏火盛之象。

3.治疗法则：滋阴潜阳，泻火安神。

4.处方用药：

（1）轻证，用百合地黄汤（《金匱要略》）加味。

生百合、珍珠母各30克，生地18克，生白芍、钩藤各15克，麦冬、木瓜、炒枣仁各12克，生甘草6克。水煎2次分服。

按：本方是百合地黄汤加珍珠母、钩藤、麦冬、枣仁、木瓜、甘草。

方中百合、生地养心肺之阴而清热，麦冬滋阴生津并能清心泻火；木瓜敛津，舒筋，以解筋脉抽搐；钩藤、珍珠母平肝清热，熄风止痉，枣仁养心安神，芍药、甘草柔肝缓急。

（2）重症，用橘枳龙牡汤（编者方）。

生龙骨、生牡蛎各30克，生地15克，橘叶、生白芍、白薇、麦冬各12克，元参、山梔、竹茹、川牛膝、炒枳壳各9克，生甘草6克。水煎2次分服。

方中龙骨、牡蛎重镇滋阴潜阳；橘叶、枳壳舒肝解郁，行气除痞；白芍、甘草柔肝敛阴缓急；生地、玄参、麦冬滋阴泻火；山梔、白薇清热除烦；竹茹清热化痰；牛膝一味引火下行。

第七节 炙 膈

如人喉中有痰如炙肉，吐之不出，吞之不下，古称为“炙膈”，又称“梅核气”。此病虽男女皆有，但以妇女居多。

【病因病机】 本病的病因在于痰气互结。正如尤在泾所说：“凝痰结气，阻塞嗝咽是也。”但凝痰结气，又多与情志有关。如《千金方》说：“内伤七情，外伤于寒所致。”总之，是由于七情郁结，痰气交阻，胃失和降而成本病。

【辨证施治】 本病由于有“吐之不出，吞之不下”的突出特点，诊断并非困难，但应排除器质性病变，然后辨证用药。

（一）痰气郁结：

1. 临床表现：自觉咽中有物梗塞，吐之不出，咽之不下，咽空及咽唾时始显，饮水吃饭咽下如常。每因情志不畅加剧。或胸闷不舒，或伴呕恶。舌淡，苔白腻，脉滑兼弦

2.主证分析：由于情志不舒，肝气郁结，以致脾失健运，郁而生痰，痰气阻喉，故自觉有物梗阻而吐之不出；气机不畅，则胸闷不舒；痰湿中阻，故呕恶泛啰。因无器质性病变，故不碍饮食下咽。苔白腻，脉弦滑，为气郁痰结之征。

3.治疗法则：行气降逆，化痰散结。

4.处方用药：半夏厚朴汤（《金匱要略》）加味。

半夏、茯苓、制香附、海浮石、桔梗各9克，陈皮、厚朴、生姜各6克，苏叶3克。水煎2次分服。

按：本方是半夏朴汤加香附、浮石、陈皮、桔梗。

方中用半夏化痰开结，下气降逆为主；辅以厚朴、生姜辛开苦降，散满调中；佐海浮石软坚化痰；香附、苏叶、陈皮芳香宣通，解郁和胃；使桔梗开肺气利咽喉。合用而有辛以散结，苦以降逆，咸以软坚，化痰下气之效。

（二）阴虚痰郁：

1.临床表现：自觉咽中有物梗塞，吐之不出，咽之不下，口燥咽干，或咽中隐痛，时有烦躁，或肌热易饥。舌红无苔，脉弦细而稍数。

2.主证分析：素体阴虚，肝气郁结，气郁化火，灼液为痰，痰火交阻，故咽中有物梗塞，或时有隐痛；痰火上炎，消灼肺胃阴液，故口燥咽干，肠热易饥。舌红无苔，脉弦细稍数，乃阴火亏虚上炎之征。

3.治疗法则：滋阴生津，化痰解郁。

4.处方用药：沙参麦门冬汤（《温病条辨》）加味。

北沙参、麦门冬、玉竹、海浮石、竹茹各12克，桔楼仁、天花粉、苦桔梗、桑叶、生扁豆各9克，薄荷6克，生甘草3克。水煎2次分服。

按：本方是沙参麦门冬汤加浮石、楼仁、竹茹、桔梗、薄荷。

方中沙参、麦冬、玉竹、花粉大队清热润燥，以滋养肺胃阴液；海浮石、竹茹、楼仁清热涤痰，宽中开郁，软坚散结；桔梗开宣肺气，疏利咽喉；薄荷芳香轻散，疏肝解郁，升清理气；扁豆、甘草益气和胃，且防甘润之过腻；桑叶疏达肺络，轻宣燥热。合而成方，具有养阴润燥，软坚涤痰，解郁利咽之功。

第八节 阴 冷

妇人阴中及少腹寒冷，性欲淡漠，称为“阴冷”。现代医学称为“性感异常”。

【病因病机】 本病的主要原因，是肾阳虚衰，不能温煦下焦，又复感受风冷所致。《妇人良方》说：“妇人阴冷，因劳伤子脏，风冷客之也。”薛立斋说：“阴冷属肝有湿热，外乘风冷所致。”

【辨证施治】 本病的治疗，以补肾助阳为主，兼脾阳虚者，佐以温中益脾。

（一）临床表现：阴中及少腹寒冷，性欲淡漠，婚久不孕，神疲健忘，甚至脊背寒冷，身面浮肿，大便泄泻，腹胀食少

等。舌淡苔薄，脉沉迟微弱。妇科检查：往往生殖器官发育欠佳。

(二)主证分析：劳伤肾气，或久病不愈，致下元亏损，命门火衰，不能温煦，则畏寒怕冷；肾属下焦，而主二阴，故阴中及少腹寒冷；肾阳不振，兴奋无源，故性欲淡漠，婚久不孕；肾主骨，腰为肾之府，肾虚则腰酸膝软；肾主髓，脑为髓之海，髓海不足，则神疲健忘；肾主水，肾阳虚不能温化水液，则水邪泛滥而为身面浮肿；肾阳虚不温暖脾土，则肾虚脾衰，故大便溏泻，完谷不化，腹胀食少。舌淡苔薄，脉沉迟微弱，均为肾阳虚衰之象。

(三)治疗法则：温补肾阳。

(四)处方用药：石英温肾汤（本院经验方）。

紫石英30克，熟地18克，炒白芍15克，女贞子、菟丝子各12克，巴戟肉、淫羊藿、当归、艾叶各9克，熟附子、肉桂各6克。水煎2次分服。

方中紫石英性甘温而润养，能温肾养肝，并能通奇脉，强心力，向为宫冷不孕之主药，实验证明，本品能兴奋卵巢之内分泌，对于性欲低下而不孕者为习用之品；熟地、山药、女贞滋肾补阴，使阴生阳长；菟丝子既能补阳，又能补阴，温而不燥，补而不滞，为平补肝、脾、肾良药，且有益精止泻之功；淫羊藿、巴戟肉补肾壮阳，祛风除湿；附子、肉桂温肾散寒，助阳行水；当归以养血，艾叶以暖宫。诸药合用，具有益阴壮阳，温宫除寒之效。

兼便溏泄泻者，再加肉豆蔻，补骨脂9克，以温脾止泻。

第九节 阴 吹

“阴吹”一证，出自《金匱要略·妇人杂证并治》篇。是指妇女阴道有气排出，并带有响声的一种病患。多见于40岁以上之经产体弱者，青少年女子极为罕见。

【病因病机】 前人对本病病因病机的认识尚不一致。如《金匱要略》说：“胃气下泄，阴吹而正喧。此谷气之实也，枳实发煎导之。”《金匱心典》中解说：“阴吹，阴中出声如人便失气之状，连络不绝，故曰正喧。谷气实者，大便结而不通，是以阳明下行之气，不得从其故道，乃别走旁窍也。枳实发煎润导大肠，便通气自归矣。”而肖庚六在《妇科经纶》中提出不同的看法：“按妇人阴吹证，仲景以为谷气实，胃气下泄所致，此病之机，有不可解……夫人谷气，胃中何尝一日不实，而见阴吹之证者？未之尝闻，千百年之书其阙疑可也。”但据临床所见，大便干结不通而阴中出气者确有其例，而因气血大虚中气下陷者为例更多。析其机理并非是后阴之气从前阴而出，而是多产之妇，气血大虚，中气下陷，身体瘦弱，致使阴道松弛，气体易进入阴道穹窿部（尤其在收腹时，阴道穹窿部形成负压，空气更易进入），当腹压再增加时，气体即从阴道排出，且有声响可闻。

【辨证施治】 对阴吹之证，首应辨其是阴道真出气抑是假出气。真出气者，不仅患者有所感觉，而他人亦可察闻，

，似出气者，仅患者自觉前阴出气，而他人则不能察觉，此多见于神经官能症者。在阴道真出气患者中，尤应排除器质性病变，如先天性前庭肛门和后天直肠阴道瘘都有典型的前阴出气，但这不属于阴吹的范围。

（一）中气下陷阴吹：

1. 临床表现：有多产、难产或产后劳力过早史。阴道时有气排出，且声响可闻，小腹下坠，四肢乏力，少气懒言。舌苔薄白，脉虚细。妇科检查：阴道壁松弛，或会阴陈旧性裂伤。

2. 治法法则：补中益气，升阳举陷。

3. 处方用药：补中益气汤（《脾胃论》）加味。

炙黄芪、党参各30克，当归、炒白术、炒枳壳、升麻各9克，陈皮、木香、柴胡、炙甘草各6克。水煎2次分服。

按：本方是补中益气汤加枳壳、木香。

补中益气汤是健脾益气，升阳举陷的常用方。加枳壳、木香者，因其均能调整肠道气机。现经证明该2味均能促使平滑肌收缩，以增强盆底组织及阴道的肌张力。

（二）气血两虚阴吹：

1. 临床表现：有产育过多、过频或产后大失血史。阴道出气有声可闻，面色苍白或萎黄，头晕目眩，心悸怔忡，神倦懒言。舌质淡，脉细虚无力。妇科检查同上。

2. 治法法则：大补气血。

3. 处方用药：十全大补汤（《和剂局方》）加味。

党参、黄芪各30克，熟地15克，白术12克，白芍、当归、

茯苓各9克，川芎、肉桂、炙甘草、生姜各6克，大枣4¹枚，升麻、柴胡各6克。水煎2次分服。

按：本方是十全大补汤加柴胡、升麻。

十全大补汤是养血补气之峻剂，加柴胡、升麻2味以增强升提举陷之力。

（三）阴虚便秘阴吹：

1. 临床表现：大便燥结，数日一解，排便艰难。前阴出气，出气之多少，往往与便秘之程度有关，常伴有五心烦热，或午后潮热，口干尿黄。舌红或绛，少苔或无苔，脉沉实。

2. 治疗法则：润肠通便。

3. 处方用药：当归苁蓉润肠汤（编者方）。

当归12克，肉苁蓉30克，火麻仁、柏子仁、郁李仁、苦杏仁各9克，生大黄、升麻各6克。水煎2次分服。

方中苁蓉、当归益肾补血，润肠通便；杏仁、麻仁、柏仁、郁李仁皆多脂润导之品，通便而不损正；大黄泻热通便，以挟内热随便排出；欲降之必升之，故佐升麻以升降气机，俾结便顺利泻下。

【简易方】 蜂蜜30克，香油6克。日1次，清晨空腹，开水冲服。

第十节 外阴瘙痒

妇女外阴部瘙痒，甚则痒痛难忍，有时波及肛门周围，或时出黄水，坐卧不安，称为“外阴瘙痒”，古称“阴虱”。

虽滴虫性阴道炎、霉菌性阴道炎、老年性阴道炎、外阴白斑、外阴干枯症等均可引起外阴瘙痒，但这些病证仍然不能代替外阴瘙痒症，因为糖尿病、黄疸、甲状腺机能紊乱、卵巢功能低下、贫血、白血病、营养不良、慢性药物中毒、过敏反应以及精神因素等，也可引起外阴瘙痒症状。故本病仍应另立章节予以论述。

【病因病机】本病的发生，多由脾虚湿盛，郁久化热，湿热蕴结，注于下焦；或忧思愤怒，肝郁生热，挟湿下注，湿热生虫，而致阴痒。或年老体弱，肝肾阴虚，精血亏耗，血虚生风化燥，而致外阴干涩作痒。

【辨证施治】严格地说，外阴瘙痒是一个症状，多种疾病均可引起。如滴虫性阴道炎、霉菌性阴道炎、老年性阴道炎、外阴白斑等，其治疗方法，均分别见于各有关章节。如未能查明是属何病，应根据临床表现辨证施治，可内服外用两法并举；若仅有外阴作痒而无全身症状者，可单用外治法。

（一）湿热下注阴痒：

1.临床表现：外阴瘙痒难忍，带下量多而腥臭，外阴湿润，或局部有渗出物；胸闷不舒，心烦纳少，口苦而粘。舌质红，苔黄而腻，脉滑数。

2.主证分析：脾虚湿盛，肝经郁热，致湿热下注，则外阴瘙痒，带下量多而腥臭，湿热蕴结于内，阻滞中焦，故胸闷不舒，胃呆纳少；湿热上蒸，故口苦而粘；痒甚难忍则心烦。舌红，苔黄腻，脉滑数，均为湿热内蕴之征。

3. 治疗法则：清热利湿，解毒止痒。

4. 处方用药：萆薢渗湿汤（《疡科心得集》）加味。

萆薢、白藓皮、滑石各15克，生薏仁30克，制苍术、黄柏、知母、赤苓、泽泻、丹皮、苦参、通草各9克。水煎2次分服。

按：本方是萆薢渗湿汤加苍术、知母、白藓皮、苦参。

方中薏仁、苍术健脾燥湿；知母、黄柏清下焦湿热；丹皮凉血化瘀；赤苓、泽泻、滑石、通草渗湿利水，使湿热之邪从小便排出；白藓皮、苦参祛湿止痒，杀虫解毒。

若外阴瘙痒，伴有心烦易怒，胁痛潮热，口苦而干，舌红，苔黄，脉弦数，为肝经湿热之证。可用龙胆泻肝汤（见赤带）。

（二）肝肾阴虚阴痒：

1. 临床表现：外阴干涩瘙痒难忍，或有灼热感，甚则五心烦热，头晕目眩，腰酸耳鸣，口干便秘。舌红少苔，脉象细数。

2. 主证分析：肝藏血，肾藏精，肝肾阴虚，精亏血少，血虚生风化燥，故外阴干涩灼热而痒。阴虚则内热生，故五心烦热；肝血虚，清窍失养，故目眩；肾精亏，髓海不足，故脑转耳鸣；腰为肾之府，肾虚则腰酸；阴虚津亏，故口干便秘。舌红少苔，脉细数，皆为阴虚内热之象。

3. 治疗法则：滋阴泻火，祛风止痒。

4. 处方用药：知柏地黄汤（《医宗金鉴》）加味。

生地黄18克，炒山药12克，山萸肉、丹皮、茯苓、当归、

知母、黄柏、泽泻各9克，大胡麻（又名壁虱胡麻）、生首乌各15克。水煎2次分服。

按：本方是知柏地黄汤加大胡麻、生首乌、当归。

方中知母、黄柏滋阴泻火；山药、山茱萸滋补肝肾；茯苓、泽泻利湿清热；生地、丹皮滋阴凉血；当归、大胡麻、生首乌养血祛风止痒，并能润燥通便。

如无大胡麻，可用黑芝麻30克代之。

【外洗方】

（一）蛇床子散（上海中医学院）。

蛇床子、川椒、白矾、苦参、百部各10~15克。煎汤先熏后坐浴，日1次，10次为一疗程。若阴痒破溃者则去川椒。

（二）搗痒汤（《疡医大全》）。

鹤虱30克，苦参、威灵仙、归尾，蛇床子、狼毒各15克。煎汤熏洗，日1次，10次为一疗程，如外阴并发溃疡者忌用。

（三）止痒方（编者方）。

白花蛇舌草30克，苦参、蛇床子、土茯苓、白藓皮各12克，川椒、石榴皮各9克，冰片1.5克（冲兑）。煎汤熏洗，日1次，10次为一疗程。

【外搽方】

（一）蛤粉3克，冰片0.3克。共研细末，涂撒于外阴患部，或用香油调涂。日1~2次。

（二）珍珠散（辽宁中医学院）。

珍珠、青岱、雄黄各3克，黄柏9克，儿茶6克，冰片0.3克。共研细末，外擦患处。日1~2次。

【针刺法】取穴太冲、阴陵泉、百虫窝、阿是穴。用提插手法。

也可在无名指侧中节横纹血管处放血，能止痒数小时，可连续针刺几次。

第十一节 外 阴 炎

外阴部皮肤或粘膜发炎称为“外阴炎”。相当于祖国医学之“阴痒”、“阴蚀”。由于解剖的特点，外阴部与尿道、阴道、肛门邻近，行动时受摩擦的机会多，故外阴部皮肤粘膜为炎症的好发部位。

【病因病机】总的病因为湿热之邪流注下焦所致。以现代医学的观点看来，其病因有三：①阴道分泌物的刺激；②糖尿病患者的糖尿、尿痿患者的尿液、粪痿患者的粪便及肠道烧虫等各种因素的刺激；③葡萄球菌、链球菌和大肠杆菌等混合性感染。

【辨证施治】

（一）临床表现：急性期外阴红肿、疼痛，或瘙痒难忍，或灼热，有的形成湿疹、疱疹或溃疡。严重者腹股沟淋巴结肿大，体温稍高，白细胞总数及中性均增多。舌红、苔黄，脉滑数。慢性炎症红肿消失，皮肤粘膜增厚粗糙，呈苔藓化，症状以痒为主。

(二) 治疗法则：清热利湿，解毒止痒。

(三) 处方用药：藜皮除湿解毒汤（编者方）

白藜皮15克，土茯苓、金银花各30克，鱼腥草24克，黄柏、泽泻、篇蓄、瞿麦各9克，木通、生甘草各4.5克。水煎2次分服。

方中白藜皮、土茯苓、鱼腥草、金银花清热祛湿，解毒止痒；黄柏、泽泻、木通、篇蓄、瞿麦清热利水，使湿随小便排出；生甘草泻火解毒，调和诸药。

【外治方】

(一) 外阴炎洗剂：苦参、蛇床子、川椒各15克，黄柏、明矾各9克，食盐3克。煎汤熏洗外阴部，每晚1次。

(二) 外阴炎粉剂：适用于外阴红肿，分泌物多者。

青黛15克，滑石30克，冰片3克。共研细末，外搽患处（或水调外敷）。日2次。

(三) 外阴炎膏Ⅰ号：适用于外阴发红，湿疹而无溃疡者。

煅蛤粉、樟丹各6克，冰片1.2克。共为细末，用香油调成稀膏。用时先洗净外阴，将药膏涂于患处，纱布敷盖，日1～3次。

(四) 外阴炎膏Ⅱ号：适用于外阴有溃疡者。

雄黄、樟丹各6克，冰片1.2克，制乳香、制没药各3克。共为细末，香油调膏。用法如上。

(五) 外阴炎膏Ⅲ号：适用于过敏性外阴炎。

黄柏30克，生石膏15克，冰片3克。共研细末，香油调

白。用法同上。

第十二节 外阴白斑

外阴白斑病，系指妇女外阴部的局限性或弥散性白色病变。发病过程一般分为两个阶段：第一阶段是组织增生肥大；第二阶段为组织萎缩。外阴白斑与外阴癌有密切关系，约有半数的外阴癌系起自外阴白斑病。为避免外阴癌的发生，在发现并确诊为外阴白斑病之后，必须积极予以治疗。

【病因病机】本病的发病机理至今尚不明确。根据其临床表现，以外阴瘙痒为主，其病因病机应属血燥生风之类。

【辨证施治】本病除有典型的症状、体征外，结合病理切片检查，诊断并不困难。其治疗方法，以内服药、外用药、针灸等综合治疗较好，而外用药则更为重要。

（一）临床表现：早期阴部多现红肿，以后皮肤变厚、变白、变干、并发生裂纹，此时患者多感外阴部瘙痒或疼痛，有时因搔抓而继发皮炎。白斑严重时亦可蔓延至会阴部及肛门周围。常伴有肝肾阴虚征象。

（二）治疗法则：滋补肝肾，祛风止痒。

（三）处方用药：养阴润燥祛风汤（编者方）。

生首乌、熟地各15克，当归、白芍、女贞、旱莲草、丹皮各9克，黑芝麻、黑大豆各30克，白藓皮12克，防风6克，生甘草3克。水煎2次分服。

方中熟地、当归、白芍补肝养血；女贞子、旱莲草、丹

皮滋肾养肝，清热凉血；生首乌、白藓皮、防风养血祛风止痒；芝麻、黑豆、甘草滋肝肾，疗风毒。

若外阴感染，湿热浸淫而痒痛者，可用龙胆泻肝汤（见赤带）。

【外治方】

（一）野菊花30克，荆芥、防风、透骨草各15克。煎汤熏洗患处。日1次。

（二）淫羊藿、鹿含草各30克，蝉蜕9克。煎汤熏洗患处。日1次。

若外阴有炎症者，上两方可各加入银花30克，蒲公英15克。

（三）白矾、雄黄、补骨脂各3克，冰片0.6克。共为细面，用70%酒精100毫升浸泡后涂于患处，日1次。

（四）生石膏、煅蛤粉各30克，冰片3克。共为细面，香油适量，调膏外敷。日3次。

（五）“七〇七”（妊娠尿）2毫升，肌注，日1次，7天为一疗程，7天后停药3天，再开始肌注。

妊娠尿收集法：消毒外阴后，用无菌瓶接孕妇尿于瓶内（最好是导尿），送化验室作细菌培养，若无细菌生长，则可应用。

【针刺法】取穴太溪、蠡沟、太冲、三阴交、百虫窝、曲骨、会阴阿是穴（一般于阴阜及大阴唇取2~3穴，斜刺），可交替选用。

第十三节 阴 道 炎

健康妇女，阴道本身有自净作用，形成自然防御功能。如青春期后，由于雌激素的影响，阴道上皮由单层变为复层，上皮细胞含有糖原，细胞脱落后破坏并放出糖原，借阴道杆菌作用将糖原转化为乳酸，使阴道变成酸性（pH值4~4.5之间），即能抑制其他细菌生长。若上述防御功能被破坏，病原菌侵入后，便可导致阴道炎症。阴道炎症中最常见的是老年性阴道炎和滴虫、霉菌性阴道炎。

老年性阴道炎

因老年（一般在绝经后）阴道抵抗力降低而引起的阴道炎症，称为“老年性阴道炎”。

【病因病机】妇女绝经后，由于肾气衰、天癸竭、卵巢功能衰退，雌激素缺乏，生殖器官萎缩，阴道上皮变薄，血运减少，阴道粘膜失去了自然防御能力，细菌易乘机侵入，引起阴道炎症。

【辨证施治】老年性阴道炎不仅多发生于自然绝经后，亦可发生于人工绝经后（如双侧卵巢切除后）或哺乳过久的妇女。

（一）临床表现：自觉阴道有烧灼感，下腹疼痛，小便时外阴和阴道刺激，其带下有时呈水样或呈血性粘液状，若混合感染则呈脓性。窥器检查，阴道壁及宫颈粘膜发红，轻

度水肿，触痛，并有散在点状或大小不等的片状出血斑。

（二）治疗法则：滋肾益脾，清热解毒。

（三）处方用药：滋肾凉血解毒汤（编者方）。

熟地、生地、炒山药、枸杞子、女贞子、旱莲草、地榆炭各12克，土茯苓30克。水煎2次分服。

方中熟地、枸杞、女贞、白芍滋肾养阴，山药、白术健脾益气；生地、旱莲、地榆益阴凉血，止血化瘀；土茯苓祛湿解毒。

【外治方】

（一）阴道炎洗剂：苦参、蛇床子各15克，黄柏9克。水煎熏洗，日1～2次。或将以上药液用纱布过滤后冰洗阴道。日1次。

（二）黄连膏坐药：黄连、黄柏、片姜黄各4.5克，归尾7.5克，生地18克，香油180克，黄蜡45克。以香油浸药2日，文火熬枯去渣，再煎入蜡成膏。以带线消毒之棉栓，蘸匀黄连膏，纳入阴道内，隔日换药1次。

（三）阴道炎粉剂：先用5%的醋酸，或用100毫升食醋加水500毫升，坐浴或冲洗阴道。然后将呋喃西林片（100毫克）及乙萘酚0.5毫克制成粉剂，喷入阴道内，每晚1次，7天为一疗程。

滴虫、霉菌性阴道炎

因滴虫或霉菌引起的阴道炎症，称为“滴虫、霉菌性阴道炎。”

【病因病机】《妇人良方》曰：“妇人阴痒，为三虫在肠胃之间，因脏虚而蚀阴中，微则为痒，甚则为痛也。”说明了脏气虚身体抵抗力降低时易患此病。事实证明，卵巢功能降低时阴道内酸度下降，阴道粘膜的厚度及糖原代谢直接受到影响，始有利于滴虫的生存。维生素缺乏、糖尿病和其他消耗性疾病，均可使念珠菌生长繁殖。另外，因细菌感染而大量使用抗菌素和肾上腺皮质激素后，也易发霉菌性阴道炎。男方的传染，也是本病的因素之一。

【辨证施治】

（一）临床表现：二者均有阴痒、带下、小便短赤及外阴刺激症状。其带下则有明显不同：滴虫性带下为黄绿色，量多稀薄，呈泡沫状或米泔样，有特殊腥味，镜检可见滴虫；霉菌性带下呈乳白色块状，如豆腐渣样，镜检可见霉菌。滴虫性阴道炎的阴道及宫颈粘膜红肿，常有散在的出血点或草莓状突起。霉菌性阴道炎的阴道粘膜呈中等度发红、水肿，有的伴有剧痒及烧灼感，严重者粘膜糜烂或形成溃疡。

（二）治疗法则：清热祛湿，杀虫解毒止痒。

（三）处方用药：三妙散（《医学正传》）加味。

制苍术、黄柏、苦参、蛇床子各9克，川牛膝、车前子各12克，鱼腥草、土茯苓各30克。水煎2次分服。

本方是三妙散加苦参、车前、鱼腥草、土茯苓、蛇床子。

方中苍术、黄柏、苦参清热燥湿；蛇床子温化辛散，杀虫止痒；鱼腥草、土茯苓利湿解毒；牛膝、车前子通利小便，使湿热毒邪从小便排出。

【外用方】

(一) 痒散：适用于霉菌及滴虫性阴道炎。

五倍子(焙)120克，蛇床子(炒)、生黄柏各30克，冰片1.5克。共研细末。每晚用淡盐水(或1/5000的高锰酸钾溶液)洗净阴道后，将药末0.6克深抹于阴道内，日1次，连用5次，症状即可消失。为预防复发，隔半月或1月后再用3次。

(二) 雄蛇丸：适用于滴虫性阴道炎。

雄黄3克，蛇床子9克。研细末，蜜为丸，每丸3克重。纱布包好，留线半尺，纳阴道内。晚睡时用，晨起后取出。连用5天。不愈者再用一疗程。

(三) 治阴道滴虫方。

苦参、白头翁、蛇床子各12克，川椒、黄柏各9克，食盐3克。煎汤熏洗外阴部；每晚1次。并治外阴瘙痒。

(四) 蛇床苦参煎：适用于霉菌性阴道炎。

蛇床子、苦参、黄柏、川椒、木槿皮各15克，艾叶、小蓟各9克。水煎熏洗外阴部。每晚1次，连用5天为一疗程。

(五) 五倍煎：适用于霉菌性阴道炎。

五倍子15克。水煎后冲洗阴道，日1次，连用3天为一疗程。

(六) 冰硼油：适用于霉菌性阴道炎。

冰硼散1小瓶加入甘油少许搅匀，清洗外阴部后涂于外阴及阴道，早晚各1次。

【预防】

(一) 加强身体锻炼，增强抵抗能力；注意个人卫生，保持外阴清洁，不用患者浴盆，以减少传染的机会。

(二) 男方感染此病时，在治疗期间，要避免性交。夫妇同时治疗。

第十四节 阴 疮

妇女前阴部忽然发生肿痛，继而化脓、溃破的疾患，称为“阴疮”。

【病因病机】由于七情郁火，损伤肝脾，二经湿热下注，或阴部破损，感染毒邪，以致气血凝滞而成。

【辨证施治】本病在发生和发展的过程中，可分初肿期、酿脓期、溃后期三个阶段。初起局部肿胀疼痛，消退不易，约3～5天便欲成脓；溃后约经5～7天即可收口而愈，但也有经常反复出脓者。在治疗上，初期宜清肝火，泻湿热；酿脓期宜通二便，除内热。溃后一般不需内治，如久溃不敛，亦可出现气血两亏现象。气虚者宜健脾宣气；血虚者宜补肝养血；气血双虚者宜气血双补。

【内治法】

(一) 阴疮初肿期：

1. 临床表现：初起阴户一侧或两侧忽然肿胀疼痛（一侧者多见），行动艰难，继则结肿处高起，形如蚕茧，消退不易（可伴发腹股沟淋巴结肿大），身发寒热，口干纳少，大便

秘结，小便涩滞。舌苔黄腻，脉滑数。

2. 治疗法则：清肝火，利湿热。

3. 处方用药：龙胆泻肝汤（见赤带）加大黄。

用本方清热泻火，利湿解毒，乃治病求本之法。以期达到湿热泻除，毒邪解去，肿块消散，免致化腐成脓之目的。

（二）阴疮酿脓期：

1. 临床表现：初期失治，或消之无效，8～5天便可化脓，形成脓肿时肿块可达鸡蛋大小，肿块剧烈疼痛，触痛明显，有波动感；壮热烦渴，腹胀便秘。苔黄腻或黄糙，脉沉数有力。

2. 治疗法则：通便除热，解毒消肿，散结溃脓。

3. 处方用药：内疏黄连汤（《医宗金鉴》）加味。

黄连、木香、薄荷、生甘草各6克，山梔、黄芩、炒白芍、当归、槟榔、桔梗、生大黄各9克，连翘、皂角刺各12克。水煎2次分服。

按：本方是内疏黄连汤加皂刺。

方中黄连、黄芩、梔子清热燥湿，泻火解毒；槟榔、大黄化滞通便，使热毒从大便排解；连翘清热散结；桔梗宣畅气机，木香、薄荷辛香疏散，以防毒邪之壅滞；皂刺托毒消肿，溃坚排脓；生甘草泻火解毒，并调和诸药。综合全方具有泻火散结，除湿解毒，利水通便，攻坚排脓之功。

若内脓已成，不易外溃，透脓迟缓者，宜透脓托毒，清热消肿。用程氏透脓散（《医学心悟》）。

生黄芪18克，当归12克，山甲珠、皂角刺、白芷、牛蒡

子各9克，银花15克，川芎6克，黄酒30毫升（冲兑）。水煎2次分服。

疮痈虽已成脓，由于气血不足，无力排脓外出，故疮面不易溃破，治宜益气溃坚排脓。方中黄芪一味，生用能益气托毒排脓，炙用则只能补气，无托毒之力，且反有助火益毒之弊，故方中黄芪必须生用，即便是生用，此时也不宜过用大量，过量同样可以助火；辅以当归、川芎养血活血，山甲、皂刺消散透透，软坚穿溃，白芷消肿排脓，牛蒡子宣透散结，银花清热解毒，黄酒通经行瘀，以助药势。合用以奏托毒溃脓之功。

脓由气血不调，郁热腐化而成，因此，疮痈等症出脓，可使邪毒随脓外泄，它和伤寒表证从汗解，腑证从下解，有着相同之道理。倘若正气不足，不但不能托毒化脓，而且有脓亦不能溃溃，即用刀针决之，溃后脓亦清稀，流而不畅，仍用托里之剂，方得脓稠出畅。所以凡是痈疮脓毒存脓成不易外溃，或不能化毒成脓，消之不可，开刀又不适宜的情况下，运用本方，最为确当。

（三）阴疮溃后期：

1. 临床表现：脓肿溃后，脓多臭秽而稠，肿块既已化腐出脓，则肿退痛止，全身症状亦可随之消失。

2. 治疗法则：一般只宜外治，不需内治，如表现气血亏而疮口久不收斂者，应补气养血。

3. 处方用药：

（1）气虚者，宜补气，用四君子汤（《和剂局方》）。

党参24克，炒白术12克，茯苓15克；炙甘草6克。水煎服。

本方是治脾胃虚弱，中气不足的主方。由于脾胃气虚，则运化失常，因而不能化生精微，以助溃疡之收敛。故方中用党参补中益气，扶脾养胃；白术健脾燥湿，以资运化；茯苓渗湿，辅白术以强脾；甘草和胃，佐党参以益气。四药合用，则有补气健脾的强壮作用。气壮则疮口易敛。

（2）血虚者，宜补血，用四物汤（《和剂局方》）。

熟地18克，当归15克，炒白芍9克，川芎6克。水煎服。

本方是补血兼能活血的方剂，也就是治疗血虚的基础方。方中熟地滋阴补血；当归养血和血，二药重在补血，为主药；白芍柔肝养血，川芎行气活血，为辅药。综合四药作用，地、芍是血中之血药，归、芎是血中之气药，两相配合，可使补而不滞，营血调和。本方具有养血、活血、行气的作用。故血虚之疮口不敛，用之收敛而不留瘀。

（3）气血两虚者，宜气血双补，用八珍汤（《正体类要》）

熟地18克，党参24克，当归、芍药、茯苓、白术各12克，川芎、炙甘草各6克，生姜3片，大枣4枚（劈）。水煎2次分服。

本方是四君子汤合四物汤的复方。四君健脾补气，四物滋阴补血，是气血双补的常用方。阴阳气血是互相为用的。在病机的变化上，往往是血随气虚，也就是“阳损及阴”，但也可

气随血虚，这就是“阴损及阳”。本方气血双补，阴阳兼顾，能使阳生阴长，气运血生。至于痈疮之难溃、难敛者，多属气血两虚所致，故对疮口久不收敛之症，本方最多使用。

【外治方】

（一）初肿期：

1. 金黄散（《医宗金鉴》）。

生大黄、黄柏、色姜黄、白芷各10克，南星、陈皮、苍术、厚朴、甘草各4克，天花粉24克。共研细末。

功用：清热除湿，散瘀解毒，止痛消肿。治一切阳证。

用法：可用葱、酒、香油调敛。

亦可用金黄油膏（凡士林4/5，金黄散1/5，调匀成膏）外涂患处。

2. 玉露散（经验方）。

芙蓉叶，研成极细末。

功用：凉血、清热、退肿。治一切阳证。

用法：可用香油或凡士林调涂患处。

亦可用玉露油膏（凡士林4/5，玉露散1/5，调匀成膏）外涂患处。

（二）脓成期：脓成后不能自溃，或服透脓散不效者，宜切开引流排脓。

（三）溃后期：

1. 初溃：宜提毒祛腐。

（1）二宝丹（经验方）。

煨石膏 8 克，红升丹 2 克。共研细末。

功用：排脓提毒。治一切溃疡、脓流不畅、腐肉不化。

用法：将药粉掺入疮口中，或粘敷于药线上，插入疮口中。外盖膏药或药膏，每日换药 1 次。

（2）九一丹（《医宗金鉴》）。

煨石膏 9 克，红升丹 1 克。共研极细末。

功用、用法均同上。

2. 收口：宜生肌收敛。

（1）生肌散（经验方）。

炙象皮、煨龙骨、赤石脂、血竭、制乳香、制没药、儿茶各 30 克，冰片 10 克。共研细末，瓶装备用。

功用：祛腐生肌。治疮疡溃后，久不收口。

用法：撒敷疮面，外以生肌玉红膏盖敷包扎。每日换药 1 次。

（2）生肌玉红膏（《外科正宗》）。

当归 60 克，白芷 15 克，轻粉、血竭各 12 克，紫草 6 克，生甘草 36 克，白蜡 60 克，香油 500 克。

制法：先将当归、白芷、紫草、甘草，入油内浸 3 日，置锅内慢火熬药微枯，过滤去渣，将油复入锅内煎滚开，入血竭化尽，次入白蜡，微火化开。用茶杯 4 个，预放凉水中，将膏分作 4 分，倾入杯内，候片时，放入轻粉，每杯 3 克，搅匀即成。

功用：活血祛腐，解毒止痛，润肤生肌。治痈疮疔肿、烫伤溃烂等。

用法：将膏匀涂纱布上，敷贴患处，并依溃瘍局部情况，可掺生肌散于膏上同用，效果更佳。

3. 脓流不畅：如疮口过小，脓腔过大，宜采取扩创手术。

【护理】

- (一) 外敷膏药宜紧贴患处，掺药粉宜散布均匀。
- (二) 疮口周围皮肤应经常保持清洁，以免并发湿疹。
- (三) 高热时应卧床休息，减少活动，并多饮开水。

第十五节 盆 腔 炎

盆腔炎是指妇女盆腔器官发生的炎性病变，包括子宫内膜炎、输卵管炎、卵巢炎、盆腔腹膜炎及盆腔结缔组织炎等。此种疾病可局限于某一部分或几个部分同时发炎。

祖国医学中没有盆腔炎病名的记载，但根据其临床表现，可概括于“热入血室”、“带下病”、“妇女症瘕”、“经水不调”、“经行腹痛”、“不孕”等病之中。如《妇人良方》载：“妇人月经痞塞不通，或产后余秽未尽，因而乘风取凉，为风冷所乘，血得冷则为瘀血也。瘀血在内，则时时体热面黄。瘀久不消，则为积聚症瘕矣。”这段话即描述了盆腔炎的病因、症状以及炎块的形成。所以尽管祖国医学中没有盆腔炎病名的记载，但用中药治疗盆腔炎时，只要根据其临床表现，进行辨证施治，就能取得良好的治疗效果。

盆腔炎是妇科常见的疾病，有急性、慢性与结核性三种。急慢性者，多发于已婚妇女；结核性者，以未婚或原发性不孕妇女较多见。

急性盆腔炎

【病因病机】本病的发生，由于经行、产后胞脉空虚，或平时体质虚弱，房室不节，邪毒内侵客于胞中而致病。

现代医学认为，在经期、产后（包括流产），身体虚弱之时，或手术消毒不严，各种致病菌经生殖器官上行感染而致病，或由于其他器官感染，经血行播散或淋巴系统蔓延至生殖器官而致病。炎症不能控制时，则可形成脓肿、包块。

【辨证施治】急性盆腔炎的主证基本一致，至于兼证之不同，在治疗用药时可随证化裁。

（一）临床表现：起病较急，恶寒发热（体温升高）。口干欲饮，下腹痛而拒按，阴道分泌物增多，呈血性或脓性或水样白带，且有秽臭，大便干结，小便短赤。舌质红，苔黄或腻，脉弦数或滑数。妇科检查：阴道充血，宫颈有抬举痛，子宫体及附件有触痛，附件区可摸到增厚或包块，白细胞总数及中性均增高。

（二）主证分析：由于湿热邪毒侵入胞宫，与气血相搏，邪正交争，营卫不和，热毒壅盛，故发热恶寒；气滞血瘀，则腹胀痛而拒按；湿热下注，则白带增多而臭；大便干结，小便短赤，为热灼津液所致。舌质红，苔黄腻，脉滑数，为湿热内盛之征。

(三) 治疗法则：清热解毒，活血化瘀。

(四) 处方用药：银翘红酱解毒汤（上海中医学院方）。

银花、连翘、败酱、红藤30克，苡米、栀子、桃仁、赤芍各12克，丹皮、元胡、川楝子各9克，乳香、没药各4.5克。水煎2次分服。

方中银花、连翘、红藤、败酱清热解毒，抗菌消炎；桃仁、赤芍、丹皮、元胡、乳香、没药活血化瘀止痛；川楝子理气止痛；栀子清热利湿；苡米利湿消肿，排脓消痈。全方有清热解毒、活血化瘀、理气止痛之功。

若表证重，加荆芥、防风、白芷各9克；腹胀重加香附9克，木香、砂仁各6克；腹痛重，加生蒲黄、五灵脂各9克；白带多而秽臭者，加黄柏、茵陈、椿根皮各9克；有包块者，加三棱、莪术各9克，丹参30克；大便干结者，加大黄、元明粉各6克；若邪毒传入营分，出现神昏、抽搐等症者，同时加用安宫牛黄丸或紫雪丹。

慢性盆腔炎

慢性盆腔炎多由急性盆腔炎治疗不当迁延而来，但也有急性期并不明显，待发现时已属慢性者。

【病因病机】

(一) 湿热瘀结：由于经期、产后胞脉空虚，用纸不洁，或房室所伤，湿热之邪内侵，正不胜邪，或急性期治疗不当，余邪未尽，瘀积于胞中，致使脏腑功能失常，气机不

利，经络受阻而致病。

（二）寒凝气滞：由于经期、产后冒雨涉水，感受寒邪，或过食生冷，寒邪客于胞中，血为寒凝，瘀结不化，气机不畅而致病。

【辨证施治】

（一）湿热瘀结：

1.临床表现：低热起伏，下腹疼痛胀坠，腰骶酸痛，经期或劳累后加重；经期延长，或经血量多，白带增多，色黄秽臭；口干不欲饮，大便秘结或溏，小便黄短。舌质红，苔黄腻，脉弦数或濡数。妇科检查：子宫活动受限，附件区压痛，增厚或有包块。

2.主证分析：湿热瘀积，气血运行失常，气滞血瘀，则下腹疼痛胀坠；郁结日久不化，则成症瘕；气机不畅，冲任受损，则月经失调；湿热下注，则白带增多而秽臭。口干不欲饮，舌红苔黄腻，脉弦数，皆为湿热之象。

3.治疗法则：清热利湿，活血化瘀。

4.处方用药：清热解毒化瘀汤（编者方）

当归、赤芍、枳壳、香附、连翘、桃仁、莪术各9克，忍冬藤、生薏仁各15克，鱼腥草、土茯苓各24克，川芎、生甘草各6克。水煎2次分服。

方中当归、赤芍、川芎养血活血；桃仁、莪术破瘀行血；香附、枳壳理气止痛；薏仁利湿；忍冬、连翘、鱼腥草、土茯苓清热解毒利湿。

如下腹部疼痛严重者加元胡9克、乳香6克、没药6克。

如输卵管积水，可用化瘀导水汤（编者方）。

川芎 6 克，当归、牛膝、元胡、红花、桃仁、防己、香附各 9 克，木通、肉桂、甘草各 3 克。水煎 2 次分服。

方中当归、川芎、桃仁、红花活血化瘀；防己、木通、牛膝通络行水；香附理气，气行则水行；肉桂温通助阳，益增行水之力，并制木通、防己之苦寒，以防腹痛。

（二）寒凝气滞：

1. 临床表现：小腹胀痛、有冷感，得温则舒；腰骶酸痛，经期或劳动后加重；经行乳房胀痛，月经后期、量少有块；白带多而清稀。舌质淡，苔白腻，脉沉迟。妇科检查同上。

2. 主证分析：寒凝气滞，气滞血瘀，故腹痛乳胀，月经后期量少有块；寒为阴邪易伤阳气，故有冷感、喜温；寒湿内停，注于下焦，伤及任带，故白带多而清稀。舌质淡，苔白腻，脉沉迟，皆为寒湿之征。

3. 治疗法则：温经散寒，行气活血。

4. 处方用药：桂枝茯苓丸（《金匱要略》）加味。

桂枝、丹皮、赤芍、桃仁、香附各 9 克，茯苓 12 克，丹参 30 克。水煎 2 次分服。

方中桂枝温经散寒、通经脉；丹皮、桃仁、赤芍破血化瘀；茯苓渗湿下行，与桂枝同用，能入阴通阳。加香附、丹参以增强理气化瘀之功。

若腹痛有冷感，加小茴香 9 克，炮姜 6 克；痛重者加元胡、白芍各 9 克，甘草 6 克；胀重者加木香 6 克；有包块者

加二棱、莪术各9克。

按：有人认为炎症不宜用温药，其实不然，尤其慢性盆腔炎，往往用温药反而奏效捷快。以桂枝为例，因桂枝可以扩张血管，能改善局部血液循环，有利于炎症的消散吸收，且桂枝尚有镇静、镇痛及抑菌作用，故治疗慢性盆腔炎有寒象者效果良好。

结核性盆腔炎

结核性盆腔炎亦称盆腔结核，本病属祖国医学的“血枯经闭”、“虚癆”、“不孕”等的范畴。

【病因病机】癆虫所侵，气血不足，正气虚衰易患此病。凡忧思伤脾，产后正虚，劳倦过度，或早婚、多产、房室不节等，导致正气虚衰，均能诱发本病。

【辨证施治】

（一）临床表现：本病发展缓慢，病变隐伏，轻者往往不易发现。如病渐加重，则出现不孕，月经紊乱，或月经进行性减少，下腹坠痛，食欲不振，体倦无力，午后潮热，手脚心热。舌光无苔，脉细数。

（二）主证分析：癆虫（结核菌）侵入输卵管而成炎症，使卵管阻塞则不孕；脾胃亏虚，运化失职，水谷之精微不能输布全身而营养机体，故体倦无力；阴血不足，冲任亏损，故月经进行性减少，下腹坠痛，严重者则造成血枯经闭。午后潮热，手脚心热，舌光无苔，脉细数，均属阴虚内热之征。

(三) 治疗法则：滋阴清热，理气化瘀。

(四) 处方用药：

1. 偏阴虚者用六味地黄汤加三甲煎。

生地18克，山药、山茱萸各12克，茯苓、丹皮、泽泻各9克，生鳖甲、生龟板、生牡蛎各30克。水煎2次分服。

方中六味地黄汤滋肾阴，三甲煎育阴潜阳以清热。

2. 热轻虚实交杂者，用滋阴养血化瘀汤（经验方）。

北沙参15克，当归、山楂炭各12克，川断、怀牛膝、郁金、元胡、苦参、生蒲黄各9克。水煎2次分服。

方中沙参养阴，当归养血，川断、牛膝以强腰膝；元胡理气止痛；苦参燥湿杀虫；郁金、蒲黄、山楂炭活血化瘀。

如月经过少可加枸杞子、菟丝各12克，以补肝肾；有包块者，加肉桂3克，赤芍、三棱、莪术各9克。必要时可配合链霉素、异烟肼等抗结核药物，协助治疗，使其早愈。

【预防】

(一) 加强卫生宣传，提高健康水平，增强机体抵抗力。

(二) 大力推广新法接生，正确处理分娩，阴道手术时，严格执行无菌操作制度。

(三) 经期及产后，保持外阴部，会阴及月经纸的清洁，禁止性交及盆浴，以防感染。

(四) 急性盆腔炎如果治疗不当，往往转为慢性。因此，积极地治疗急性盆腔炎是预防慢性盆腔炎的关键。

第十六节 子宫颈糜烂

由于炎症分泌物的刺激，颈管外口粘膜的鳞状上皮细胞脱落，被增生的柱状上皮所覆盖，其表面颜色鲜红，光滑或高低不平，这种改变叫做“子宫颈糜烂”。

【病因病机】在正常情况下，子宫颈表面光滑，颈管分泌无色透明的粘液，是抵御病邪由阴道侵入体内的重要栅栏，如病邪侵入，阴道内环境有了改变，则分泌物增多，于宫颈长期浸渍在过多的分泌物中，逐渐导致感染而成糜烂。

【辨证施治】

（一）临床表现：白带量多，呈脓性或夹血液。重者腰酸背痛，疲乏无力，小腹下坠，外阴作胀。宫颈糜烂，色鲜红，轻者光滑，重者表面高低不平呈乳头状。根据糜烂程度不同分为轻、中、重三度。

轻度糜烂（Ⅰ度）：糜烂面占整个子宫颈面的1/3以下。

中度糜烂（Ⅱ度）：糜烂面占整个子宫颈面积的1/3～2/3之间。

重度糜烂（Ⅲ度）：糜烂面占整个子宫颈面积的2/3以上。

根据糜烂的深浅程度可分为单纯型、颗粒型和乳突型三种。

（二）治疗法则：清热化淤，祛湿解毒。尤以外用药为

主法。

(三) 处方用药：清热解毒化瘀汤（见盆腔炎）。

【外治方】

(一) 轻度用宫颈糜烂Ⅰ号方。

蛇床子、黄柏、苦参、贯众各15克。水煎冲洗阴道，日1次。

(二) 中度用宫颈糜烂Ⅱ号方。

蛇床子15克，川椒9克，白矾6克，白藓皮9克，硼砂15克，苍耳子9克。上药烘干为面，冲洗外阴和阴道后，将药面喷入宫颈上，再放一棉球塞住，以防药随分泌物流出，每周2次，8次为一疗程。

(三) 重度用宫颈糜烂Ⅲ号方。

蛤粉、钟乳石各30克，樟丹、雄黄各15克，乳香、没药各3克，薄荷冰0.6克。上药共为细面，香油调成糊状，敷于子宫颈上，每周2～3次。若充血红肿较重者，在上述两种外用药中可加入二黄粉（黄芩、黄柏各9克研成细粉）。

(四) 紫草油纱布方。

紫草300克，香油或花生油1200～1500克，先将油熬开后，稍放，待温度降到100度左右，加入紫草浸泡半小时，油即成鲜紫色，过滤去掉紫草，将小纱布侵入油内备用。用时先冲洗外阴和阴道，进行消毒，再将紫草油纱布贴在子宫颈上，日1～2次。

(五) 宫颈丸（粉）。

血竭、硼砂、硼砂、儿茶、钟乳石各15克，樟丹、青

黛、雄黄各7.5克，乳香、没药、冰片各6克，蛇床子24克，白矾30克，射香0.3克。共研细末，水泛为丸如绿豆大。每次1～2丸，放入阴道深入，或将药粉喷在子宫颈上。日1次，5天为一疗程。

以上(四)、(五)两方，对中、重度糜烂皆可使用。

第十七节 子宫颈癌

子宫颈癌是妇女最常见的恶性肿瘤。大多发生在40岁以后的妇女。

【病因病机】本病的发病原因尚不明确。一般认为与早婚、多产、子宫颈慢性炎症，宫颈损伤以及精神因素等有一定关系。祖国医学认为内伤七情是重要病因，忧思郁怒，伤及肝脾，气滞血瘀，经络阻塞，或湿热瘀毒互结于胞宫，血败肉腐而致本病。若病程日久，气血亏虚，脏腑功能失常，或肝肾阴虚，或脾肾阳虚，或五脏俱虚，阴阳离决而死亡。

【辨证施治】子宫颈癌早期的治愈率较高，而晚期的治愈率则大大降低。因而早期明确诊断非常重要。临床常见症状有：①白带增多有味往往是早期癌瘤的前期病变所致，开始带下色青质稀逐渐变为血性且有腥臭味的带下。②不规则阴道出血，周期缩短，经期延长，血量增多。而性交后出血及检查时接触性出血常是最早的信号。晚期常有大量出血以致造成严重贫血。③疼痛是晚期宫颈癌的症状，由于癌肿浸润转移或压迫盆腔内神经，疼痛常极为严重。但也有早期即

出现不定部位隐隐作痛，并伴有下腹部及腰部的不适感。④其他症状：晚期癌肿侵犯到膀胱，病人出现尿频、尿痛、血尿，甚至造成膀胱阴道瘘。侵犯输尿管则可出现尿闭、尿毒症。侵犯直肠则出现大便困难、便血或粪瘘。晚期常有严重贫血及恶病质等。妇科检查：子宫颈可呈糜烂型、菜花型、结节型或空洞型。阴道细胞涂片及活组织检查可找到癌细胞。宫颈癌根据病情早晚分为五期。0期：原位癌，病变未侵犯基底膜。Ⅰ期：癌瘤局限于宫颈。Ⅱ期：肿瘤侵犯超过宫颈，宫旁受侵未达盆壁，肿瘤侵及阴道，但未达下1/3。Ⅲ期：肿瘤侵犯达盆壁，穹窿受侵达阴道1/3。Ⅳ期：宫颈癌广泛浸润，盆底如冰冻状，尿道膀胱直肠受侵，甚至有远处转移。

宫颈癌明确诊断后，根据其症状之不同，进行辨证施治，同时应内治法与外治法结合进行，不可偏废。

在内服药中，可在筛选的抗癌药物中辨证选配以增强疗效。如昆布、海藻、乌贼骨、半枝莲、夏枯草、白花蛇舌草、败酱草、银花、连翘、山豆根、党参、黄芪等。

（一）肝郁气滞型宫颈癌：

1.临床表现：情志郁闷，心烦口干，胸胁痛或胀闷不适，小腹痛，夜间多梦，或头痛失眠，月经失调，白带量多。舌苔薄白，脉弦或弦细。常有植物神经功能紊乱表现。

2.主证分析：由于情志抑郁，肝失疏泻，肝气横逆则胸胁疼痛，或胀闷不适；肝郁化火，肝阳上亢，则头痛、失眠、多梦；肝气郁滞，影响脾之运化及气血运行，脾不运湿则

白带增多，气滞血瘀则月经不调，小腹疼痛。脉弦为肝气郁滞之象。

3. 治疗法则：疏肝解郁，佐以祛湿解毒。

4. 处方用药：逍遥散《和剂局方》加减。

柴胡、当归、白术、泽泻各9克，白芍、茯苓各15克，生甘草6克，土茯苓30克，茵陈12克，蒲公英15克。水煎2次分服。

方用逍遥散疏肝解郁，加土茯苓、公英、茵陈、泽泻祛湿解毒。

（二）瘀毒型宫颈癌：

1. 临床表现：阴道分泌物增多，色白如米泔或浊黄或灰污，气味恶臭，下腹痛，骶后憋胀。口干或苦。舌质正常或稍暗，苔白厚或微黄，脉滑数。宫颈局部坏死溃烂或感染。

2. 主证分析：久病脾气虚弱，不能运化水湿，湿蕴下焦，郁久化热，外邪乘虚而入，湿毒下注，则阴道分泌物增多，且色如米泔或灰污而气臭；瘀毒阻塞，脉络不通，则下腹疼痛，骶后憋胀。苔黄脉滑数，均为热毒内蕴之象。

3. 治疗法则：清热解毒，活血化瘀。

4. 处方用药：宫颈抗癌汤（编者方）。

白花蛇舌花、土茯苓各30克，半枝莲、黄药子、蒲公英、丹参、茵陈各15克，黄柏、赤芍各9克。水煎2次分服。

方中土茯苓、公英、茵陈、黄柏清热祛湿解毒；丹参、赤芍活血化瘀；白花蛇舌草、半枝莲、黄药子均有较强的抗

癌作用。

（三）肝肾阴虚型宫颈癌：

1.临床表现：腰酸背困，头晕耳鸣，手足心热，夜间梦多，口干便燥。舌红少苔或无苔，脉细数。有的伴有高血压。

2.主证分析：肾气虚衰则腰酸背困；阴虚内热，精气不能化血，精血不足，则头晕耳鸣，睡则梦多，五心烦热；热灼津伤，则口干便燥。舌红少苔或无苔，脉细数，均为阴虚内热之象。阴虚肝阳上亢可致高血压。

3.治疗法则：滋阴养肝，清肝活血。

4.处方用药：知柏地黄汤（《医宗金鉴》）加味。

熟地24克，山药12克，山茱萸、茯苓、泽泻、丹皮、知母、黄柏各9克，夏枯草、丹参各15克。水煎2次分服。

方中地柏地黄汤滋阴泻火；夏枯草清肝散结；丹参活血化瘀。

（四）脾肾阳虚型宫颈癌：

1.临床表现：精神疲乏，面色㿠白浮肿，四肢无力，腰酸背困，白带多而气臭，纳少便溏，或五更泄泻。舌体肥胖，质地淡红，苔薄白，脉缓。体质虚弱，常有贫血。

2.主证分析：久病失于调养，脾失健运，不能运化水湿、输布精微，血无化生之源，则浮肿、神疲、乏力、面色㿠白、贫血；肾阳不振，脾虚湿盛，则大便溏薄，白带增多；脾虚胃亦虚故纳少。苔薄，脉缓，乃脾肾阳虚之征。

3.治疗法则：温肾健脾祛湿。

4. 处方用药：参苓白术散（《和剂局方》）加减。

党参、茯苓各15克，山药、生薏仁各24克，白扁豆、白术、苦桔梗、莲子肉各12克，陈皮、炮附子、干姜、甘草各6克。水煎2次分服。

按：本方是参苓白术散去砂仁，加附子、干姜。

方中四君补气；山药、扁豆、莲子、薏仁健脾渗湿；桔梗以宣肺，陈皮以和胃，二药相伍以调畅气机；附子、干姜以温脾肾之阳。

【外治方】在辨证分型内服汤剂调整机体的同时，必须结合宫颈局部用药（外敷或注射），以去腐解毒，软坚散结，敛疮生肌，标本兼顾。可根据局部病变情况对下列方药，选择使用。每日或隔日1次。

（一）莪术注射液（浙江瑞安制药厂）。

1%莪术油注射液，日1次，每次5~10毫升，局部瘤体注射。或1次20毫升用5%葡萄糖溶液500毫升，摇匀后静脉点滴。

2%莪术注射液，瘤体注射，日1次，每次5~10毫升。

（二）宫颈癌栓片（上海中药二厂）：系天南星科半夏属植物掌叶半夏的地下块茎加工制成。

扁圆形栓剂：每次1枚，日1次。阴道使用。

棒型栓剂：每次1条，日1次，子宫颈使用。口服片剂：每次2~3片，日3次。

（三）宫颈癌粉一号：败毒去腐。

乌梅炭30克，鸦胆子、轻粉、生马前子各3克，生附子

6克，雄黄12克，砒石0.6克，硃砂0.3克，麝香0.015克。共研细末。

（四）宫癌粉二号：清热解毒。

黄连、黄芩各15克，黄柏、枯矾、紫草各30克，硼砂9克，冰片0.9克。共为细末。

（五）宫癌粉三号：敛疮生肌。

血竭、炉甘石、白芨、象皮、枯矾各15克，煅石膏30克，青黛9克。共为细末。

以上一、二、三号方亦可试用于慢性宫颈炎。

（六）宫癌粉四号：软坚散结，适用于结节型。

血竭、炉甘石各15克，黄柏30克，儿茶、铜绿各6克，穿山甲9克，蜈蚣3条，麝香0.015克。共为细末。

（七）宫癌粉五号：蟾酥、制白砒、五倍子各0.15克，雄黄6克，白芨12克，明矾60克，三七3克，紫硃砂0.3克。共研细末。

（八）宫癌粉六号：乳香、没药各9克，儿茶、冰片、硼砂、硃砂各10.5克，蛇床子12克，雄黄、钟乳石各13.5克，血竭7.5克，樟丹46.5克，白矾570克，麝香0.012克。共研细末。每周涂宫颈2次。或加凡士林、羊毛脂调成糊状，局部敷用。一般每3~4天换药1次。

（九）宫癌粉七号：轻粉3克，雄黄9克，冰片0.3克，麝香0.015克，蜈蚣2条，黄柏15克，共研细末。取药粉3克放在大棉球中间送入穹窿部，使棉球中间有药部分紧靠宫颈，最初每天用药1次，月经期停用，以后根据病情减少用

药次数，直到活组织检查查不到癌细胞为止。

根据临床经验，用低价的硼砂代替贵重的麝香，并未减低疗效。

【参考方】

（一）昆藻汤：软坚散结，解毒抗癌，适于初病身体情况较好者。

昆布15克，山豆根、柴胡、香附、乌贼骨各9克，全蝎6克，蜈蚣2条，炒白芍12克，海藻、半枝莲、夏枯草各30克。水煎2次分服。每日1剂。

（二）镇冲汤：补气养血，解毒止血。适于久病虚弱，流血腥臭及腹痛下坠者。

黄芪、生龙骨、生牡蛎各15克，知母、黄柏、当归、炒白芍、茜草炭、血余炭、芥穗炭各9克，三七粉3克（分2次冲）。水煎2次分服。每日1剂。

（三）愈黄丹：破瘀散结，消炎解毒。适用于宫颈癌早期浸润型，宫颈坚硬，接触出血者。

水蛭、虻虫、制乳香、制没药、黄连各6克，黄柏、蜂房各9克，丹皮12克，龙胆草15克。共为细末。照方配30料，用银花90克煎汤泛丸如梧桐子大，雄黄9克为衣，忌高温烘。每次1.5克，每天2次，白开水送服。

据报道，内服愈黄丹，外涂宫癌粉六号，效果良好。

（四）征癌丸：止痛止血，消炎解毒。适用于宫颈癌溃疡而身体情况一般者。

乳香、没药各15克，生大黄60克，紫石英、白石英各

15克，白矾30克，白药子180克，紫草、仙鹤草各500克，雄黄90克，草薢、炒干膝各150克，木香60克，黄芩30克，白芍300克，银花360克。共为细末，水泛为丸，如梧子大，每次15~20粒，日3次，白开水送服。

（五）宫颈癌丸：补气和血，滋肾养肝。适于体虚而带血淋漓者。

黄芪15克，焙牛角腮、海螵蛸、桑螵蛸各9克，茜草炭、紫河车、黄鱼膘各6克，炙龟板12克，鹿角霜、血余炭各8克，生牡蛎12克。配5公斤（5000克）为1料，共为细末，加猪脊髓1条（练化为油），合炼密为丸，每丸重9克。每次1丸，日2次，淡盐汤送服。

第十八节 绒毛膜上皮癌

绒毛膜上皮癌（简称绒癌）是一种恶性程度很高的肿瘤。近年来采用化学抗癌药配合中药治疗取得可喜的成绩。

【病因病机】本病的发生绝大多数与妊娠有关，其中以发生在葡萄胎之后者最多，发生在流产或正常产之后者次之，极少数由孕卵直接发生，甚至有的来自畸胎瘤内所含卵子的滋养叶成分。

绒癌是一种上皮瘤，由绒毛上皮细胞（即罕氏细胞与合体细胞）滋养层所组成。此种肿瘤本身并无血管和间质，而靠母体血液的直接接触获得营养。它具有侵入母体血管并破坏母体组织的特性。故在肿瘤发生之处，必伴有出血现象。

绒癌多数起源于绒毛附着部分，故大多数开始生长于宫腔，继之向子宫肌层、宫旁组织而达到腹膜层，或穿破腹膜层入腹腔。并可转移到远离脏器，最多为肺，次为阴道、脑部、消化系、泌尿系等。从而出现相应的临床症状。同时由于绒癌分泌绒毛激素，故出现单侧或双侧卵巢黄素囊肿。

因绒癌主要症状是出血及肿块，以及出血后的严重贫血。祖国医学认为，本病的起始，主要是血瘀，其后是气血俱虚，或瘀久化热，或感染邪毒而发热。

【辨证施治】

（一）临床表现：如癌肿突出于子宫腔者，早期出现不规则阴道流血，发生时间多在妊娠终止后6～8周之间，流血可为间断性，持续淋漓不断或大量下血并有血块。病久则气血两亏，体倦无力。双合诊可触及子宫增大、质软，有时呈结节状突出，或出现单侧或双侧卵巢黄素囊肿。妊娠试验强阳性。舌质淡，苔薄，脉沉细而弱。若转移到肺部则出现咳嗽、咯血、胸闷。胸部X线摄片可见转移瘤阴影。若转移到脑则出现严重的头痛抽搐或偏瘫。若转移到脊髓则出现下肢运动障碍，二便不能自解或失禁，甚至截瘫。

（二）主证分析：绒癌初起侵及胞宫，阻塞经脉而瘀血内停，瘀血不去，新血不得归经，故出现阴道流血；瘀血积聚于胞宫及胞脉，故使子宫增大，卵巢出现肿块；长期出血或大量失血必致阴血亏虚，伤于血必及于气，故久病则气血双亏，体倦乏力，肝主藏血，血亏肝阴不足，肝阴虚肝阳亢，使肝风内动而抽搐；瘀而化热，或感受毒邪而发热，热

伤肺络则咳嗽、咯血。舌淡苔薄，脉沉细而弱，均为气血亏虚之象。

（三）治疗法则：补气养血，渗湿解毒。

（四）处方用药：益气渗湿解毒汤（编者方）。

黄芪、党参各15~30克，败酱草15克，白芨、茜草、生蒲黄、阿胶、当归、白芍各9克，薏仁、赤小豆、冬瓜仁、鱼腥草各30克，三七粉3克（2次冲），甘草6克。水煎2次分服。

方中党参、黄芪、甘草以补气；当归、阿胶、白芍以补血；薏仁、瓜仁、赤小豆利湿行水；败酱、鱼腥草解毒；茜草、三七、生蒲黄化瘀止血。

腹中有块加三棱、莪术各9克；肺转移胸痛者加郁金、陈皮各9克；咯血重者加藕节15克，白茅根30克；腹胀纳少者加鸡内金粉6克（2次冲），广木香6克。

若见头痛抽搐者，可用紫雪丹（成药）每次3克，日服1~2次。

若因用抗癌药而白细胞下降者，可用抗癌补血汤（编者方）。

熟地、制首乌、党参各15克，鸡血藤30克，当归、白芍、丹参各9克，肉桂6克，红大枣60克（劈）。水煎2次分服。

若因白细胞下降而患口腔炎者，上方去肉桂，加黄芩9克，花蕊石15克，升麻3克。水煎服。同时在口腔溃疡处喷酒锡类散消炎。

若发烧咳吐脓血者用苇茎汤（《千金方》）加味。

苇茎、冬瓜仁、银花、公英、薏仁各30克，地丁、连翘各15克，桃仁、红花9克，甘草6克。水煎2次分服。

按：本方是苇茎汤加银花、公英、地丁、红花、连翘、甘草。

方中苇茎（芦根，鲜者佳）清热泄肺，冬瓜仁祛痰排脓，薏仁清热利湿，桃仁活血化痰；加银花、公英、地丁、连翘、红花以增强清热解毒，活血散结之力。

第十九节 乳 痈

乳痈是乳房部的急性化脓性疾病，现代医学叫“急性乳腺炎”。因发病时期和病因不同，故有两种名称：在哺乳期发生的，名“外吹乳痈”；在妊娠期发生的，名“内吹乳痈”。在临床上以外吹乳痈为最多，内吹乳痈较少见。

【病因病机】

（一）外吹乳痈：

1.因乳汁积滞不得外流而发生，有以下几种原因：

（1）产妇乳头破裂疼痛，不能使乳儿吸尽乳汁。

（2）乳头破裂后，外结黄痂，阻止乳汁外流。

（3）乳母乳汁过多，婴儿吸少；或初产妇乳络不畅，或断乳后乳汁壅塞。

2.在哺乳期，乳儿含乳而睡，或婴儿口中热气与乳头接触，吮乳吹风所致。

3.情绪刺激，暴怒忧郁，紧张恐惧，以致气滞血凝，壅结而成。

4.膏粱厚味，饮食不节，脾胃运化失调，湿热浊气蕴结而成。

5.产后血虚，外感风寒热邪壅滞而成。

(二)内吹乳痈：由于胎气旺盛，胸满气逆，气机失于疏泄，邪热蕴蒸阳明，以致结肿而成。

总之，由于乳头属足厥阴肝经，乳房属足阳明胃经，故本病多由肝经之气，胃经之热，互相郁结，致使经络阻塞，营气不和而发生。

【辨证施治】本病由于发病时期不同，致病原因各异，故其病程亦有所差异。如外吹乳痈，大多是产后尚未满月的哺乳妇女，尤以初产妇最为多见；内吹乳痈，多见于怀孕6～7个月的时期发生。内吹乳痈较外吹乳痈难消，酿脓亦慢，溃后往往持续产后才能收口。本病的治疗，在内治法中，一般以疏肝气，清胃热为主，热重者偏重清热，气郁者偏重理气，可根据辨证灵活运用。本病在发生发展过程中，可分为郁乳期、酿脓期、溃后期3个阶段。

【内治法】

(一)外吹乳痈：

1.乳痈郁乳期：

(1)临床表现：乳房肿胀、触痛，肿块或有或无，皮色或白或红，尚未成脓，乳汁分泌不畅，伴有发热恶寒，头痛骨楚，或有胸闷、口渴、呕恶等症。舌苔白腻或黄腻，脉

弦数或滑数。

(2) 治疗法则：疏肝清胃，泄热解毒，散结通乳。

(3) 处方用药：栝楼牛蒡汤（《医宗金鉴》）加味。

栝楼仁、牛蒡子、栀子、连翘、花粉、柴胡、黄芩各9克，银花15克，陈皮、青皮、生甘草各6克，蒲公英30克。水煎2次分服。

按：本方是栝楼牛蒡汤加蒲公英。

方中柴胡、青皮疏肝理气，解郁退热；栀子、黄芩泻肝胃湿热；银花、连翘、牛蒡、栝楼清热消肿，解毒散结；蒲公英不仅能清热解毒，尚有疏通阻塞之乳腺管的作用，与栝楼配合，历来为消散乳痈之要药；天花粉能清胸胃之烦热，又善滋生阴液以止渴，并能入血分，消瘀血，散结肿；陈皮、甘草益脾和胃，泻火解毒。综合全方能使肝郁疏，胃热除，乳汁通，肿结消之作用。

在哺乳期间，乳汁壅滞不通者，宜通乳，加漏芦、王不留行各12克。

如产妇不哺乳或断乳后，乳汁壅滞者，宜回乳，可加生麦芽30克。

新产妇恶露不净者，宜祛瘀，可加益母草15克，当归尾9克。

有肿块者，宜活血和营，加当归、赤芍各9克。

2. 乳痈酿脓期：

(1) 临床表现：郁乳期经上述治疗后，病势不减，寒热不退，或热退不尽，乳部肿块增大，掀红疼痛，并有持续

跳痛，舌苔白膩或黄膩，脉象弦滑带数者，则已有化脓趋势。

(2) 治疗法则：清热解毒，消肿溃坚，活血止痛。

(3) 处方用药：仙方活命饮(《外科发挥》)。

银花30克，花粉15克，当归、赤芍、贝母(土贝亦可)、白芷，山甲珠、皂角刺各9克，制乳香、制没药、防风、陈皮、生甘草各6克。水煎2次分服。或加黄酒30克兑服。

方中主以银花、甘草清热解毒，为治痈疮要药；辅以防风、白芷散风除湿排脓以消肿；当归、赤芍、乳香、没药活血散瘀以止痛；佐贝母、花粉清热化痰以散结；陈皮和胃理气；使以山甲、皂刺穿通经络，溃坚消肿；加酒入煎，更能增强活血通络作用，协山甲、皂刺速达病所。合用有清热解毒，消肿溃坚，活血止痛之功。故凡痈疮初起，肿块坚硬难消，属于阳证者，本方皆可应用。由于本方具有以上功用，所以脓未成者，服之可使之消散，脓已成者，亦可促使外溃，故为阳证痈肿之常用方。

若酿脓期，服上方后，仍身发寒热，乳房疼痛，连续10天左右不减，硬块中央渐软，按之应指者，已到脓熟阶段。宜托毒透脓。用程氏透脓散(见阴疮)加蒲公英30克。

3. 乳痈溃后期：

(1) 临床表现：脓肿溃破，浊液外流，热退身凉，肿痛渐减。

(2) 治疗法则：补益气血，解除余毒。

(3) 处方用药：四妙汤（《外科精要》）加味。

生黄芪24克，银花、蒲公英各15克，当归、白芷、白芍、赤芍各9克，生甘草6克。水煎2次分服。

按：本方是四妙汤加公英、白芷、赤芍、白芍。

方中黄芪、甘草益气，当归、白芍补血，赤芍活血化瘀，白芷消肿排脓，银花、公英清热解毒，并能通乳。

如溃后脓出不畅，肿痛不减，身热不退者，宜按郁乳期、酿脓期治法处理。

如身体虚弱，肉芽生长迟缓，创口久不愈合者，宜补益气血，用八珍汤（见阴疮）。

(二) 内吹乳痈：是由于在妊娠期间而患乳痈，须于疏肝清胃方中佐以安胎之药，免伤胎儿。

1. 若皮色不变，偏于气郁者，宜疏肝解郁，可用逍遥散（见月经后期）加苏梗、苎麻根各9克。

2. 若皮红色赤，偏于热壅者，宜解郁和胃清热，可用橘叶散（《外科正宗》）加味。

橘叶12克，柴胡、梔子、黄芩、连翘、苎麻根各9克，生石膏15克，青皮、川芎、生甘草各6克。水煎2次分服。

按：本方是橘叶散加苎麻根。

方中橘叶、柴胡、青皮疏肝解郁，行气散结，梔子、黄芩、连翘、甘草清热解毒，川芎活血祛瘀，石膏清泻胃热，苎麻根既能解毒，又能安胎。

【外治法】外吹、内吹二证，均可采用下法：

(一) 郁乳期：

1.按摩乳房，或用木梳背向乳头方向梳之。可使积乳消散。

2.热敷：薄荷、陈皮各30克，煎汤趁热以纱布数层蘸透敷患部。可消肿散结，促使乳汁分泌，积乳排出。

3.冷敷：芒硝250克，装纱布袋中，放置乳房肿块处。适于乳汁过多，胀痛严重者。

4.仙人掌90克，白矾9克。共捣如泥敷患处，外盖纱布，用胶布条贴紧，一日换药1次。可散结消肿止痛。

5.皮肤焮红灼热者，宜玉露油膏或金黄油膏（均见阴疮）外敷。

6.皮色微红或不红者，宜用冲和膏，掺红灵丹敷盖。

（1）冲和膏（《外科正宗》）。

紫荆皮（炒）150克，独活90克，赤芍60克，白芷30克，节菖蒲45克。共为细末。用凡士林4/5，冲和膏1/5，调匀成膏。

功用：疏风活血，定痛消肿，祛寒软坚。适于阴阳不和，冷热相凝者。

（2）红灵丹（经验方）。

雄黄、制没药、制乳香，火硝各18克，煅硼砂30克，朱砂60克，冰片6克，麝香1.5克（缺时不用）。除冰片，麝香另研外，其他各药共研细末，最后加入冰、麝共研匀，瓶装密封，备用。

功用：活血止痛，消坚软结。适用于一切痈疮未溃者。

用法：掺膏药上或调油膏（红灵丹45克，凡士林300克。

先将凡士林烱化冷却，再将药粉徐徐调入，和匀成膏，敷贴于患处。

敷药前，可用大葱120~150克，煎汤热敷。

（二）脓成期：脓已成熟而不能自溃者，宜采取以乳头为中心做放射形切开排脓，不能横切，以防损伤乳络。切大口者，须塞大黄油纱布引流；小切口则损害组织少，必须插纸捻引流。

（三）溃后期：

1.脓多，有坏死组织时，可用大黄油纱布蘸少许九一丹或二宝丹（均见阴疮）塞入创口引流。

2.脓少，肉芽组织新鲜时，用生肌玉红膏（见阴疮）油纱布换药。

3.新生肉芽组织生长迟缓者，结合应用生肌散（见阴疮）。

4.形成乳房窦道者，可用红升丹（成药）药条插入窦道内换药。

5.乳汁从创口流出者，用垫棉法束紧，压缩乳汁分泌，促使收口愈合。

【护理】

（一）在未成脓及破溃后，均宜应用吸奶器充分吸出乳汁，或让较大儿童吸去，或带玻璃乳罩，亦可照常授乳。

（二）以三角巾或胸罩托起患乳，脓未成可减少行动牵痛，破溃后可使脓液畅快流出。

（三）乳母宜心情舒畅，注意个人卫生和乳儿口腔清洁，勿使乳儿含乳而睡。

附：方剂索引

一 画

一阴煎····· 73

二 画

二仙汤····· 137

二妙散····· 295

二宝丹····· 340

十全大补汤(丸)····· 91、72

七味白术散····· 124

人参养荣汤····· 72

人参滋血汤····· 85

人参麦冬汤····· 192

八仙饮····· 156

八珍汤····· 339、72、121

九一丹····· 341

九仙散····· 197

三 画

三妙散····· 334

三才封髓汤····· 311

三甲复脉汤····· 257

大营煎····· 71

大七气汤····· 280

大补元煎····· 308、295

大黄麝虫丸····· 99

大黄附子细辛汤····· 291

下乳涌泉散····· 270

小营煎····· 95

小柴胡汤····· 254、117

小半夏加茯苓汤····· 177

四 画

六君子汤····· 97

六味地黄汤(丸)····· 106、121、136

木通散····· 245

五倍煎····· 335

五苓散····· 200

五淋散····· 186

五味消毒饮····· 167

五子衍宗丸····· 313

开郁正元散····· 280

开郁种玉汤····· 302

天仙藤散····· 180

少腹逐瘀汤	302
止痒方	327
止带方	149
止痒散	258
内补丸	144
内疏黄连汤	337
见睨丹	279
乌药汤	241
乌药散	98
丹栀逍遥散	66、120
化癥导水汤	346

五 画

半夏厚朴汤	319
平痒散	335
平肝开郁止血汤	110
右归丸	107、133、137
左归丸	133
玉露散	340
玉露油膏	340
上肾风散	261
龙胆泻肝汤	152
石英温肾汤	321
艾附暖宫丸	71
甘麦大枣汤	139
四物汤	339
四君子汤	147
四苓散	259、181

四妙散	309
四妙汤	365
四神丸	126
归脾汤	68
白术散	178
生化汤	239、158
生肌散	341
生肌王红膏	341
生津止渴糖水饮	243
失笑散	234
仙方活命饮	364
加减小阴煎	255
加减小腹饮	152
加减小腹丸汤	312
加味吴茱萸汤	145
加味地骨皮饮	118
加味固阴煎	164
外阴炎洗剂	329
外阴消炎粉	329
外阴消炎膏Ⅰ号	329
外阴消炎膏Ⅱ号	329
外阴消炎膏Ⅲ号	329
圣愈汤	260

六 画

冲洗液	150
冲和膏	366
冰硼油	335

百白回生汤	196
百合地黄汤	317
过期饮	74
死精Ⅰ号方	315
死精Ⅱ号方	315
芎归二陈汤	76
当归补血汤	97
当归地黄饮	86
当归芍药散	206
当归建中汤	264
当归六黄汤	287
当归苁蓉润肠汤	324
竹沥汤	193
血竭散	288
血府逐瘀汤	89
华佗愈风散	258
导赤散	185
阴道炎洗剂	333
阴道炎粉剂	333
红灵丹	366
红花桃仁煎	89
约营煎	127
先期饮	83

七 画

启宫丸	303、76
完带汤	143
补血汤	67

补心丹	138
补中益气汤	120、154
补气通肝汤	217
补气固经丸	67
补肾地黄丸	96
补肾固冲丸	217
补肾安胎饮	218
补气解晕汤	250
沙参麦门冬汤	319
两地汤	65
束胎丸	227
寿胎丸	211
杏苏散	198
苏叶黄连汤	176
苍附导痰丸	102
苇茎汤	361
花蕊石散	214
抗痿灵	369
抗癌补血汤	360
吴茱萸汤	101
吴茱萸浴汤	166
利火汤	163
佛手散	222
肠宁汤	263
坐盆熏洗方	150
身痛逐瘀汤	267
附子汤	205
阿胶养血汤	208

八 画

定经汤	80
治阴道滴虫方	335
转胎汤	228
抵当汤	278、75
抵当丸	278
苦楝丸	158
固经丸	84
固精丸	117
固脬丸	247
昆藻汤	357
易黄汤	149
肾气丸	190
征瘕丸	357
和血通经汤	100
知柏地黄丸	326、312
金黄散	340
金黄油膏	340
参附汤	280
参苓白术散	79、123

九 画

宫颈丸	350
宫外孕汤	287
宫外孕Ⅰ号方	286
宫外孕Ⅱ号方	287
宫颈癌丸	358

宫颈抗癌汤	353
宫颈癌栓片	355
宫颈糜烂Ⅰ号方	350
宫颈糜烂Ⅱ号方	350
宫颈糜烂Ⅲ号方	350
宫颈癌粉一号	355
宫颈癌粉二号	356
宫颈癌粉三号	356
宫颈癌粉四号	356
宫颈癌粉五号	356
宫颈癌粉六号	356
宫颈癌粉七号	356
养阴润燥祛风汤	330
举元煎	283、82、105
济生肾气丸	244
济生地黄丸	182
活血润燥生津汤	115
荆芥散	250
荆防四物汤	253
茯菟丹	147
茯苓导水汤	182
柏子仁丸	96
枳壳瘦胎饮	227
珍珠散	327
胃苓汤	146
胃风汤	166
保阴煎	238、153
保胎无忧散	228

独参汤·····	249、105
独活寄生汤·····	268
香桂丸·····	264
香砂六君子汤·····	175
胜湿汤·····	156
顺经两安汤·····	128
逐瘀通精汤·····	311

十 画

凉胎饮·····	219
凉血解毒汤·····	256
消症散·····	288
益母膏·····	157
益气止淋汤·····	187
益气渗湿解毒汤·····	360
调肝汤·····	92
调经升阳除湿汤·····	111
桃仁散·····	157
桃红四物汤·····	80、87、109
桂枝四物汤·····	116
桂枝茯苓丸·····	277、221
栝楼牛蒡汤·····	363
莪术油注射液·····	355
真武汤·····	180
泰山磐石散·····	212
逍遥散·····	74、78、119
逍遥散加减方·····	116
柴芩四物汤·····	159

柴胡四物汤·····	74
柴胡疏肝散·····	131
秘精丸·····	311
健固汤·····	126
通乳丹·····	270
胶艾汤·····	205

十一 画

麻黄四物汤·····	117
清经汤·····	64
清经四物汤·····	114
清热固经汤·····	108
清热调血汤·····	255
清热解毒化瘀汤·····	345
清肝止淋汤·····	154
清心莲子饮·····	170
液化汤·····	314
羚羊钩藤汤·····	201
理中汤·····	124
黄连解毒汤·····	112
黄连膏坐药·····	333
黄芪当归散·····	248
黄芪桂枝五物汤·····	266
萆薢分清汤·····	169
萆薢渗湿汤·····	326
蛇床子散·····	327
蛇床苦参煎·····	335
脱花煎·····	215

银花戢菜饮·····	253、224
银翘红酱解毒汤·····	344

十二 画

痛泻要方·····	125
温经汤·····	70
温肾丸·····	299
湿热遗精方·····	311
滋肾凉血解毒汤·····	333
滋阴养血化瘀汤·····	348
琥珀分清泄浊丸·····	168
黑神散·····	235
雄蛇丸·····	335
紫苏饮·····	207
紫草油纱布方·····	350
程氏透脓散·····	337

十三 画

蜂房散·····	309
塌痒汤·····	327
催生饮·····	227
愈黄丹·····	357

十四 画

毓麟珠·····	300
蔡松汀难产方·····	226
扁下逐瘀汤·····	301

十五 画

增液汤·····	195
增味四物散·····	278
橘叶散·····	365
橘枳龙牡汤·····	317
镇冲汤·····	357
鹤顶丸·····	160
鲤鱼汤·····	183

十六以画上

赞育丹·····	308
擦剂·····	150
薤皮除湿解毒汤·····	329

[G e n e r a l I n f o r m a t i o n]

书名=实用中医妇科科学

作者=周凤梧

页数= 3 7 3

S S 号= 1 0 5 2 6 1 7 4

出版日期= 1 9 8 5 年 0 5 月第 1 版